



저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:



저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.



비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.



변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)

교육학박사학위논문

중학생의 비자살적 자해행동 감소를 위한
변증법적 행동치료(DBT) 집단기술훈련
프로그램 개발 및 효과분석

국립순천대학교대학원

교육학전공

선미란

2025년 8월

중학생의 비자살적 자해행동 감소를 위한
변증법적 행동치료(DBT) 집단기술훈련
프로그램 개발 및 효과분석

지도교수 임경희

이 논문을 교육학 박사학위 논문으로 제출합니다.

2025년 7월 11일

국립순천대학교대학원

교육학전공

선미란

선미란의 교육학 박사학위
논문을 인준합니다.

심사 위원장 손 승 남 인

심 사 위 원 이 병 환 인

심 사 위 원 신 흥 임 인

심 사 위 원 김 지 인 인

심 사 위 원 임 경 희 인

2025년 8월

국 립 순 천 대 학 교 대 학 원

목 차

국문초록	x
I. 서론	1
1. 연구의 필요성 및 목적	1
2. 연구 문제	5
3. 용어의 정의	6
II. 이론적 배경	9
1. 중학생의 비자살적 자해행동	9
1) 비자살적 자해행동의 개념 및 진단 기준	9
2) 중학생의 비자살적 자해행동 실태	15
3) 비자살적 자해행동 청소년의 심리적 특성	18
2. 비자살적 자해행동의 이론적 모델 및 관련 요인	22
1) 비자살적 자해행동의 원인 및 관련 변인	22
2) 비자살적 자해행동 설명모델	27
3. 변증법적 행동치료(DBT)와 비자살적 자해행동	39
1) DBT의 기원 및 역사	39
2) DBT의 특성 및 적용	41
3) DBT 효과에 관한 선행연구	52

Ⅲ. 연구 방법	59
1. 연구 절차 및 설계	59
1) 프로그램 개발 절차	61
2) 프로그램 효과분석 절차	62
2. 연구 대상 선정	67
3. 측정 도구	70
1) 비합리적 신념 척도	70
2) 정서조절 곤란 척도	71
3) 우울 척도	72
4) 고통감내력 척도	73
5) 자해행동 척도	74
6) 연구 참여자 성찰 일지	75
4. 연구 윤리	75
1) 연구자의 소양	75
2) 연구에 대한 윤리적 고려	75
3) 윤리의 엄격성	76
5. 자료 분석	77
1) 프로그램 효과의 정량적 자료분석	77
2) 참여자 성찰 내용 및 연구자 관찰 분석	78

IV. 변증법적 행동치료(DBT) 집단기술훈련 프로그램 개발	79
1. 프로그램의 기획, 목적 및 목표	79
1) 프로그램의 기획	79
2) 프로그램의 목적과 목표 설정	81
2. 요구 조사	83
1) 조사 대상 및 절차	83
2) 학생 대상 요구 조사	83
3) 전문 상담사 대상 요구 조사	88
4) 요구 조사 시사점	91
3. 프로그램 내용, 활동 구성 및 타당도 검증	92
1) 프로그램 내용	92
2) 프로그램 활동, 회기별 주제 및 목표	94
4. 예비 프로그램 개발 및 타당도 검증	98
1) 예비 프로그램 개발의 이론적 근거	98
2) 최종 프로그램의 개발	113
3) 프로그램의 운영 지침	117
V. DBT 집단기술훈련 프로그램 효과분석	122
1. 프로그램 효과의 정량적 분석	122
1) 집단 간 사전검사 동질성 검증	122
2) 실험, 통제, 비교집단 간 사후 차이 검증	127
3) 집단 내 사전-사후 차이 검증	134
4) 실험집단과 비교집단 간(인지적, 정서적, 행동적) 추후 차이 검증	141
5) 집단 내 사전-사후-추후(인지적 변인, 정서적 변인, 행동적 변인) 차이 검증	146
2. 프로그램 참여자 경험 및 연구자 관찰	156

1) 1회기: 변증법적 행동치료(DBT) 이해와 마음 친구와 함께 해봐요. ·	156
2) 2회기: 마음챙김(mindfulness training) ‘What’ 기술	158
3) 3회기: 마음챙김(mindfulness training) ‘HOW’ 기술	159
4) 4회기: 고통감내(distress tolerance) 기술훈련	160
5) 5회기: 고통감내(distress tolerance) 기술훈련	162
6) 6회기: 정서조절(emotion regulation 기술훈련	164
7) 7회기: 정서조절(emotion regulation 기술훈련	166
8) 8회기: 대인관계 효율성(interpersonal effectiveness) 기술훈련	168
9) 9회기: 대인관계 효율성(interpersonal effectiveness) 기술훈련	170
10) 10회기: 종결 단계	172

VI. 논의 및 결론 174

1. 논의	174
1) 프로그램 개발에 대한 논의	175
2) 프로그램 효과에 대한 논의	184
2. 결론 및 제언	193
1) 결론	193
2) 제언	195

참고문헌 198

Abstract 237

부 록 241

표 목 차

<표Ⅱ-1> 비자살적 자해와 자살의 차이	12
<표Ⅱ-2> DSM-5의 비자살적 자해 진단 기준	15
<표Ⅱ-3> 청소년 비자살적 자해행동 심리특성	21
<표Ⅱ-4> 비자살적 자해의 4가지 기능 모델	29
<표Ⅱ-5> 비자살적 자해행동 모델 비교	38
<표Ⅱ-6> DBT의 세 가지 마음 상태	46
<표Ⅱ-7> DBT의 마음챙김 기술 요인	47
<표Ⅱ-8> DBT의 고통감내력 기술 요인	49
<표Ⅱ-9> DBT의 정서조절 단계	51
<표Ⅱ-10> 변증법적 행동치료(DBT) 청소년 대상 프로그램 선행연구	54
<표Ⅱ-11> 변증법적 치료 효과성 선행연구	58
<표Ⅲ-1> 연구설계	64
<표Ⅲ-2> 중학생 분노 조절을 위한 인지·정서·행동 통합프로그램	66
<표Ⅲ-3> 연구 대상 제외 기준	69
<표Ⅲ-4> 연구 대상의 일반적인 특성	69
<표Ⅲ-5> 측정 도구	70
<표Ⅲ-6> 비합리적 신념 척도의 하위 요인별 문항 구성 및 신뢰도	71
<표Ⅲ-7> 정서조절 곤란 척도의 문항 구성 및 신뢰도	72
<표Ⅲ-8> 우울 척도(CES-D) 문항 구성과 신뢰도	73
<표Ⅲ-9> 고통감내력 척도의 문항 구성 및 내적 일관성 신뢰도	73
<표Ⅲ-10> 자해행동 평가 문항 구성 및 신뢰도	74

<표IV-1> 학생 요구 조사 응답자	84
<표IV-2> 학생 대상 요구 조사 결과	86
<표IV-3> 전문 상담사 요구 조사 응답자	88
<표IV-4> 전문 상담사 대상 요구도 조사	90
<표IV-5> DBT 프로그램 활동 주제와 목표	94
<표IV-6> 프로그램의 활동 내용 이론적 근거	101
<표IV-7> 중학생의 비자살적 자해행동 감소를 위한 DBT 예비 프로그램 구성(안)	103
<표IV-8> 예비 프로그램 타당성 검증 전문가 정보	105
<표IV-9> 프로그램 개발과 타당도 검증 절차	105
<표IV-10> 회기별 전문가의 의견 및 반영	107
<표IV-11> 예비 프로그램의 평가 내용	109
<표IV-12> DBT 의견을 반영한 예비 프로그램 수정·보완내용	110
<표IV-13> 중학생의 비자살적 자해행동 감소를 위한 변증법적 행동치료 (DBT) 집단기술훈련 최종 프로그램	116
<표V-1> 집단 간 인지적 변인(비합리적 신념) 의 사전 동질성 검사비교 ...	123
<표V-2> 집단 간 정서적 변인(정서조절)의 사전 동질성 검사비교	124
<표V-3> 집단 간 정서적 변인(우울)의 사전 동질성 비교	125
<표V-4> 집단 간 행동적 변인(고통감내력)의 사전 동질성 비교	126
<표V-5> 집단 간 행동적 변인(자해행동)의 사전 동질성 비교	126
<표V-6> 집단 간 인지적 변인(비합리적 신념) 사후검사 차이 검증	128
<표V-7> 집단 간 정서적 변인(정서조절) 사후 차이 검증	129
<표V-8> 집단 간 정서적 변인(우울) 사후 차이 검증	131
<표V-9> 집단 간 행동적 변인(고통감내력) 사후 차이 검증	133
<표V-10> 집단 간 행동적 변인(자해행동) 사후 차이 검증	134
<표V-11> 집단 내 인지적 변인(비합리적 사고)의 사전-사후 차이 검증	135

<표 V-12> 집단 내 정서적 변인(정서조절) 변화의 사전-사후검사 비교	137
<표 V-13> 집단 내 정서적 변인(우울) 변화의 사전-사후 차이 검증	138
<표 V-14> 집단 내 행동적 변인(고통감내력)의 사전-사후 검사비교	140
<표 V-15> 집단 내 행동적 변인(자해행동)의 사전-사후 차이 검증	141
<표 V-16> 실험집단과 비교집단 간 인지적 변인(비합리적 신념) 추후 차이 검증	142
<표 V-17> 실험집단과 비교집단 간 정서적 변인(정서조절) 변화 추후 검사비교	143
<표 V-18> 실험집단과 비교집단 간 정서적 변인(우울) 추후 차이 검증	144
<표 V-19> 실험집단과 비교집단 간 행동적 변인(고통감내력) 추후 차이 검증	145
<표 V-20> 실험집단과 비교집단 간 행동적 변인(자해행동) 추후 차이 검증	146
<표 V-21> 실험집단과 비교집단 내 인지적 변인(비합리적 신념) 사전-사후 -추후 검사 차이 검증	147
<표 V-22> 실험집단과 비교집단 내 정서적 변인(정서조절) 변화 사전-사후 -추후 차이 검증	149
<표 V-223> 실험집단과 비교집단 내 정서적 변인(우울) 변화 사전-사후 -추후 차이 검증	151
<표 V-24> 실험집단과 비교집단 내 행동적 변인(고통감내력) 사전-사후-추후 차이 검증	153
<표 V-25> 실험집단과 비교집단 내 행동적 변인(자해행동) 사전-사후-추후 차이 검증	155
<표 V-26> 1회기 프로그램 참여자 성찰 경험 및 연구자 관찰	157
<표 V-27> 2회기 프로그램 참여자 성찰 경험 및 연구자 관찰	159
<표 V-28> 3회기 프로그램 참여자 성찰 경험 및 연구자 관찰	160
<표 V-29> 4회기 프로그램 참여자 성찰 경험 및 연구자 관찰	162
<표 V-30> 5회기 프로그램 참여자 성찰 경험 및 연구자 관찰	164
<표 V-31> 6회기 프로그램 참여자 성찰 경험 및 연구자 관찰	166

<표 V-32> 7회기 프로그램 참여자 성찰 경험 및 연구자 관찰	168
<표 V-33> 8회기 프로그램 참여자 성찰 경험 및 연구자 관찰	170
<표 V-34> 9회기 프로그램 참여자 성찰 경험 및 연구자 관찰	171
<표 V-35> 10회기 프로그램 참여자의 성찰 경험 및 연구자 관찰	173

그림 목차

[그림Ⅱ-1] 통합적 이론 모델(Nock, 2009)	31
[그림Ⅱ-2] 경험 회피 모델(Chapman, Gratz, & Brown, 2006)	33
[그림Ⅱ-3] 비자살적 자해의 인지-정서 모델(Hasking et al. 2017)	35
[그림Ⅱ-4] 비자살적 자해 극복 과정 모형(서미 외, 2019)	36
[그림Ⅱ-5] DBT 수용과 변화의 기술 요인	44
[그림Ⅲ-1] 프로그램 개발 및 효과성 검증을 위한 연구 절차	60
[그림Ⅳ-1] 프로그램 목적, 목표, 구성 및 구조의 선형관계	115
[그림Ⅴ-1] 실험집단과 비교집단 내 인지적 변인(비합리적 신념) 사전-사후 -추후 차이 검증	148
[그림Ⅴ-2] 실험집단과 비교집단 내 정서적 변인(정서조절) 변화 사전-사후 -추후 차이 검증	150
[그림Ⅴ-3] 실험집단과 비교집단 내 정서적 변인(우울) 변화 사전-사후 -추후 차이 검증	152
[그림Ⅴ-4] 실험집단과 비교집단 내 행동적 변인(고통감내력) 사전-사후 -추후 검사비교	154
[그림Ⅴ-5] 실험집단과 비교집단 내 행동적 변인(자해행동) 사전-사후-추후 차이 검증	155

국문초록

중학생의 비자살적 자해행동 감소를 위한 변증법적 행동치료(DBT) 집단기술훈련 프로그램 개발 및 효과분석

선미란

교육학 전공

순천대학교 대학원

(지도교수 임경희)

본 연구의 목적은 중학생의 비자살적 자해행동 감소를 위해 변증법적 행동치료(DBT) 기술훈련 집단프로그램을 개발하고, 이를 중학생 분노조절 향상을 위한 인지·정서·행동 통합프로그램과 비교하여 그 효과성을 검증하는 것이다. 비자살적 자해행동(Nonsuicidal Self-Injury; NSSI)은 자살 의도가 없이 신체를 직접적으로 훼손하는 행위를 의미하며, 베기, 긁기, 때리기 등 다양한 형태로 나타날 수 있다. 이는 주로 청소년 시기에 정서적 고통을 일시적으로 완화하기 위한 대처기제로 자행되는 데 이에 대한 적절한 중재가 요구되고 있다. 본 연구는 정서조절 및 대인관계 기술 향상에 유효한 방안으로 제시되는 변증법적 행동치료(DBT)에 주목하여 청소년기의 비자살적 자해행동을 억제, 완화 시키는 변증법적 행동치료(DBT)의 실제적인 효과를 평가하고자 변증법적 행동치료(DBT) 프로그램을 개발하고 그 유효성을 검증하였다.

본 연구의 대상은 G 광역시 소재 C 중학교 학생들로, 자해행동을 보이는 중학생으로서 대상 선별 기준은 첫째, C 중학교에서 실시한 정서·행동 특성 선별검사(AMPQ-II)에서 자해행동을 보고한 학생, 둘째, DSM-5의 진단 기준에 따라 NSSI를 시도한 청소년 중에서 고의로 1년 이상 5일 이상 자기 신체를 훼손한 사례와 자해기능평가지(SHI)에서 1년 이내 5회 이상 자해행동을 한 학생들을 대상으로 사전면담을 통해 최종 선정하였다. 선정된 학생들은 실험집단, 비교집단, 통제집단으로 각각 7명씩 임의 배정되었다.

본 연구의 프로그램 개발 과정은 다음과 같다. 첫째, 비자살적 자해행동의 심리적 기제와 위험 요인에 대한 문헌 고찰을 통해 NSSI의 다양한 기능과 그로 인한 정서적 고통을 분석하였다. 둘째, 변증법적 행동치료(DBT)의 네 가지 핵심 모듈인 마음챙김, 고통감내, 정서조절, 대인관계 효능감을 기반으로 예비 프로그램의 초안을 구성하였다. 셋째, 전문가 자문을 통해 이론적 타당성과 임상적 적절성을 검토하였다. 넷째, 예비 프로그램은 실험집단에 속한 중학생 3명을 대상으로 4회기에 걸쳐 진행하였으며 발견된 문제점을 수정함으로써 프로그램을 최적화하였다. 다섯째, 최종 프로그램은 총 10회기로 구성하였으며, 회기별로 구체적인 활동을 설정하였다. 마지막으로, 각 집단의 프로그램 효과성을 비교하여 변증법적 행동치료(DBT) 프로그램의 유효성을 확인할 수 있는 기초자료를 마련하였다.

본 연구는 SPSS 21.0을 사용하여 자료를 분석하였고 빈도분석을 통해 연구 대상자의 사회 인구학적 특성을 파악하였으며, Pearson 상관계수를 사용하여 평가 목록의 신뢰도를 검증하였다. Kruskal-Wallis 검정을 통해 집단 간 사전검사 점수 차이를 분석하고 Bonferroni correction을 적용하여 사후검사 점수를 비교하였다. Wilcoxon signed-rank test로 각 집단의 사전-사후 점수 차이를 확인하고, Mann-Whitney U 검정을 통해 추후 검사 차이를 분석하였다. 마지막으로 Friedman test를 실시하여 사전-사후-추후 검사 점수의 변화를 평가하였다. 효과 검증 결과, 본 연구에서 제시하

는 변증법적 행동치료(DBT) 집단기술훈련 프로그램은 비합리적 신념, 자기 비하, 정서조절 곤란, 우울 수준, 고통감내력 부족 등의 지표에서 사후 및 추후 검사 시 유의한 개선을 보였으며, 비교집단보다 효과가 지속적으로 유지됨이 확인되었다.

본 연구의 의의는 다음과 같다. 첫째, 중학생 NSSI에 특화된 치료 프로그램이 부족한 국내 현실에서 변증법적 행동치료(DBT) 기반 프로그램을 제안함으로써 임상적 공백을 메우고 효과적인 개입 모델을 제시하였다. 둘째, 변증법적 행동치료(DBT)의 핵심 원리를 청소년의 발달 수준에 맞춰 성공적으로 적용하여, NSSI 치료에 대한 근거 기반을 마련하였다. 셋째, 체계적 프로그램 개발 과정은 임상 실무자 및 교육 현장에 실질적인 지침을 제공하여, 상담사와 교사들이 효과적으로 중학생을 치료할 수 있는 대안적 중재 적용의 시사점을 제공하였다.

핵심어: 비자살적 자해행동 변증법적 행동치료(DBT), 집단기술훈련, 중학생, 비합리적 신념, 정서조절, 우울, 고통감내력, 분노조절

I. 서 론

1. 연구의 필요성 및 목적

비자살적 자해(NSSI, non-suicidal self-injury)는 자신의 생명을 끝내겠다는 강력하고 분명한 목적이 없는 상태에서, 직접적이고 고의적으로 신체 조직을 반복적으로 손상시키는 일련의 행동을 의미한다(윤다은, 엄연용, 송원영, 2025; 이다슬, 오성은, 신성만, 2021; Klonsky, 2007; Andrei et al., 2024). 비자살적 자해행동은 습관적으로 반복되는 특성으로 인해 개인이 느끼는 통증과 두려움에 둔감하게 되어(Ferrara et al., 2012), 자칫 실제 죽음으로 연결될 가능성을 내재하고 있는 심각한 문제행동이다. 비자살적 자해가 모두 자살 행동에 이르지 않지만, 가벼운 자해행동이 점진적으로 발전하여 자살 행동으로 이어질 수 있다는 측면과 더불어 정서적으로 불안정한 12~14세의 청소년기에 상대적으로 쉽게 시도될 수 있다는 점(박소연, 2021; Braga, & Gonçalves, 2014; Vieira et al., 2016)에서 현상의 이해와 실제에 대한 효과적인 개입이 매우 중요하다.

지금까지 청소년의 자해행동은 주로 경계선 성격장애, 우울장애, 외상 후 스트레스 장애, 또는 반사회성 성격장애 등과 관련이 있는 정신병리 증상의 결과(Briere & Gil, 1998; Gratz et al., 2015; Nock, 2009; Selby et al., 2012)로 해석하는 것이 일반적이었다. 하지만 최근에는 특별한 정신 병리적 문제가 없는 청소년 사이에서도 자해행동이 증가하고 있는데 실제로 전체 조사 대상 청소년 중 약 22.8%가 비자살적 자해 경험이 있는 것으로 확인되고 있다(안영신, 송현주, 2017).

청소년의 비자살적 자해행동이 심각한 이유는 이 시기 청소년은 자아 혼

란과 다양한 내·외부적 스트레스 증가, 급격한 생리적 변화 등으로 인해 정서적으로 매우 민감하다는 것이다. 특히, 중학생 시기는 아동기에서 청소년기로 넘어가는 전환기로서 감정제어의 어려움을 자해와 같은 충동적인 방식으로 해소(박소연, 2021; 양정하, 이미나, 2024)하고자 하는 경향이 강해지는 시기이다.

자해행동은 학업 스트레스와 역동적인 또래 관계, 그리고 고통스러운 기억이나 힘든 현실로부터 도피하려는 의도에서 이루어지는 행동이라는 특징이 있다(Klonsky & Muehlenkamp, 2011). 청소년기 중학생의 경우, 또래 집단을 통해 자신의 사회적 역할과 소속감을 느끼고 감정을 공유하며 강한 연대의식을 형성하지 못할 경우, 정서적 좌절과 스트레스에서 도피하려는 수단으로 자해행동을 하기도 한다. 청소년기 중학생은 또래 집단으로부터 소속감을 얻지 못하거나 친밀감이 충족되지 못할 경우, 우울이나 불안과 같은 정서장애를 경험(Rubin et al., 1990; Sutton, 2007)하며 이는 예측하기 어려운 부정적 시도로 연결될 수 있다.

우리나라의 현재 비자살적 자해행동 실태를 살펴보면, 전국 236개 청소년 상담복지센터의 청소년 자해 관련 상담 건수는 2017년 8,352건, 2018년 27,976건, 2019년 39,406건, 2020년 32,458건으로 2017년 대비 2020년 상담 지원 실적이 약 4배 증가한 것으로 나타났다(한국 청소년 상담복지개발원, 2021). 최근 3년 자해 관련 사유별 위원회개최 건 비율은 2023년의 경우, 2022년에 비해 8배에 달하고 있으며¹⁾ 청소년 사이버 상담센터 온라인 자해 상담실적에서도 2020년 1분기 744건에서 2021년 1,055건으로 41.8%로 급증하였다(청소년 상담복지개발원, 2021).

자해 청소년은 자해로 생긴 상처를 타인에게 감추려는 특성이 있으며(Nock, 2010), 부모와 함께 상담받는 것을 꺼려 솔직하게 응답하지 않으려

1) 강경숙 국회의원실 보도자료, '좋은교사운동', 2024.10.20.

는 경향이 있다는 경험적 사실을 고려한다면 드러나지 않은 자해 청소년의 실제 수치는 이보다 많을 것으로 추정된다. 앞서 기술한 바와 같이, 청소년의 자해는 매년 심각해지는 상황으로 특히, 자해 시도를 경험한 청소년의 60%가 반복적으로 자해할 가능성이 높다는 점에서 학술적, 실천적 관심이 필요(허영민, 2023; 조순아, 2021)한 이유이다.

지금까지, 자해 연구는 성격장애 또는 외상 후 스트레스 장애 등을 가진 청소년을 대상으로 하는 연구가 대부분이었으나(Briere & Gil, 1998; Gratz et al., 2015; Nock et al., 2006; Selby et al., 2012), 최근 자해를 겪는 일반 청소년에 관한 관심이 증가하면서 이들을 대상으로 한 연구가 증가하고 있다. 비자살적 자해와 관련한 연구는 지금까지 국외를 중심으로 이루어져 왔으나, 최근 우리나라도 청소년 자해 관련 연구(박소연, 2021; 양정하, 이미나, 2024; 김형수, 이주영, 2021; 윤다은, 엄연용, 송원영, 2025; 이다슬, 오성은, 신성만, 2021)가 다양한 패러다임에 근거하여 비교적 활발하게 수행되고 있다. 하지만 대부분 정량적, 정성적 관점에서 설정된 변인 간의 인과성을 밝히는 데 주력하고 있기 때문에 청소년 비자살적 자해행동을 실질적으로 개선하는데 요구되는 실효적 중재 담론은 상대적으로 부족한 것으로 판단된다. 예컨대, 청소년 상담복지개발원에서는 자살·자해 위기 청소년 상담 매뉴얼(서미 외, 2018)을 개발하고, 고위기 청소년(정신건강 영역 중 자살, 자해) 대상 사후관리 시스템 구축과 ‘집중 심리 클리닉’ 운영 등 당면한 문제에 대한 대책을 강구하고 있으나 여전히 이론적 방법론과 실천의 관점에서 충분하지 않다는 지적이 있다(이귀숙, 장은희, 김은영, 2016; 박석원 외, 2020).

이와 관련하여 변증법적 행동치료(Dialectical Behavior Therapy, DBT)가 다양한 국·내외 실증연구(김동일 외, 2024; 이종국 외, 2023; Linehan et al., 2015; Kenny et al., 2020)를 통해 청소년의 충동적 행위를 제어하거

나 완화하는데 장·단기적 실효성이 입증되면서 관심을 받고 있다. 관련 논의(김동일 외, 2024; 이종국 외, 2023; Buerger et al., 2019; Donaldson et al., 2005; Pereplechikova et al., 2011)에 따르면, 제3세대 인지행동 치료의 변증법적 행동치료는 반복된 비자살적 자해행동을 감소시키기 위하여 자기 감찰을 통해 감정을 통찰하고, 마음챙김 훈련을 통하여 자신의 갈등을 수용하여 있는 그대로의 자신을 바라볼 수 있게 함으로써 내담자로 하여금 자신의 문제를 수용하도록 돕는다. 또한, 대인관계 행동치료, 이완 훈련, 정서조절, 인지재구성을 통하여 자해 충동이 올라올 때 자신이 자해 충동을 느끼고 있음을 알아차리고 충동적인 감정과 고통을 감내하게 함으로써 자해행동을 지속하지 않도록 돕는 것으로 알려져 있다.

정서조절의 실패가 반복적으로 나타나게 될 경우, 부정적인 정서가 해소되지 못한 채 악화하여 개인의 사회적, 직업적 기능에 방해가 된다(Ehring, et al., 2008). 중학생의 경우 빈번한 감정 기복과 이로 인한 심리적 문제를 경험하게 되면 원만한 또래 관계를 형성하기 어려울 뿐만 아니라 학습 집중도를 떨어뜨려 전반적인 학교생활에 어려움을 초래할 수 있다(박보미, 2021; 신주영, 2018; 이성직, 2017). 이러한 문제를 해결하기 위해 정서 조절 능력을 향상하고, 건강한 대처 전략을 개발하는 것이 중요하다(이지영, 권석만, 2006)는 관점에서 변증법적 행동치료(DBT)는 실효적 대안의 가능성을 가지고 있다. 개인의 감정은 인지적인 방식만으로 통제할 수 없기 때문에 감정적 자기수용이라는 맥락에서 정서조절 기술을 배우고 익힐 수 있는 인지적 변화보다는 행동치료에 비중을 두는 변증법적 행동치료(DBT)가 효과적일 수 있다는 것이다. 하지만, 앞서 기술한 바와 같이 청소년기 중학생을 대상으로 변증법적 행동치료(DBT)를 기반으로 하는 중재 프로그램을 구안하고 이를 실제 비자살적 자해행동 경험자에게 적용하여 효과를 검증한 논의는 매우 제한적이기 때문에 이에 대한 요구가 제기된다.

따라서 본 연구는 변증법적 행동치료(DBT)의 기본 가정과 이론에 근거하여 중학생 비자살적 자해행동 개선을 위한 프로그램을 개발하고 그 효과를 검증함으로써 시사점을 도출하는 것을 목적으로 한다. 본 연구의 결과는 일선 교육 및 상담 기관에서 적용할 수 있는 실효적 중재 프로그램을 제시함으로써 중학생 비자살적 자해행동 예방 및 감소에 기여할 수 있을 뿐만 아니라 관련 논의의 경험적 자료를 제공한다는 측면에서도 의미가 있다.

2. 연구 문제

본 연구의 목적을 달성하기 위해서 설정한 연구 문제는 다음과 같다.

[연구 문제 1]

중학생의 비자살적 자해행동 감소를 위한 변증법적 행동치료(DBT) 집단 기술훈련 프로그램의 구성요소와 내용은 무엇인가?

[연구 문제 2]

변증법적 행동치료(DBT) 집단기술훈련 프로그램이 중학생의 비자살적 자해행동에 미치는 효과는 어떠한가?

2-1. 중학생 자해행동과 관련된 인지적 변인 중 비합리적 신념에 미치는 효과는 어떠한가?

2-2. 중학생 자해행동과 관련된 정서적 변인 중 정서조절, 우울함에 미치는 효과는 어떠한가?

2-3. 중학생 자해행동과 관련된 행동적 변인 중 고통감내력 부족, 자해행동에 미치는 효과는 어떠한가?

3. 용어의 정의

본 연구에서 사용되는 용어의 정의는 다음과 같다.

1) 비자살적 자해

비자살적 자해(Non-suicidal self-injury, NSSI)란 자살 의도 없이 자기 신체를 고의로 훼손하는 행동으로(Nock et al., 2009) 정의된다. 이러한 행동은 개인이 고통을 줄이거나 자기 처벌, 혹은 타인에게 도움을 요청하기 위한 행위로서 정신장애의 진단 및 통계 편람(DSM-5)에서는 자해를 "자살 의도가 없는 자해"로 분류하며, 1년 동안 5일 이상 반복적으로 나타나는 경우를 말한다. 따라서 본 연구에서는 비자살적 자해(Non-suicidal Self Injury)를 '죽고자 하는 의도 없이, 직접적이고, 고의적으로 신체를 훼손하는 행위'(Bresin & Gordon, 2013; Nock, 2009; Nock & Prinstein, 2004)로 보고, 자해 동기를 제외한 빈도의 유무를 나타내는 자해행동과 동일한 의미로 정의한다.

2) 변증법적 행동치료(DBT)

변증법적 행동치료(Dialectical Behavior Therapy: DBT)는 Linehan(1987, 1993)이 경계선 성격장애의 치료를 위해 개발한 행동치료 프로그램이다. 본 연구는 변증법적 행동치료(DBT)의 4가지 구성인 마음챙김 기술(mindfulness), 정서조절 기술(emotion regulation skills), 고통감내력 기술(distress tolerance skills,) 대인관계 효율성 기술(interpersonal effectiveness skills)로 구성된 중재 기법으로 정의한다.

3) 비합리적인 신념

비합리적 신념(irrational belief)은 합리적 신념에 비해 논리적으로 여러 가지 모순점들이 많고 경험적 현실과 맞지 않으며, 삶의 목표 달성에 걸림돌이 될 수밖에 없는 신념이다. 즉 아무런 근거도 없으면서 건전한 인간 행동을 지속하는데 지장을 일으키는 비실제적이고 비윤리적인 사고나 신념을 말한다(Ellis, 1962). 본 연구에서는 Lindner 등(1999)이 제시한 비합리적 신념으로 자기비하, 성취/편안한 욕구, 승인/공평한 욕구로 정의하였다.

4) 정서조절

일반적으로 정서조절(emotional regulation)은 Gratz와 Roemer(2004)에 따라, 정서를 인식하고 수용하는 능력으로 정의된다. 이는 충동적 행동을 통제하고, 원하는 목표에 맞춰 행동하게 하며, 개인의 목표와 상황적 욕구를 충족시키기 위해 적절한 정서조절 전략을 유연하게 사용하는 능력을 포함한다. 따라서 본 연구에서는 정서조절을 정서조절 및 정서조절 곤란의 수준을 모두 포함하는 의미로 정의하였다(Gratz & Roemer, 2004).

5) 우울

우울(depression)은 슬픔, 외로움, 죄의식, 무가치감 등 다양한 정서적 증상과 사고력 저하, 불면증, 식욕 감소 등의 생리적 증상을 포함한다. 이는 자해 및 자살 생각과 밀접하게 관련되어 있다. 본 연구에서는 우울을 외로움, 슬픔, 근심, 걱정, 예민함, 짜증, 공허감, 무력감 등 부정적인 상태로 정의하였다.

6) 고통감내력

고통감내력은 넓은 의미에서 주관적으로 혐오적이거나 위협적인 상태를 견디는 능력이라고 정의할 수 있으며(Bernstein et al., 2011), 정서 또는 신체적인 고통을 경험하고 견디는 능력(Brown et al., 2005)인 동시에 상황이나 정서적 불편감을 경험하는 가운데서도 목적 지향적인 행동을 할 수 있는 경향성으로 정의된다(Simons & Gaher, 2005).

본 연구에서는 고통감내력을 ‘청소년이 정서적 또는 신체적 고통에 대해 기꺼이 경험하고 견뎌낼 수 있는 개인의 능력’으로 정의하였다.

Ⅱ. 이론적 배경

1. 중학생의 비자살적 자해행동

1) 비자살적 자해행동의 개념 및 진단 기준

(1) 개념

비자살적 자해행동의 개념에 대해서는 2011년 DSM 5(DSM-5; American Psychiatric Association, 2013)에서 자해를 비자살적 자해로 등재함에 따라 2013년도 이후로는 이와 관련된 연구가 비교적 활발하게 진행되었다. 국내 외적으로 ‘Self-Injury’(자해)라는 용어를 키워드로 발표된 연구들 가운데 본격적으로 비자살적 자해 논의가 시작된 것은 검사 도구의 번안 및 타당화가 이루어진 시기의 2013년 이후부터인 것으로 파악된다(성나경, 강이영, 2016).

정신장애 진단 및 통계 편람 DSM-5(2013)에 따르면, 비자살적 자해(NSSI: non-suicidal self-injury)는 죽고자 하는 의도가 없이 자기 신체를 고의로 훼손하는 행동으로 정의된다(방선경, 2024; 안영신, 손현주, 2017; Andrei et al., 2024). 비자살적 자해는 자살시도와 매우 근접한 개념이기는 하지만, 자살 행동 장애와 비자살적 자해행동 장애를 구분하는 중요한 기준 중 하나는 ‘죽고자 하는 의도’가 있다(Nagy, Shanahan, & Seaford, 2022). 즉, 자살이 죽을 의도를 내포한 행동이라면, 비자살적 자해는 죽을 의도를 내포하지 않은 행동이며, 비자살적 자해행동은 직접적이고 즉각적으로 신체 조직에 해를 가하는 것을 의미한다는 것이다.

DSM-5에서 자살 의도가 없는 자해를 추가 연구가 필요한 진단적 상태로 분류하였는데, 아직은 임상적 진단명으로서는 불충분하지만 적어도 자해에

대한 진단과 치료 및 추후 연구에 관한 관심과 필요성을 반영하는 것이라고 할 수 있다. 비자살적 자해는 신체 조직의 손상과 긴장 완화를 목적으로 자신의 신체에 의도적으로 반복적인 행위를 가하는 행위로서 넓은 의미에서 자해는 자살을 시도하고자 하는 목적은 없지만, 의도적이고 지속적이며 무모하게 스스로 상처를 입히는 행위로 해석할 수 있다. 다시말해, 비자살적 자해행동의 가장 큰 심각성은 반복성에 있다는 것이다.

한편, 자해행동은 개인의 신체, 심리적 우울 면에서 모두 문제를 일으킨다. 개인은 일시적인 안정감을 위하여 자해를 선택하게 되지만, 자해행동 이후 자신의 행동에 대한 죄책감과 상처를 숨기는 행동을 통해 수치심을 감추기도 한다(Wilkinson et al., 2011). 자해행동은 자신의 몸에 다양한 흉터를 남기는 결과로 이어지기도 하는데 중학생의 경우, 이러한 흉터는 또래 관계에 부정적으로 작용하거나 경우에 따라서는 따돌림의 원인이 되기도 한다.

Leith & Baumeister(1996)에 따르면, 비자살적 자해행위와 관련하여 파괴적 행동(self-destructive behavior)은 장기적으로는 유기체에 해가 되며, 단기적이고 순간적인 만족을 얻기 위해 이루어지는 행동이다. 이러한 자기 파괴적 행동은 크게 간접적인 행동과 직접적인 행동으로 구분된다. 간접적인 행동은 자신의 신체에 해를 입히는 대표적인 방법에는 오랜 기간 단식을 하거나, 기타 물질 및 알코올을 사용하는 것 등이 있다. 직접적인 행동은 자기 파괴적 행동으로는 자신을 때리거나 날카로운 도구 등을 이용하여 손목을 긋거나 신체 부위에 직접적인 위험과 재해를 가하는 등의 행동들을 말한다.

이동귀 외(2016)는 자살과 자해를 구분하는 연구를 통해 각각의 특성을 이해하고, 그 바탕으로 적절한 치료 및 예방적 개입에 대한 필요성과 중요성을 제안하였다. 또한, 자살과 자해는 개인이 심리적 고통으로부터 도피하

기 위한 의도적인 행위라는 점에서 공통 분모를 가지고는 있지만, 그 외에 원인, 목적, 방법, 치사율, 발병 연령 등의 특성에 있어 차이가 있다. 이에 비자살적 자해는 죽고자 하는 의도 없이 스스로 자신의 신체 부위를 직접적이고 고의적으로 손상시키는 행위로서 구체적으로는 스스로 자신의 신체를 칼로 긁기, 베기, 때리기, 화상 입히기, 머리카락 뽑기 등의 훼손 행동으로 정의된다(Nock, 2009).

이러한 행동을 과거에는 자상(self-mutilation)으로 칭하였으나, 1990년대 중반부터는 일반적으로 비자살적 자해(non-suicidal self-injury: NSSI) 또는 자해(self-injury)로 명명하고 있다. 또한 여러 연구에서도 자해에 대하여 Self-injury(자기 손상), Self-harm(자해), Cutting(자르기), Self-mutilation(자기 절단), Para-suicide(자살극을 벌이는 사람) 등 다양한 용어를 사용하고 있다(Cipriano et al. 2017; Turner et al., 2014). 반면, 비자살적 자해행동에 대해서 미국정신의학회(American Psychiatric Association)가 출간한 정신질환 진단 및 통계 편람 제5판(DSM-5)에서 자살 의도가 없는 자해(Non-Suicidal Self Injury)로 통일하면서 자살 행동 장애(Suicidal Behavior Disorder)와 명확하게 구분되는 개념으로 이해되고 있다(APA, 2017; Nock, 2010).

한편, DSM-5에 등재되어 있지는 않지만, 일부 연구에서는 자해를 비자살적 자해와 자살적 자해로 구분하고 있으며, 여기서 자살적 자해는 자살 시도와 같은 맥락이다. 자해행동에 속하면서 고의적 자해로 이해되는 자살과는 달리 비자살적 자해는 치사율이 높지 않은 다수의 방법을 사용하는 만성적인 행동이라고 할 수 있다. 이에 본 연구에서는 자해를 비자살적 자해와 자살적 자해인 자살 시도로 구분하기로 한다. 이 두 개념의 특성을 구체적으로 비교하여 살펴보면 <표Ⅱ-1>과 같다.

<표 II -1> 비자살적 자해와 자살의 차이

특성		비자살적 자해	자살 시도
의도/ 행동의 목적		· 심리적 고통으로부터 일시적 도피	· 영구적으로 의식 단절/ 삶을 끝냄
		· 자기/상황의 변화 추구	· 참을 수 없는 심리적 고통에서 벗어남
방법의 치명성/심각성		· 낮음	· 높음
행동 빈도		· 높음(때론 100회 이상) · 반복적, 만성적	· 낮음(일반적으로 1~3회)
시도된 방법		· 다양한 방법	· 단일한 방법
인지적 상태		· 고통스러우나 희망은 있음 · 적응적 문제해결이 어려움	· 희망 없음, 무기력함 · 문제해결이 불가능
결과/ 영향	개인적	· 안도감, 진정 · 일시적 고통의 감소	· 좌절, 실망감 · 고통의 증가
	대인 관계적	· 타인의 비난, 거절	· 타인의 돌봄, 관심

출처: Hasking, & Boyes, 2018, Muehlenkamp & Kerr(2010).

위의 <표 II -1>에서 제시한 바와 같이 비자살적 자해와 자살 시도의 분류를 살펴보면, 비자살적 자해 특성의 의도와 행동 목적은 심리적 고통으로부터 일시적인 도피와 자신에게 주어진 어려운 문제의 상황에서의 변화를 추구함에 있다. 비자살적 자해행동은 다양한 방법으로 자기 신체에 상해를 입히는 것이고, 그 빈도는 반복적이고 만성적이다. 반면, 자살 시도 특성의 의도와 행동의 목적으로는, 영구적으로 의식을 단절하고 삶을 끝내려는 극단적이며 참을 수 없는 심리적 고통에서 벗어나고자 하는 것이다. 자살 시도는 치명성이 높다. 자살 시도 행동의 빈도는 단일한 방법으로 인지적 상태는 삶에 희망이 없으며 무기력하다.

이처럼, 직접적으로 스스로에게 해를 끼치는 자해행동(Self-Injury)에서 자살적 현상(suicidal)과 구분은 죽음에 대한 의도 여부에 상관된다(Nock, 2010). 비자살적 자해행동을 약화 된 자살 행동으로 보는 관점에서는 비자살적 자해행동의 극단적인 형태를 자살로 판단(Stanley et al., 2001)하며

실제로 많은 연구가 자해행동과 자살 시도가 뚜렷한 연관성이 있음을 보고하고 있다(Joiner, 2005; Glenn & Klonsky, 2009; Ribeiro et al., 2016).

한편, 개인의 자해행동은 다양한 발생 동기가 있으며, 특히 정서 완화를 목적으로 행해진다는 점을 고려할 때, 자해행동을 반드시 자살 의도를 가진 충동적인 행동으로 간주할 수 없다는 견해도 있다(Hooley, Fox, & Boccagno, 2020; Fox & Hawton, 2004). 죽음에 대한 의도를 기준으로 하기에 모호한 경우가 많고, 죽을 의도가 애매하거나 과장되어 자해행동에서 자살 의도를 구별하는 것이 어려우며(이동훈 외, 2010), 자해행동을 쉽게 자살 시도로 오해하여 부적절한 개입이 이루어질 수 있기 때문이다.

주변 사람들의 반응과 도움을 구하려는 의지나 자신의 행동에 대한 폐쇄 의도에 영향을 주므로, 정신건강 전문가들은 비난적 아닌 비판적인 태도로 비자살적 자해행동을 하는 청소년들의 경험을 민감하게 듣는 태도가 필요하다(Hooley et al., 2020). 예컨대 자해행동이 긴장을 완화하는 데 효과적인 수단이 되며, 이 행동이 강화되면 비슷한 감정을 경험할 때 다시 자해할 가능성이 높아진다(Spandler, 1996). 이 점에서 자해는 청소년들이 경험하는 부정적인 정서와 밀접한 관련성이 있으며, 해소되지 못한 고통스러운 감정이 부적응 행동인 자해로 나타날 수 있다(이동훈, 2019).

(2) 진단 기준

비자살적 자해에 관한 개념과 진단 기준은 정확하게 제시되지 못하다가, 2013년 발간된 DSM-5를 통해 등재 및 정의되었다. 이를 구체적으로 살펴보면 다음과 같다. 비자살적 자해는 지난 1년간, 5일 또는 그 이상, 신체 표면에 고의적으로 출혈, 상처 고통을 유발하는 행동을 스스로에게 가하는 것으로 정의된다(Hooley et al., 2020; Cipriano, et al., 2017). 이러한 진단 기준에는 자해의 정도로 판단하는 것을 넘어 자살 의도가 없는 그것도 포함하고 있다. 특히, 자살 의도가 없고 반복적 자해행동이 죽음에 이르지 않

을 것을 스스로 이미 알고 있거나 도중에라도 알고 있음을 의미한다. 비자살적 자해의 원인은 안도감을 얻기 위해서이거나 대인관계의 어려움을 해결하기 위해서, 그리고 긍정적 기분 상태를 유도하기 위한 것이다.

비자살적 자해의 원인은 우울, 불안, 긴장, 분노, 일반화된 고통, 자기비하 등과 같은 대인관계의 어려움 등이 주요하며, 자해행위를 하지 않는 시점에도 자살에 대한 빈번한 생각을 이어 나가는 특징을 보인다. 비자살적 자해를 통해 기대하는 결과는 대인관계나 학업 등에서 현저한 고통이나 방해를 초래하는 것이다. 이와 관련하여 Kahan과 Pattison(1984), 이동훈 외, 2010 등은 자해행동의 반복성을 강조하였으며 이들은 자기 훼손(self-mutilation)과 자해를 비교하면서, 자기 훼손의 경우 직접적이고 치사성이 낮아 자살 의도가 없다는 점에서 자해와 비슷하지만 반복적이지 않다는 점에서는 자해와 다르다는 점을 명확히 하였다.

자해행동과 자살 행동 간의 관련성과 범주를 구분하는 것에 대한 논의는 계속해서 활발하게 이루어지고 있었는데 Lloyd 외(2007)는 자해를 자살로 이행되는 연속 과정으로 보는 태도와, 자해를 하나의 독자적인 임상적 증후로 보고 자해행동과 자살 행동을 구분할 필요가 있다는 견해를 제시하였다. 즉, 자해행동을 자살 의도의 동반 유무에 따라 자살적 자해와 비자살적 자해로 구분해야 한다고 하였다. 비자살적 자해를 판단하기 위해 DSM-5(APA, 2013)가 제시한 진단 기준은 <표Ⅱ-2>와 같다.

<표 II -2> DSM-5의 비자살적 자해 진단 기준²⁾

- A. 지난 1년간, 5일 또는 그 이상, 신체 표면에 고의적으로 출혈, 상처 고통을 유발하는 행동(예: 칼로 긁기, 불로 지지기, 과도하게 문지르기)을 자신에게 스스로 가한다. 이는 단지 경도 또는 중등도의 신체적 손상을 유발할 수 있는 자해 행동을 하려는 의도에 의한 것이다(즉, 자살 의도가 없음).
- ※주의점: 자살 의도가 없다는 것이 개인에 의해 보고된 적이 있거나 반복적인 자해행동이 죽음에 이르지 않을 것이라는 점을 개인이 이미 알고 있었거나 도중에 알게 된다고 추정된다.
- B. 개인의 기대하에 다음 중 하나, 그 이상의 자해행동을 시도한다.
1. 부정적인 느낌 또는 인지 상태에서부터 안도감을 얻기 위해서
 2. 대인관계 어려움을 해결하기 위해서
 3. 긍정적인 기분 상태를 유도하기 위해서
- ※주의점: 개인은 원했던 반응이나 안도감을 자해행동 직후에 경험하며, 반복적 자해행동에 대한 의존성을 시사하는 행동 양상을 보일 수 있다.
- C. 다음 중 최소한 한 가지와 연관된 고의적인 자해행동을 시도한다.
1. 우울, 불안, 긴장, 분노, 일반화된 고통, 자기비하와 같은 대인관계의 어려움, 부정적 느낌, 생각이 자해행위 바로 직전에 일어남.
 2. 자해행위에 앞서, 의도한 행동에 몰두하며, 통제하기 어려움.
 3. 자해행위를 하지 않을 때도 자해에 관한 생각이 빈번함.
- D. 행동은 사회적으로 용인되는 것(예: 신체 피어싱, 문신, 종교적, 문화적 의례)이며 딱지를 뜯고, 손톱을 물어뜯는 등 제한이 안 됨.
- E. 행동 또는 그 결과는 대인관계, 학업 또는 다른 중요한 기능 영역에서 임상적으로 현저한 고통이나 방해를 초래한다.

2) 중학생의 비자살적 자해행동 실태

자해행동을 처음 시도하는 시기는 일반적으로 약 12.43세로 초등학교 6

2) American Psychiatric Association(disorderlinessstic and statistical manual of mental disorders(5th ed). Washington, DC: American Psychiatric Association. p. 886.

학년과 중학교 1학년 사이로 보고(Kims et al., 2018; Nock, 2010)있지만, 청소년 도입기와 성인 도입기에서도 많이 발생하는 것으로 파악되고 있다(김수진, 2016; Klonsky & Muehlenkamp, 2007). 비자살적 자해행동 내용과 관련된 권혁진, 권석만(2017)의 조사 내용을 살펴보면, 8.8%의 청소년이 비자살적 자해를 경험하였으며, 남자 청소년은 8.0%, 여자 청소년은 9.7%로 남자 청소년보다 여자 청소년의 자해 경험이 더 많은 것으로 나타났다. 자해 경험이 있는 사람 중에서 평균 자해 빈도는 7.2회로 나타났으며, 남자는 6.6회, 여자는 7.7회로 남자보다 여자의 평균 자해 빈도가 더 높은 것으로 나타났다. 아울러 자해 시도 후 심리적 상태에 대해서는 ‘아무 느낌이 없었다’라고 응답하거나 ‘누군가가 자신의 마음 알아주기를 바랐다’가 각각 25.7%와 25.1%로 확인되었다.

나이에 따른 비자살적 자해행동 발생을 살펴보면, 임상 집단의 경우에는 성인의 21%, 청소년이나 대학생은 30~40%(Briere & Gil, 1998; Darche, 1990; Jacobson & Gould, 2007). 비임상 집단에서는 성인의 4~6%(Briere & Gil, 1998; Klonsky et al., 2003), 청소년의 14~21%(Heath et al., 2008; Ross & Heath, 2002), 대학생의 17~38%(Gratz et al., 2002; Whitlock et al., 2006)가 비자살적 자해를 하는 것으로 보고되고 있다. 비자살적 자해는 도입 청소년기에 시작하여 성인 도입 후기에 걸쳐서 점차 감소하는 경향이 있지만, 비자살적 자해를 하는 13~18세 청소년의 80%가 5~10년 후인 성인 도입까지 자해행동을 지속한다는 보고(Ye, Song, Hong, Lee, & Yook, 2012)가 있기 때문에 초기 시도자에 대한 지속적인 관심이 필요하다.

국가별 유병률을 살펴보면, 미국의 경우 십 대 청소년의 14~15%가 최소한 1번 이상 비자살적 자해 경험이 있고(Ross & Heath, 2002), 영국도 15~16세 청소년 6,020명을 대상으로 한 연구에서 대략 10% 정도가 자해

경험이 있는 것으로 보고되어(Hawton et al., 2002). 아시아권 나라 중 대만은 고등학생의 11.3%(Tsai et al., 2011), 중국은 12~24세 청소년의 17%가 비자살적 자해를 경험한 것으로 나타났다. 우리나라에는 여중생을 대상으로 한 연구에서 20.9%(이동귀 외, 2016), 일반 중학생(1~3학년) 대상으로 한 연구에서는 31.1%(배수현, 2019), 일반 중학교 3학년 대상 연구에서는 41%(김수진, 2019)의 유병률을 보였다. 또한, 인문계 중·고등학생과 법무부 산하 비행 청소년 교육센터의 중·고등학생 대상으로 한 연구에서 22.8%(안영신 외, 2017), 인문계 중·고등학생을 대상으로 한 김화정·송현주(2019)의 연구에서는 24%, 특성화고등학교 남고생을 대상으로 한 연구에서는 21.2%(박문숙 외, 2020), 대학생들을 대상으로 한 연구에서는 45.3%(권혁진 외, 2017)가 한 번 이상의 자해 경험이 있는 것으로 조사되었다.

기존 선행연구에서 보여주듯 비자살적 자해는 조사 대상이나 조사 시점, 조사 지역, 조사 주체에 따라서 다소 상이하게 보고되고 있어 정확한 실제 유병률을 파악하는 것은 어려울 수 있다. 이는 자해 청소년들의 특성상 자기 노출 회피 경향성으로 대부분 자해를 은밀하게 시도하고, 자해로 생긴 상처를 타인에게 감추려 하며, 치료받으려고 하는 경우가 드물기 때문이다(Nock, 2010).

이러한 연구 결과들을 고려해 볼 때, 비자살적 자해가 일회적이고 일시적인 행위가 아닌 반복적이고 지속 가능한 행위로 연결될 수 있으므로 자해 행동이 발생하는 시기와 영향을 미치는 요인에 대해 주목해 볼 필요가 있다. 특히, 비자살적 자해 경험이 있는 청소년 중 70%는 실제 자살 시도 경험이 있다고 보고되었고(Nock & Kessler, 2006), 자살적 자해를 시도한 사람의 40~60%는 비자살적 자해 경험을 가지고 있다고 조사되었다(Hawton et al., 2003). 다시 말해, 비자살적 자해는 자살적 자해의 중요한 예측 요인으로 간주할 수 있다는 것이다(Guan, Fox, & Prinstein, 2012).

관련된 국내 연구에서도 비자살적 자해를 경험한 도입 청소년의 32%가 자살 의도가 있었다고 보고한 바 있다(이동귀 외, 2016). 또한 비자살적 자해를 경험한 중학생의 자살의도 유무에 따른 집단 간 차이에서 자살적 자해 의도가 있는 집단이 그렇지 않은 집단보다 자해행동 경험 수준이 유의하게 높게 나타남이 확인됨으로 비자살적 자해는 자살적 자해와 높은 위험 관련성이 있음을 시사하고 있다(이영희, 2020).

3) 비자살적 자해행동 청소년의 심리적 특성

청소년 시기에 경험하게 되는 학업 및 진로에 대한 과중한 부담감이나 경쟁 등으로 인해 중학생의 비자살적 자해행동은 최근 주목받는 연구 주제로 일부 다루어지고 있지만 그동안 이루어진 연구는 비교적 미흡한 상황이다. 지금까지 이루어진 비자살적 자해행동 청소년의 심리적 특성을 다룬 선행연구를 살펴보면 다음과 같다.

Wilkinson et al(2011)는 주로 청소년들의 자해행동은 부정적인 생각할 때 비합리적인 사고 확장으로 이어져 외로움과 우울감 등의 부정적이고 불쾌한 감정들이 자기조절 과정을 방해함으로써, 정서적 안정감을 찾기 위한 행동이라고 주장하였다.

유사한 맥락으로 Bunclark & Crowe(2000)은 자신의 감정을 언어로 표현하지 못할 때 자해행동을 보이며 청소년들이 심리적인 스트레스나 고통을 말로 표현할 수 없거나, 감정적 고통을 완화하기 위해 비자살적 자해행동을 통한 통증과 피는 보는 것을 추구한다고 하였다. 한편, Swannell et al(2014) 등은 비임상 군 청소년을 대상으로 비자살적 자해에 영향을 미치는 전반적인 요인을 밝혀냈는데, 사회 인구통계학적 변인 중에서는 여성이, 환경적 요인으로는 신체적 및 성적 학대 경험이나 또래로부터의 폭력 경험, 그리고 정서적으로는 우울 증상이 있는 경우에 강한 영향을 미친다는 것을

확인하였다. 즉, 대인관계로 인한 갈등 및 애착 문제가 비자살적 자해에 영향을 주는 주요 요인이라는 것을 직·간접적으로 명시한 것이다.

국내 연구에서는 신민섭 외(1990)의 연구가 청소년의 비자살적 자해에 대한 심리적 특성을 확인한 초기 연구라고 할 수 있는데, 이 연구에서는 변화가 많은 청소년기는 정서적으로 불안정하고, 스트레스에 대한 대응능력이 급격히 붕괴하여 취약하며 인지적으로도 미성숙하여 갈등이나 스트레스로 인한 충동적인 위험 행동을 보일 확률이 높음을 밝혀냈다. 조은지(2018)는 외로움과 비자살적 자해의 관계를 탐색하기 위해 청소년 315명을 대상으로 양적연구를 실시 한 결과를 통해 외로움을 많이 느끼는 청소년일수록 자해 행동을 반복적으로 행한다는 현상을 논의하였다.

임경문 외(2020)는 중·고등학생을 대상으로 한 연구에서 일반 청소년의 자해 원인으로 정서조절 곤란이 가장 많고, 자기 비하와 양육 환경이 영향을 미친다고 하였다. 이는 정서적 변화가 심하고 자제력을 상실하기 쉬운 청소년기에 정신적 고통을 겪거나 감정표현의 어려움을 겪는 청소년들이 감정의 해소를 위한 대안으로 자해를 선택한다는 것을 확인하였다. 즉, 비자살적 자해는 불안, 우울, 스트레스, 정서적 무감각, 실패감 및 자기 혐오감 같은 격렬한 감정들을 일시적으로 경감시키는 작용을 한다는 것이다 (Ross & Heath, 2003). 이는 자해가 격렬한 감정을 견디기 어려울 때 안정감을 가져다주고, 마음의 평정심을 회복하고자 할 때 의지하는 정서조절 도구로 기능한다는 것을 시사하는 것이다.

송지숙, 구본용(2023)은 청소년의 유년기 무효화 환경이 비자살적 자해에 미치는 영향 간에 고통감내력 부족과 비자살적 자해 결과 기대의 이중 매개효과를 확인한 결과, 고통감내력 부족과 비자살적 자해 결과 기대가 비자살적 자해를 증가시키는 역할을 하는 것을 확인하였고, 이를 근거로 청소년 비자살적 자해의 예방을 위한 방안을 제시하였다. 이러한 현상은 청소년들

이 반복적 자해 시도를 통해 통각에 익숙해지고 무뎌지게 되면, 점점 더 날카로운 도구와 다양한 방법을 찾게 된다는 것을 의미한다. 이러한 행위는 상처 부위에 감염이 발생할 수 있으며, 반복적이며 만성적인 자해는 비록 자살 의도가 없더라도 상처나 통증에 대해 둔감해지고 무감각해지게 만들어 심하게는 자살에까지 이를 수 있다.

Giletta et al.(2012), Gandhi et al(2018)의 연구는 청소년들이 경험하는 외로움 중, 특히 학업에 대한 스트레스를 많이 경험할수록 자해를 더 많이 하게 됨을 확인하였다. 이처럼 비자살적 자해와 관련한 국내외 선행연구를 통해 자해행동에 대한 다각적인 정의와 그에 따른 개념의 발전을 확인할 수 있다. 특히 자해와 관련한 다양한 변인들이 청소년들이 지니는 특성과 연관되어 부적응 행동으로 작용하고 있음을 이해할 수 있다.

이처럼 비자살적 자해행동의 다양한 동기 중에서 정서조절 기능에 문제가 생기는 것을 원인으로 지적하는 관련 논의가 다수의 연구에서 확인되고 있다.

<표 II -3> 청소년 비자살적 자해행동 심리 특성

심리적 특성 범주	세부 내용
감정조절의 어려움	- 부정적 감정(슬픔, 분노, 불안 등) 조절 능력 결여 - 감정조절 훈련 시 자해 빈도 감소
충동성	- 즉각적 자극에 대한 충동적 반응으로 자해 행동 시도 - 감정조절 어려움과 상호작용
낮은 자존감 및 자기 비난	- 자기 비하, 낮은 자기 가치감 - 자기비난과 수치심 및 자기 처벌 신념
대인관계 문제	- 가족, 또래 등과의 부적응적 관계 - 사회적 지지 부족, 가족기능 저하
높은 스트레스 취약성	- 환경적·일상적 스트레스에 민감 - 일시적 스트레스 증가 시 자해 위험 상승
정신 병리적 공존 질환	- 우울, 불안, PTSD, 경계성 성격장애 등의 높은 공존율
자해의 주요 기능	- 감정 해소(내적 고통 완화), 자기 처벌, 환경 통제 - 대인관계 조절, 자기전환의 기능
인지적 왜곡	- 흑백논리, “나는 상처받아 마땅하다” 등 비합리적 자기 신념
완벽주의 경향	- 높은 성취기대와 자기비판적 완벽주의가 NSSI 위험 증폭
회복탄력성 (Resilience) 결여	- 스트레스 상황 대처 및 정서적 회복력 부족 - 자해에 의존하게 되는 경향

출처: Bjureberg et al.(2023); Gratz et al.(2015); McKenzie & Gross(2014); You, et al.(2023).

이상에서 기술한 바를 종합하면, 비자살적 자해행동을 감행하는 청소년의 심리는 자신이 일상에서 마주하는 다양한 사건과 그로부터 발생하는 정서를 통제하고 융통성 있게 대응하기보다는 그에 따른 압도감과 불편감을 회피(Gohm, 2002; Gratz & Romer, 2008)하고 싶은 심리적 상태로 이해할 수 있다. 청소년은 이러한 회피전략을 통해 임시적 자신의 강렬한 감정에서 벗어나지만, 곧 부정적 정서 상태에 다시 이르게 되어 자해행동의 패턴이 지속될 수 있다(Gohm, 2002). 또한, 이처럼 발생된 사건에서 자신의 정서를 수용하지 못함으로써 정서조절 곤란 상황에 부딪치게 되고 이에 대한 회피 수단으로 비자살적 자해행동을 다시 시도하는 악순환에 빠지게 될 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다(김경미, 2024).

2. 비자살적 자해행동의 이론적 모델 및 관련 요인

1) 비자살적 자해행동의 원인 및 관련 변인

중학생 시기는 직접적으로 정서를 표출하는 아동기와 달리 정서 표출을 억압하여 내면화하거나 다른 방식으로 표출하려는 경향이 높다(한상철, 2014). 이처럼 중학생 시기에 일반적인 정서의 변화를 지나치게 충동성을 억압하거나 지나치게 방치할 경우, 분노, 우울, 불안, 죄책감, 수치심, 수줍음, 외로움, 불행감 등의 부정 정서를 자기 파괴적인 정서적, 행동적 부정적응의 문제행동으로 나타낼 수 있다.

즉 모든 원인을 자신 탓으로 돌려 자신에 대한 분노를 표출하는 하나의 방법으로 비자살적 자해를 하게 되는 것이다(서미 외, 2020). 이러한 비자살적 자해는 자신을 처벌하는 기능으로 자신에게 고통을 주는 행동을 지속적으로 감행할 수 있다(김수진, 2017; 백보검 외, 2019; Nock, 2009).

지난 10년간 인터넷, 노래, 인쇄매체 및 영화, 등으로 자해가 강화되었음을 지적한 Whitlock 등(2009)은 자해하는 동안 내인성 진통제(endogenous opioid)가 분비되어 부정적인 정서가 줄어든다는 결과를 제시한 바 있으며, 김수진(2017), 백보검 외(2019), Nock(2009) 등의 연구는 자해가 상처에 대한 진통 효과가 있고 엔도르핀을 분비하여 스트레스를 감소하는 역할을 한다는 결과를 보여주고 있다. 비자살적 자해는 자신을 처벌할 목적으로 자신에게 고통을 주며, 이는 부정적 감정을 해소하는 기능을 하게 된다는 것이다.

중학생 시기는 또래 집단을 통해 자신의 사회적 역할과 소속감을 느끼고 감정을 공유하며 강한 연대 의식을 형성한다. 따라서 중학생은 또래 집단으로부터 소속감을 얻지 못하거나 친밀감이 충족되지 못할 경우, 우울함이나 불안과 같은 정서장애를 경험한다(Rubin et al, 1990). 이들은 사회적 고립

과 소외감, 공허감과 무감각 등의 비현실의 느낌을 없애고, 자신이 살아있는 느낌이 얻기 위해(Sutton, 2007), 비자살적 자해행동을 선택할 수 있다.

Lewis, Rosenrot & Messner(2012)에 따르면, 비자살적 자해를 하는 많은 청소년들이 개인의 자해 경험을 타인과 소통하는 수단으로 SNS(Social Network Service) 활용하기도 한다. 최근 들어 청소년들 간에 SNS를 통해 자해 인증이 번지고 커뮤니티 모임을 만드는 등 자해가 급격하게 확산하는 추세와 연관될 수 있다. 중학생의 비자살적 자해행동의 원인 및 관련 변인들을 구체적으로 살펴보면 다음과 같다.

(1) 비합리적인 신념

중학교 시기는 인지적으로 미성숙하므로 그에 따르는 심리적 문제들이 발생할 위험이 증가한다. 또한 먼 미래에 대한 부정적인 생각과 우울한 기분 등에 의해 충동적으로 자살할 위험이 크며 청소년의 자살 시도는 심리적 갈등을 해결하려는 상황을 피하고자 충동적 행동으로 나타날 수 있고, 개인의 이러한 현실 도피적인 문제해결 방식은 인지적 왜곡인 비합리적 신념이 주요 원인이 된다(변영주, 1994, 장은선, 2007).

비합리적 신념은 부적응적이고 역기능적 행동에 영향을 주며(Abrams & Ellis, 1994), 스트레스 상황에서 비합리적 신념을 가진 사람은 부적절한 정서나 행동을 보이기 쉽다(하정희, 조하익, 2006). 인간이라면 누구나 가지게 되는 비합리적 신념은 주위의 모든 사람으로부터 항상 사랑과 인정을 받아야 한다고 생각하는 인정의 욕구와 모든 면에서 유능하고 성취적이어야 한다는 욕구를 자기만의 강한 신념으로 살아간다. 여기에는 무기력감, 지나친 염려, 자기와 타인 비난은 경향성, 좌절 반응, 정서적 무책임, 문제 회피, 의존성, 승인 욕구, 높은 자기 기대감, 완벽주의 등이 있다.

비합리적 신념은 장기간에 걸쳐 형성된 개인의 신념 체계이기에 단기간

의 교육과 훈련, 상담을 통해서 변화시키는 것이 매우 어렵다. 비합리적인 신념의 정도가 높을수록 동일한 위험 자극에 노출된 사람이라 하더라도 그가 가진 인지적 도식의 취약성에 따라 경험되는 사회불안의 정도는 크게 달라진다. 비합리적 신념을 갖는 청소년의 경우 행동과 정서에 영향을 줄 수 있다.

장은선 등(2007)의 연구는 역시 비합리적 신념이 청소년의 자해 생각과 정적 관련이 있음을 보여주고 있다. 특히 남녀 중학생 대상으로 비합리적 신념이 자해 충동을 촉진하는 중요한 유발 변인임을 입증해 주고 있다. 비합리적 신념들이 생물학적 요인으로 타고난 사고와 행동 양식이며, 사회적 요인으로는 가정, 친구 관계, 학교, 사회적 기관, 매체 등에 의해서 초래된다. 비합리적 신념 체계에서 인간의 우울, 불안, 공포와 같은 부정적 정서가 연관되어 우리가 불안과 우울을 느끼는 것은 어떤 일에 실패했을 때 그것을 엄청나게 잘못된 일이라고 스스로 믿거나 거부당한 고통을 견디어 낼 수 없다고 굳게 믿기 때문이라고 하였다(김남성, 1995).

(2) 정서조절

정서조절(emotional regulation)이란 정서를 자각하고 이해하는 능력과 정서를 수용하는 능력으로 정의된다(안영신, 송현주, 2017). 이러한 정서조절 능력에 문제가 있는 경우, 다양한 인지적, 심리적, 정서적 영역에서의 역기능을 초래하는 데 특히, 자해행동의 경우 이러한 정서조절과 밀접한 관련이 있는 것으로 확인되었다(성나경, 강이영, 2016).

이와 관련하여 최근 김수진(2017)은 자해의 위험 요인으로 부정적인 아동기 양육 환경, 정서조절의 어려움, 부정적 자기상, 정신의학적 상태 및 심리 사회적 요인을 언급하였다. 반면 보호 요인으로는 상처에 대한 인식, 삶

의 목표, 자기의 회복, 사회적 지지를 제시함으로써 추후 자해의 예방과 치료적 개입에 대한 시사점을 제공하였다. 자신의 정서를 적절하게 조절하는 능력은 일상생활에 적응적이고 심리적으로 건강하게 살아갈 수 있도록 돕지만, 정서조절 곤란을 경험하는 사람들은 심리적인 고통뿐만 아니라 자해나 자살과 같은 자기 파괴적 행동을 초래할 수 있다(이수정, 2019).

(3) 우울

우울은 자살 생각·의도를 가진 사람들에게 발견되는 가장 흔하게 동반되는 증상으로 알려져 있다. 우울과 관련된 초기 연구에서 Beck(1979)은 우울에 대해서 무기력하거나 자신에 대해 무가치하게 느끼는 등 자신에 대한 부정적인 정서를 의미하는 것으로 정의하고, 우울로 인해 파생되는 다양한 정서적 현상에 대해서 논의하였다. 특히, 아직 심리적, 정서적으로 성숙하지 못한 중학생의 경우 자해행동을 일으킬만한 우울을 경험할 때 이에 대한 내적 영향력이 자신의 통제력에 넘어서게 되면 자살하는 경향이 높다고 할 수 있다.

다시 말해, 청소년이 경험하는 촉발 사건 자체가 자해를 유발하기보다는 촉발 사건에 대해서 청소년이 인지적 결핍이나 내적 영향력의 정도가 자살을 유발한다고 본다는 것이다. 촉발 사건에 대한 문제해결(problem solving) 능력이 결핍되면 문제의 해결 방안으로 자해행동 및 자살을 하는 경우가 많다는 것은 다양한 관련 연구에서 논의된 바 있다(Lemer & Clum, 1990). 청소년의 자살 생각과 관련된 변인에 관한 국내 메타분석 연구(김보영, 이정숙, 2009)에서도 자살 생각에 대한 우울함이 효과 크기가 가장 큰 것으로 나타났으며 단일요인으로 가장 중요한 위험 요인임을 확인하였다.

대부분의 관련 조사에서 한국의 학생들은 미국 학생들보다 우울증의 수

준이 거의 2배 가까이 될 정도로 심각한 상태에 이르고 있는데 타인으로부터 부정적인 평가를 받은 것에 대한 두려움을 느끼는 사회적 평가 스트레스와 자신을 타인과 비교함으로써 생기는 위협인 자기평가 스트레스가 가중되어 스스로 처리하기 힘든 상황(신수정, 2020)에 있음을 짐작할 수 있다. 한국 학생들이 처해 있는 이러한 환경에서 개인이 경험하는 우울의 수준이 높아질 수 있으며 이는 자해행동 등 구체적인 반응으로 전이될 수 있다는 점에서 관심이 필요하다.

(4) 고통감내력

고통감내력이 부족한 사람은 부정적 정서를 감내하지 못한 채, 회피하기 위해 물질 남용, 도박, 폭식 및 자해행동 같은 부적응적인 대처 행동을 할 가능성이 높다(Keough et al., 2010; Cipriano et al., 2017). Daughters 등 (2005)의 연구에서도 고통감내력이 부족한 사람들은 심리적인 부적응을 보이며, 다양한 정신장애 취약성을 나타낼 가능성이 크다고 보고한 바 있다. 특히, 고통스러운 경험을 참지 못하고, 이를 회피하거나 줄이기 위해 사용하는 다양한 시도들이 여러 유형의 심리 장애를 형성하게 된다(Cipriano et al., 2017; Cummings, 2021).

이처럼 고통감내력은 다양한 심리 장애의 위험 요인으로 주목받는데 (서장원, 권석만, 2015), 이러한 심리 장애의 공통요인으로 주목받는 고통감내력은(Leyro et al., 2010) 물질 사용 장애(Brown et al., 2005), 불안장애(Vujanovic et al., 2010), 섭식장애 (Corstorphine et al., 2007), 경계선 성격장애(Linehan, 1993), 반사회성 성격장애(Daughters et al., 2008), 비자살적 자해 및 자살 행동(Anestis & Joiner, 2012) 등 심리 장애 및 문제 행동과 밀접한 관련이 있다. 또한, 고통감내력은 비자살적 자해행동으로 이어지고, 비합리적인 신념은 우울감 및 정서적 조절 어려움으로 비자살적 자

해행동 감소의 중요한 역할을 한다(강화정, 이지연, 2016; 정지현, 권석만, 2013; Daughters et al., 2005; Vujanovic et al., 2010).

2) 비자살적 자해행동 설명모델

비자살적 자해행동을 설명하는 데 유용한 모델은 여러 가지가 제안되었으나, 본 연구에서는 중학생의 비자살적 자해행동을 설명하기 위해 ‘4가지의 기능 모델(FFM)’, ‘통합적 이론 모델(ITM)’, ‘경험 회피 모델(EAM)’, ‘인지-정서 모델’, ‘비자살적 자해 극복 과정 경험’ 모델을 중심으로 설명하고자 한다.

(1) 4가지 기능 모델(The Four-Function Model; FFM)

Nock과 Prinstein(2004)이 제안한 4가지 기능 모델(The Four-Function Model; FFM)은 자해의 동기에 따라 자동적-부정적 강화(automatic-negative reinforcement), 자동적-긍정적 강화(automatic-positive reinforcement), 사회적-긍정적 강화(social-positive reinforcement), 사회적-부정적 강화(social-negative reinforcement)의 4가지로 구분한다. 비자살적 자해행동을 하는 개인은 자해를 시도함으로써 개인 내적으로 고통스러운 정서를 제거하거나 줄이고자 한다. 또한 사회적으로는 주변 사람들의 관심을 끌고 그들과 소통하고자 하며, 또한 필요한 어떤 자원에 접근하고 도움을 얻고자 한다. Nock & Prinstein(2004)은 ‘automatic’이라는 단어를 사용하여 무의식적이거나 자연스럽게 촉발된 자해가 아니라 개인 내적 이유에 의해 자동으로 비자살적 자해가 유발된다는 것을 설명한다. 즉, 스스로 시도하는 자해행위를 의미하는 것이다.

이 모델에서 제시하는 자해 동기 4가지인 ‘개인 내적-부적 강화(Automatic-negative reinforcement)’, ‘개인 내적-정적 강화(Automatic -positive

reinforcement)’, ‘사회적-부적 강화(Social-negative reinforcement), ‘사회적-정적 강화(Social-positive reinforcement)’를 각각 살펴보면 다음과 같다.

첫째, ‘개인 내적-부적 강화(Automatic-negative reinforcement)’로 이는 자신에게 불쾌감을 주는 불안, 분노와 같은 부정적인 정서를 완화시키기 위해 비자살적 자해하게 되는 동기를 설명한다. 불안과 분노와 같은 부정적 정서는 자해의 빈도와 정적인 관계가 있으며, 이는 비자살적 자해와 높은 관련이 있다(권혁진, 2014; 김수진, 김봉환, 2015).

둘째, ‘개인내적-정적 강화(Automatic-positive reinforcement)’는 비자살적 자해를 시도하면서 개인이 원하는 자극을 얻는 경우를 말한다. 이는 부정적 감정 상태를 완화하거나 제거하려는 ‘개인 내적 부적 강화’와 다르게, ‘개인 내적 정적 강화’에서는 개인이 추구하는 감정을 얻기 위한 수단으로 자해를 할 수 있다.

셋째, ‘사회적-부적 강화(Social-negative reinforcement)’는 대인관계나 사회적 관계에서 요구되는 책임이나 의무를 회피하고자 비자살적 자해를 시도하는 것이다. 학교에 가거나 직장에 출근해야 하는 의무나 책임에서 벗어나거나 원치 않는 대인관계를 피하거나 자신이 받을 처벌 같은 불미스러운 일에서 벗어나고자 하는 것이 이에 해당한다.

넷째, ‘사회적-정적 강화(Social-positive reinforcement)’는 다른 사람의 관심을 받고 자신에게 필요한 것을 얻기 위해 비자살적 자해를 하는 것이다. 주변 사람들의 관심과 애정을 얻거나 나의 상황을 알리고 싶거나 다른 사람을 조종하기 위해 비자살적 자해한다. 이처럼 부정 정서를 회피하고 원하는 것을 얻게 되면서 행동이 강화되어 반복적으로 자해를 하게 된다.

이 중 ‘사회적 부적 강화’나 ‘사회적 정적 강화’는 대인관계에서 주로 나타나며, 대인관계 속에서 나타나는 문제들은 비자살적 자해를 유발하는 요

인이 될 수 있다(You et al., 2012). 또한 경계선 성향이 높을수록 대인관계에 민감하여 부정적인 감정이 자주 나타나며 비자살적 자해행동으로 이어진다(서아현, 2019).

4가지 기능 모델을 적용하여 비자살적 자해의 동기를 살펴보면 다음의 <표 II -4>과 같다.

<표 II -4> 비자살적 자해의 4가지 기능 모델

	부적 강화 (nerative reinforcement)	정적 강화 (postitive reinforcement)
개인 내적 (automatic)	부정적인 정서 상태 완화/ 제거	개인이 원하는 자극 추구
사회적(social)	원하지 않는 대인관계 및 사회적 상황 및 책임 회피	타인의 관심을 얻거나 원하는 것을 얻음

출처: Nock & Prinstein(2004)

(2) 통합적 이론 모델(The Integrated Theoretical Model: ITM)

Nock과 Prinstein(2004)이 제안한 4가지 기능 모델(FFM)은 단순히 분노, 불안 등 부정적 정서를 완화하거나 사회적 책임을 피하고자 자해행동이 나타난다고 할 때, 비자살적 자해행동은 충동적인 행위로 간주할 수 있다는 점에서 한계가 있다. 또한, 4가지 기능 모델은 비자살적 자해의 기능이나 목적을 설명하고 있지만, 비자살적 자해의 생물학적인 요인이나 사회 환경적인 요인을 설명하지 못한다는 지적이 있다(김수진, 2016).

다수의 선행연구에서는 사회적 기능보다 정서와 관련된 개인 내적 기능과 관련지어 비자살적 자해를 설명하고 있기 따라서 비자살적 자해를 개인 내적인 요인만으로 설명하기에는 한계가 있어 반드시 사회 환경적 요인도 함께 고려되어야 할 필요가 있다(배수현, 성희자 2020). 이를 설명할 수 있는 모델로는 Nock(2009)이 제안한 통합적 이론 모델(The Integrated Theoretical Model: ITM)이 있다. 이 모델에서 자해는, 개인 내외적 취약

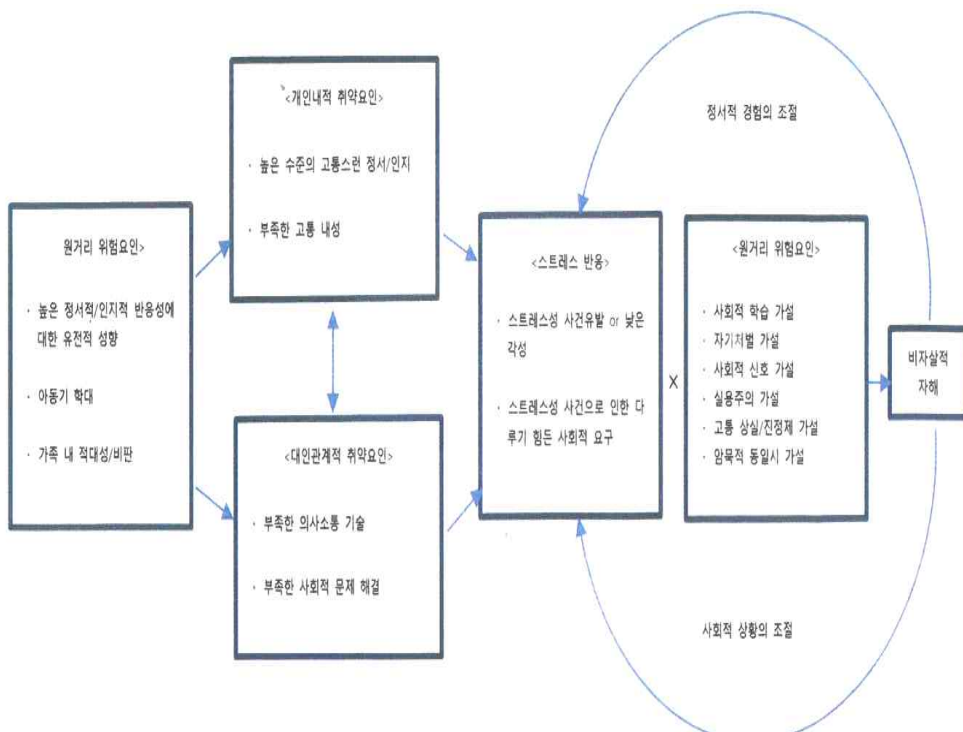
성을 가지고 있는 개인이 스트레스가 촉발되는 사건으로 유발된 정서적, 사회적 상태를 조절하기 위한 행동으로 개념화된다.

통합적 이론 모델은 기존의 비자살적 자해 이론을 바탕으로 비자살적 자해 연구 결과들을 반영하면서 자해 원인을 통합한다. Nock(2009)에 따르면, 민감한 유전적 반응, 가족 간 적대감, 아동기 학대와 같은 원거리 위험 요인(Distal risk factor)이 개인 내적 및 대인 관계적인 취약 요인을 가지고 있는 개인이 어떠한 스트레스 상황을 경험했을 때, 이에 따라 유발된 정서적 상태나 사회적 상황을 조절하거나 완화하기 위해 개인은 비자살적 자해를 선택한다고 설명한다. 평소와 달리 면역력이 약해질 때 바이러스에 취약해지듯, 개인이 개인 내적으로 불안정하고 스트레스를 스스로 다루기 힘든 상황에서 자해 현상이 나타날 가능성이 높아진다는 것을 의미한다.

비자살적 자해에 영향을 미칠 수 있는 간접적인 요인은, 그 개인이 부정적인 정서를 견디거나 적절하게 조절하지 못하면 자해행동과 같은 부적절한 행동으로 나타나게 된다고 보고하였다(김수진, 2016). 비자살적 자해의 개인 내적인 취약 요인으로는 높은 수준의 고통스러운 부정적 정서나 낮은 수준의 고통감내력이 있으며, 대인관계 적인 취약 요인으로는 부족한 의사소통 기술과 미흡한 사회적인 문제 해결력이 있다.

한편, Jacobson과 Batejan(2014)은 Nock(2009)의 통합적 이론 모델을 보완하여 수정된 비자살적 자해 통합모델을 제안하였다. 이 수정된 모델에서는 Nock(2009)이 제시한 원거리 위험 요인을 유전적 요인과 환경적 요인으로 구분하였고, 이 두 요인이 서로 밀접하게 영향을 미친다고 설명한다. 아동기 시기 지속적인 학대 경험과 가족의 적대성 및 아동기 상실 경험은 생물학적 변화를 유발하거나 생물학적 이상을 보여 개인 내적 취약성을 증가시킨다. 아동기 시절의 높고 민감한 정서적 반응은 아동 학대의 자해행동 위험성을 높이고, 자해행동 요인 및 자해행동의 빈도수도 높아진다.

또한, 병리적이고 역기능적인 가족 관계나 가족 내 불화도 중요한 요인이 비자살적 자해행동이 될 수 있다고 보고하였다(김수진, 2017). 수정된 비자살적 자해의 통합적 모델은 유전이나 환경적 요소를 고려하여 비자살적 자해가 발생하는 이유를 전체적으로 설명하였으며, 이는 다른 모델에 비해 다양하고 복합적인 변수를 고려했다는 점에서 의미가 있다. 수정된 통합모델은 아래의 [그림 II -1]과 같다.



[그림 II -1] 통합적 이론 모델(Nock, 2009)

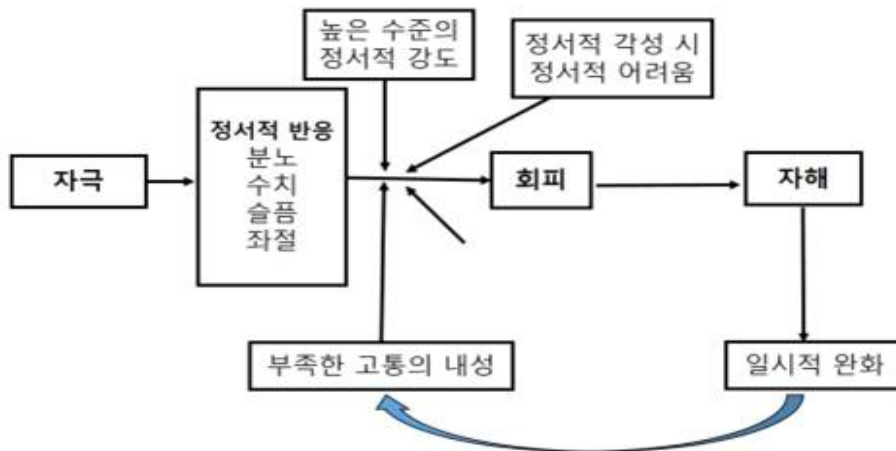
(3) 경험 회피 모델(Experiential Avoidance Model)

Chapman 등(2006)은 개인이 원하지 않는 감정을 경험하는 것을 회피하기 위한 목적으로 자해한다고 설명하면서 정서조절을 목적으로 행해지는

것에 특히 초점을 두어 경험 회피 모델(Experiential Avoidance Model)을 제안하였다. 이 모델은 개인이 원치 않는 정서적 각성을 피하거나 완화하기 위해 자해한다고 제안한다. 즉, 정서적 자극을 유도하는 사건을 통해 정서적 반응이 일어나고, 높은 정서강도, 각성에 대한 조절의 어려움, 낮은 고통 내성, 정서조절 기술의 부족 등의 취약 요인들로 인해 정서적 반응에 대한 회피로 자해하게 된다는 것이다. 이 과정에서 일시적으로 자해를 통해 부정적인 정서가 완화되는 경험을 하게 되면서 자해가 습관화된다는 것이다.

경험 회피 모델에서 비자살적 자해행동은 부적 강화 원리를 바탕으로 한다. 어떠한 선행된 사건이나 자극이 발생했을 때, 불안, 분노, 수치심, 슬픔, 좌절 등 부정적 정서를 느낄 수 있는데, 개인이 이러한 부정적 정서를 조절하는 데 어려움이 있거나 정서적인 고통을 견디는데 취약할 경우, 부정적 정서를 완화하거나 회피하기 위해 비자살적 자해를 한다.

이 과정이 반복되면 비자살적 자해행동이 부적 강화 원리에 따라 자동적인 조건화된 반응으로 나타나게 된다. 이처럼 부정적 정서를 회피하기 위한 감정조절 전략으로 비자살적 자해행동을 반복하며 이에 더욱 의존하게 된다(Chapman & Brown, 2006). 이를 요약하면 [그림 II-2]와 같다.



[그림 II -2] 경험 회피 모델(Chapman, Gratz, & Brown, 2006)

(4) 비자살적 자해의 인지-정서 모델

비자살적 자해를 설명하는 정서 변인에 대한 모델이다. 인지 변인에 해당하는 인지 재평가나 반추도 비자살적 자해를 설명하는 변인으로 활용되었으나, 정서조절 과정의 어려움을 약화하는 변인으로 설명되었다(Chapman et al., 2006; Gross, 1998; Nock, 2009; Selby & Joiner, 2009). 정서 변인을 중심으로 개인의 생물학적 변인, 환경 변인을 다루는 경우가 대부분인데, 최근 Hasking 등(2017)은 비자살적 자해행동에 대한 더 통합적이고 심층적인 이해를 도모하고자 비자살적 자해에 대한 인지 변인을 포함한 비자살적 자해의 인지-정서 모델을 제안했다.

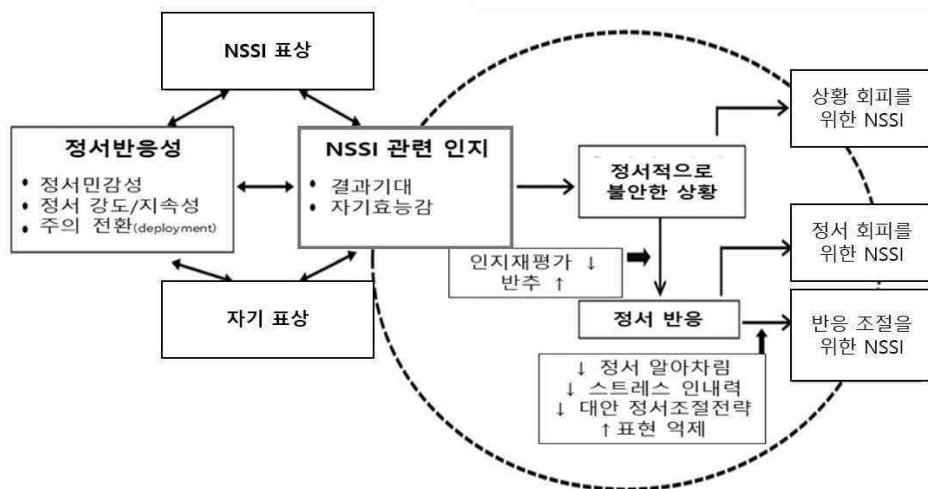
이 모델은 비자살적 자해의 기존 모델들에서 공통으로 다룬 정서 변인에 사회인지 이론의 인지 변인을 추가하여 비자살적 자해의 시작과 유지, 중단을 더 포괄적으로 이해하고자 했다. Hasking 등(2017)은 다른 모델들과 마찬가지로 비자살적 자해에 있어 정서적 취약성, 정서조절의 중요성을 언급하였다. 정서 변인으로 Nock et al.(2008)이 제안한 정서 반응성을 설정하

였다. 이외에도 Bandura(1986, 1997)의 자기효능감과 결과 기대라는 인지 변인을 비자살적 자해의 이해에 적용하고자 했다. 다시 말해 사회인지 이론의 자기효능감과 결과 기대라는 개념을 비자살적 자해 충동을 회피할 수 있다는 효능감과 비자살적 자해행동을 한 후에 나타난 결과에 대해 기대로 적용하여 비자살적 자해행동을 이해하고자 하였다.

자기효능감은 주어진 상황에서 자신의 능력에 대한 개인의 신념을 말하며(Bandura, 1977), 자기효능감이 높은 사람은 어려운 상황에 맞닥뜨렸을 때 원하는 결과를 얻기 위해 큰 노력을 기울여 원하는 성취에 도달한다(이명순, 2006). 비자살적 자해 회피 효능감은 비자살적 자해 충동을 느끼는 장면에서 자신이 그 충동에 굴복하지 않을 수 있다는 확신을 말한다. 마찬가지로 결과 기대는 특정한 행동이 특정한 결과를 가져올 것이라는 개인의 예측을 말하며(Bandura, 1977), 비자살적 자해 기대는 비자살적 자해행동이 초래할 결과에 대해 개인이 예상하는 기대를 말하며(이세은, 2021), 이러한 기대는 직접 경험과 대리 경험을 통해 학습되어 형성된다. Hasking 등(2017)은 이러한 두 인지 변인이 비자살적 자해행동의 여부를 결정하는데 핵심적인 역할을 할 것이라고 하였다. 다시 말해 개인의 정서 반응성과 비자살적 자해에 관한 인지(결과 기대, 효능감)가 자신과 비자살적 자해에 대한 표상에 상호영향을 미친다고 가정하였다.

이후 이런 표상을 지닌 개인이 정서 반응을 불러일으키는 특정 상황에 놓였을 때, 비합리적 신념과 같은 인지 전략을 어떻게 사용하는지에 따라 비자살적 자해행동으로 이어질 수 있다고 제안했다. 그러나 최초의 모델 제안 이후, 비자살적 자해의 인지-정서 모델의 대표 저자인 Hasking이 참여한 Dawkins et al(2019)의 연구에서는 정서 반응성과 비자살적 자해에 대한 인지 변인(결과 기대, 효능감)이 상호영향에 대한 가정을 수정하였음을 확인할 수 있다. 다시 말해 정서 반응성이 비자살적 자해행동에 미치는 영

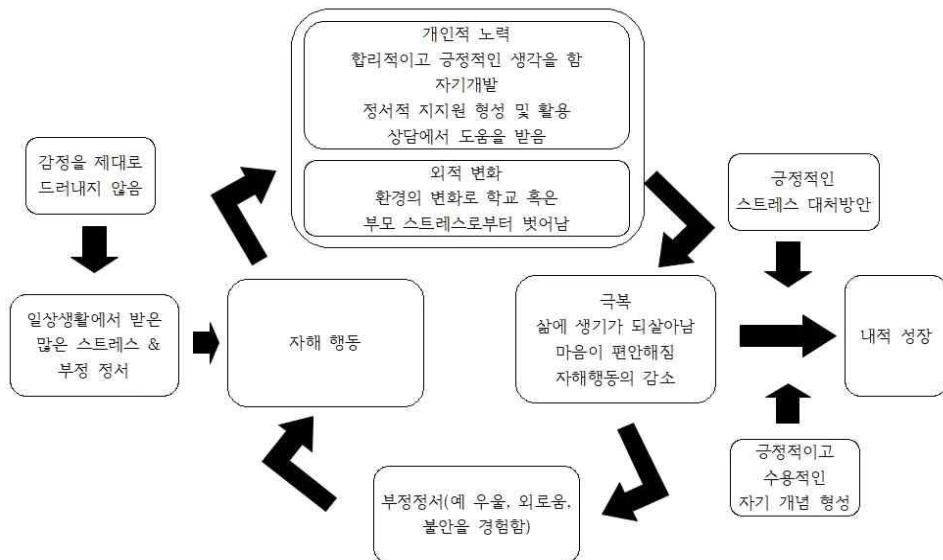
향에서 비자살적 자해에 대한 인지 변인이 조절 효과를 가진다고 설정하고 이를 검증하는 경험적 연구를 진행하였다.



[그림 II-3] 비자살적 자해의 인지-정서 모델(Hasking et al., 2017)

비자살적 자해와 극복 과정 경험에 대한 질적연구에서 제시한 모델이다. 비자살적 자해행동 극복 과정 모형은 ‘자해행동’, ‘개인적 노력과 외적 변화’, ‘극복’, ‘내적 성장’의 4단계로 제시하고 있다.

결과적으로 자해행동을 더욱 가속한다. 두 번째 단계는 스트레스를 해소하기 위해 자해한다. ‘개인적 노력과 외적 변화’에서 들은 자해행동에서 벗어나기 위해 ‘개인적 노력’을 시도한다. 세 번째 단계인 ‘극복’에서는 참여자들은 ‘개인적 노력과 외적 변화’로 인해 삶에 생기와 에너지가 되살아나 가고 마음이 편안해지면서 자해행동을 덜 하게 된다. 네 번째 단계인 ‘내적 성장’에서는 ‘긍정적인 스트레스 대처 방안’과 ‘긍정적이고 수용적인 자기개념 형성’을 통해 내적으로 성장한다(서미 외, 2019). 비자살적 자해 극복 과정 모형은 [그림 II-4]와 같다.



[그림 II-4] 비자살적 자해 극복 과정 모형(서미 외, 2019)

자해는 의도적으로 자신의 신체에 상처를 입히는 것으로 그 행동이 직접적이고, 치사성이 낮으며, 반복적인 특성이 있다(Kahan & Pattison, 1984). 즉, 자해는 신체조직의 손상과 긴장 완화를 목적으로 자신의 신체에 반복적인 위해를 가하는 행위이다(Klonsky, 2007).

여기서 자해의 반복성은 자해행동이 특정한 시기 내에 한 번만 이루어진 것이 아닌 반복적으로 행해졌음을 의미하는 것으로, 자해는 자살을 시도하고자 하는 목적은 없지만 의도적이며 지속적으로 스스로에게 상처를 입히는 행위로 해석된다(Zila & Kiselica, 2001). 비자살적 자해 중단에 대한 연구적 접근을 위해 자해의 이에 따른 질적연구 모델을 비자살적 자해행동 감소를 위한 우울, 외로움의 부정 정서가 반복된 자해행동의 특성이다.

통합적 이론 모델(ITM) 다차원적 접근 특징은 다양한 이론과의 통합과 다양한 개인차 반영하는 특징이 있다. 한계점은 실제 적용의 어려움 있으며, 경험적 검증 부족 인과성 부족, 문화적 맥락 부족을 들 수 있다. 4가지 기능 모델(FFM)의 특징으로는 정서적, 사회적, 내·외적 동기의 강화이다.

한계점으로는 개별 차이 고려, 다양한 요인 간의 상호작용 고려, 문화적, 사회적 맥락에 대한 고려 등이다. 특히 경험 회피 모델(EAM)은 정서 완화, 대체 행동 존재, 인지적 처리를 강조한다. 한계점은 일차원적 설명, 개인차와 상황적 요인, 장기적 효과에 대한 우려이다.

비자살적 자해의 인지-정서 모델 특징은 인지적 평가의 중요성, 정서조절, 인지, 정서 상호작용, 치료적 적용 한계점은 인지와 정서에 대한 과도한 초점, 범위의 제한성, 개인차와 문화적 차이의 설명 부족, 경험적 지원 부족을 한계로 볼 수 있다.

비자살적 자해 극복 과정 모형의 특징은 단계적, 체계적 접근, 인지, 정서적 요소의 통합, 사회적, 환경적 지원의 필요성 강조, 유연한 개입 등이다. 한계점은 각 단계의 경직성과 개인의 다양성 반영이 미흡하며 경험적 근거가 제한적이라는 데 있다. 비자살적 자해행동 설명모델을 비교 정리하면 <표Ⅱ-5>와 같다.

<표 II -5> 비자살적 자해행동 모델 비교

모델	특징	한계점
4가지 기능 모델(FFM)	정서적, 사회적, 내·외적 동기의 강화	- 개별 차이 고려. - 다양한 요인 간의 상호작용 고려 - 문화적·사회적 맥락 고려
통합적 이론 모델(ITM)	- 다차원적 접근 - 다양한 이론과의 통합 - 다양한 개인차 반영	- 실제 적용의 어려움 - 경험적 검증 및 인과성 부족 - 문화적 맥락 부족
경험 회피 모델(EAM)	- 정서 완화 - 대체 행동 존재 - 인지적 처리 강조	- 일차원적 설명 - 개인차와 상황적 요인. 장기적 효과
비자살적 자해의 인지-정서 모델	- 인지적 평가의 중요성 - 정서조절. - 인지, 정서의 상호작용, 치료적 적용	- 인지와 정서에 대한 과도한 초점 - 범위의 제한성 - 개인적 문화적 차이에 대한 설명 부족 - 경험적 지원의 한계
비자살적 자해 극복 과정 모형	- 단계적, 체계적 접근 - 인지적, 정서적 요소의 통합 - 사회적, 환경적 지원의 필요성 강조 - 유연한 개입	- 단계의 경직성 - 개인적 다양성 반영 미흡 - 제한적인 경험적 근거

출처: 서미 외(2018, 2019); Nock & Prinstein(2004); Nock(2009); Chapman, Gratz & Brown(2006); Hasking et al.(2017)

3. 변증법적 행동치료(DBT)와 비자살적 자해행동

1) DBT의 기원 및 역사

변증법적 행동치료(DBT)의 기원을 살펴보기 전에 먼저 변증법의 용어를 살펴볼 필요가 있다. 변증법이란, 영어로는 dialectics이고, 그리스어로는 διαλεκτική에서 유래한 단어로서 문답법 또는 대화법이라는 뜻이 있다. 동양에서는 한자어 그대로 사용하여, 증거를 분별한다는 의미로 모순 또는 대립을 근본원리로 사물의 운동을 설명하는 의미로 사용된다.

변증법의 기원을 살펴보면, 창시자는 엘레아학파의 제논으로 상대방의 입장에 어떤 자기모순이 있는가를 논증함으로써 자기 입장의 올바름을 입증하려고 시도하였다. 이는 이후 소크라테스에 의해 발전되었고, 플라톤에 의해 진리를 인식하는 방법으로 다루어져 왔다. 즉, 변증법이란 이성적 주장을 통해 진리를 확립하고자 하는, 그리고 주제에 대해 서로 다른 견해를 가진 두 명 이상의 사람들 사이의 담론이다(남정우, 2009; Collinson, 2014, 2005).

고대 그리스에서 엘레아의 제논이나 소크라테스에게는 변증법이 철학적 방법 그 자체였으나, 소피스트가 부정(不正)을 정의(正義)라고 우기는 기변술(奇辨術)로 사용한 이후, 변증법을 적극적인 철학적 방법으로 삼는 용법과 기변술로서 부정적으로 다루는 용법이 대립하였다. 이에 플라톤은 내면화(內面化)된 이데아에 이르는 적극적 방법으로 삼았으나 아리스토텔레스는 논박(論駁)의 기술 또는 명제의 귀납적 탐구 술이라 하여 부정적이었다. 이로부터 중세에 와서는 흔히 논리학 그 자체를 가르치면서 이어져 왔다(남정우, 2009; Collinson, 2014, 2005).

근대에 와서 칸트는 순수이성이 그 원리를 가르쳐 형이상학적 문제에 적용했을 때 생겨나는 가상(假象)의 논리를 변증법이라 하여 부정적으로 평가

했다. 이에 대하여 이성이 범하는 모순의 적극적인 의의를 포착한 사람은 헤겔이었다(백훈승, 2015). 헤겔에게 있어서 변증법은 고정적 견해인 형이상학에 대립하는 인식의 방법이 되었으며(김준수, 2012), 동시에 사유(思惟)의 자기운동과 자연·역사(歷史)의 모든 현실적 자기운동에 대한 보편적인 합법칙성이법(合法則性理法)이었다. 그러나 헤겔은 자신의 내부에 있는 모순에 의해 대립을 낳고 그것을 지양함으로써 더 높은 차원으로 나아가는 이 운동을 관념론적 입장에서 개념으로 전개하여 정착시켰다(강순전, 2002).

헤겔은 인간의 인식뿐만 아니라 존재에 관한 논리로 생각하여 인식이나 사물은 정(正)·반(反)·합(合)의 3단계를 거쳐 전개된다고 하였으며, 이 3단계의 전개를 변증법이라 하였다(김영채, 2015). 본 연구는 변증법을 “진리를 찾기 위해 대립하는 개념들을 자세히 살펴보고 논의하는 방법”으로 다루고 “반대되는 것들 사이의 긴장 혹은 통합”으로 이해하고자 한다.

변증법적 행동치료가 상담에 접목된 배경은 자살 및 자해 고위험군에 대한 임상적 관점의 효과적인 치료 방법이 고민되기 시작하면서 다양한 이론적, 실천적 시도를 통해서 1980년도에 완성된 심리치료 기술이 시초라고 할 수 있다. 이후 Linehan(2015, 2020)은 자신의 경계선 성격장애(Borderline Personality Disorder, BPD)의 치료를 위해 자신을 포용하는 것에서 시작되는 치료 방법을 개발하고 이를 변증법적 행동치료(dialectical behavior therapy, DBT)라고 명명하였다. 이후에는 인지행동치료 원리와 선불교 철학, 그리고 변증법 철학이라는 세 가지 주요 축을 기반으로 본 치료 기술은 발전 되어왔다.

DBT는 제3세대 인지행동치료로서 개발자인 Linehan은 자기 발달 이론, 인지 발달 이론, 진화생물학의 영향을 받아 심리치료 영역에 변증법적 철학을 도입하였다(Linehan & Schmidt, 1995). DBT는 다음 세 가지 변증법

적 가정을 통해 현상의 본질을 파악해야 한다고 강조하는데 이를 구체적으로 살펴보면 다음과 같다.

첫째, 모든 현상은 서로 연관되어 있다. 둘째, 모든 현상은 반대의 측면을 내포하고 있다. 셋째, 모든 현상은 끊임없이 변화한다. 이러한 맥락을 고려하여 개인의 내부에 공존하는 상호 중첩된 체계들인 생화학적 체계, 정서조절 체계, 정보처리 체계 사이의 연관성을 고려해야 할 필요가 있다. 또한 개인의 외부에 존재하면서 개인의 내부에 영향을 미치는 상호 중첩된 체계들인 가족, 문화, 환경 사이의 연관성을 반드시 고려해야 한다는 점을 강조한다.

2) DBT의 특성 및 적용

(1) 변증법적 행동치료(DBT)의 특성

변증법적 행동치료는 제3세대 인지행동치료 중 하나로 2000년대 이후 심리치료 현장에서 주목받고 있는 심리치료이다. 앞서 기술한 바와 같이 변증법적 행동치료(DBT)는 Linehan(1993)에 의해 개발된 심리 사회적 처치이며 특히, 경계선 성격장애(Borderline Personality Disorder, BPD)를 가진 개인을 치료하기 위해 제안되었다. 경계선 성격장애(Borderline Personality Disorder) 환자들의 충동성(Impulsivity)은 돌출 행동으로 외부로 표출되는데 폭력, 폭음, 폭식, 난폭운전, 과도한 성관계, 자해(시늉), 자살(시늉) 등 광범위한 영역의 부정적 반응으로 나타난다.

Linehan은 경계선 성격장애 외에도 우울장애, 기분장애, 충동장애, 섭식장애, 성격장애 가진 환자들에게 마음챙김 기술, 고통감내력 기술, 정서조절 기술, 대인관계 효율성 기술의 훈련을 통해 자살 문제 및 정신장애에 대한 치료를 목표로 하는 절충주의적 치료접근을 고안하였고, 이는 다른 정신장애 진단을 가진 환자들을 위한 실효적 효과가 입증되었다(Marra, 2005).

DBT는 서로 반대쪽에 있는 양극단(정(政)-반(反))을 통합(합(合))하는 정반합 원리인 변증법을 토대로 개발된 심리치료 이론으로 자신을 변화시키는 것과 자신을 있는 그대로 수용하는 것 사이의 균형을 이루면서 자해 청소년의 행동 변화를 이루는 것을 목적으로 하는 중재 요법으로 가능성을 내재하고 있다(Linehan, 1993b, 2020). DBT는 효과적인 치료를 위해 개인치료, 사례 관리, 그룹이나 개인 스킬 훈련, 회기 간 코칭과 치료자 자문 등 다양한 접근법이 제시되어 있으며, 무엇보다 중요한 점은 스킬의 숙련도 수용과 변화의 적절한 균형을 갖추는 것을 강조하고 있다. 이러한 관점에서 DBT는 건강하고 만족스러운 또래 관계를 중요하게 여기며 급작스러운 사회적 지위의 변화와 관계 속에 있는 청소년의 행동 변화를 유도하는 데 적합한 대안으로 여겨질 수 있다는 것이다.

구체적으로 DBT는 내담자에게 개인 상담, 행동치료, 집단상담, 코칭 치료자 팀 협력 등 다양한 집단상담 등의 기회를 제공하며 궁극적으로 참여자들이 마음챙김, 고통감내력, 정서조절, 대인관계 기술 등 4가지 기술을 익혀 자신의 심리적 문제를 더 잘 통제하도록 하는 것을 목표로 한다 (Linehan, 1993a, 1993b).

DBT의 구체적인 전략으로서 마음챙김 기술은 자신의 마음에 대한 집중과 조절을 통해 주의와 전략을 전환하고 과잉 경계를 감소시킬 수 있는 능력을 증대시키는 것을 목적으로 수행된다. 또한, 고통감내력 기술은 순간의 고통을 경감시키는 기술로 심리적인 위기 순간을 견디도록 돕는 것을 목적으로 한다. 정서조절 기술은 개인이 어떤 정서를 가졌으며, 언제 그 정서를 가지게 되었고, 어떻게 그 정서를 경험하고 표현하는지에 관한 기술로써, 정서조절 기술의 목표는 자신의 감정을 더 잘 이해하고 조절하도록 돕는데 주안점을 두고 있다. 마지막으로 대인관계 기술은 관계에서 원하는 것을 얻는 것, 대인관계를 원만하게 유지하는 것, 자아존중감을 유지하면서 건강한

관계를 맺는 것을 돕는 것을 참여 목적으로 설정하고 있다(조용범, 2018; 진다슬, 손정락, 2013).

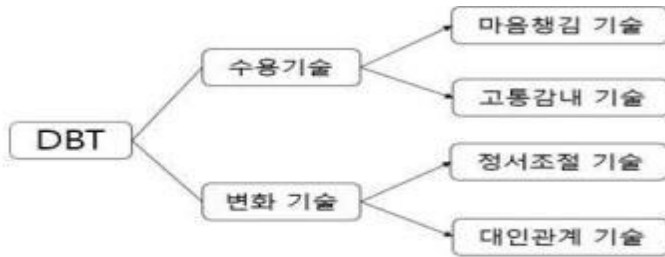
이상에서 제시한 DBT의 이러한 전략들은 내담자의 우울, 정서 문제, 고통감내력, 비합리적 신념, 자해행동 문제 등을 개선하거나 교정하는 데 효과가 있음이 국·내외 여러 연구에서 확인된 바 있다(권혜미, 2013; 조안남, 권해수, 2021; Bradley & Follingstad, 2003; Cavanaugh et al., 2011; Marra, 2005; Soler et al., 2009; Van Dijk et al., 2013).

최근 국내에서도 DBT에 관한 관심이 높아지면서, 변증법적 행동치료 집단상담의 적용과 효과에 대한 초기 탐색적 논의가 시작되었으나 아직 많은 연구가 이루어지지 못한 것으로 보인다. 현재까지 국내에서 수행된 관련 연구는 주로 변증법적 행동치료 집단상담 효과성 검증 연구로, 낮은 정서지능을 가진 대학생(최초롱, 손정락, 2014)의 정서지능과 정서적 안녕감, 대인관계 향상을 검증한 바 있으며, 우울한 청소년의 우울 감소 및 자기 조절력과 대인관계 능력의 향상(권혜미, 2013), 공격성이 높은 청소년(진다슬, 손정락, 2013)의 공격성 감소, 불안이 높은 대학생(조안남, 권해수, 2021)의 고통감내력, 우울 감소 효과를 확인하였다. 이러한 연구들은 기존에 발표된 변증법적 행동치료 양식과 프로그램을 다양한 대상에 적용하고 실제 프로그램 참여가 증상 완화에 효과적인지 측정하는 방식이 주류를 이루고 있다. 반면, 특정한 대상을 사전에 고려하여 프로그램을 개발하고 타당성에 대해서도 있게 논의한 연구는 상대적으로 충분하지 않은 것으로 파악된다.

(2) 변증법적 행동치료(DBT) 기술 요인

DBT의 핵심은 내담자가 DBT의 이론적 토대에서 발생한 다양한 심리, 정서적 기술을 습득함으로써 수용(accept)과 변화(change)의 적절한 균형을 이루는 것에 있다. 따라서 DBT에는 수용 기술 세트와 변화 기술 세트가 함께

있으며, 어떤 문제에 부딪히더라도 수용과 변화를 모두 포함해야 효과적인 치료 접근법이라고 할 수 있다. 수용과 변화의 기술에서 제안하는 각 기술 요인은 내용은 [그림 II -5]와 같다.



[그림 II -5] DBT 수용과 변화의 기술 요인

변증법적 행동치료(DBT)의 구성요소는 행동치료와 개인 심리치료, 회기 간 전화 코칭, 치료자를 위한 자문이라는 하나의 통합된 치료 패키지로 구성되어 있다. 행동치료는 내담자에게 효과적인 기술을 학습하고 연마하는 기회를 제공하고, 개인 심리치료는 행동치료 집단에서 습득한 기술을 강화하는 방향으로 진행된다. 전화 코칭은 행동치료 과정에서 습득한 기술을 일상생활에 적용하도록 촉진하는 효과를 낳는다. 다만, 전화 코칭은 오직 유사 자살 행동을 시도하기 전에만 허용하고 있다. 끝으로 치료자 자문을 통해 치료자의 문제에 초점을 맞추어 내담자의 이해를 돕거나 치료 전략을 협의하도록 구성되어 있다.

이러한 구성요소 중 행동치료 가장 핵심적인 과정이며, 개인 행동치료와 집단행동 치료 중 선택하여 진행될 수 있다. 집단행동 치료는 개인 행동치료 상황에서 발생할 수 있는 치료 방향과 치료 목표 상실을 방지할 수 있다는 점에서 더 유익하다(Linehan, 1993b).

이상에서 진술한 바와 같이 DBT가 제안하는 목적을 달성하기 위해서 내

담자에게 제공되는 치료 경험은 마음챙김, 정서조절, 대인관계, 고통감내력 등 4가지 기술로 이루어진다. 구체적인 내용은 다음과 같다.

① 마음챙김(mindfulness training) 기술 요인

마음챙김 기술은 DBT에서 가장 처음 가르치는 기술이며, 세 가지 다른 기술을 시작하기 전에 먼저 복습하는 기술이기도 하다(Linehan, 1993a). 마음챙김 기술은 동양의 영적 전통에서 나온 명상 훈련을 심리학적이고 행동주의적인 관점으로 해석한 것이다.

DBT에서는 세 가지 마음 상태를 제시한다. 첫째는 ‘합리적 마음’, 둘째는 ‘감정적 마음’, 셋째는 ‘지혜로운 마음’이다(Linehan, 1993a, 1993b). 지혜로운 마음 상태는 ‘합리적 마음’과 ‘감정적 마음’ 상태를 뛰어넘어 감정적 경험과 논리적 분석에 직관적 인식을 추가해 놓은 상태이다(Linehan, 1993a). 마음챙김 기술은 감정적 마음과 합리적 마음의 균형을 유지하면서 지혜로운 마음을 갖도록 인도하는 역할을 한다. DBT의 세 가지 마음 상태는 <표Ⅱ-6>와 같다.

<표 II -6> DBT의 세 가지 마음 상태

합리적 마음	지혜로운 마음	감정적 마음
• 감정이나 공감, 애정, 미운 감정은 무시. • 합리적이고 논리적으로 생각. • 지적이며, 경험적 사실에만 주의를 기울임. • 문제에 접근할 때는 차갑고 냉철함. • 계획적, 실질적 모든 의사결정과 행동에 논리적 대응.	• 모든 사람 안의 지혜. • 감정적 마음과 합리. • 마음의 균형.	• 인지 상태가 뜨겁고 강렬함. • 논리적으로 생각하기 어려움. • 현재 느끼는 감정에 지배됨. • 감정에 집중함.

출처: DBT 학교에 가다: 청소년 정서 문제해결을 위한 DBT 기술훈련(조운화 외, 2022)의 교육 내용을 참조하여 연구자가 재구성함.

DBT에서는 자각이 없는 참여는 충동적이며 기분에 의존하는 행동의 특징이 발현된다고 가정한다(Linehan, 1993a). 이는 비자살적 자해행동 충동성 정서조절의 문제와 맞닿아 있다. 일반적으로 자신의 행동적 반응을 관찰하고 기술하는 것은 새로운 행동을 습득하거나 문제가 발생하였을 때 혹은, 행동 변화가 요구될 때 필요하다.

마음챙김 기술의 핵심은 ‘What’이라고 명명하는 3가지 기술과 ‘How’라고 명명하는 3가지 기술이라고 할 수 있다. ‘What’ 기술은 관찰(Observe)하고 사건과 현상을 기술(describe the incident)하며 현재의 경험이나 활동에 완전히 몰입하고, 순간에 집중하며 적극적으로 참여(Participate)하는 기술이다. 이러한 기술을 습득하는 주된 목표는 자각하는 상태에서 참여하는 생활방식을 발전시키는 것에 있다. ‘How’ 기술은 무 판단(Non-judgmentally)적인 마음으로, 한가지 마음 갖기(One-mindfully), 효과적인 것이 집중(Effectively)하기이다. 즉, 첫째는 무 판단적인 자세를 유지하는 것이고, 둘째는 주어진 순간에 오직 한 가지 일에만 집중하는 것이며, 셋째는 현실적 상황과 목표에 맞추어 가장 효과적이고 적합한 행동을

선택함으로 고집이나 이론적 옳고 그름보다는 실제적 효용을 중시하는 실천을 강조하는 것이다(Linehan, 1993b). DBT의 마음챙김 기술에 대한 핵심 내용의 요약은 <표Ⅱ-7>과 같다.

<표Ⅱ-7> DBT의 마음챙김 기술 요인

What 기술	• 관찰하기
	• 기술하기
	• 참여하기
How 기술	• 무 판단적 마음으로
	• 한가지 마음 갖기
	• 효과적인 것에 집중하기

출처: DBT 학교 가다(조운화 외, 2022)의 내용을 참조하여 연구자가 재구성함.

② 고통감내력(distress tolerance) 기술 요인

비자살적 자해행동을 보이는 중학생의 경우 다양한 일을 시도 하지만 외부 보상이 즉각적으로 이루어지지 않거나 조금의 불편함을 감수하는 데도 어려움을 느끼기 때문에 일을 끝마치지 못하고 중도에 포기하는 경우가 많다(Cipriano et al., 2017; Cummings, 2021). 이러한 경우에 고통감내력 기술은 외부적인 보상에 대한 충동성을 경감시키고, 내적 동기부여 능력을 증진시켜 반복되는 자해행동 감소에 도움이 될 수 있다.

고통감내력은 자기 생각과 행동 양식을 멈추게 하거나 통제하려고 하지 않고 그대로 관찰하는 것을 말한다(Linehan, 1993b). 이러한 자세를 무 판단적 태도라고 할 수 있는데 이 태도는 단순히 모든 것을 용납한다는 의미는 아니다. 그러므로 DBT 운영자는 내담자에게 현실 수용이 현실 용인과 같은 의미가 아니라는 것을 분명히 할 필요가 있다. DBT에서 말하는 고통 감내 행동은 위기를 참고 살아남는 것이며, 그 순간의 삶을 있는 그대로 받

아들이는 것이다(Linehan, 1993a).

DBT에서는 고통을 아주 노련하게 감내하는 방법을 습득하는 것을 중요하게 생각하는데, 그 이유는 고통을 수용하고 감내하는 능력이 건강한 마음 상태를 유지하기 위해 중요하기 때문이다(Linehan, 1993a). 고통이나 아픔은 인간 삶의 일부분으로 인간은 고통을 완전히 피하거나 제거할 수 없다. 이렇게 변하지 않는 사실을 있는 그대로 받아들이려고 하지 않으면 고통은 오히려 가중된다. 또한, 고통 감내는 부분적으로나마 자신을 변화시키려는 시도로서 고통을 잘 참아내지 못하면 충동적인 행동 때문에 원하는 방향으로 스스로 변화시킬 수 없다. 고통감내력 기술은 마음챙김 기술의 연장선상에서 진보된 형태라고 볼 수 있다. 고통감내력을 위해서는 자신과 현재 상황을 있는 그대로 수용하는 능력이 있어야 하며, 비판단적인 자세를 가져야 한다(Linehan, 1993a).

고통감내력 기술 습득 과정에서는 개인의 환경을 억지로 바꾸려고 하지 않고 있는 그대로 인식하고, 현재의 감정 상태 역시 바꾸려 하지 않고 그대로 경험하도록 한다. 고통감내력 기술은 위기 생존 기술과 수용 기술로 구성된다. 위기 생존 기술은 주의 분산하기, 자기 위안하기, 이 순간을 살리기, 장단점 찾기이며, 수용 기술에는 철저한 수용(예: 마음 깊은 곳에서 온전하게 받아들이기), 수용하는 자세로 마음을 돌리기(예: 현실을 있는 그대로 수용하는 것을 선택하기), 기꺼이 함과 고집스러움 비교하기 기술이 포함된다. DBT의 고통감내력 기술은 <표Ⅱ-8>과 같다.

<표 II -8> DBT의 고통감내력 기술 요인

위기 생존	• 자기 위안하기 • 이 순간을 살리기 • 주의 분산하기 • 장점 및 단점 찾기
현실 수용	• 철저한 수용 • 수용하는 자세로 마음 돌리기 • 기꺼이 하기 vs 고집스러움

출처: 복합 외상을 위한 변증법적 행동치료(DBT)(조윤희, 2022) 내용을 참조하여 연구자가 재구성함.

③ 정서조절(emotion regulation) 기술 요인

개인이 정서조절 실패를 반복적으로 경험하게 되면 부정적인 정서가 해소되지 못한 채 악화되며 결국, 사회적, 직업적 기능에 심각한 방해가 될 수 있다(Ehring et al., 2008). 비자살적 자해행동 중학생의 경우 빈번한 감정 기복과 이로 인한 심리적 문제를 경험하게 될 경우, 원만한 또래 관계를 형성하기 어려울 뿐만 아니라 학습 집중도를 떨어뜨려 전반적인 학교생활에 어려움을 초래할 수 있다. 정서조절 문제를 가지고 있는 자해행동 경험의 중학생에게 DBT에서 제공하는 정서조절 기술의 습득은 정서적 문제 개선에 있어 중요 행동치료이며 반복적 자해행동을 제어할 수 있는 본질적인 접근이라 할 수 있다.

DBT의 정서조절 기술은 7단계의 정서조절 방법을 제시하고 있다.

1단계는 현재의 감정을 파악하고 그 감정의 이름을 지어 주는 것이다. 감정은 복잡한 행동 반응이기 때문에 감정을 파악하기 위해서는 반응을 관찰하는 것뿐만 아니라 감정이 발생하는 맥락을 정확하게 기술하는 능력이 요구된다(Linehan, 1993b).

2단계는 감정 상태를 변화시키는 장애 요인을 파악하는 것이다. 특정한 정서적 행동은 개인에게는 기능적으로 발달한 것이라고 할 수 있다

(Linehan, 1993a). 특히, 이러한 정서적 행동이 특정한 강화적 결과를 일으킬 때는 그 행동을 변화시키기가 더욱 어렵다. 따라서 특정한 정서적 행동의 기능성과 강화에 대해서 파악하는 것이 매우 유용하다. 감정의 기능을 파악하는 것, 특히 부정적 감정을 파악하는 것은 앞으로의 변화를 위해서 중요한 첫걸음이 된다.

3단계는 '감정적 마음 상태'에 대해 유약성 줄이기이다. 모든 사람은 신체적 혹은 환경적 스트레스 상황에 놓이면 더욱 민감한 정서적인 반응을 보이게 된다(Linehan, 1993a). 따라서 DBT에서는 균형 잡힌 영양 상태 유지하기, 적절한 수면 취하기, 정서 상태가 바뀌는 약물 끊기, 적절히 운동하기, 신체적 질병 치료하기, 자기효능감과 자신감을 향상할 수 있는 활동에 몰입함으로써 숙련감 쌓기와 같은 기술이 포함된다.

4단계는 긍정적 감정을 일으키는 일들을 증가시키는 것이다. 즐거운 사건을 증가시키는 것은 긍정적인 감정을 증가시키게 되고, 장기적으로는 즐거운 사건이 더 많이 생길 수 있도록 삶을 변화시킬 수 있게 된다. 이렇게 적극적으로 즐거운 사건을 증가시키는 것, 외에도 즐거운 경험 하고 있을 때 마음챙김 상태를 유지하도록 노력하고, 긍정적인 경험이 곧 끝날 것이라는 걱정으로 마음이 흐트러질 때도 다시 마음의 중심을 잡아 마음챙김의 자세를 유지하는 것이 도움이 될 수 있다.

5단계는 현재 감정에 대한 마음챙김 상태의 증진이다. 현재 감정에 마음챙김이란 감정을 판단하려고도 억제하려고 하지 않으며 막거나 분산시키지 않으면서 감정을 있는 그대로 경험하는 상태를 의미한다(Linehan, 1993a). 여기에서 중요한 개념은 부정적인 결과가 나오리라는 것을 연상하지 않으면서 고통스럽거나 괴로운 감정에 노출되어 이차적으로 발생하는 부정적 감정을 막는 것이다(Linehan, 1993b).

6단계는 정반대 행동하기이다. 모든 감정에는 행동적으로 표현되는 반응

(behavioral expressive responses)이 있다. 이것은 감정의 중요한 부분이라고 할 수 있다. 따라서 감정을 조절하거나 변화시키기 위해서는 행동적으로 표현되는 반응을 원래의 감정과 정반대되거나 불일치하는 행동을 함으로써 변화시켜 나갈 수 있다(Linehan, 1993a). DBT에서는 감정을 여러 방식으로 표출하도록 하는 것이지 결코 감정표출 자체를 절제하는 것이 아니라는 것을 내담자가 잘 이해할 수 있도록 해야 한다. 표출하고 싶은 것을 막고 있는 굳은 표정과 편안한 상태를 표현하는 좋은 표정은 다르기 때문이다.

7단계는 고통감내 기술 적용하기이다. 상황을 더 악화시키는 충동적인 행동하지 않으면서 부정적인 감정을 참아낼 수 있는 능력이 향상되면, 부정적인 감정의 강도와 지속 시간을 잘 조절할 수 있게 된다. DBT의 정서조절 단계는 <표Ⅱ-9>과 같다.

<표Ⅱ-9> DBT의 정서조절 단계

1단계	• 감정을 이해하고 이름 붙이기
2단계	• 감정 상태를 변화시키는 장애 요인 파악하기
3단계	• ‘감정적 마음 상태’에 대한 유약성 줄이기
4단계	• 긍정 감정 일으키는 일들을 증가시키기
5단계	• 현재 감정에 대한 마음챙김 상태의 증진하기
6단계	• 정반대 행동하기
7단계	• 고통감내력 기술 적용하기

출처: 청소년을 위한 DBT 다이어렉티컬 행동치료(DBT)(조용범, 2022) 내용을 참조하여 연구자가 재구성함

④ 대인관계 효율성(‘interpersonal effectiveness) 기술 요인

정서적으로 혼란한 비자살적 자해행동을 반복적으로 하는 중학생의 경우는 대인관계 갈등을 자주 생기고(Lee et al., 2022), 이들은 자신의 감정뿐

만 아니라 다른 사람의 감정을 잘 인식하지 못하므로, 따라서 대인관계에서 적절한 대처 기술을 사용하지 못한다. 비자살적 자해행동이 반복성 있는 중학생의 경우는 자신에 대한 부정적인 생각과 역기능적이고 비합리적인 신념 체계를 형성하게 하고, 적절한 대인관계 능력을 습득할 기회를 상실하게 된다. 이에 따라 대인관계에 대한 소극적인 자세를 보일 수 있다.

DBT에서의 대인관계 훈련은 대인관계 문제해결 전략과 자기 주장하기(assertiveness) 전략에서 다루는 것과 매우 유사하다. 대인관계 기술에는 원하는 것을 요구하는 것과 원하지 않는 것에 대해 “아니요.”라고 말할 수 있는 것, 그리고 대인관계 갈등을 다루는 효율적인 전략이 포함되어 있다. 여기서 효율성이란 원하는 것을 얻는 것, 자기 존중감을 유지하는 것 그리고 대인관계를 원만하게 유지하는 것을 의미한다. 사회적 효율성을 증진하기 위해서는 특정한 상황적 맥락에서 설정한 목표를 달성할 수 있도록 행동하는 것이 중요하기 때문에 이처럼 상황을 분석하고 목표를 정하는 능력은 대인관계 효율성 측면에서 필수적인 요소라고 할 수 있다(Linehan, 1993a).

3) DBT 효과에 관한 선행연구

개인의 비자살적 자해행동 감소를 위해 가장 널리 알려진 중재 방법 가운데 하나는 변증법적 행동치료일 것이다. 미국 심리학자인 Linehan이 자살 행동 또는 자살 의도가 없는 자해를 경험하는 내담자에게 효과적으로 개입하고자 개발한 근거 기반 심리치료 기법으로 알려져 있다(Linehan, 1993). 이 치료법을 처음으로 개발한 Linehan(1993)은 미국의 여성 심리학자로 1980년대부터 비자살적 자해행동 완화하기 위한 실효적 방안을 제안하고자 하였다.

비자살적 자해행동 치료 목표로 먼저 경계선 성격장애를 위한 변증법 행

동치료(DBT) 이론과 기법을 소개하였다(Linehan, 1993). 비자살적 자해행동 완화에 궁극적인 관심이 있었으나, 정신장애 진단 편람의 기준에 맞추어 연구를 진행해야 하였기에 경계선 성격장애를 핵심 목표로 기술했다고 알려져 있다.

Linehan의 변증법적 행동치료(DBT)는 기존에 인지 행동치료와 달리 선불교의 영성 훈련의 마음챙김, 인지행동치료(DBT)의 세 가지 요소를 기반으로, 변증법적으로 생각하고, 행동하고 느끼기를 목표로 삼는다(Linehan, 1993).

변증법적 철학적인 면에 따르며 세상에 진리는 존재하지 않으며 양 측면 모두가 참일 수 있다. 또한, 어떠한 일이 일어나는 데 절대적인 조건은 없으며 변화는 여러 조건의 작용으로 일어나기에 절대 원인을 추론하는 것은 불가능하고 현상을 이해하기 위해서는 다양한 관점의 사실을 받아들이고 해결책을 추론해야 한다. 즉, DBT는 모순적 상황에서 변증법적으로 생각하고 행동하여 ‘지혜로운 마음(wise mind)’을 찾도록 돕는 것이며, 이 지혜로운 마음에 다다르기 위해서 선불교의 수행 방식인 마음챙김(mindfulness)을 제시하고 있다. 특히 변증법적 행동치료(DBT)에서는 궁극적인 정서조절 방법으로 마음챙김을 들고 있는데, 이는 회피에서 벗어나 경험을 있는 그대로 처리하는 능력을 의미하며, 여타 다른 심리치료의 공통된 치료 요소와도 맥을 같이 한다.

이에 따른 연구된 선행연구를 살펴보면 국내에서 청소년의 정서조절을 위한 DBT 프로그램 효과성 검증한 선행연구는 비슷한 목적을 갖는 다른 분야의 논의보다는 상대적으로 많지 않은 실정이다. 실제로, 이경민(2003)의 연구에 따르면 2012년부터 2023년 6월까지 국내 학술논문은 15편에 불과하다. 이 중에서 중·고등학교에 해당하는 청소년의 정서조절 효과성을 검증한 논문은 2편에 불과하며, 2023년 6월 이후 중학생을 대상으로 DBT 프

로그래밍의 효과성 연구(이종국 외, 2023)가 추가되었다.

변증법적 행동치료(DBT) 청소년 대상 프로그램 관련 선행연구는 <표 II-10>과 같다.

<표 II-10> 변증법적 행동치료(DBT) 청소년 대상 프로그램 선행연구

프로그램	연구자 (연도)	대상 (회기)	종속 변인	구성 요소	프로그램 내용
DBT 기술 훈련	진다솔 손정락 (2013)	청소년 중학교 2학년 (9회기)	공격성 자아 존중감 분노 표현 양식	마음챙김 기술 I / II	- 기술훈련의 이론과 목표 설명. - 변증법적 행동치료 이론 소개. - 마음챙김 기술 배우기. (세 가지 마음 상태). 'What' 기술과 'How' 기술
				고통감내 기술 I / II	- 자기위안(Self-soothing) - 현실수용(Reality acceptance)기술
				정서조절 기술 I / II	- 감정 스피드 게임. - 자신의 감정 이해하기. - 정서적 고통 줄이기. - 정반대 행동하기.
				대인관계 기술 I / II	- 원하는 것을 얻기 위한 지침. - 관계를 유지하기 위한 지침. - 자존감을 유지하기 위한 지침.
우울 청소년 위한 DBT	권혜미 (2013)	청소년 중학생 2,3학 년 (7회기)	우울감 자기 조절 대인 관계	마음챙김 기술 I / II	- 기본 마음 챙김 연습. - Mindful Breathing, 1분 세어보기, 3분 동안의 생각 적어보기. - 마음중심 잡기(세 가지 마음 상태) - 심화 마음챙김 연습, 'What' 기술, 'How' 기술.
				고통감내 기술	- 고통감내 연습. - 숨 관찰하기, 살짝 미소짓기, 고통 감내의 장·단점 찾기.
				정서조절 훈련 I / II	- 기본 감정조절 연습. - 감정에 대해 바로 알기, 감정 일기, 부정적인 감정으로 인한 영향 줄이기. - 심화 감정조절 연습. - 감정 바로 알기, 반대로 행동 하기. - 감정에 노출되기(Emotion Exposure), 긍정적인 감정 늘리기.
				대인관계 기술 I / II	- 기본 대인관계 기술 연습. - 나의 관계 성향 알아보기. - 원하는 일과, 해야 하는 일. - 구분하기, 내가 원하는 것, 상대가 원하는 것 구분하기. - 심화 대인관계 기술 연습 간단한 부탁하기, 갈등 상황 극복하기.

변증법적 행동치료(DBT) 청소년 대상 프로그램 선행연구 (계속)

프로 그램	연구자 (연도)	대상 (회기)	종속 변인	구성 요소	프로그램 내용
DBT 음악 치료	곽현주 김영희 (2012)	대학생 (10회기)	심리적 안녕감 자아 탄력성	감정 조절 기술	• 자신의 감정을 이해하기. 감정 유익성 줄이기. 정서적 고통 줄이기 • 감정 기술 방법/사랑의 언어, 기쁨의 언어, 분노의 언어, 슬픔의 언어, 두려움의 언어, 수치감 언어, 기타 중요한 감정이입. • 긍정적 감정을 증진 시키는 방법/경험을 있는 그대로 알아차리고 받아들이기, 걱정하는 마음 알아차리기. • 정서적 고통 지나가게 하기 (현재의 감정 상태에 대한 마인드 플니스)/감정 관찰하기, 감정을 있는 그대로 경험하기, 감정을 사랑 하는 연습하기.
				대인 관계 효율 성 기술	• 대인 관계 효율성의 목표/효과적인 관계, 효과적인 자기존중. • 대인관계 효율성을 증진시키는 긍정적인 기술18가지. • 대인관계 효율성을 위한 지침(관계 유지하기)/GIVE기술. Gentle, Interested, Validate, Easy manner
DBT 기술 훈련	최초롱 손정락 (2013)	대학생 (12회기)	정서 지능. 대인 관계.	마음 챙김 기술 I / II	• 마음챙김 배우기/마음챙김 호흡하기. • 신체적 감각 느끼기/ 명상으로서의 마음 챙김.
				정서 조절 기술 I / II	• 정서 조절의 목표, 일차적/이차적 정서 장애물, 탄력성, 즐거움 증진시키기, 반대행동 취하기 • EMOTIONALS
				고통 감내 기술 I / II	• 고통 감내, 수용, 감각 사용하기, 주의 분산, 극단적 수용.
				전 략 적 동 작 기술 I / II / III	• 과제확인, 마음챙김 연습 OBJECTIVES, 민감성. • 네 가지 기술 복습.

변증법적 행동치료(DBT) 청소년 대상 프로그램 선행연구 (계속)

프로 그램	연구자 (연도)	대상 (회기)	종속 변인	구성 요소	프로그램 내용
DBT 기술 훈련	김민주 (2021)	여대생 (10회기)	심리 수용 정서 조절 곤란	마음챙김 기술 I /Ⅱ	- 마음챙김배우기/마음챙김 호흡하기. - 신체적 감각 느끼기/ 명상으로서의 마음 챙김.
				정서조절 기술 I /Ⅱ /Ⅲ	- 정서 조절의 목표, 일차적/이차적 정서. - 장애물, 탄력성, 즐거움 증진시키기, 반대행동 취하기. - EMOTIONALS
				고통감내 기술 I /Ⅱ	고통 감내, 수용, 감각 사용하기, 주의 분산, 극단적 수용.
				전략적 행동 기술 I /Ⅱ /Ⅲ	- 과제확인, 마음챙김 연습OBJECTIVES, 민감성. - 네가지 기술 복습.
DBT 기술 훈련	강은숙 (2024)	여자 중학생	마음 챙김 정서 조절 곤란 고통 감내	마음챙김	- 마음챙김활동. - 호흡 관찰법. - 마음 균형잡기.
				정서조절 곤란	- 감정 기능 알아보기. - 문제해결하기를 통해 정서조절 - 반대로 행동하기.
				고통 감내력	- 자기 위안 활동 발견하기. - 극단적인 행동 줄이기. - 지금- 여기 감정을 수용하기.

출처: 국내 학술정보 서비스를 기반으로 연구자가 정리

DBT와 관련된 외국 연구들은 그동안 다양한 현장 및 실증연구를 통해 DBT의 치료적 근거를 보고해 왔다. 예컨대, Dijk 등(2013)의 연구에서는 조울증 환자에게 정서를 지각하고 관리하는 대처 방법을 교육하는 과정을 통해 증상이 유의미하게 감소하였음을 확인하였고, Nelson 등(2006)의 연구에서는 반항성 장애가 있는 청소년에게 DBT 프로그램을 시행한 결과 정서조절 곤란과 대인관계의 어려움이 유의미하게 감소하였다는 효과를 보고하였다.

반면, 외국 연구 사례에 비해 상대적으로 국내의 경우 비자살적 자해를 예방하고 증상을 완화하는 중재 효과 결과를 검증하는 DBT 연구는 매우 제한적으로 수행된 것으로 판단된다. 이에 본 연구는 간접적인 관점에서 비자살적 자해 문제해결과 유사한 목적을 위해 DBT를 적용한 프로그램 연구를 탐색하고 이를 고찰하였다. 먼저, 반신환(2007)은 우리나라 청년 자살의 특징을 알아보고 변증법적 행동치료(DBT)를 통해 위기 개입의 효과성을 검증하였으며 경계선 성격장애에 대한 변증법적 행동치료(DBT)와 기독교 상담의 효과성을 확인하였다.

남동현 외(2012)는 청소년 자살 시도자의 DBT 기반 단기 치료 적용에 대한 예비조사를 실시하였고, 진다슬,손정락(2013)은 변증법적 행동치료 기술 훈련이 청소년의 공격성, 자아존중감 및 분노 표현 양식에 미치는 효과, 최초롱, 손정락(2014)은 변증법적 행동치료 기술훈련이 정서지능이 낮은 대학생의 정서지능, 대인관계 문제 및 정신건강에 미치는 효과에 대해, 최현정(2018)은 변증법적 행동치료의 근거와 한국 보급: 체계적 문헌 고찰을 통해, 박숙경 (2019)은 자해 청소년을 위한 DBT의 미술치료적 접근, 조안남, 권혜수(2021)는 비대면 변증법적 행동치료 기술훈련 집단프로그램이 대학생의 사회불안 감소에 미치는 효과에 대해, 곽희정 외(2021)는 20대 여성 강력범죄 피해자를 대상으로 한 단기 변증법적 행동치료 스킬 훈련의 효과에 대한 질적연구, 유숙경, 양영길(2022) 트랜스젠더, 젠더 비순응 및 젠더 확장자를 위한 자기조절 역량 향상 프로그램 효과성 예비 연구는 변증법적 행동치료 기술훈련과 소매틱 경험 집단의 비교를 통해, 최지선, 이민지(2023) 무용 동작 치료와 변증법적 행동치료의 절충적 통합프로그램의 필요성에 관한 연구를 통해, 유숙경, 김영은(2023)은 교정시설 남성 성범죄자의 대인관계 증진과 가족 관계 회복을 위한 변증법적 행동치료 프로그램 개발 및 학술적 근거를 통해 DBT의 효과성을 확인한 바 있다. 변증법적 치료 방

법의 효과성 선행연구 <표Ⅱ-11>과 같다.

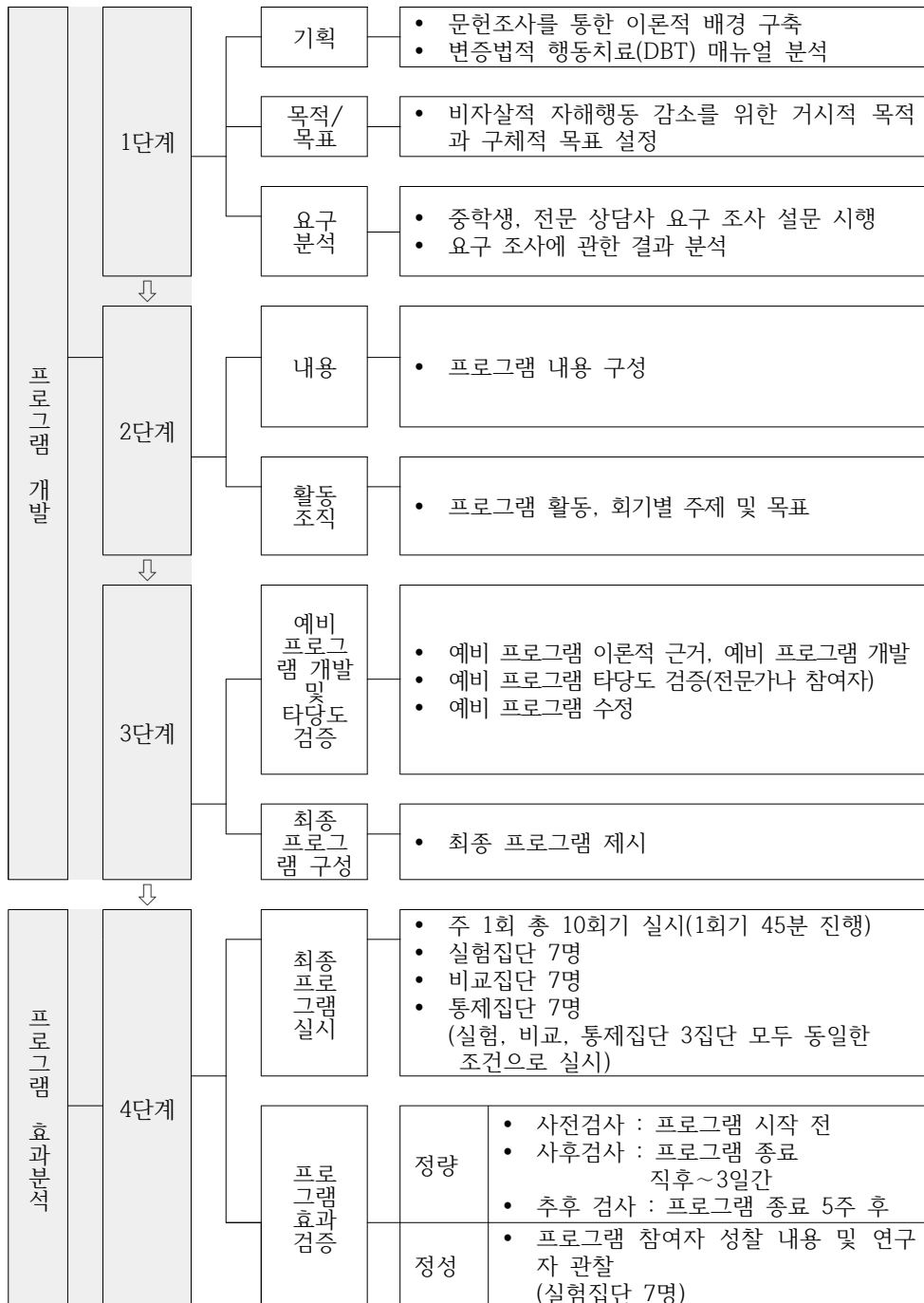
<표Ⅱ-11> 변증법적 치료 효과성 선행연구

저자(연도)	제목
반신환 (2007)	• 우리나라 청년 자살의 특징과 변증법적 행동치료(DBT)의 위기 개입.
반신환 (2010)	• 경계선 성격장애에 대한 변증법적 행동치료(DBT)와 기독교 상담.
남동현 외 (2012)	• 청소년 자살기도자의 Dialectical Behavior Therapy 기반 단기 치료 적용에 대한 예비조사.
진다슬·손정락 (2013)	• 변증법적 행동치료(DBT) 기술훈련이 청소년의 공격성, 자아존중감 및 분노 표현 양식에 미치는 효과.
최초롱·손정락 (2014)	• 변증법적 행동치료(DBT) 기술훈련이 정서지능이 낮은 대학생의 정서지능, 대인관계 문제 및 정신건강에 미치는 효과.
최현정 (2018)	• 변증법적 행동치료(DBT)의 근거와 한국 보급: 체계적 문헌 고찰.
박숙경 (2019)	• 자해 청소년을 위한 DBT의 미술 치료적 접근
조안남·권혜수 (2021)	• 비대면 변증법적 행동치료(DBT) 기술훈련 집단프로그램이 대 학생의 사회불안 감소에 미치는 효과.
곽희정, 임남열, 국혜윤, 김해숙 (2021)	• 20대 여성 강력범죄 피해자를 대상으로 한 단기 변증법적 행동치료(DBT) 스킬 훈련의 효과에 대한 질적연구.
유숙경·양영길 (2022)	• 교정시설 성범죄 수형자의 재범 예방을 위한 변증법적 행동치료(DBT) 프로그램 효과: 혼합 연구 방법으로 수행.
정지인·김문정, 최현정 (2022)	• 트랜스젠더, 젠더 비순응 및 젠더 확장자를 위한 자기조절 역량 향상 프로그램 효과성 예비 연구: 변증법적 행동치료(DBT) 기술훈련과 소매틱 경험 집단의 비교.
최지선·이민지 (2023)	• 무용 동작 치료와 변증법적 행동치료(DBT)의 절충적 통합프로그램의 필요성에 관한 연구.
유숙경·김영은 (2023)	• 교정시설 남성 성범죄자의 대인관계 증진과 가족 관계 회복을 위한 변증법적 행동치료(DBT) 프로그램 개발 및 학술적 근거 마련.
강은숙 (2024)	• 변증법적 행동치료(DBT) 집단프로그램이 여자 중학생의 정서적 곤란, 마음챙김, 고통감내력에 미치는 영향.

Ⅲ. 연구 방법

1. 연구 절차 및 설계

본 연구의 절차는 비자살적 자해행동을 반복적으로 수행하는 중학생을 대상으로 DBT 프로그램을 개발하고, 프로그램의 효과성을 검증하는 과정으로 이루어졌다. 프로그램 개발 및 효과성 검증을 위한 연구 절차를 [그림Ⅲ-1]에 제시하였다.



[그림Ⅲ-1] 프로그램 개발 및 효과성 검증을 위한 연구 절차

1) 프로그램 개발 절차

본 연구에서는 김창대 외(2011)가 제시한 집단상담 프로그램 개발의 4단계 모형을 토대로 비자살적 자해행동 감소를 위한 DBT 프로그램을 개발하였다. 프로그램 개발 모형은 프로그램을 개발하는 과정에 단계적으로 진행해야 하는 절차를 명확하고 체계적으로 제시해 주는 개념 틀을 의미한다. 따라서 본 연구는 김창대(2002), 김창대 외(2011)가 제시한 4단계 프로그램 개발과 평가 모형으로서 목표 수립 단계, 프로그램 구성 단계, 예비 연구 단계, 프로그램 시행 및 개선 단계 순으로 구성되어 있으며 각 단계는 순환적인 개발과 평가 과정을 포함하고 있다. 단계별 구체적인 내용은 다음과 같다.

프로그램 개발 1단계는 목표 수립 단계로 프로그램 개발과 관련하여 비자살적 자해행동의 반복되는 행동을 파악하고, 문헌조사를 통한 이론적 배경 구축과 중학생의 자해행동 감소를 줄이기 위해 변증법적 행동치료(DBT) 매뉴얼 분석하였다. 요구 조사는 중학생 283명과 청소년 대상 전문 상담사 33명 대상으로 비자살적 자해행동 감소를 위한 프로그램 개발의 필요성을 요구 분석하여 프로그램의 목적을 반영하였다.

프로그램 개발 2단계는 프로그램의 구성 단계로 프로그램의 내용 조직과 예비 프로그램 연구와 전문가 내용 타당도 검증을 거쳐 프로그램 내용을 수정 및 보완하였다.

프로그램 개발 3단계는 예비 연구 단계로 이전 단계에서 구성된 프로그램을 토대로 예비 연구 대상자들을 모집하여 실제로 프로그램을 적용하였다. 이후 프로그램에 대한 적절성과 타당성을 평가하여 수정·보완 작업을 거쳐 최종 프로그램 내용을 확정하였다.

2) 프로그램 효과분석 절차

본 연구의 DBT 집단기술훈련 프로그램 효과 검증분석 절차는 다음과 같다. 첫째는 실험집단의 구성 내용 효과분석 절차이다. 둘째는 비교집단의 효과분석과 통제집단의 효과분석 절차이다. 셋째는 DBT 집단기술훈련 프로그램 사후검사와 마지막의 추후 검사 순서로 효과 분석하였다.

(1) 연구설계

본 연구에서 제시하는 중학생의 비자살적 자해행동 감소를 위한 변증법적 행동치료(DBT) 프로그램의 효과를 실증적으로 검증하기 위한 연구설계는 다음과 같다. 프로그램 효과 검증을 위한 집단은 실험집단, 비교집단, 통제집단을 포함한 사전·사후·추후 검사 설계로 구성하였다. DBT 프로그램의 효과 검증 절차의 사후검사는 프로그램의 효과를 알아보기 위한 것으로 실험집단, 비교집단, 통제집단을 대상으로 사전검사와 동일한 방법으로 프로그램을 종료하는 당일 실시하였다. 마지막 추후 검사는 프로그램 효과의 지속성을 알아보기 위한 그것으로 실험집단, 비교집단, 대상으로 사후검사 4주 후 사전 사후검사와 동일한 방법으로 실시하였다.

가. 실험집단

변증법적 행동치료(DBT) 프로그램 (2024년 3월 12일~5월 14일, 매주 화요일, 총 10주)에 참여하였으며, 비교집단은 중학생 분노조절 향상을 위한 인지·정서·행동 통합프로그램 (2024년 3월 7일~5월 9일, 매주 목요일, 총 10주)에 참여하였다.

나. 비교집단

실험집단과 동일한 조건의 대상으로 중학교 1학년 총 7명이 프로그램에 참여하였다. 비자살적 자해행동 청소년을 위한 중학생 분노 조절 향상을 위한 인지·정서·행동 통합프로그램 시행 비교집단에서 실시된 비자살적 자해행동 청소년을 위한 프로그램은 G 광역시에 있는 C 중학교의 학부모상담실에서 시행하였다.

비교집단 프로그램은 지도자 변인을 최소화하기 위해 연구자가 직접 실시하였다. 비자살적 자해행동의 반복된 행동을 한 청소년 7명을 대상으로 2024년 3월 7일부터 5월9일까지 주 1회 목요일 5시 교시 매회기 45분씩 10회기로 진행하였다. 프로그램 진행은 매회기마다 준비된 길잡이에 따라 진행하였으며 프로그램의 모든 회기는 참여자들의 동의를 받아, 회기에 활용했던 워크시트 결과물을 연구에 활용하는 것에 대해서도 동의를 받았다. 연구자는 각 참여자에게 수집된 자료가 연구 목적 이외로는 다른 용도로 사용되지 않으며, 대상자가 원하면 언제든지 프로그램 참여를 거부하거나 중단할 수 있음을 설명하였다.

다. 대기자 통제집단

통제집단은 무처치 집단으로 대기자 통제집단으로 구성하였으며, 실험집단과 동일한 연구 대상으로 총 7명으로 비자살적 자해행동 감소를 위한 변증법적 행동치료(DBT) 집단기술훈련 프로그램에 참여하지 않은 대상이다. 이들에 대한 프로그램은 실험집단의 프로그램이 끝난 후 실험집단과 동일한 프로그램을 (2024년 5월 16일~7월 4일, 매주 목요일, 총 10주) 진행하였다. 프로그램 효과에 대한 검증 일정은 처치 전(사전), 처치 후(사후) 평가를 시행하였고, 1개월 후 추후 검사를 실시하였다. 프로그램의 효과 검증을 위하여 모든 측정치에 대하여 집단 간의 동질성을 확인하였다.

구체적인 연구설계는 다음 <표Ⅲ-1>과 같다.

<표Ⅲ-1> 연구설계

집 단	사전검사		사후검사	추후 검사
실험집단	O ₁	x	O ₂	O ₇
비교집단	O ₃	y	O ₄	O ₈
통제집단	O ₅	x	O ₆	

x : 비자살적 자해행동 변증법적 행동치료(DBT) 집단 기술훈련 시행

y : 중학생 분노 조절 향상을 위한 인지·정서·행동 통합프로그램 시행

O₁ : 실험집단 사전검사 O₂ : 실험집단 사후검사

O₃ : 비교집단 사전검사 O₄ : 비교집단 사후검사

O₅ : 통제집단 사전검사 O₆ : 통제집단 사후검사

O₇ : 실험집단 추후검사 O₈ : 비교집단 추후검사

(2) 비교집단 프로그램

비교집단에서 적용된 프로그램은 김경희(2017)의 연구에서 제시한 중학생 분노 조절 향상을 위한 인지·정서·행동 통합프로그램이다.

비교집단의 프로그램은 실험 프로그램과 중학생의 고통감내력과 분노 조절의 공통점이 있으며, 인지·정서·행동적 접근으로 구성되어 있다. 그러나 중학생의 비자살적 자해행동 감소를 위한 변증법적 행동치료 집단 기술훈련 프로그램(실험집단)은 인지적 접근방법과 노출 훈련에 차이를 두고 있다.

첫 번째 차이점은 인지적 접근에서의 차이점으로, 중학생의 비자살적 자해행동 감소를 위한 변증법적 행동치료 집단 기술훈련 프로그램(실험집단)에서는 인지적 재구성과 함께 자신의 마음을 다스리는 호흡 관찰을 매회기

마다 프로그램 시작과 끝으로 자신의 감정을 알아차리는 훈련에서 초점을 두었다. 비자살적 자해행동 상황에서 보이는 왜곡된 사고와 더불어 인지과정 훈련에서 보이는 자기 비하 부적응적인 사고의 신념을 찾아 긍정적으로 바꾸었다. 또한 비자살적 자해행동 중학생의 편향된 인지를 수정하기 위하여 마음챙김 기술훈련을 단계별 알아차리도록 일상에서 활용하도록 나뭇잎, 주변 사물을 활용하여 적용하도록 초점을 두었다. 반면 중학생 분노조절 향상을 위한 인지·정서·행동 통합프로그램(비교집단) 집단원의 친밀감 형성과 호흡명상 배우기를 통해 흥미를 느끼고 즐겁게 참여할 수 있도록 하였다.

두 번째 차이점은 정서적 접근에서의 차이점으로, 중학생의 비자살적 자해행동 감소를 위한 변증법적 행동치료 집단기술훈련 프로그램(실험집단)에서는 정서를 자각하고 표현하는 단계로 자해행동을 하고 싶은 충동이 생기면 자신의 감정을 알아차리고 감정을 검토하여 고통스러움을 감정을 명료화하여 어떻게 대체할 것인지에 초점을 두었다. 반면 중학생 정서적 분노조절 향상을 위한 인지·정서·행동 통합프로그램(비교집단) 집단원의 경청과 공감을 화난 감정을 알아차리는 데 초점을 두었다.

세 번째 차이점은 행동적 접근에서 차이점은 중학생의 비자살적 자해행동 감소를 위한 변증법적 행동치료 집단기술훈련 프로그램(실험집단)에서는 고통감내력 통해 자해행동을 다른 방법으로 대체 방법을 제시하고 위기 상황에서 자해행동을 멈출 수 있는 기술훈련을 연습하였다. 반면, 중학생 분노조절 향상을 위한 인지·정서·행동 통합프로그램(비교집단) 의사소통 기술 익히기와 합리적인 문제해결 방법 익히기에 초점을 두었다.

중학생 분노 조절 향상을 위한 인지·정서·행동 통합프로그램 비교집단으로 선정한 이유 기술은 DBT 집단기술훈련과 프로그램 구성 요인의 인지·정서·행동에 접근할 수 있고, 중학생 여러 가지 상황에서 오는 자신의 분노를 조절하지 못하여 자살 및 자해, 비행, 폭력으로 분노 표출의 빈도가 매우

높게 나타나 이를 비교하고자 선정하였다(한동화, 2009).

비교집단 중학생 분노 조절 향상을 위한 인지·정서·행동 통합프로그램은 <표Ⅲ-2>에 제시하였다.

<표Ⅲ-2> 중학생 분노 조절 향상을 위한 인지·정서·행동 통합프로그램

단계	회기	영역	활동 목표	프로그램 내용
도입단계	1	마음을 열기	-프로그램 소개 및 친밀감을 형성할 수 있다.	- 진행자소개와 전체 프로그램 안내 - 서약서와 개인 목표 정하기 - 자기소개 작성 및 발표, 집단원 상호 간 친밀감 형성하기(짝이 상대방을 소개하기) - 호흡명상 배우기 (인지, *정서, 행동) - 회기 평가 및 소감 나누기
	2	감정 자각하기	-일상생활에서 경험하는 자기 정서를 자각하고 표현할 수 있다.	- 신체활동(친밀감 형성) 2인 1조(상대가 좋아하는 안마 서로 해주기) - 생활 속에서 경험하는 나의 부정적 정서와 긍정적 정서 찾아보기(*인지, 정서) - 회기 평가 및 소감 나누기 - 과제: 분노 경험일지 적어오기(*인지,*행동)
	3	분노 인식하기	-나의 분노 정서를 이해할 수 있다.	- 호흡명상(인지, *정서, *행동) - 분노 이해하기(긍정적, 부정적인 면)(인지) - 과제 확인: 분노 경험 발표하기(행동)(일주일 동안 기록한 분노 경험일지를 보면서 화가났던 상황을 이야기하고 그때의 신체 반응과 생각, 행동에 대해 나누기) - 분노 장면에 (몸, 마음, 행동) 반응 확인하기(인지,*정서, 행동) - 나의 분노 패턴 발견하기(일주일 동안 기록한 것을 보면서 나는 주로 어떤 식으로 대응하는지, 신체적, 행동적 변화가 일어났는지 발견:인지) - 회기 평가 및 소감 나누기
전개단계	4	감정이입, 관찰, 느낌, 욕구, 부탁	-감정 상담 5단계를 사용하여 타인을 공감	- 감정 상담 5단계 소개 1단계: 감정을 포착하기 2단계: 강한 감정을 표현할 좋은 기회로 여기기(알아차림) 3단계: 감정을 들어주고 공감하기 4단계: 감정에 이름 붙이기(명료화) 5단계: 바람직한 행동으로 이끈다. - 감정 상담 단계별 적용하기 - 회기 평가 및 소감 나누기

	5	마음의 소리 듣기	-느낌을 표현하는 것의 중요성을 알고 감정이입 경험하기	• 마음의 소리 듣기 • 우울, 외로움의 감정을 해소, 관찰, 공감하기 • 회기 평가 및 소감 나누기
	6	느낌 정확하게 말해요!	-정서조절의 유형과 필요성을 알기 -화 다스리기	• 화 다스리기 • 화에 대하여 소극적, 공격적, 주장 적 행동을 이해 및 해소하기 • 회기 평가 및 소감 나누기
	7	내 슬픔 버리기, 있는 그대로 보고 말해요/관찰	-있는 그대로 관찰하기	• 버리고 싶은 슬픔 감정을 해소, 공감하고 정리할 수 있다. • 평가와 관찰 다른 점 알고 구분할 수 있다. • 회기 평가 및 소감 나누기
	8	자기 성장	-욕구를 나타내는 말을 알아보기	• 욕구(마음)에 무엇인지 알아보기 • 마음과 욕구의 연결성 알아보기 • 회기 평가 및 소감 나누기
	9	건강한 감정 조절 및 분노조절	-감정조절 및 분노조절 통합 적용하여 연습할 수 있다.	• 호흡명상(인지, 정서, 행동) • 감정조절 및 분노 조절 통합 강의(인지) • 분노를 표현하는 상황에 어떻게 내 생각을 이야기할 것인지 연습하고 다짐한다. • 함께 하기 협동작품 만들기(인지, 행동) • 긍정 선언문 만들어 큰 나무 꾸며보기 • 회기 평가 및 소감 나누기
종결단계	10	변화된 나	-느낀 점과 변화된 나를 만날 수 있다.	• 그동안 배운 내용 정리해 보고 프로그램을 통해 변화된 점에 대해 나누기(인지, 정서, 행동) • 감정조절 및 분노조절 실천 계획표 작성 및 발표(인지, 행동) • 집단원 간의 긍정적 피드백 주고받기(인지, 정서, 행동) • 전체 프로그램 만족도 및 목표 달성도 평가 • 최종 소감 나누기 및 사후검사

2. 연구 대상 선정

본 연구의 대상은 G 광역시 소재 C 중학교 학생으로서 실험집단, 비교집단, 통제집단 각 7명씩 21명을 선정하였다. 연구 대상 선정 기준은 학생 정서·행동 특성 선별검사(AMPQ-II)에서 자해행동 선별된 학생과 DSM-5(APA, 2013)가 제시한 진단 기준(죽고자 하는 의도 없이 직접적이고 고의로 1년간 5일 이상 반복적으로 자기 신체를 훼손하는 행위)을 만족하는 청소년이다.

본 연구의 대상은 사전에 연구의 취지와 목적 및 연구 권리에 대해서 충분히 설명을 들었으며, 본인과 교사 및 학부모에게 연구참여 동의를 받은 자발적 참여자로 구성하였다. 연구 대상을 7명으로 선정한 이유는 지금까지 자해행동 청소년과 학교 상담이라는 특수성을 고려하여 적합한 표본 크기를 선정, 효과성을 제시한 연구들은 거의 없지만, 자해 청소년을 위한 ‘Cutting Down’ 프로그램을 활용하여 자해 경험 청소년 12세부터 18세까지 16명을 대상으로 개입하여 효과성을 제시한 선행연구(Taylor et al., 2011), 개인적 특성을 고려하는 심도 있는 연구(질적연구) 수행의 단일 사례도 의미가 있지만 다중사례로서 신뢰성을 높이는데 6-7명 정도의 사례가 적합할 수 있다는 견해(Yin, 2016)가 있다.

또한, 집단프로그램은 소수 인원(5~8명)의 참여가 적절(김수진 외, 2015; 박순득, 2009; 황임란, 2001)하고 특히, 여학생은 DBT 기술훈련을 경험한 이후, 자해 충동을 감소하기 위한 개인 훈련이 필요하며, 비자살적 자해행동의 상담 효과 검증과 감소 현상을 이해하는 표본 크기로 잘 드러나지 않는 연구 대상자의 특성과 연구 현장을 고려할 때 7명 내외를 선정하는 것이 타당할 것으로 판단하였다. 뿐만 아니라, 청소년 집단은 법적·윤리적 보호가 중요한 ‘취약 집단(vulnerable population)’으로서 부적절한 대규모

모집은 동의 절차와 개인정보보호, 탈락 위험 등의 문제를 키울 수 있으므로, 소수 인원에 대한 면밀한 관찰과 보호가 권장(Kim & Seo, 2013; Lakens, 2021) 된다는 관점을 인용한 것이기도 하다.

연구 대상 선별 평가는 연구 도중에 탈락하여 끝까지 참여하기 어렵다고 의사를 밝힌 인원 및 연구 기간 내 다른 심리 프로그램에 참여하는 경우 연구 대상에서 제외하였다. 연구 대상의 제외 기준 <표Ⅲ-3>와 같다.

<표Ⅲ-3> 연구 대상 제외 기준

연구 대상 제외 기준	
(1)	중증도 및 심각한 고위험군 수준의 자살 사고가 높은 청소년.
(2)	연구 도중에 탈락하여 끝까지 참여하기 어렵다고 의사를 밝힌 청소년.
(3)	연구 기간 내 다른 심리 프로그램에 참여 경우는 연구 대상자에서 제외.

1) 연구 대상자의 일반적인 특성

본 연구의 대상자의 일반적 특성은 모든 대상자가 중학교 1학년으로 동일하여, 성별은 남자 9명, 여자 12명이다. 대상자의 출생 순위는 첫째가 10명, 둘째가 7명, 셋째가 4명으로 나타났다. 구체적인 연구 대상의 일반적인 특성은 <표Ⅲ-4>과 같다.

<표Ⅲ-4> 연구 대상의 일반적인 특성

구분		실험집단		비교집단		통제집단		전체		
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
연구대상	학년	중학교 1학년	7	(100)	7	(100)	7	(100)	21	(100)
	성별	남자	3	(42.9)	3	(42.9)	3	(42.9)	9	(42.9)
		여자	4	(57.1)	4	(57.1)	4	(57.1)	12	(57.1)
	출생순위	첫째	4	(57.1)	4	(57.1)	2	(28.6)	10	(47.6)
		둘째	2	(28.6)	2	(28.6)	3	(42.9)	7	(33.3)
		셋째	1	(14.3)	1	(14.3)	2	(28.6)	4	(19.1)

3. 측정 도구

본 연구에서는 비자살적 자해행동 관련 변인을 세 가지 영역으로 분류하였다. 구체적으로 비자살적 자해행동 감소를 위한 측정 도구의 관련 인지 변인으로는 비합리적 신념 척도(IBM)를 사용하였으며, 정서 변인으로는 정서조절 척도, 우울척도(CES-D)를 적용하였다. 또한, 행동 변인으로는 자해행동 척도(SHI), 고통감내력 척도(DTS) 부족 행동을 선정하고 각 변인은 자기 보고식 방법으로 측정하였다. 측정 도구는 <표Ⅲ-5>와 같다.

<표Ⅲ-5> 측정 도구

측정 변인	측정 도구	문항 수	기입 방법
인지 변인	비합리적 신념(IBM)	19	자기 기입법
정서 변인	정서조절 척도 우울척도(CES-D)	34	자기 기입법
		20	
행동 변인	고통감내력 척도(DTS) 자해행동 척도(SHI)	15	자기 기입법
		20	
참여 경험	성찰 경험 및 연구자 관찰	성찰 내용 및 관찰	

1) 비합리적 신념 척도

응답자의 비합리적 신념을 측정하기 위한 비합리적 신념 척도는 Lindner 등(1999)이 개발한 단축형 GABS(Shortende GABS)를 송영희와 이윤주(2010)가 한국어로 번안 및 타당 화한 비합리적 신념 척도를 사용하였다. 본 연구에서는 비합리적 신념 척도는 번안 도중 신뢰도가 높은 자기 비하(4 문항), 성취/편안한 욕구(8문항), 승인/공평한 욕구(7문항) 3개 하위 요인 총 19문항으로 사용하였다. 전체 문항은 Likert 5점 척도로 답변하게 되어

있다. 배은희(2021)의 연구에서 비합리적 신념 척도의 신뢰도(Cronbach's α)는 .88였으며, 본 연구에서의 신뢰도는 .91로 나타났다.

비합리적 신념 척도의 하위 요인별 문항 구성 및 신뢰도는 <표Ⅲ-6>와 같다.

<표Ⅲ-6> 비합리적 신념 척도의 하위 요인별 문항 구성 및 신뢰도

하위 요인	문항 번호	문항 수	Cronbach's α
자기 비하	6, 7, 11, 12	4	.806
성취/편안한 욕구	1, 3, 4, 8, 13, 14.15, 18	8	.776
승인/공평한 욕구	2.5.9.10.16.17.19	7	.785
	전체	19	.914

2) 정서조절 곤란 척도(Difficulties in Emotion Regulation Scale: DERS)

본 연구에서는 청소년의 발달적 특성을 고려하여 응답자의 정서조절 곤란 수준을 측정하기 위하여 Gratz와 Roemer(2004)가 개발하였던 정서조절 곤란 척도(Difficulties in Emotion Regulation Scale: DERS)를 박지선(2013)이 14~18세 청소년을 대상으로 타당화한 Difficulties in Emotional Regulation Scale(이하, DERS) 척도를 사용하였다. DERS 척도는 정서에 대한 비수용성(7문항), 정서에 대한 자각 부족(7문항), 정서 명료성 부족(3문항), 충동 통제 곤란(6문항), 정서조절 전략 부족(7문항), 목표 지향 행동 수행의 어려움(4문항)의 6가지 하위 요인으로 구성되어 있다. 본 척도는 총 34개 문항으로, Likert 5점 척도로 평정한다. 총점이 높을수록 정서조절 곤란의 정도가 크다는 것을 의미한다. 박지선(2013)의 연구에서 전체 문항의 신뢰도 계수(Cronbach's α)는 .91이었다. 본 연구에서 확인한 신뢰도는 .94로 나타났다.

정서조절 곤란 척도의 문항 구성 및 신뢰도는 <표Ⅲ-7>과 같다.

<표Ⅲ-7> 정서조절 곤란 척도의 문항 구성 및 신뢰도

하위 요인	문항 번호	문항 수	Cronbach's α
정서에 대한 비수용성	11, 12, 20, 22, 24, 28, 29	7	.86
목표 지향 행동 수행의 어려움	13, 17, 19*, 25	4	.80
충동 통제 곤란	3, 14, 18, 23*, 26, 31	6	.89
정서적 자각 부족	1*, 2*, 6*, 7*, 8*, 10*, 21*	7	.77
정서적 명료성의 부족	4, 5, 9	3	.90
정서조절 전략 부족	15, 16, 27, 30, 32, 33, 34	7	.92
전체		34	.94

* 역 채점 문항

3) 우울척도(Center for Epidemiological Studies Depression Scale: CES-D)

본 연구에서 응답자의 우울 수준을 측정하기 위한 질문지는 지역사회 역학 조사용인 미국 정신 보건연구원(National Institute of Mental Health: NIMH)에서 제작된 20개 문항으로 이루어진 자기보고 형(self-report) 우울 척도검사이다. 이 도구는 Radloff(1977)가 개발하였고, 윤지영(2019)의 연구에서 타당화하여 사용한 CES-D를 사용하였다. 이 척도는 중학생 대상으로 황소희(2018) 등의 연구에 사용하였으며 신체 및 우울 정서(10문항), 정서적 고통(5문항), 대인관계(2문항), 긍정적 정서(3문항)의 4가지 하위 요인으로 구성되며 총 20문항이다. 각 문항은 Likert 식 5점 척도로서 우울 척도 점수가 1점 ~100점까지 높을수록 우울 수준이 높다는 것을 의미한다. 윤지영(2019)의 연구에서 신뢰도(Cronbach's α)는 .88였으며, 본 연구에서 확인된 문항 전체 신뢰도는 .93으로 나타났다. 문항 구성과 신뢰도 구성의 우울 검사 척도는 <표Ⅲ-8>과 같다.

<표Ⅲ-8> 우울 척도(CES-D) 문항 구성과 신뢰도

하위 요인	문항 번호	문항 수	Cronbach's α
신체 및 우울 정서	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 20	10	.897
정서적 고통	9, 12, 14, 17, 18	5	.889
대인관계	16, 19	2	.864
긍정적 정서	5*, 10, 15*	3	.673
전체	1-20	20	.931

*역 채점 문항

4) 고통감내력 척도(Distress Tolerance Scale: DTS)

본 연구에서 응답자의 고통감내력 수준을 측정하기 위한 도구는 Simons와 Gaher(2005)가 응답자의 부정 정서를 측정하기 위해 개발한 15문항이다. 이 척도는 5점 Likert 척도로서 점수의 범위는 15점에서 75점까지이며, 점수가 높을수록 고통에 대한 감내력이 부족함을 의미한다(정지현, 2015). 문항의 내적 일치도(Cronbach's α)는 .91이었으며, 본 연구에서 확인한 문항 전체 신뢰도는 .83으로 확인되었다.

고통감내력 척도의 문항 구성 및 신뢰도는 <표Ⅲ-9>과 같다.

<표Ⅲ-9> 고통감내력 척도의 문항 구성 및 내적 일관성 신뢰도

하위 요인	문항 번호	문항 수	Cronbach's α
조절	8, 13, 14	3	.64
감내력과 몰두	1, 2, 3, 4, 15	5	.72
평가	5, 6*, 7, 9, 10, 11, 12	7	.64
전체		15	.83

*역 채점 문항

5) 자해행동 척도(SHI)

본 연구에서 응답자의 자해행동 수준을 측정하기 위하여 Sansone, Wiederman, & Sansone(1998)이 의도적인 자해행동을 측정하기 위해 개발한 자기보고 식 측정용 도구를 공성숙, 이정현, 신미현(2009)이 한국판으로 번안한 것을 사용하였다. 본 설문지는 4점 Like rt 척도(1: 거의 그렇지 않다 ~4점: 항상 그렇다)로 총 20문항으로 구성되어 있다. 배은희(2021)의 연구에서 신뢰도(Cronbach's α)는 .82였으며 본 연구에서 확인한 문항 신뢰도는 .89로 나타났다.

비자살적 자해행동을 측정하기 위한 자해행동 평가 문항 구성 및 신뢰도는 <표Ⅲ-10>와 같다.

<표Ⅲ-10> 자해행동 평가 문항 구성 및 신뢰도

구성 문항	문항 번호	문항 수	Cronbach's α
자해행동	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20	20	.89

6) 연구 참여자 성찰 일지

본 연구에서는 제시된 중학생의 비자살적 자해행동 감소를 위한 변증법적 행동치료(DBT) 집단기술훈련 프로그램의 참여자들이 경험한 성찰 내용을 정성적 관점에서 이해하기 위하여 각각의 회마다기 프로그램 참여자의 성찰 내용을 작성하도록 하였으며 이를 제시함으로 프로그램의 효과를 보다 입체적으로 확인하는 데 도움을 얻고자 하였다.

4. 연구 윤리

1) 연구자의 소양

본 연구자는 한국 상담학회 1급 수련 중이며, 인지행동 치료학회 1급 자격을 보유하고 있다. 본연구와 관련해서 상담자를 위한 변증법적 행동치료(DBT) 실습 마침, 인지행동 상담프로그램 개발과 운영에 관한 다수의 학술대회와 세미나에 참석하였다. 현재 Wee 클래스 학교 상담 경력 13년 차로 개인 상담, 집단상담 및 학부모 상담을 포함하여 연간 800회 이상씩 상담을 진행하였다. 또한, 본 연구를 위하여 DBT 행동치료 과정을 이수하였으며, 꾸준히 전문가의 상담사례 슈퍼비전을 받고 있다.

2) 연구에 대한 윤리적 고려

연구가 진행되는 동안 연구자는 비자살적 자해 위험이 있는 학생의 안정과 권리를 세심하게 살피고자 노력하였다. 먼저, 연구의 목적과 연구를 위한 상담 질문의 전체적인 요소를 안내하여 연구 참여자가 상담에 응할 것인지를 판단하고 사전에 준비할 수 있게 배려하였다. 이후 약 20분 정도의 사전면담을 통해 참여할 의사를 묻고, 동의서를 받았다. 집단프로그램을 시작하기 전에 대상자에게 연구참여자의 권리와 연구자의 의무에 대해서 충분히 안내하였다. 또한, 연구의 진행 절차, 상담 내용의 녹음, 인용, 개인정보보호, 연구 도중 자유로운 불참에 대하여 상세하게 안내 후 프로그램을 진행하였다.

상담 일정이나 장소는 연구 참여자와 사전에 조율하여 최대한 편안한 분위기에서 이야기할 수 있도록 환경을 조성하였고, 상담 내용이 녹음, 기록될 수 있음을 사전에 공지해 주고, 녹음된 내용을 활용할 시에는 익명 처리

하여 사용한다는 것과 수집된 모든 자료는 연구가 완료된 후에 영구히 파괴 처리됨을 안내하였다. 이상에서 제시한 연구 참여자의 권리와 연구자 의무에 대하여 충분한 안내를 한 후 최종적으로 연구 설명서와 참여 동의서를 작성하고 연구 참여자의 보호자로부터 동의를 받고 연구과정을 진행하였다.

본 연구에서 상담 도중 심리적으로 어려움을 호소하거나 부정적인 정서가 심각하게 올라오는 경우 언제든지 그만둘 수 있음을 설명하여 편안한 마음으로 자신의 경험과 감정을 말할 수 있도록 하며, 상담을 종결 후 내담자가 안정적으로 적응하고 성장하는지 추수 관리를 하였다.

3) 윤리의 엄격성

본 연구는 연구 대상자를 보호하기 위하여 본 순천대학교 IRB(생명윤리심의위원회) 심의(승인 번호:1040173-202306-HR-011-02) 의 원칙에 따라 진행하였다. 자료를 수집하기 이전에 연구 진행에 도움을 준 교장선생님이나 담임교사에게 연구 및 연구 대상자들의 윤리적인 측면과 비밀을 보장할 것을 안내하였다. 연구 대상자는 중학생의 미성년자이므로 개인정보 동의와 학교장 승인 및 보호자의 동의서를 받은 후 진행하였으며, 응답한 설문지와 결과는 연구의 목적으로만 사용하고 연구 완료 후 폐기하였다.

5. 자료 분석

1) 프로그램 효과의 정량적 자료 분석

본 연구는 중학생의 비자살적 자행하는 행동 억제를 위한 변증법적 행동 치료(DBT) 프로그램을 개발하고 효과를 검증 및 논의하는 데 있다. 이러한 연구 목적에 따라서 관련 자료를 수집하였으며 SPSS 21.0 통계 프로그램을 활용하여 수집된 자료를 분석하였다. 구체적인 분석 절차와 내용은 다음과 같다.

첫째, 수집된 자료의 적절성을 확인하고 연구 대상의 일반적 사항을 분석하기 위하여 기술통계를 실시하였으며 연구 도구의 신뢰도 검증을 위하여 신뢰도를 Cronbach's α 기준으로 확인하였다.

둘째, 집단 간 사전 동질성을 확보하기 위해 비모수 적 검정인 Kruskal-Wallis 검정을 시행하였다.

셋째, 집단 간 사후검사 점수에 차이가 있는지 검증하기 위해 Kruskal-Wallis 검정과 일원 분산분석 및 사후검정을 시행하였으며, 각 집단의 집단 내 중학생의 자해행동 사전-사후 점수 차이를 알아보기 위해 비모수 검정인 Wilcoxon signed-rank test를 실시하였다.

넷째, 실험집단과 비교집단 간 중학생 자해행동의 추후 검사 점수 차이를 알아보기 위해 비모수 검정인 Mann-Whitney U 검정을 진행하였다.

다섯째, 실험집단과 비교집단을 대상으로 집단 내 중학생의 자해행동 사전-사후-추후 검사 점수의 변화를 알아보기 위해 Friedman test를 실시하였다. 모든 통계적 검증의 유의수준은 5%로 설정하였다.

2) 참여자 성찰 내용 및 연구자 관찰 분석

본 연구에서는 제시된 중학생의 비자살적 자해행동 감소를 위한 변증법적 행동치료 집단기술훈련 프로그램 참여자들의 성찰 내용을 정성적 관점에서 이해하고자 DBT 참여를 통한 자신의 인식과 행동 변화에 대해서 회기별 성찰 내용을 작성하도록 하였다. 각 성찰 경험 내용에 대해 연구자가 DBT의 치료적 효과 요인에 초점을 두고 성찰 경험 내용을 분석하여 기술하였다. 함축적으로 기술된 참여자의 성찰 경험 내용은 다시 프로그램 참여자 중학생에게 정확한 단어 선택과 의미인지 재확인 절차를 거쳐 최종적으로 선정된 자료를 인용하였다.

IV. 변증법적 행동치료(DBT) 집단기술훈련 프로그램 개발

1. 프로그램의 기획, 목적 및 목표

1) 프로그램의 기획

본 연구자는 고등학교 5년 중학교 8년의 총 13년 Wee 클래스 상담실에서 청소년을 상담한 경력이 있다. 이러한 경험을 통해, 중학생의 비자살적 자해행동에 대한 문제의식을 느끼게 되었으며 다양한 관련 문헌을 고찰한 결과, 이에 대한 실천적 대안으로서 변증법적 행동치료(DBT)가 중재 전략으로 가능성이 있음을 확인하고 관련 프로그램을 개발하고자 하였다.

중학생의 비자살적 자해행동 감소를 위한 변증법적 행동치료(DBT) 집단 기술훈련 프로그램을 개발하기 위해 중학생의 자해행동 또는 자해행동 변인에 관련된 선행연구를 분석한 결과 청소년의 비자살적 자해는 심각한 정신건강 문제(안영신, 송현주, 2017)로 1990년대 후반부터 전 세계적으로 증가하고 있음을 확인하였다(이동훈, 2019; 임경문 등, 2020; Fortune & Hawton, 2005). 또한, 중학생의 자해행동을 자해 빈도와 자해 방법의 심각성 및 자해의 근본적인 원인으로 세분할 수 있으며 이 원인을 인지적·정서적·행동적 요인에서 찾을 수 있다(권혁진, 2014; 김경미, 2024; 배은희, 2021; Cavicchioli, et al., 2020). 구체적 관련 내용은 다음과 같다.

첫째, 자해행동은 주로 도입 청소년기에 시작되고(안영신, 송현주, 2017; 이동귀 외, 2016; Klonsky & Muehlenkamp, 2007) 비임상 군인 청소년의 자해행동 평생 유병률은 17.2%로 다른 나이 보다 높다(Swannell, et al., 2014). 임상군인 청소년 중 40~82%가 자해행동을 하는 것으로 나타나

(Bjureberg et al, 2018) 이들의 자해행동을 이해하고자 다양한 연구들이 이루어지고 있다.

둘째, 청소년의 일반적인 자해행동 원인과 동기는 정서조절의 실패로 인한 충동적 반응이며, 이는 심리적 고통을 줄이려는 행동 전략이다(이동귀 외, 2017). 정서조절 실패와 관련된 연구를 살펴보면 자해는 불안, 우울, 정서적 무감각, 자기혐오, 실패감, 스트레스와 같은 격렬한 감정들을 한시적으로 감소시키는 하나의 대처기제로 기능한다(김수진, 2016; 이동훈 등, 2010; Ross & Heath, 2002).

자해행동을 하는 청소년을 대상으로 심층 면접한 연구(김수진, 김봉환, 2015; 서미 외, 2018)에서 청소년은 스트레스로 인한 비합리적 신념이 형성되어 부정적 정서를 적절히 표현하지 못하며 느끼는 심리적 고통을 해소하고자 자해행동을 한다는 사실을 확인하였다. 청소년기의 자해행동은 일시적인 해소에 불과 하지만, 반복된 자해행동은 부정적인 정서나 긴장이 완화되는 경험이 반복적이고 습관적으로 하게 된다(안영신, 송현주, 2017; Chapman et al., 2006). 특히, 중학생의 청소년기에 자해행동은 주목해볼 부분으로 정서조절 곤란이 발견되었다(Corbisiero et al., 2013; Gibbins & Weiss, 2007).

셋째, 중학생은 또래 집단을 통해 자신의 사회적 역할과 소속감을 느끼고 감정을 공유하며 강한 연대 의식을 형성한다. 특히 중학생은 또래 집단으로부터 소속감을 얻지 못하거나 친밀감이 충족되지 못한 청소년은 우울함이나 불안과 같은 정서장애를 경험하는 것으로 나타났다(Rubin et al., 1990). 선행연구에 따르면, 청소년기에 경험하는 우울은 기분이 울적하고, 무기력감이 생기고 평소보다 짜증이나 화를 많이 내고, 신체적 통증 호소, 등교 거부, 스마트폰 중독, 비행 등(김현정, 2015) ‘가장된 우울(masked depression)’의 특징을 보인다. 이와 같이 중학생 시기의 정서조절 어려움

과 우울감이 동반되고 고통감내력 부족으로 비자살적 자해행동 영향을 미칠 수 있는 주요한 요인으로 작용할 수 있다(정지현, 2015).

넷째, 중학생의 비자살적 자해행동 감소를 위한 치료 프로그램 분석한 결과 인지행동치료를 기반으로 한 프로그램이 주를 이루고 있다(김동일 외, 2009; 신주영, 2018; 안재순, 2016; 정혜원 외, 2011; Hesslinger et al., 2002; Solanto, 2013; Weiss & Hechtman, 2006; Wilens et al., 1999).

비자살적 자해행동의 청소년은 아동기에서 청소년 시기를 지나 성인으로 넘어가는 발달적 과도기이며, 급격한 신체 변화와 성적으로 성숙, 그리고 인지능력의 발달과 사회 정서적 변화를 겪는 시기다. 중학생 시기는 발달적 특성에 적절하게 대처하지 못할 경우, 심리적 부적응을 초래하여 불안, 분노, 우울, 충동성, 낮은 자존감, 비자살적 자해행동 문제 증상으로 나타날 수 있다. 그러므로 중학생 시기는 빠른 변화와 성장을 경험하면서 아동기와는 다른 갈등이 유발되는 다양한 특성이 있는 시기라 할 수 있다.

이상과 같이 선행연구에서 밝히고 있는 청소년 시기 비자살적 자해행동의 유형과 특성 및 원인에 근거하여 한국 중학교 학생과 환경에 부합되고 효과적인 변증법적 행동치료(DBT) 프로그램을 개발하여 그 효과를 확인하고자 한다.

2) 프로그램의 목적과 목표 설정

(1) 프로그램의 목적

프로그램의 목적이란 프로그램의 중재를 통해 성취되어야 할 직접적이고 구체적인 의도를 체계적으로 명시하는 것을 뜻한다(김진화, 2008; 김창대 외, 2011;). 프로그램 목표는 프로그램 참여 대상자에게 어떤 측면의 실효적 변화를 유도할 것인지에 대한 과정과 결과의 수행 과제를 제시하는 그것을 의미한다는 것이다. 일반적으로 특정한 목적을 가지고 개발되는 프로그램은 거

시적 관점의 프로그램 목적과 이를 기반으로 구성되는 단기적 목표를 제시함으로써 프로그램의 구체성을 확보하게 된다(김창대, 2002; 김창대 외, 2011).

본 연구에서 제시하는 중학생의 비자살적 자해행동 감소를 위한 변증법적 행동치료 집단기술훈련 프로그램은 청소년 자해행동에 관여하는 인지적, 정서적, 행동적 요인의 변화를 이끌고 이들의 반복된 자해행동을 감소시키는 것에 목적이 있다. 궁극적으로 이를 통해서 청소년 중학생의 자살 및 자해의 위험 요소를 감소시키기 위한 지속적인 지원 체계를 구축하는 것에 프로그램 개발 목적이 있다.

(2) 프로그램의 목표

특정 프로그램의 시행 이유에 대한 거시적이고 포괄적인 질문이 목적이 라면, 이를 통해서 궁극적으로 무엇을 달성해야 할 것인지에 대한 구체적인 질문이 목표라고 할 수 있다(김창대 외, 2011; Hayes, & Strosahl, 2004). 다시 말해, 목적은 거시적 방향으로서 전략적 성격인 반면, 목표는 목적을 달성하는 수단으로서 미시적이고 전술적인 내용을 구체적이고 체계적으로 담게 된다. 이러한 진술에 기초하여 본 연구에서 제시하는 프로그램의 목표는 마음챙김, 고통감내력, 정서조절, 대인관계 효율성의 4가지 모듈을 근거(Linehan, 1993)로 하였으며 구체적인 프로그램의 목표는 다음과 같다.

첫째, 자기 행동과 생각을 의식화함으로써 성급하게 판단하지 않고 현재 상황과 자신의 상태를 있는 그대로를 바라볼 수 있다.

둘째, 자신의 비합리적 신념과 정서조절 문제에 대한 이해와 수용의 관점을 가질 수 있다. 또한, 감정에 대한 절제력과 통제력을 습득하여 자신의 행동이 주는 유익과 불이익을 구분하고, 목표에 적합한 행동을 할 수 있다.

셋째, 자신의 정서 발현 과정을 이해함으로써 자기 이해 및 감정에 대한 통제력을 갖고 행동할 수 있다.

넷째, 변화된 자신의 정서, 심리상태를 기반으로 가족, 친구나 동료 관계에 적극적으로 반응하며 개선된 관계를 유지할 수 있다.

2. 요구 조사

1) 조사 대상 및 절차

중학생의 비자살적 자해행동 감소를 위한 중재 프로그램에 대한 요구를 파악하기 위하여 연구자가 재직한 G 광역시 C 중학교 학생 283명과 상담 기관이나 Wee센터, Wee 클래스 전문 상담사 33명 대상으로 대면과 온라인으로 설문지를 실시하였다. 요구 조사 기간은 생명윤리(IRB)위원회 심사 승인받은 후 담임선생님, 학생이나 학부모님께 프로그램 개발 연구 이외의 목적으로는 개인정보를 이용하지 않음을 가정 통신문 발송하여 공지하였으며, 설문 기간은 2023년 10월 1일부터 10월 10일까지 서면 및 온라인을 통해 수집하였다. 학생 대상 요구 조사 내용은 학교생활 중 가장 큰 어려움을 겪고 있는 영역, 비자살적 자해행동 감소를 위한 교육 및 프로그램에 참여 경험 여부, 집단프로그램 개설 시 참여 의향 및 횟수, 집단프로그램에 대한 기대 등을 포함하였다.

2) 학생 대상 요구 조사

요구도 조사에 참여한 중학생 청소년들의 배경 특성은 다음과 같다. 학년은 1학년 35.0%, 2학년 29.3%, 3학년 35.7% 등으로 고르게 조사하였으며, 성별은 남성 49.5%, 여성 50.5%이다. 요구도 응답자의 일반적 특성은 <표 IV-1>과 같다.

<표Ⅳ-1> 학생 요구 조사 응답자

전체		학년		
		1학년	2학년	3학년
N(%)		N(%)	N(%)	N(%)
283		99(35.0%)	83(29.3%)	101(35.7%)
성별	남	140(49.5%)	52(52.5%)	38(45.8%)
	여	143(50.5%)	47(47.5%)	45(54.2%)

비자살적 자해 고위험군을 알아보기 위한 정서·행동 특성 검사에서 선별 상담을 받은 경험이 있는지는 4.6% 가 있다고 응답하였다. 비자살적 자해 행동 경험에 대한 응답으로 최근 3개월 이내에 비자살적 자해행동을 경험 했는지는 12.0%가 있다고 답하였으며, 1학년의 최근 비자살적 자해행동 경 험이 상대적으로 높았다.

최근 비자살적 자해행동 경험이 있는 청소년들의 자해 횟수는 3회 이상 이라는 응답이 47.1%로 가장 많았고, 3학년의 경우 절대적인 인원 자체는 적었지만 3회 이상이 80.0%로 높았다. 자해 방식과 관련한 질문에서는 학 년별로 두드러진 차이는 없었다. 칼로 피부를 긁거나 피부에 무엇인가 새기 는 행위는 0회 88.0%, 3회 이상 7.1%, 1회 2.8%, 2회 2.1% 순으로 나타 났다.

고의로 자신을 때리는 행위는 3회 이상 6.4%이었으며, 자기 머리카락을 뽑는 행위는 이상 7.1%로 나타났다. 몸에 있는 상처를 꼬집는 행위는, 3회 이상 2.8%로 나타났으며, 피부를 불로 지지는 행위는 아무도 하지 않은 것 으로 나타났다. 어떤 물체를 손톱이나 피부 속에 찔러넣는 행위는 3회 이상 0.7%로 확인되었다. 또한, 자신을 깨무는 행위는 3회 이상 12.7%로 나타났 다. 피가 날 때까지 신체 특정 부위를 꼬집는 행위는, 3회 이상, 상처가 날

정도로 피부를 긁는 행위는 3회 이상 4.9% 나타났다. 살갓을 벗기는 행위는 3회 이상이 1.8%로 집계되었다.

관련 교육 및 프로그램에 참여한 경험이 있는지는 경험 없다는 응답이 76.7%로 가장 많았고, 한두 번 참여 21.6%, 여러 번 참여 1.8% 순으로 나타났다. 프로그램 참여 경험은 학년별로 다소 차이를 보였는데 경험 없다는 비율이 1학년 76.8%, 경험 비율이 상대적으로 낮았다. 향후 프로그램에 참여할 의향이 있는지에 대해서는 참여하고 싶지! 않으면 43.5%, 참여 의향 없는 청소년이 조금 더 많았으며, 학년별로 참여 의향이 없는 청소년의 비율은 3학년 69.3% 등으로 학년이 높을수록 참여 의향이 낮았다. 프로그램이 도움이 될지에 대한 의견으로는 도움이 될 그것이라는 응답이 73.9%로 가장 많았고, 과반수의 청소년이 참여 의향이 없었던 것에 반해 도움 정도에 대해서는 긍정적인 의견이 많았다.

중학생을 기준으로 프로그램에 주당 몇 회 참여하는 것이 적정한가에 대해서는 주 1회라는 의견이 64.7%로 가장 많았고, 적절한 참여 횟수에 대한 의견은 학년별로 다소 차이를 보였는데, 주 1회 참여가 적절하다는 의견이 3학년 75.2%로 학년이 높아질수록 적은 참여 횟수를 선호하는 것으로 나타났다. 학생 대상 요구 조사 결과는 <표Ⅳ-2>와 같다.

<표Ⅳ-2> 학생 대상 요구 조사 결과

			전체
			N(%)
배경 특성	항목	응답	283
	정서·행동 특성 검사에서 선별 상담을 받은 경험	없다.	270(95.4%)
		있다.	13(4.6%)
비자살적 자해행동 경험	최근 3개월 이내 비자살적 자해행동 경험	없다.	249(88.0%)
		있다.	34(12.0%)
	(경험 있는 경우, n=34) 최근 3개월 이내에 비자살적 자해행동 횟수	1회	7(20.6%)
		2회	3(8.8%)
		3회 이상	16(47.1%)
		무응답	8(23.5%)
	칼로 피부를 긁거나 피부에 무엇인가를 새겼다.	0회	249(88.0%)
		1회	8(2.8%)
		2회	6(2.1%)
		3회 이상	20(7.1%)
	고의로 자신을 때렸다.	0회	246(86.9%)
		1회	14(4.9%)
		2회	5(1.8%)
		3회 이상	18(6.4%)
	자기 머리카락을 뽑았다.	0회	243(85.9%)
		1회	16(5.7%)
		2회	4(1.4%)
		3회 이상	20(7.1%)
	몸에 있는 상처를 꼬집었다.	0회	260(91.9%)
		1회	11(3.9%)
		2회	4(1.4%)
		3회 이상	8(2.8%)
	피부를 불로 지졌다.	0회	283(100.0%)
	어떤 물체를 손톱 및 피부 속에 찔러 넣었다.	0회	274(96.8%)
		1회	5(1.8%)
		2회	2(0.7%)
		3회 이상	2(0.7%)
	자신을 깨물었다.	0회	227(80.2%)
		1회	17(6.0%)
		2회	3(1.1%)
		3회 이상	36(12.7%)
	피가 날 때까지 신체 특정 부위를 꼬집었다.	0회	271(95.8%)
		1회	3(1.1%)

비자살적 자해행동 개선 프로그램 관련		2회	4(1.4%)
		3회 이상	5(1.8%)
	상처가 날 정도로 피부를 긁었다.	0회	248(87.6%)
		1회	11(3.9%)
		2회	10(3.5%)
		3회 이상	14(4.9%)
	살갓을 벗겼다.	0회	265(93.6%)
		1회	10(3.5%)
		2회	3(1.1%)
		3회 이상	5(1.8%)
	학교생활 중 가장 큰 어려움을 겪고 있는 영역	학업 활동	32(11.3%)
		개인 심리	56(19.8%)
		대인관계	31(11.0%)
		사회 체험	1(0.4%)
		없음	163(57.6%)
	관련 교육 및 프로그램 참여 경험	여러 번 참여	5(1.8%)
		한두 번 참여	61(21.6%)
		경험 없음	217(76.7%)
	프로그램 참여 의향	매우 참여하고 싶음	3(1.1%)
		참여하고 싶음	105(37.1%)
		참여하고 싶지 않음	123(43.5%)
		전혀 참여하고 싶지 않음	52(18.4%)
	프로그램 도움 정도	매우 도움이 될 것	21(7.4%)
		도움이 될 것	209(73.9%)
		도움 되지 않을 것	24(8.5%)
		전혀 도움 되지 않을 것	29(10.2%)
	중학생의 적정 참여 횟수	주 1회	183(64.7%)
		주 2회	87(30.7%)
		주 3회 이상	13(4.6%)

3) 전문 상담사 대상 요구 조사

본 연구에서 실시한 요구도 조사 참여 상담사는 모두 여성으로 구성되어 있다. 반면, 남성 상담사가 포함되어 있지 않은 이유는 G 광역시 Wee 클래스 전문 상담사 중 남자 전문 상담사는 초등학교 중학교, 고등학교 각각 1명씩 근무하고 있으나 중학교 전문 상담사 1명이 표집 과정에서 연락이 되지 않아 요구 조사에 포함되지 못했기 때문이다.

구체적으로 본 연구의 요구도 조사 대상 근무 장소는 Wee 클래스 87.9%, Wee센터 9.1%, 개인 상담센터 3.0% 나타났다. 상담 기관 경력은 10년 이상이 90.9%로 가장 많았고, 5년 이상 6.1%, 1년 이상 3.0% 순이었다. 비자살적 자해행동 감소를 위한 DBT 행동치료 프로그램을 개발하기 위한 요구도 조사 참여 상담사들의 기본 정보는 <표Ⅳ-3>과 같다.

<표Ⅳ-3> 전문 상담사 요구 조사 응답자

전체 33N (%)		
구분	항목	인원(%)
성별	남자	0명 (0%)
	여자	33명 (100.0%)
근무 장소	Wee센터	3명 (9.1%)
	Wee 클래스	29명 (87.9%)
	개인 상담센터	1명 (3.0%)
상담 기관 근무 경력	1년 이상	1명 (3.0%)
	5년 이상	2명(6.1%)
	10년 이상	30명(90.9%)

전문 상담사 대상 요구 조사 결과, 1년 이내에 비자살적 자해 상담을 경험한 경우는 84.8%로 나타났으며, 이들 중 60.7%가 최근 1년간 4회 이상의 상담 횟수를 경험한 것으로 나타났다. 1년 이내에 비자살적 자해 감소를 위한 집단 행동치료 프로그램 진행을 경험한 경우는 18.2%로 상담 경험에

비해서 매우 적었다. 학교나 지역사회에서 비자살적 자해 감소를 위한 집단 행동치료 프로그램 매뉴얼을 제공해 주는지는 조금 제공된다는 응답이 42.4%로 가장 많았고, 전혀 제공되지 않으면 36.4% 적당히 제공됨 15.2%, 많이 제공됨. 6.1%로 나타났다.

비자살적 자해 감소를 위한 집단행동 치료 프로그램 개발의 필요성에 대해서는 모든 상담사가 필요하다고 응답하였으며, 이들 중 66.7%는 매우 필요하다고 응답하였다. 프로그램이 제공되면 진행할 의향이 있는지는 90.9%가 그렇다고 답하였다.

비자살적 자해행동 개선 프로그램 구성 의견과 관련된 응답은 다음과 같다. 프로그램의 주당 횟수에 대해서는 1회가 적절하다는 의견이 45.5%로 가장 많았고, 2회 33.3%, 3회 이상 21.2% 순으로 나타났다. 회당 시간은 45분이 적절하다는 의견이 57.6%로 가장 많았고, 50분 30.3%, 60분 이상 12.1% 순으로 나타났다. 회기 구성은 8회 기가 적절하다는 응답이 42.4%로 가장 많았고, 10회기 30.3%, 12회기 이상 24.2%, 4회기 이내 3.0% 순으로 나타났다. 프로그램이 다루어야 할 영역은 '전혀 필요하지 않음' 1점~'매우 필요함' 5점으로 조사하였는데 인지적 영역 4.67, 정서적 영역 4.70, 행동적 영역 4.73으로 나타나 상담사들은 3가지 영역 모두가 중요하게 다루어져야 한다고 인식하였다. 프로그램에 필요한 변증법적 행동치료(DBT) 역시 '전혀 필요하지 않음' 1점~'매우 필요함' 5점으로 조사하였는데 마음챙김 기술 4.09, 정서조절 기술 4.24, 고통감내력 기술 4.15, 대인관계 효율성 기술 4.24로 나타나 상담사들은 4가지 행동치료 모두 필요성이 크다고 인식하였다. 상담사 대상 요구 조사 내용 결과는 <표Ⅳ-4>와 같다.

<표Ⅳ-4> 전문 상담사 대상 요구도 조사

전체			N(%)
항목	내용		응답 33
비자살적 자해행동 개선 프로 그램 경험 및 필요성	1년 이내 비자살적 자해 상담 경험		없다. 있다. 5(15.2%) 28(84.8%)
	(경험 있는 경우, n=28) 1년 이내 비자살적 자해 상담 횟수		1회 2회 3회 4회 이상 4(14.3%) 3(10.7%) 4(14.3%) 17(60.7%)
	1년 이내 비자살적 자해 감소를 위한 집단 행동치료 프로그램 진행 경험		없다. 있다. 27(81.8%) 6(18.2%)
	학교나 지역사회에서 비자살적 자해 감소를 위한 집단 행동치료 프로그 램 매뉴얼 제공 여부		많이 제공됨 적당히 제공됨 조금 제공됨 전혀 제공되지 않음 2(6.1%) 5(15.2%) 14(42.4%) 12(36.4%)
	비자살적 자해 감소를 위한 집단행 동 치료 프로그램 개발 필요성		매우 필요 필요 22(66.7%) 11(33.3%)
	프로그램 제공 시 진행 의향		진행 안 함 진행함 3(9.1%) 30(90.9%)
	비자살적 자해행동 개선 프로 그램 구성 의견	프로그램 시간 의견	주당 걱정 횟수
회당 걱정 시간			45분 50분 60분 이상 19(57.6%) 10(30.3%) 4(12.1%)
			걱정 회기 구성
프로그램이 다루어야 할 영역		인지적 영역 정서적 영역 행동적 영역 평균 4.67, 표준편차 0.54 평균 4.70, 표준편차 0.47 평균 4.73, 표준편차 0.45	
		프로그램에 필 요한 변증법적 행동치료(DBT) 내용	
			대인관계 효율성 훈련 평균 4.24, 표준편차 0.56

4) 요구 조사 시사점

요구 조사를 토대로 도출된 중학생의 비자살적 자해행동 감소를 위한 변증법적 행동치료(DBT) 집단기술훈련을 위한 집단프로그램의 구성과 관련한 시사점은 다음과 같다.

첫째, 자해행동 중학생의 자해행동 극복에 대한 어려움을 개선하는 데 도움이 되는 프로그램이 필요하다. 응답자의 66.7%가 비자살적 자해행동 감소를 위한 집단프로그램 필요성으로 자해행동 감소를 위한 프로그램을 요구됨을 파악하였다. 그리고 비자살적 자해행동 감소를 위한 집단프로그램 제공 시 참여하겠다는 응답자 90.9%로 매우 높게 나타났다.

둘째, 회기 구성은 8회 기가 적절하다는 응답이 42.4%로 가장 많았고, 10회기 30.3%, 12회기 이상 24.2%, 4회기 이내 3.0% 순으로 나타났으며 8회 기와 10회기는 큰 차이가 없었다.

셋째, 프로그램이 다루어서여야 할 영역은 '전혀 필요하지 않음' 1점~'매우 필요함' 5점으로 조사하였는데 인지적 영역 4.67, 정서적 영역 4.70, 행동적 영역 4.73으로 나타나 상담사들은 인지적, 정서적, 행동적 3가지 영역 모두가 중요하게 다루어져야 한다고 인식하였다.

넷째, 프로그램에 필요한 변증법적 행동치료(DBT) 역시 '전혀 필요하지 않음' 1점~'매우 필요함' 5점으로 조사하였는데 마음챙김 훈련 4.09, 정서 조절 훈련 4.24, 고통감내력 훈련 4.15, 대인관계 효율성 훈련 4.24로 나타나 상담사들은 4가지 행동치료 모두 필요성이 크다고 인식하였다.

자해행동 감소를 위한 하위 요인으로 인지, 정서, 행동의 변증법적 행동치료(DBT) 주요 기제로 인지행동(비합리적 신념), 정서(정서조절, 우울), 행동(고통감내력 부족, 자해행동) 이로 Linehan(1993b)의 변증법적 행동치료 DBT 매뉴얼을 기반으로 하였다. 변증법적 행동치료(DBT) 집단기술훈련의 마음챙김, 고통 감내, 정서조절, 대인관계 효율성 나온 것들을 요구도 분석

에 포함했는데, 실질적으로 중요 점으로 뽑은 것들이 요구분석에서도 높은 순위로 나타나서 프로그램 진행에서 중요한 고려 사항임을 시사한다. Linehan(1993b)의 변증법적 행동치료 4가지는 개인 상담, 집단상담, 치료사를 위한 상담, 전화 코칭으로 소요 시간은 1회기 성인 기준 2시간으로 진행하고, 참여자의 상황에 맞게 진행한다. 중학생의 비자살적 자해행동 감소를 위한 변증법적 행동치료 집단기술훈련은 프로그램은 중학생 수업 시간과 청소년기 발달 과정의 집중력을 고려하여 1회기를 45분으로 10회기로 프로그램 운영 방식과 시간에 있어서 응답자들의 의견을 고려하였다.

3. 프로그램 내용, 활동 구성 및 타당도 검증

1) 프로그램 내용

본 연구에서 제안하는 DBT 프로그램의 목표는 프로그램 참여자가 자기 행동과 생각을 의식화함으로써 성급하게 판단하지 않고 현재 상황과 자신의 상태를 있는 그대로를 바라볼 수 있으며, 자신의 비합리적 신념과 정서 조절 문제에 대한 이해와 수용의 관점을 가질 수 있도록 하는 데 있다. 또한, 자신의 감정에 대한 절제력과 통제력을 습득하여 행동이 주는 유익과 불이익을 분별하고, 목표에 부합한 행동을 할 수 있는 경험을 제공하려는 것이다. 또한, 자신의 정서 발현 과정을 이해함으로써 자기 이해 및 감정에 대한 통제력을 갖고 행동할 수 있고, 변화된 자신의 정서, 심리상태를 기반으로 가족, 친구나 동료 관계에 적극적으로 반응하며 개선된 관계를 유지할 수 있도록 유도하는 것에 있다.

이러한 프로그램 목표를 달성하기 위해서 설정된 구체적인 프로그램의 내용은 ‘마음챙김 기술’, ‘고통감내력 기술’, ‘정서조절 기술’, ‘대인관계 효

율성 기술훈련'이다. 이러한 프로그램 구성 내용은 변증법적 행동치료(DBT)가 지향하는 핵심적인 가치(Bohus, et al., 2020; Cavicchioli, et al., 2020; Southward et al., 2021)로, 각 내용에 대한 구체적인 활동 지침은 다음과 같다.

첫째, 마음챙김 기술: 마음챙김은 현재 순간에 집중하고 자신의 감정, 생각, 신체 감각을 비판 없이 인식하는 능력을 기르는 그것을 의미한다. DBT에서 마음챙김 기술은 감정 인식과 수용을 통해 스트레스나 불안 상황에서도 더욱 효과적으로 대처할 수 있도록 돕는다. 이는 명상, 호흡 연습, 감각 인식 등의 방법을 포함하여, 자기 내면과 외부 환경을 깊이 이해할 수 있도록 지원한다는데 궁극적인 의미가 있다(배은희, 2021; Southward, et al., 2021).

둘째, 정서조절 기술: 정서조절 기술은 감정을 인식하고, 이해하며, 조절하는 능력을 향상하는 데 초점을 맞춘다. DBT는 다양한 정신건강 장애의 기저에 있는 정서조절 결핍을 다루는 데 효과적이며(Delaquis, et al., 2020) 감정을 적절히 표현하고 관리할 수 있는 기술 습득에 의미를 두고 있다.

셋째, 고통감내력 기술: 고통감내력 기술은 어려운 상황이나 감정적 고통을 피하지 않고, 이를 수용하고 견디는 능력을 기르는 것을 목표로 한다. DBT는 개인이 고통스러운 상황에서 성장의 기회로 삼는 방법을 가르치며, 이를 통해 수용자가 스스로 장기적인 해결책 모색에 도움이 된다(김경미, 2024; 배은희, 2021; Cavicchioli, et al., 2020)

넷째, 대인관계 효율성 기술: 대인관계 효율성 기술은 효과적인 의사소통 및 관계 형성을 위한 기술을 개발하는 것을 중점으로 한다. DBT는 자신과 타인에 대한 존중을 바탕으로, 건강한 경계를 설정하고, 갈등을 해결하며, 관계를 강화하는 방법을 경험하게 한다. 이는 주장하기, 경청, 상호작용에

서의 감정표현 등을 포함하여, 대인관계에서 어려움을 줄이고 더욱 긍정적인 상호작용을 촉진한다(배은희, 2021; Bohus, et al., 2020; Harned, et al., 2021).

2) 프로그램 활동, 회기별 주제 및 목표

본 연구에서 제안하는 프로그램의 목표에 기초하여 이상과 같이 설정한 프로그램 내용의 구체적인 활동은 학생이나 전문가 요구를 반영하여 총 10회기, 각 회기 45분을 기획하였다. 전체 회기 중 1회기 프로그램 성찰 내용 및 운영자와의 유대감 형성과 10회기 마무리를 통한 반성을 제외하고 프로그램 목표를 반영하는 각각의 내용은 8회기에 구성되어 있으며 구체적인 활동 주제와 목표는 다음과 같다.

DBT 프로그램 활동 주제와 목표는 <표IV-5>와 같다.

<표IV-5> DBT 프로그램 활동 주제와 목표

단계	회기	주제	활동 목표
도입	1	마음 친구. 함께해봐요.	• 신뢰감 • 안정성 확보
전개	2	마음챙김 훈련(What)	• 나의 주의력 문제 알기/바꾸고 싶은 감정 찾기
	3	마음챙김 훈련(How)	• 일어나는 감정의 파도를 조심해!
	4	정서조절 훈련 1	• 일어나는 감정을 조절하기
	5	정서조절 훈련 2	• 일어나는 감정에 머무르기
	6	고통감내력 훈련 1	• 나를 긍정적으로 돌보기
	7	고통감내력 훈련 2	• STOP 기술 연습하기
	8	대인관계 효율성 훈련 1	• 다른 사람을 수인하기
	9	대인관계 효율성 훈련 2	• 자해행동 감소의 변화 알기
종결	10	마무리	• 여정을 마치고

(1) 1회기: 마음 친구 함께 해봐요.

활동 목표는 신뢰감, 친밀감을 형성하고 집단원의 안정성을 확보하기이다. 주요 DBT 활동 내용은 DBT 개념에 대하여 이해하고, 프로그램 대한 전반적인 과정을 설명한다. 또한, 비밀보장의 범위와 필요시 녹음에 대한 동의를 얻는다. 집단구성원 약속 정하고, 도입 면담 과정에서 심리검사 및 심리 치료과거력을 파악한다.

(2) 2회기: 마음챙김 훈련(What)

활동 목표는 나의 주의력 문제를 알고, 이를 바꾸고 싶은 감정 찾기이다. 주요 DBT 활동 내용은 마음챙김 기술로서(What) 첫째, 내 감정을 관찰하기, 둘째, 마음에 흐르는 감정 기록하기, 셋째, 기록한 내용을 감정에 모셔와서 집중하여 느껴보기 훈련한다. 정서조절은 감정 카드를 활용한 자신의 감정 알아차려서 기록하기이며 비자살적 자해행동 감소를 위한 요소는 자신의 주의력 문제에 대해 알아차려서 자해행동 동기 탐색하고, 자해, 숨기지 않기, 자해행동 관찰 일지 쓰기를 써봄으로써 자신이 느끼는 비합리적 신념의 원인을 알아차리기로 한다.

(3) 3회기: 마음챙김 훈련(HOW)

활동 목표는 현재 일어나는 감정의 파도를 조심하기이다. 주요 DBT 활동 내용은 마음챙김 기술(HOW)에서 내 감정을 관찰하여 마음에 흐르는 감정을 알아차리되 평가하거나 판단하지 않고, 관찰하여 하나씩 집중하기이며, 비자살적 자해행동 감소를 위한 요소는 자해 이해하기, 자해를 왜 할까? 자신이 자해했던 감정을 이해하고 기술하는 것이었다.

(4) 4회기: 정서조절 훈련 1

활동 목표는 일어나는 정서조절이다. 주요 DBT 활동 내용은 정서조절에서 일어나는 감정을 균형 잡기, 정서조절에서는 사건을 다양한 시각에서 보기이다. 또한, 자신의 감정 이해하기, 우울감 감소하기 비자살적 자해행동 감소를 위한 요소는 자해를 촉발하는 요인에 지혜롭게 대처하는 기술을 안내하는 것이었다.

(5) 5회기: 정서조절 훈련 2

활동 목표는 일어나는 감정에 머물러보기이다. 주요 DBT 활동 내용은 정서조절에서 현실의 고통을 자연스럽게 받아드리고 기꺼이 하는 마음이 주는 장점을 알고 수용하기, 현재 순간에 몰입하기로 비자살적 자해행동 감소를 위한 요소는 지속성 점검. 자동적 사고 및 비합리적 신념, 우울감 점검하여 스트레스 대처방식, 핵심 신념 찾아서 자해행동을 이해하는 정서 다루기였다.

(6) 6회기: 고통감내력 훈련 1

활동 목표는 나를 긍정적으로 돌보기이다. 주요 DBT 활동 내용은 고통감내력 훈련으로 자신을 긍정적으로 돌보는 방법 배우기 활동에 참여한다. 한 가지 마음만 가지고 지금, 이 순간 집중하기를 중심으로 진행되었고, 이 중 비자살적 자해행동 감소를 위한 요소는 자동적 사고 및 비합리적 신념을 한가지 사건을 부정적으로 생각하는 지점을 알아차리고, 이에 따라 스트레스를 받으면 자신이 어떻게 대처하는지 스트레스 대처방식 찾기 활동에 참여하는 것이었다. 또한, 부정적인 감정을 긍정적인 신념으로 바꾸어 써보기 활동을 수행한다.

(7) 7회기: 고통감내력 훈련 2

활동 목표는 STOP 기능 연습하기이다. 주요 DBT 활동 내용은 고통감내력 훈련으로 정서적 고통의 수위 측정하여서 고통을 일으키는 촉발 사건을 알아보고 이를 정지하기, 한걸음 물러서기 훈련을 수행하고 비자살적 자해 행동 감소를 위한 요소는 자해행동을 지속적으로 하는지 점검한 자해행동 정지 연습에 참여한다.

(8) 8회기: 대인관계 효율성 훈련 1

활동 목표는 다른 사람을 수인하기 훈련을 적용해 보기이다. 주요 DBT 활동 내용은 대인관계 효율성 훈련으로 친구에게 관심 기울이는 연습하기 활동으로 다른 사람이 말한 내용 잘 듣고 다시 말해주는 연습에 참여한다. 비자살적 자해행동 감소를 위한 요소, 친구와 자해행동 멈추었던 상황에 대하여 적어보기이며 친구들과 관계에서 자신의 생활 습관을 분석한다.

(9) 9회기: 대인관계 효율성 2

활동 목표는 자해행동 감소의 변화 알기이다. 주요 DBT 활동 내용은 대인관계 효율성 훈련으로 친구랑 자해행동 정지했던 경험 나누고 서로 칭찬해 주기 활동에 참여한다. 자해 감정이 올라오면 위기에 대책을 마련하도록 호신술을 배운다고 생각하고 미리 예행연습을 해 보게 하여 탄력성 활용 경험에 참여한다.

(10) 10회기: 마무리

활동 목표는 그동안 변증법적 행동치료 실험집단 프로그램 여정을 마치고 전반적인 활동과 소감 나누기한다. 변증법적 행동치료 예비 프로그램 성과 및 효과성 점검기록과 비자살적 자해행동 감소를 위한 요소는 앞으로

자해행동하지 않기 서약서 쓰기에 참여한다.

중학생의 비자살적 자해행동 감소를 위한 변증법적 행동치료의 예비 프로그램 구성요소를 계획하고 실제적인 비자살적 자해행동 감소를 위한 변증법적 행동치료 프로그램을 마무리한다.

4. 예비 프로그램 개발 및 타당도 검증

예비 프로그램의 개발은 본 프로그램의 타당성을 높이기 위하여 요구 조사를 통해 얻은 정보를 기반으로 프로그램의 내용, 운영, 평가 등 구체적인 프로그램의 구성요건을 설정하고 최종적으로 검토하기 위한 절차이다.

예비 프로그램 개발은 프로그램 구성요소 선정, 세부 활동 내용 선정, 전체 프로그램과 회기별 세부 프로그램 구성, 전문가 검토 및 수정, 예비 프로그램 확정 과정으로 수행하였다. 프로그램의 구성을 위해 이론적 근거에 기존 프로그램들을 수집하고 프로그램 구성요소와 세부 활동 내용을 선정하여 전체 프로그램과 회기별 세부 프로그램을 구성하였다. 구성된 예비 프로그램의 내용 타당도를 검증하기 위하여 전문가 3인과 연구자가 1:1 대면 방식으로 자문 과정을 진행하였다. 전문가는 중학생 대상 비자살적 자해 사례를 개입 및 집단으로 변증법적 행동치료(DBT) 상담을 다수 적용해 본 경험을 가진 DBT 전문가이자 상담심리 전문가로 구성하였다.

1) 예비 프로그램 개발의 이론적 근거

(1) 예비 프로그램 개발의 구성

본 연구에서 제시하고자 하는 중학생의 비자살적 자해행동 감소를 위한 DBT 프로그램의 개발을 위한 예비 프로그램의 구성과 내용에 대한 이론적 근거는 다음과 같다.

도입 단계인 1회기는 호흡 관찰을 적용은 마음챙김 중에서 ‘관찰하기’ 연습 호흡이다. 관찰하기는 있는 그대로 받아들이는 수용전념치료(Acceptance Commitment Therapy: ACT)로, 마음챙김이 인지치료의 변증법적 행동치료(DBT)(Hayes et al. 1996)에 적용하여 마음을 알아차림 등이 있다. 도입 단계 1회 기의 이론적 근거는 호흡명상 활동을 통하여 본 회기의 활동과 관련된 촉진으로 마음을 열고 이완훈련에 도움이 된다(김경희, 2017). Linehan(1993)에는 변증법적 행동치료의 4가지 모듈(마음챙김, 고통감내력, 정서조절, 대인관계 효율성) 중에서 마음챙김 기술훈련이 가장 핵심으로 보고, 매회기마다 도입에 시행하였다.

전개 1단계인 2, 3회기는 마음챙김(What, HOW) 기술훈련으로 순간을 인식하고, 마음을 관찰하기, 자해행동 동기를 탐색하는 인지적 변인으로 Lindner 등(1999)이 제시한 비합리적 신념은 타인 비하, 자기 비하, 성취/편안한 욕구, 승인/공평한 욕구를 의미한다. 전개 1단계 2, 3회 기의 이론적 근거는 비합리적인 신념을 합리적으로 전환하는 곳인데 중점을 두었다면 변증법적 행동치료는 개인의 부정적 감정을 온전히 수용하여 긍정 정서와 부정 정서를 통합하여 사고하도록 하는 도와준다(Mcnair et al., 2017; Sakdalan & Gupta, 2014; Shingler, 2004).

전개 2단계인 4, 5회기는 고통감내력 기술훈련이다.

변증법적 행동치료(DBT)의 고통감내력 기술은 매우 큰 스트레스를 주는 상황, 즉, 고통이 심한데 이것을 빨리 낮출 수 없을 때 위기 생존 기술의 활기 비밀, 지혜로운 미음으로 주위 분산시키기, 자기 위안 기술, 신체 이완, 고통에서 잠시 탈출하는 섬의 섬의 상자 만들기 등을 사용하는 것이다. 전개 2단계 4, 5회 기의 이론적 근거는 고통 감싸기로 고통을 일으키는 촉발 사건으로 인한 극단적인 감정을 다루기 위해 자해 충동 정지하기, 한걸음 물러서기, 냉동 복식 기술훈련을 사용하는 것이다(Lihnehan, 1993b,

2020).

전개 3단계인 6, 7회기는 정서조절 기술훈련이다. 감정을 관찰하고 기술하여 자신의 감정을 정확히 알기이다. 슬픈 감정, 외로움의 정서적 증상을 변증법적 집단 기술훈련, DBT는 서로 반대쪽에 있는 양극단(정(政)-반(反))을 통합(합(合))하는 정반합 원리인 변증법을 토대로 개발된 심리치료 이론으로 자신을 변화시키는 것과 자신을 있는 그대로 수용하는 그것 사이의 균형을 이루면서 자해 청소년의 건강 변화를 위해 지혜로운 마음으로 수용하기 기술이다(Lihnehan, 1993b, 2020).

전개 4단계인 8, 9회기는 대인관계 효율성 기술훈련이다. 긍정적인 관계를 만들고 유지하는 방법 익히기 GIVE 기술훈련으로 나의 권리나 바람에서 거절하거나 상대의 압력에 저항해야 하는 상황에서 대인관계를 위한 우선순위 정하기이다. 전개 4단계 8.9회 기의 이론적 근거는 효과적인 대인관계는 다른 사람이 내가 원하는 것 하게 하기, 존중받지 못한 상황을 극복하고 자해행동 정지했던 경험과 재발 교육이다(Linehan, 1993a).

마지막 10회기 종결 단계인 변증법적 행동치료(DBT) 총정리로 가장 도움받았던 기술과 전략이 무엇이었는지 이야기 나눈다.

10회기의 이론적 근거는 앞으로 자해행동하지 않기 서약서 쓰기 종결 감정 다루기이다(조안남, 2023). 이에 따른 중학생의 비자살적 자해행동 감소를 위한 예비 DBT 프로그램 구성(안)은 프로그램의 활동 내용의 이론적 근거는 <표IV-6>과 같다.

<표Ⅳ-6> 프로그램의 활동 내용 이론적 근거

단계	회 기	활동 내용	이론적 근거
도입 단계	1	• 긴장감을 낮추고, 친밀감 형성하기 • 규칙을 정하고 서약서 개인정보 동의서 작성하기 • 비밀보장의 범위 녹음에 대한 동 • 프로그램 목적 및 집단 활동 참여하기 • 개인적인 목표 세우기 • 감소해야 할 행동과 긍정적인 행동 기술 작성하기.	(김경희, 2017)
전개 단계 1 (마음챙김)	2	마음챙김 : ‘What’ 기술 • 마음챙김이란? 현재 순간을 인식하고 우리의 마음을 우리가 원하는 곳에 두는 것. • 마음챙김: ‘관찰하기’ 연습 마음챙김을 통하여 우울감 알아차리기. • 마음챙김 관찰하기를 통하여 자해행동 동기를 탐색하기	
	3	마음챙김(호흡 관찰 연습하기 • 마음챙김 ‘HOW’ 기술 • 무비판적 마음 갖기 • 있는 그대로를 보십시오. 좋은 것과 나쁜 것을 평가하려고 하지 않기 • 한가지 마음 갖기 • 지금, 이 순간에 완전히 자신을 몰입시키기 • 효과적인 것에 집중하기	
전개 단계 2 (고통 내기 기술)	4	마음챙김(호흡 관찰하기). • 고통 내기 기술: 위기 생존 기술화 달라진 활기 비밀(지혜로운 마음으로 주위 분산시키기) • 자기 위안 기술, 섬의 삼의 상자	Linehan (1993b, 2020).
	5	마음챙김(호흡 관찰하기) • 고통감내력 기술 • 자기 위안 기술, 섬의 삼의 상자 • 고통을 일으키는 촉발 사건 (STOP 기술, 한걸음 물러서기)	
전개 단계 3 (정서조절 기술)	6	마음챙김(호흡 관찰하기) • 정서조절 • 지혜로운 마음으로 수용하기 기술로 주의 분산하는(ACCEPTS) 연습하기 • 활동하기(Activites) • 이바지하기 contributing) • 비교하기(Comparisons)	Linehan (1993b, 2020).

		• 정·반대 감정 만들기(Emotions) • 밀어내기(Pushing Away) • 생각(Thoughts) • 고통 감내 훈련을 통하여 자행동 충동 때 지혜로운 마음으로 정서조절 수용하기	
	7	마음챙김(호흡 관찰하기) • 대인관계 효율성을 감소시키는 요인 알기 • 대인관계 효율성 훈련 (긍정적인 관계를 만들고 유지하는 방법 익히기: GIVE 기술) • 친절하게(Gentle) • 호의적으로 행동하면서(Interested) • 수인 적 태도로(Validate). • 가벼운 마음으로(Easy Manner) • 좋은 관계 맺고 파괴적인 관계 끝내기 • 대인관계 효율성 스킬을 통하여 친구와 좋은 관계 맺는 방법	
전개 단계 4 (대인관계 효율성)	8	마음챙김(호흡 관찰하기) • 대인관계 효율성을 감소시키는 요인 알기 • 대인관계 효율성 훈련 (긍정적인 관계를 만들고 유지하는 방법 익히기: GIVE 스킬) • 친절하게(Gentle) • 호의적으로 행동하면서(Interested) • 수인 적 태도로(Validate) • 가벼운 마음으로(Easy Manner) • 좋은 관계 맺고 파괴적인 관계 끝내기 • 대인관계 효율성 스킬을 통하여 친구와 좋은 관계 맺는 방법	(Linehan, 1993a).
	9	마음챙김(호흡 관찰하기) • 대인관계 효율성 훈련. • 친구랑 자해행동 정지했던 경험 나누기. • 자해행동 재발 교육.	
종결 단계	10	마음챙김(호흡 관찰하기) • 미리 연습하기 • 문제행동으로 이어질 수 있는 상황을 상상하기 • 미리 연습하기 워크시트를 완성하기 • DBT 행동치료(DBT) 총정리 • 가장 도움받았던 기술과 전략이 무엇이었는지 이야기 나눔 • 앞으로 자해행동하지 않기 서약서 쓰기 • 종결 감정 다루기	(조안남, 2023).

(2) 예비 프로그램 개발

이상에서 제시한 프로그램 개발의 이론적 근거를 기초로 개발된 중학생의 비자살적 자해행동 감소를 위한 예비 DBT 프로그램 구성(안)은 <표IV-7>과 같다.

<표IV-7> 중학생의 비자살적 자해행동 감소를 위한 DBT 예비 프로그램 구성(안)

단계	회기	주제	활동 목표	예비 구성요소(안)	
				DBT 프로그램 구성	비자살적 자해행동 감소를 위한 요소
도입	1	마음 친구 함께 해봐요~	- 신뢰감 - 안정성 확보	• 라포형성 (신뢰감, 안정 확보) • DBT 개념 이해 프로그램 설명 • 비밀보장의 범위 녹음에 동의 • 집단구성원 약속 정하기 • 도입 면담(심리검사 및 과거 심리치료 경험 파악) • 사전검사 실시(측정 도구 6가지)	
	2	마음챙김 기술 (What)	- 나의 주의력 문제 알기/바꾸 고 싶은 감정 찾기	• 마음챙김: (What) • 내 감정을 관찰하기 • 마음에 흐르는 감정을 관찰하여 언어로 기술 • 온전히 집중하여 몸과 마음을 집중하여 느껴 보기	• 자해행동 동기 탐색 (자해, 숨기지 않기) • 자해행동 관찰일지 쓰기 • 비합리적 신념 파악 원인 알아차리기
전개	3	마음챙김 기술 (HOW)	- 일어나는 감정의 파도를 조심해!	• 마음챙김 기술(HOW) • 평가하지 않고 하나씩 효과적으로 정서조절 • 감정 카드를 활용한 자신의 감정 알아차려서 기록하기 • 자신의 주의력 문제에 관한 연구	• 자해 이해하기 • 자해를 왜 할까요? • 자해했던 감정 이야기 나누기
	4	정서 조절	- 일어나는 감정을 조절하기	• 정서조절 (감정을 균형 잡기) • 정서조절 (사건을 다양한 시각에서 보기) • 자신의 감정 이해하기, 우울감 감소하기	• 자해를 촉발하는 요인에 지혜롭게 대처하기 • 위기 대처의 기술 배우기
	5	정서 조절	- 일어나는 감정에 머무르기	• 정서조절 (현실의 고통을 자연스럽게 받아들이기) • 기꺼이 하는 마음이 주는 장점을 알고 수용하기 • 현재 순간에 몰입하기	• 지속성 점검 • 자동적 사고 및 비합리적 신념, 우울감 점검(스트레스 대처방식, 핵심 신념 찾기) • 자해 이해의 정서 다루기

	6	고통 감내력 훈련	-나를 긍정적으 로 돌보기	• 고통감내력 훈련 • 자신을 긍정적으로 돌보는 방법 배우기 • 한가지 마음만 가지고 지금, 이 순간 집중하기	• 자동적 사고 및 비합리적 신념. (스트레스 대처방식 찾기, 긍정적인 신념으로 바꾸어 써보기)
	7	고통 감내력 훈련	-STOP 기술 연습하기	• 고통감내력 훈련 • 정서적 고통 수위 측정하기 • 고통을 일으키는 촉발 사건 (정지하기, 한걸음 물러서기)	• 자해 위험의 지속적 평가 • 자해행동 정지 연습하기
	8	대인관 계 효율성 훈련	-다른 사람을 수용하기	• 대인관계 효율성 훈련 • 친구에게 관심 가지기 • 다른 사람이 말한 내용 잘 듣고 다시 말해주기 연습	• 친구와 자해행동 정지에 관한 이야기 적어보기 • 생활 습관 분석
	9	대인관 계 효율성 훈련	-자해행동 감소의 변화 알기	• 대인관계 효율성 훈련 • 친구랑 자해행동 정지했던 경험 나누고 칭찬해 주기 • 자해행동 재발 교육	• 자해행동 재발 방지 교육 • 예방연습 (탄력성 활용)
종결	10	마무리	-여정을 마치고	• 변증법적 행동치료 (DBT) 예비 프로그램 성과 효과성 점검기록	• 앞으로 자해행동 하지 않기 서약서 쓰기 • 종결 감정 다루기

(3) 예비 프로그램(안) 구성 및 내용 타당도 전문가 검증

예비 프로그램의 내용 타당도를 검증함으로써 본 프로그램의 구성 및 내용 타당도를 담보하고 나아가 프로그램의 효과를 보장하기 위한 절차로서 관련 전문가 3인을 통해 프로그램에 대한 자문을 진행하였다. 전문가 자문은 총 3차례에 걸쳐 진행되었고, 각각의 전문가와 연구자가 1:1 대면 방식으로 진행하였다. 1, 2차 자문은 예비 프로그램 구성 단계에서 비자살적 자해행동의 중학생을 상담 및 변증법적 행동치료 기술훈련을 지도한 경험이 있는 전문가 1인과 DBT 프로그램을 다수 개발한 경험을 가진 DBT 전문가이자 상담심리 전문가로부터 진행되었다. 또한, 3차 자문은 DBT 전문가이자 상담심리 전문가 2인에게 예비 프로그램 진행 후 예비 프로그램을 수정하고 본 프로그램을 확정하기 위한 단계에서 자문을 진행하였다. 자문에 참여한 전문가 이력과 절차는 <표IV-8>, <표IV-9>에 제시하였다.

<표Ⅳ-8> 예비 프로그램 타당성 검증 전문가 정보

전문가 유형	이력
교육학 (상담심리) 박사	- 교육학 (상담심리) 박사 - 한국심리학회 공인 임상 심리 전문가 - 보건복지부 공인 정신보건 임상심리사 1급
DBT 전문가 1	- 임상 상담심리학 박사 - 한국심리학회 공인 상담심리사 1급 - 한국심리학회 공인 임상 심리 전문가 - DBT 프로그램 개발 연구 경험 다수 - DBT 강의 경험 - 청소년 자살 및 자해행동 상담 경험 다수
DBT 전문가 2	- 상담심리학 박사 - 한국심리학회 공인 상담심리사 1급 - DBT 프로그램 개발 연구 경험 다수 - DBT 강의 경험 - 청소년 자살 및 자해행동 상담 경험 다수

<표Ⅳ-9> 프로그램 개발과 타당도 검증 절차

연구 내용	기간
• 문헌 검토	2022년 7월~2023년 2월
• 프로그램 1차 자문	2023년 2월
• 프로그램 2차 자문	2023년 3월
• 요구 조사 실시	2023년10월1일~2023년10월10일
• 예비 프로그램 시행	2023년 11월 6일~12월2일
• 프로그램 3차 자문	2024년 1월
• 프로그램 확정	2024년 2월
• 본 프로그램 시행(실험집단)	2024년 3월12일~5월14일(매주 화요일) 총 10주
• 프로그램 시행(비교집단)	2024년 3월7일~5월9일(매주 목요일) 총 10주
• 프로그램 시행(통제집단)	2024년 5월16일~7월4일(매주 목요일) 총 10주
• 실험집단 추후 검증	2024년 8월13일(화요일)
• 비교집단 추후 검증	2024년 8월16일(금요일)

1차와 2차 자문에서 제시된 전문가 의견은 다음과 같다.

첫째, 가장 위급한 상황을 다룰 수 있도록 고통감내력 기술을 정서조절 기술에 선행하여 시행하는 것이 바람직하다.

둘째, 숙제 확인하는 시간 10분이라도 가지면서 대상자들이 실제 프로그램 내용을 적용할 능력을 배양하고 있는지 확인할 필요가 있다.

셋째, 고통 감싸기 중에서 주의 분산과 자기 위안 기법을 포함하되, 이 중 내담자가 실제 상황에서 적용할 수 있는 한두 가지에 집중하여 구체적으로 안내하고 이에 대한 과제 요구 및 피드백 제공이 필요하다.

넷째, 정서조절 기술 중 1) 감정 자각하고 인식하기 2) 감정에 머무르기 3) 감정이 사실에 부합하는 것인지 판단해 볼 필요가 있으며 4) 반대 행동하기로 조절하기의 내용을 포괄하되, 특히 감정을 자각하고 인식하는 방법에 초점을 맞추어야 한다.

다섯째, 대인관계 기술훈련에 대해 모두 교육하기 힘들면, 3가지 옵션이 있다는 점을 알려주고, 세 옵션 중 잘해 보지 않던 것을 적용해 보도록 할 필요가 있다. 예를 들어, 이 중 거절하기, 자기주장 해 보기 중심으로 연습해 보는 접근이 있을 수 있다.

구성된 전문가들은 변증법적 치료를 적용한 본 프로그램을 자해 청소년에게 도움이 될 것으로 평가하였으며, 대상자들이 실제 상황에서 직접 활용할 수 있도록 보다 실질적인 프로그램으로 구성되면 좋겠다는 의견이 있었다. 이상과 같은 전문가 자문 및 이에 대한 반영 내용을 회기별로 제시하면 <표IV-10>과 같다.

<표Ⅳ-10> 회기별 전문가의 의견 및 반영

단계	회기	전문가의 의견 및 내용 반영
도입 단계	1	• 참여자들의 라포형성과 신뢰감, 안정성 확보하는 데 의견을 반영하였다. • 도입 단계에 진행해야 할 내용과 순서를 반영하였다.
전개 1단계 (마음챙김 기술)	2,3	• DBT의 핵심은 마음챙김 기술이니, 마음을 관찰하고 관찰된 마음을 기술하고 표현하도록 훈련이 잘 진행되도록 해야 한다는 의견을 반영하였다. • 자해행동 위험군 가의 감정이 너무 깊게 있는지 살펴보고 자해행동이 재발하지 않도록 기술훈련을 안내하고 훈련해야 한다는 전문가의 의견을 반영하였다.
전개 2단계 (고통감내력 기술)	4,5	• 프로그램 시작 전 호흡 관찰 시간을 넣어서 참여자들의 심리적 안정하도록 도움이 되고, 호흡 관찰 시간은 5분을 넘지 않게 하라는 전문가의 의견을 반영하였다. • 가장 위급한 상황을 다룰 수 있도록 고통감내력 기술을 정서조절 기술에 선행되어야 한다는 전문가의 의견을 반영하였다. • 자해행동 감소를 위한 프로그램의 구성면에서 먼저 자해행동 충동 시 쉽의 상자 만들기 매우 적절하다고 판단된다는 전문가의 의견이 있었다.
전개 3단계 (정서조절 기술)	6,7	• 정서조절 기술 중 감정 자각하고 인식하기, 감정에 머무르기, 감정이 사실에 부합하는 것인지 판단 해 보기, 반대 행동 하기로 조절하기의 내용을 포괄해야 한다는 전문가의 의견을 제시하였다. • 특히 감정을 자각하고 인식하는 방법에 초점을 맞추어야 한다는 전문가의 의견이 있었다. • 자해행동 충동 시 감정조절 할 수 있는 적절한 내용이라 는 전문가의 의견이 있었다.
전개 4단계 (대인관계 효율성 기술)	8,9	• 대인관계 기술훈련에 대해 모두 교육하기 힘들면, 3가지 옵션이 있다는 점 알려주고, 세 옵션 중 잘해 보지 않던 것을 적용해 보라는 전문가의 의견을 반영하였다. • 거절하기, 자기주장 해 보기 중심으로 연습 하라는 전문가의 의견을 반영하였다. • 전문가는 변증법적 치료를 적용한 본 프로그램을 자해 청소년에게 도움이 될 것이라 평가하였으며, 대상자들이 직접 활용할 수 있도록 프로그램이 구성되면 좋겠다는 의견을 제시하였다.
종결 단계	10	• 전체 프로그램 만족도 및 목표 달성도 평가 변증법적 행동 치료(DBT) 효과성 점검기록 성찰 내용 나누기 진행하도록 하라는 전문가의 의견을 반영하였다. • DBT 기술에 대한 퀴즈 의미 있는 변화 알아보도록 하고 목표 달성 확인하는 과정이 가지도록 해야 한다는 전문가의 잘 반영하였다. • 자해행동 금지 서약서 작성하여 재발하지 않게 심리교육이 진행하도록 해야 한다는 전문가의 의견을 반영하였다.

(4) 예비 프로그램(안) 구성 및 내용 타당도 학생 검증

중학생의 비자살적 자해행동 감소를 위한 변증법적 행동치료(DBT) 집단 기술훈련 프로그램을 시행하기에 앞서 예비 프로그램을 시행하였다. 이는 프로그램의 목적을 달성하기 위한 진행 및 운영상의 문제, 치료 구성의 적절성, 활동 내용의 이해도 등의 타당성을 검증하기 위한 것이다. 본 프로그램 개발을 위한 전 단계로 실시한 예비 프로그램의 참여자는 본 연구에서 선정한 측정 도구인 자해행동 척도(SHI), 고통감내력 척도(DTS), 정서조절 척도, 우울 척도(CES-D), 비합리적 신념 척도(IBT)를 적용하여 최종 3명을 선정하였다.

예비 프로그램 실시기간은 2023년 11월 6일부터 12월2일까지 매주 화요일 5교시에 이루어졌으며, C 중학교 Wee class 상담실에서 총 5회기에 걸쳐 한 1회기 당 45분씩 진행하였다. 예비 프로그램은 연구자가 직접 진행하였으며 Wee Class 상담실의 쾌적하고 안정된 공간에서 실시하였다. 예비 프로그램에 참여자들의 의견과 반응, 또한, 변화에 대한 보고 및 관찰 등을 토대로 프로그램 내용은(마음챙김, 고통감내력, 정서조절, 대인관계 효율성) 운영 방식을 보완하였다. 예비 프로그램에 참여한 참여자들을 대상으로 마지막 회기 종료 후 회기와 진행이 적절했는지, 프로그램 장소와 환경은 어떠했는지 프로그램 시행 후 도움이 된 점과 개선점에 대해 설문을 실시하여 예비 프로그램에 대해 평가하였다. 예비 프로그램 참여자들에게는 프로그램 종료 후 소정의 답례를 지급하였다. 예비 프로그램에 대한 DBT의 평가 내용은 <표IV-11>에 제시하였다.

<표Ⅳ-11> 예비 프로그램에 대한 DBT의 평가 내용

영역	내용
회기와 진행	• 회기는 10회기 적절함. • 시간은 1회 45분, 주 1회 적절함.
장소 및 환경	• 주변에 소음도 없고, 독립된 Wee Class 상담실 환경은 쾌적하고 안락하여 만족하였음.
프로그램 진행	• 변증법적 행동치료(DBT) 집단기술훈련 참여할 때 친구들이 알까 봐 걱정했는데 자해행동을 멈출 수 있는 기술훈련을 배워서 자해를 안 할 것 같아서라고 함. • 과제를 점검하고, 새로운 기술을 익히는 방식으로 진행한다. 보니 자연스럽게 마음챙김 기술과 정서조절 기술을 익힐 수 있었음. • 자해행동 했던 나에 대한 분노가 커서 순간 주변의 물건들을 집어 던지는 일이 종종 있었는데 그런 충동이 드는 순간 알아차리게 되었음. • 부정적인 감정을 조절하고 다르게 행동할 수 있게 된 사건을 경험하면서 프로그램에서 배웠던 기술들이 어느 순간 나에게 스며들어 있다는 그것을 느낄 수 있었음. • 상담자가 다양한 해결 방안에 대해 제시하고, 관심을 두는 모습이 인상적이었음.
도움이 되는 점	• 라포형성이 잘 이루어지고, 소수 인원으로 예비 프로그램 진행하여 자신의 문제를 자유롭게 개방함. • 고민이나 화났을 때 타인에게 막말했던 행동을 고치는 방법 알아서 도움 되었다고 함. • 정서조절 부분에서 자신의 마음 상태를 조금 더 알게 되었음. • 계획을 세우는 방식을 배우고 실천하다 보니 부주의했던 행동들이 많이 감소함을 느꼈음. • 마음챙김과 정서조절 기술에서 사실확인을 배우면서 평소 내 감정에 대해 정확하게 알게 됨. • 감정에 의해 충동적으로 행동하고 후회하는 일이 많았는데 마음챙김 기술과 정서조절 기술을 통해 감정을 알아차리고 조절하는 게 예전에 비해 훨씬 수월해졌음. • 프로그램이 자해행동을 감소시키는 데 도움이 되었음. • 내 감정과 마음 상태를 잘 알아차리게 만드는 데 도움이 되었음. • 친구의 의견을 듣고 나를 돌아볼 시간이 되어 자신의 비합리적 신념이 긍정적으로 변해서 좋았음.
개선점	• 변증법적 행동치료(DBT) 집단기술훈련 프로그램이 어려워하여 이론적 배경 설명이 필요했음. • 변증법적 행동(DBT) 집단기술훈련들을 일상생활에서 활용했는지를 확인할 수 있는 대조표가 좀 더 구체적으로 구조화되었으면 좋겠음. • 변증법적 행동(DBT) 집단기술훈련 7명이 45분에 과제 점검하고 기술훈련 연습하는데 시간이 짧아서 시간 확보가 필요함.

(5) 예비 프로그램의 수정·보완

중학생의 비자살적 자해행동 감소를 위한 변증법적 행동치료(DBT) 집단기술훈련 프로그램 개발을 위한 예비 프로그램 타당도 검증을 위하여 전문가 3인과 학생 참여자의 의견을 종합하였으며 DBT 의견을 반영한 예비 프로그램 수정·보완 내용은 <표Ⅳ-12>와 같다.

<표Ⅳ-12> DBT 의견을 반영한 예비 프로그램 수정·보완 내용

	회기	예비 프로그램 내용	전문가 피드백 내용	수정된 내용
도입	1회	-라포형성 (신뢰감, 안정 확보) -DBT 개념 이해 프로그램 설명	-일반적인 집단상담과 달리 집단원의 나눔은 최소화하고 교육 연습 위주로 진행할 것	-DBT 기술 4가지를 기술을 청소년들이 이해하기 쉽게 발달 과정 충분히 고려하여 설명
전개 1 단계	2회	-마음챙김: (What) -내 감정을 관찰하기	-What 기술과 HOW 기술 충실하게 배우기	-DBT기술: 마음챙김 기술
	3회	-마음챙김: (HOW) -마음에 흐르는 감정을 관찰하여 언어로 기술하기 -온전히 몸과 마음을 집중하여 느껴보기		
전개 2 단계	4회	-고통감내력 기술: -위기 생존 기술 (지혜로운 마음으로 주위 분산시키기) -자기 위안 기술 -쉽의 삼의 상자	-스트레스 찾기, 스트레스에 대한 기존의 대처(자해) 효과적으로 행동하기를 통해 나에게 필요한 행동, 도움 되는 행동하기	- DBT 기술: 정서조절 1. 감정 자각하고 인식하기 2. 감정에 머무르기 3. 감정이 사실에 부합하는 것인지 판단 해 보기 4. 반대 행동 하기로 조절하기
	5회	-고통감내력 기술 자기 위안 기술 쉽의 삼의 상자 과제 점검 -고통을 일으키는 촉발 사건(정지하기, 한걸음 물러서기)	-나만의 구급상자 만들기: 자해 발동이 예측되는 순간 꺼내 쓸 수 있는 or 자기 위안 방법 찾기	
전개 3 단계	6회	-정서조절 기술 -감정 자각하고 인식하기 -감정에 머무르기 행동 치료	-정서에 대한 바른 이해 정서의 기능 설명하기 -자신의 정서 알아차리기	-DBT 기술:고통감내력 기술 1. 고통 감내와 감정조절의 순서 바꾸기 2. 숙제 확인하는 시간 10분이라도 갖기 3. 고통 감싸기 중에서 주의분 산과 자기 위안 기법을 포함하되, 이 중 내
	7회	-정서조절 기술 정서 반응 변화를 위한 기술	-정서의 발현 경로 탐색하기 -비합리적 신념 탐색	

		-정서변화를 위한 반대로 행동하기	or 사고-감정-행동으로 이어지는 과정 교육 및 탐색하기	담자가 써먹을 수 있는 것 한두 가지에 집중하여 구체화 시켜주고 숙제 내 주기
전개 4 단계	8회	-대인관계 효율성 훈련 -친구에게 관심 기울이기 -다른 사람이 말한 내용 잘 듣고 다시 말해 주기 연습	-대인관계를 방해하는 믿음 찾기, 옹호 반박 활동, 기표 주보, 친심원해 ³⁾ , 근가진자 ⁴⁾ 중 집단에 맞는 기술 적용 -거절과 부탁 따져보기	- DBT 기술:대인관계 효율성 1. 3가지 옵션이 있다는 점 알려주기 2. 거절하기/자기주장 해 보기 3. 진심 원해 - 친구를 인정해 주는 말해보기
	9회	-대인관계 효율성 훈련 -친구랑 자해행동 정지했던 경험 나누고 칭찬해 주기 -자해행동 재발 교육		
종결	10회	-변증법적 행동치료(DBT) 예비 프로그램 성과 및 효과성 점검기록	-앞으로 자해행동하지 않기 서약서 쓰기 -종결 감정 다루기	-마무리 -자해행동 퀴즈 정리하기

도입 단계 1회기는 전문가의 피드백 내용은 일반적인 집단상담과 달리 집단원의 나눔은 최소화하고 교육 연습 위주로 진행하는 것이 바람직하다는 것이다. 이에 대한 수정 보완 내용은 DBT 기술 4가지 기술을 청소년들이 이해하기 쉽게 발달 과정 충분히 고려하여 설명하였다.

전개 1단계인 2, 3회기에 대한 전문가의 피드백 내용은 What 기술과 HOW 기술 충실하게 배우기에 관한 것이다. 수정 보완 내용은 DBT 기술의

3) 국내 임상 DBT 집단기술훈련에서 교육자의 편의와 내담자의 암기를 돕기 위해 GIVE를 “친심원해” 등의 약어로 번안하는 사례가 있으며, ‘친절’, ‘심(마음/관심)’, ‘원(인정/공감)’, ‘해(해맑게/쉽게/부드럽게)’와 같은 표현으로 기억술을 부여한다. 하지만, DBT의 공식 매뉴얼이나 국제 표준 교재에서는 ‘GIVE’, ‘DEAR MAN’, ‘FAST’가 원칙적으로 사용된다. 즉, “친심원해”는 한국 임상 현장에서 비공식적으로 널리 쓰이긴 하나, 공식 skill 명칭은 아니라고 할 수 있다. 하지만, 본 연구에서는 국내에서 널리 통용되는 용어로서 친심원해(친절), ‘심(마음/관심)’, ‘원(인정/공감)’, ‘해(해맑게/쉽게/부드럽게)’로 통일하여 사용하였다.

4) “근가진자”(apparent competence)는 DBT에서 겉보기 유능성과 실질적 취약성의 ‘분리’ 현상을 일컫는 중심 개념이며, 치료자는 이 점을 반드시 감안하여 표면적 행동이 아닌 전체 맥락에서 기능 수준을 파악해야 한다. DBT 기술 습득 및 적용 과정, 치료 목표 설정, 치료 결과 해석 등 모든 임상 단계에서 중요한 안내 원리로 작동한다.

핵심이므로 마음챙김 기술을 구체적으로 훈련할 수 있도록 매회가 시작할 때 반복해서 배우도록 구성하였다.

전개 2단계인 4, 5회기에 대한 전문가의 피드백 내용은 고통감내력 기술 훈련을 익히도록 하는 것이다. 스트레스 찾기, 스트레스에 대한 기존의 대처(자해) 효과적으로 행동하기를 통해 나에게 필요한 행동을 하도록 도움이 되는 나만의 구급상자 만들어 자해 발동이 예측되는 순간 꺼내 쓸 수 있는 or 자기 위안 방법 찾기이다. 수정 보완 내용은 DBT 기술 정서조절 기술 훈련으로 감정 자각하고 인식하기, 참여자의 감정에 머무르기이며, 감정이 사실에 부합하는 것인지 판단해 보게 하도록 프로그램 반영하고, 부정적인 정서를 긍정적인 정서로 반대 행동하기로 수정 보완하여 반영하여 구성하였다.

전개 3단계인 6, 7회기에 대한 전문가의 피드백 내용은 정서에 대한 바른 이해 정서의 기능 설명하고, 자신의 정서 알아차리도록 하는 것이다. 정서의 발현 경로 탐색해 보게 하고 비합리적 신념 탐색과 사고- 감정-행동으로 이어지는 과정 교육 및 탐색하도록 해야 한다. 수정 보완 내용은 DBT 기술 고통감내력 기술훈련은 비자살적 자해행동 참여자들은 위기 대처 훈련 우선되어야 하므로 정서조절과 회기 순서를 바꾸어야 한다. 숙제 확인하는 시간 10분이라도 갖고, 고통 감싸기 중에서 주의 분산과 자기 위안 기법을 포함한, 이 중 참여자가 직접 활용할 수 있는 것 한두 가지에 집중하여 구체화해 숙제 내주기를 구성에 반영하였다.

전개 4단계인 8, 9회기에 대한 전문가의 피드백 내용은 대인관계를 방해하는 믿음 찾기와 옹호 반박 활동에 관한 것이다. 효과적인 대인관계 기술 기표 후보는 기술하기, 표현하기, 주장하기, 보상하기 집단협상 기술이며, 친 심원한 친절하게, 관심 보이기, 원만하게, 이해해 주기, 근가진자는 금지하라 사과, 가치 지키기, 진솔하게, 자타 공평 그중 집단에 맞는 기술을 적

용하도록 하였다.

수정 보완 내용은 DBT 기술 대인관계 효율성 기술훈련은 3가지 옵션이 있다는 점 알려주기이다. 거절하기 자기주장 해 보기, 근가진자, 친심원해 (Heerebrand et al., 2021; Panos, et al., 2014)의 친구를 인정해 주는 내용 구성에 반영하였다.

종결 단계인 10회기에 전문가의 피드백 내용은 앞으로 자해행동하지 않기 서약서 쓰기, 종결 감정에 관한 것이다. 수정 보완 내용은 마무리 자해행동을 퀴즈 정리하기이다. 최종 프로그램 구성 전문가들의 의견과 지도교수님의 의견을 반영하여 예비 프로그램을 수정 · 보완한 중학생의 비자살적 자해행동 감소를 위한 최종 변증법적 행동치료 프로그램을 구성하였다.

2) 최종 프로그램의 개발

(1) 프로그램의 구성 원칙

본 연구에서 제시하는 비자살적 자해행동 중학생의 자해행동 감소를 위한 변증법적 행동치료(DBT) 집단기술훈련 프로그램은 청소년 자해행동에 관여하는 인지적, 정서적, 행동적 요인의 변화를 이끌고 궁극적으로 이들의 반복된 자해행동을 감소시키는 데 목적을 두고 수행되었다. 또한, 이러한 목적을 달성하기 위한 구체적인 프로그램의 목표로서 ‘자신의 상태를 있는 그대로 바라볼 수 있다’, ‘자신의 비합리적 신념과 정서조절 문제를 수용하고 통제력을 습득하며 유익과 불이익을 분별한다’, ‘자기 이해 및 감정에 대한 통제력을 갖고 행동한다’, ‘주변의 인간관계에 적극적으로 반응하며 개선된 관계를 유지한다’ 등을 설정하였다.

본 연구는 앞서 살펴봤던 관련 문헌 및 이론에 대한 고찰, 다양한 담론에서 제시하는 함의와 시사점 및 이를 반영한 프로그램 개발 절차 등을 통해서 위에서 제시한 프로그램의 목적 및 목표를 달성할 수 있는 프로그램의

구성 원칙을 다음 같이 설정하였다.

첫째, 마음챙김(What, HOW) 기술훈련 활동의 목표는 자신의 비합리적인 신념이 왜곡된 인지적 내용을 변화시킨다.

둘째, 고통감내력 기술훈련 단계로 자해행동의 충동성이 올라오면 잠시 멈추는 ‘STOP’ 기술훈련이다. S:정지하기(Stop) T: 한걸음 물러서기(take a step back) O: 관찰하기(Observe) P: 마음챙김(Proceed Mindfully)을 통하여 고통을 일으키는 촉발 사건과 촉발 사건으로 인해 비자살적 자해행동의 떠오른 생각과 감정, 몸의 안과 밖에서 느껴졌던 충동에 대해 따져보고 자해행동을 멈춘다.

셋째, 정서조절 기술훈련과 심리교육을 통하여 자신의 감정을 알아차리고 감정에 대한 오해를 바로잡아 올바른 관점으로 전환하고, 있는 그대로의 감정을 이해한다.

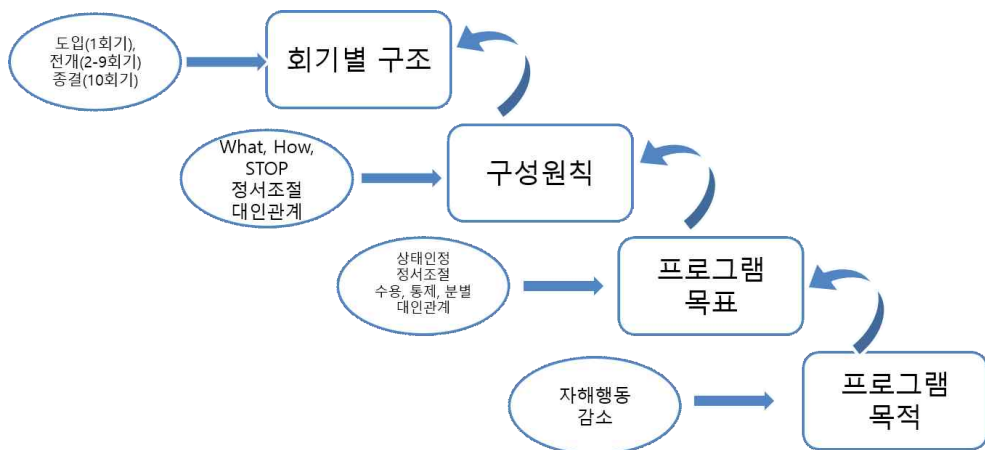
넷째, 대인관계 효율성은 대인관계에서 친심원해(친절하게, 관심을 보이기, 원만하게, 이해해 주기) 기술훈련을 통하여 원활한 대인관계 맺은 방법을 이해한다.

(2) 프로그램 회기별 구조

본 프로그램의 진행은 회기별로 매뉴얼을 구조화해서 각 회기 간의 차이를 최소화하고, 프로그램 진행 과정에 대해 예측할 수 있게 하였다. 본 프로그램은 주 1회 진행으로 총 10회기를 10주간에 걸쳐 진행하였으며, 도입(1회기), 전개(2~9회기), 종결(10회기)로 구성하였다. 본 프로그램의 도입 단계에서는 라포형성(신뢰감, 안정 확보) DBT 개념에 대한 참여자들의 이해를 도모하였으며 비밀보장의 범위에 대한 동의를 받고 집단구성원 약속 정하고 사전검사 실시하였다. 1회기는 도입으로 모듈화로 진행하지 않고, 참여자 간의 소개 및 참여 동기를 나누고 DBT 기본 개념에 대한 이해와 참

여자들의 개별 목표를 설정하도록 구성하였다.

본 연구에서 선정한 프로그램 개발 목적과 이를 달성하는 구체적 전략으로 프로그램 목적, 목표 및 프로그램 구성 원칙과 회기별 구조의 선형적 관계를 시각화하면 다음 <그림Ⅳ-1>과 같다.



[그림Ⅳ-1] 프로그램 목적, 목표, 구성 및 구조의 선형관계

이상에서 기술한 바와 같이 프로그램의 이론적 토대와 구성개념, 구성 절차를 종합하여 본 연구에서 최종적으로 개발된 비자살적 자해행동 중학생의 자해행동 감소를 위한 변증법적 행동치료(DBT) 집단기술훈련 프로그램의 각 회기와 주제 및 활동 목표 및 구성요소는 <표Ⅳ-13>과 같다.

<표Ⅳ-13> 중학생의 비자살적 자해행동 감소를 위한 변증법적 행동치료 (DBT) 집단기술훈련 최종 프로그램

단계	회기	주제	활동 목표	최종 프로그램 구성요소
도입	1	마음 친구 함께 해봐요~	신뢰감 안정성 확보	• 라포형성(신뢰감, 안정 확보) • DBT 개념 이해 프로그램 설명 • 비밀보장의 범위 녹음에 대한 동의 • 집단구성원 약속 정하기 • 도입 면담(심리검사 및 과거 심리치료 경험 파악) • 사전검사 실시
전개	2	마음챙김 기술 (What)	비자살적 자해행동 문제 알기	• 마음챙김: (What) • 내 감정을 관찰하기 • 마음에 흐르는 감정 관찰 및 언어로 기술하기 • 몸과 마음을 온전히 집중하여 느껴보기
	3	마음챙김 기술 (HOW)	일어나는 감정의 파도를 조심해!	• 마음챙김 기술(HOW) • 과제 점검 • 평가하지 않고 하나씩. 효과적으로 내 생각, 감정, 행동해 준 영향을 정리하기
	4	고통감내력 기술	위기 상황에서 STOP 기술훈련 연습하기	• 마음챙김(호흡 관찰하기) • 과제 점검 • 고통 내 기술 위기 생존 기술 • 달라진 활기 비밀 (지혜로운 마음으로 주의 분산시키기) 자기 위안 기술, 쉽의 상자.
	5	고통감내력 기술	나를 긍정적으로 돌보기	• 마음챙김(호흡 관찰하기) • 과제 점검 • 고통감내력 훈련(현실 수용 기술) • 자기 위안 기술, 쉽의 삼의 상자 • 과제 점검 • 고통을 일으키는 촉발 사건 (정지하기, 한걸음 물러서기) • 나의 위기 생존 구급상자 만들기
	6	정서조절 기술	일어나는 감정에 머무르기	• 마음챙김(호흡 관찰하기) • 과제 점검 • 정서조절 기술 • 감정 지각하고 인식하기, 감정에 머무르기 행동치료(DBT)
	7	정서조절 기술	일어나는 감정을 조절하기	• 마음챙김(호흡 관찰하기) • 과제 점검 • 정서조절 기술 • 정서 반응 변화를 위한 기술 • 정서변화를 위한 반대로 행동하기. • 자신의 감정 이해하기. 우울감 감소하기

	8	대인관계 효율성 기술	다른 사람을 수인하기	• 마음챙김(호흡 관찰하기) • 과제 점검 • 대인관계 효율성 훈련 • 친심원해 • 친구에게 관심 기울이기 • 상대 이야기 경청하고 다시 말해주기 연습
	9	대인관계 효율성 기술	자해행동 감소의 변화 알기	• 마음챙김(호흡 관찰하기) • 과제 점검 • 대인관계 효율성 훈련 • 친심원해 과제 점검 • 금가진자 연습 • 자기의 존중감 높이기
종 결	10	마무리	여정을 마치고	• 마음챙김(호흡 관찰하기) • 변증법적 행동치료(DBT) 효과성 점검 기록 • DBT 기술 퀴즈 • 의미 있는 변화 알아보기. • 자해행동 금지 서약서 작성 및 재발 방지 교육

3) 프로그램의 운영 지침

<표Ⅳ-13>에서 제시하는 바와 같이 본 연구에서 제안하는 비자살적 자해 행동 중학생의 자해행동 감소를 위한 변증법적 행동치료(DBT) 집단기술훈련 프로그램의 도입, 전개, 종결에 포함되는 회기별 운영지침은 다음과 같다.

(1) 도입 단계

도입 단계의 활동 목표는 프로그램 운영진과 참여자, 참여자들 간의 친밀감(rapport)형성과 신뢰감, 안정성 확보이다. 따라서 1회기에서 연구자소개 및 집단원 소개를 통하여 서로 친밀감을 형성하도록 프로그램을 구성하였다. 또한, 10회기 동안 진행할 비자살적 자해행동 감소를 위한 변증법적 행동치료(DBT) 프로그램의 목적과 회기별 내용을 설명하고 각각 회기별 진행 방법에 관하여 설명한다. 또한, 집단구성원 간의 참여 규칙을 세우고 녹취에 대한 동의를 구하는 것으로 설정하였다. 프로그램을 시작하는 도입 단계이기 때문에 참여자에 대한 이해를 높이기 위해서 과거 심리치료 경험을

파악하고, 프로그램 종료 후 프로그램 참여의 효과를 다양한 관점에서 파악하기 위한 사전검사를 실시하는 것으로 구성하였다.

(2) 전개 단계 (2회기~9회기)

전개 단계는 2회 기부부터 9회기까지 구성되었다. 전개 단계의 목표는 변증법적 행동치료(DBT) 마음챙김, 고통감내력, 정서조절, 대인관계 효율성 4가지의 기술훈련을 제공함으로써 궁극적으로 프로그램 참여자의 자해행동 감소에 실질적인 도움을 주고자 하였다.

① 마음챙김 (2회기, 3회기)

2회기의 마음챙김 기술(What) 실행의 이론적 목표는 비자살적 자해행동 알기이다. 전개 단계의 2회 기부부터 9회기까지 구성 중 2회기 마음챙김 모듈에서는 마음챙김(What) 기술훈련에는 내 감정을 알아차리기인 마음을 흐르는 감정을 언어로 기술하기 훈련이며, 자해행동 원인을 탐색하고, 자해행동을 숨기지 않기, 내 감정을 정확히 확인하고, 인지적 영역으로 자기 생각을 비합리적 신념을 파악하고 자해행동의 원인을 알아차리도록 구성하였다.

3회기의 마음챙김(HOW) 집단기술훈련 실행의 이론적 목표는 자신에게 일어나는 감정의 파도를 이해하고 감정 카드를 활용한 자신의 감정 알아차려서 기록하기이다. 자해 이해하기와 타인의 감정을 판단하지 않도록 하는 기술이 포함되어 있다. 비난하지 않고 있는 그대로 자해행동 경험을 이해하고 자해했던 감정을 나누어 서로를 이해하도록 구성하였다.

② 고통감내력 (4회기, 5회기)

4회기 고통감내력 기술훈련 실행의 이론적 목표 고통감내력 집단기술훈

련으로 “STOP” 기술이다. “STOP” 기술은 자해 충동 시 S: 정지하기 (Stop) T: 한 걸음 물러서기(take a step back) O: 관찰하기(Observe) P: 마인드풀하게 진행하기(Proceed Mindfully) 고통을 일으키는 촉발 사건과 촉발 사건으로 인해 비자살적 자해행동의 떠오른 생각과 감정, 몸의 안과 밖에서 느껴졌던 충동에 대해 따져보고, 그로 인한 결과가 어떠했는지 예시를 통해 함께 배워보고, 자신의 각각의 사건들을 토대로 활동지에 세부적으로 작성해 보도록 하였다. 자해행동을 하고 나면 심리적 고통과 신체적 고통으로 조절하려는 행동에 따라 일시적으로 감정이 해소되지만, 그러나 곧 이어 스스로 자해를 했다는 사실에 수치심이나 죄책감을 느끼게 되어, 비자살적 자해행동이 습관적인 증상으로 인한 행동을 멈출 수 있는 STOP 기술 연습하기이다. 위기를 경험하거나 감정에 따라 행동하려는 충동이 들 때 연습하기, 고통감내력 기술과 위기 생존 기술, 달라진 활기비밀의 집단기술훈련을 익히도록 한다. 달라진 활기비밀 기술은 달라진 감정, 달라진 생각, 달라진 감각 달라진 자해행동 충동 시 지혜로운 마음으로 주위 분산시키기, 자기 위안 기술을 익히기이다. 이와 더불어 쉼의 상의 상자 속에 자해 위험의 지속적 생기면 마음이 편안해지는 물건을 꺼내 봄으로써 평가 자해행동 정지 연습하고, 위기 상황에서 자해행동이 멈추는 대처 기술을 배우도록 하였다.

5회기 고통감내력 기술 실행의 이론적 목표는 나를 긍정적으로 돌보기이다. 자기 위안 기술을 익히고, 쉼의 상자를 만들어보고, 고통을 일으키는 촉발 사건에 대해 정지하기, 한걸음 물러서기 등을 사용해보고, 자동적 사고 및 비합리적 신념. 정서조절 긍정적인 신념으로 바꾸어 써보게 하고 자해행동을 하고 싶을 때 그 행동을 멈추기 위한 나의 구급상자를 만들어 보게 하였다.

③ 정서조절 (6회기, 7회기)

6회기 정서조절 기술훈련 실행의 이론적 목표는 일어나는 감정에 머무르기이다. 모듈에서는 정서의 기능에 대해 교육함으로써 부정적인 정서에 대해 지나치게 적대시하는 마음을 갖지 않도록 하기이다. 각자가 느끼는 감정에 대해 이해하도록 하였다. 이해를 바탕으로 수용이 이루어지고, 감정에 대한 수용이 이루어지면 변화에 대한 동기를 가질 수 있도록 하였다.

정서조절이 어려운 이유에 대해 교육하고, 감정에 대한 오해를 바로잡는 시간으로 구성하였다. 감정에 대한 지시문을 제시하고, 동의 여부를 체크하게 한 후 참여자 간에 역할극을 통해 동의 입장과 반대 견해가 되어 서로 반론하는 시간을 갖도록 구성하였다. 이를 통해 그동안 자신이 가지고 있었던 감정에 대한 오해를 바로잡고, 올바른 관점에서 감정을 바라보게 하였다.

7회기 실행의 이론적 목표는 일어나는 감정을 조절하기이다. 현재 삶에서 본인이 중요하다고 생각하는 일의 목록과 많은 시간을 보내고 있는 일의 목록을 작성하게 하여 그 중요도를 척도 점수를 부여하게 하였다. 이를 통해 자신이 정작 중요한 일에 집중하고, 많은 시간을 보내고 있었는지를 직접 눈으로 확인하게 한 후 중요하지 않음에도 많은 시간을 들여서 하고 있었던 일들을 확인하도록 하였다. 이러한 과정을 통해 중요하지 않은 일을 걸러내는 작업을 하도록 함과 동시에 자기 삶에서 집중해야 하는 집중 포인트를 발견하고, 동기를 부여하도록 하였다. 정서조절 모듈의 경우 감정경로를 탐색하고 사실확인을 한 결과 사실에 부합하지 않는 감정이 발생하였을 경우 대처 방법인 정반대 행동하기를 교육하고, 연습하도록 구성하였다.

④ 대인관계 효율성(8회기, 9회기)

8회기 대인관계 효율성 실행의 이론적 목표는 다른 사람을 수인하기이다. 대인관계 효율성 집단기술훈련 중 친심원해 기술로 친절하게, 관심을 보이

기, 원만하게, 이해해 주기이다. 친구에게 관심을 가지고 다가가기 친구가 자해행동에 관해서 이야기할 때 친절하게 관심을 보이고, 비난하지 않고 이해해 준다. 다른 사람이 말한 내용 잘 듣고 다시 말해주기 연습이다. 친구와 함께 자해행동 정지에 관한 이야기를 기술하도록 구성하였다.

9회기 대인관계 효율성 실행의 이론적 목표는 “금 가 진 자” 기술로 ‘금지하라 사과, 가치 지키기, 진솔하게, 자타공평’이다. 친구와 갈등을 피하려고 무조건 사과하는 것은 금지하도록 하였다. 친구에게 관심을 기울이기 훈련으로 친구랑 자해행동 정지했던 경험을 나누고 칭찬해 주면서 스스로 자신을 격려해 주기로 구성하였다.

(3) 종결 단계

10회기 여정을 마치는 실행의 이론적 목표는 재해행동 재발을 방지한다. 종결 회기로 도입 회기인 1회기처럼 모듈화로 진행하지 않고 앞선 회기 동안 익힌 집단기술훈련에 대해 총정리 및 평가하는 시간으로 구성하였다. 참여자들이 차례로 돌아가면서 그동안 배운 기술의 명칭을 한 가지씩 이야기하도록 하였고, 퀴즈를 통해 배운 기술에 대해 정리하도록 하였다. 예시로 제시하여 이러한 상황에서 사용할 수 있는 기술을 참여자들이 직접 생각해 보고 각각의 의견을 제시하도록 하였다. 앞으로 발생할 수 있는 상황에서 어떤 기술을 사용해 볼 수 있을지 미리 시연하기 기술을 통해 생각해 보고, 비자 실적 자해행동을 멈출 수 있는 대처 방법을 찾아보는 시간을 갖도록 하였다. 지혜로운 마음으로 주의 환기를 통해 비자살적 자해행동의 위기 상황에서의 대처 방법에 대해서도 교육을 반복하였으면 비자살적 자해행동을 재발 방지 서약서를 작성하도록 하였다.

V. DBT 집단기술훈련 프로그램 효과분석

1. 프로그램 효과의 정량적 분석

1) 집단 간 사전검사 동질성 검증

프로그램의 효과를 검증하기에 앞서서 각 집단 간 사전 동질성 검사를 하였다. 집단 동질성 검사를 위하여 실험집단, 통제집단, 비교집단의 인지적 변인(비합리적 신념)과 구성 하위 요인(자기 비하, 편안한 욕구), 승인 및 편안한 욕구의 차이를 알아보기 위하여 Kruskal-Wallis 검정을 진행한 구체적인 내용은 다음과 같다.

(1) 집단 간 인지적 변인(비합리적 신념)의 사전 동질성 비교

연구 참여자 집단 간 비합리적 사고(자기 비하, 성취 및 편안한 욕구)에 대한 사전 동질성 검사를 시행하였다. 검사 결과, 비합리적 사고 전체($\chi^2=.320$, *n.s*)와 구성 하위 요인 자기 비하($\chi^2=.965$, *n.s*), 성취 및 편안한 욕구($\chi^2=.993$, *n.s*), 승인 및 공평한 욕구($\chi^2=3.218$, *n.s*)에서 통계적으로 유의한 차이를 보이지 않는 것으로 나타나 세 집단 간 사전 동질성이 검증되었다.

집단 간 인지적 변인(비합리적 신념)의 사전 동질성 검사 결과는 <표 V-1>와 같다.

<표 V-1> 집단 간 인지적 변인(비합리적 신념)의 사전 동질성 검사비교

변인 및 하위 요인			평균(표준편차)			평균순위			X^2	df (p)
			실험 집단 (N=7)	통제 집단 (N=7)	비교 집단 (N=7)	실험 집단 (N=7)	통제 집단 (N=7)	비교 집단 (N=7)		
인지적 변인	비합 리적 신념	전 체	65.00 (6.68)	67.71 (8.81)	67.43 (6.11)	9.93	11.64	11.43	.320	2 (.852)
		자기 비하	16.00 (1.83)	14.71 (2.75)	15.57 (2.76)	12.36	9.21	11.43	.965	2 (.617)
		성취 및 편안한 욕구	26.00 (4.08)	28.43 (4.72)	26.43 (4.16)	9.57	12.79	10.64	.993	2 (.609)
		승인 및 공평한 욕구	23.00 (3.16)	24.57 (3.55)	25.43 (1.90)	8.71	10.0	14.29	3.218	2 (.20)

(2) 집단 간 정서적 변인(정서조절 및 우울) 사전 동질성 비교

① 집단 간 정서적 변인(정서조절) 사전 동질성 비교

연구 참여집단 간 정서적 변인의 정서조절 변화(정서에 대한 비수용성, 목표 지향 행동 수행의 어려움, 충동 통제 곤란, 정서적 자각 부족, 정서적 명료성의 부족, 정서조절 전략 부족)에 대한 사전 동질성 검사를 시행하였다. 검사 결과 정서조절 변화 전체($\chi^2=.358$, $n.s$), 정서에 대한 비수용성($\chi^2=.545$, $n.s$), 목표 지향 행동 수행의 어려움($\chi^2=.195$, $n.s$), 충동 통제 곤란($\chi^2=1.029$, $n.s$), 정서적 자각 부족($\chi^2=.276$, $n.s$), 정서적 명료성의 부족($\chi^2=2.134$, $n.s$), 정서조절 전략 부족($\chi^2=.321$, $n.s$) 등 모든 요인에서 통계적으로 유의한 차이를 보이지 않는 것으로 나타나 세 집단 간 사전 동질성이 확인되었다. 집단 간 정서적 변인(정서조절)의 사전 동질성 검사 결과는 <표 V-2>와 같다.

<표 V-2> 집단 간 정서적 변인(정서조절)의 사전 동질성 검사비교

변인 및 하위 요인			평균(표준편차)			평균 순위			X^2	df (p)
			실험 집단 (N=7)	통제 집단 (N=7)	비교 집단 (N=7)	실험 집단 (N=7)	통제 집단 (N=7)	비교 집단 (N=7)		
정서적 변인	정서조절변화	전체	90.43 (14.0)	94.86 (10.7)	95.86 (19.1)	9.86	11.5 7	11.5 7	.358	2 (.836)
		정서에 대한 비수용성	18.00 (4.76)	19.00 (1.73)	19.71 (5.71)	9.64	11.3 6	12.0 0	.545	2 (.762)
		목표 지향 행동 수행의 어려움	10.29 (2.87)	10.43 (3.21)	10.86 (3.02)	10.2 1	11.1 4	11.6 4	.195	2 (.907)
		충동 통제 곤란	14.86 (1.86)	16.14 (2.41)	16.14 (3.24)	9.14	12.3 6	11.5 0	1.02 9	2 (.598)
		정서적 자각 부족	17.57 (5.16)	18.00 (6.51)	17.29 (6.07)	10.2 1	11.9 3	10.8 6	.276	2 (.871)
		정서적 명료성의 부족	8.14 (3.02)	9.29 (1.25)	10.14 (3.02)	8.86	10.5 7	13.5 7	2.13 4	2 (.344)
		정서조절 전략 부족	19.00 (5.16)	19.00 (3.32)	19.14 (4.74)	11.4 3	9.93	11.6 4	.321	2 (.852)

② 집단 간 정서적 변인(우울)의 사전 동질성 비교

연구 참여집단 간 정서적 변인의 우울(신체 및 우울, 정서적 고통, 대인관계, 긍정적 정서)에 대한 사전 동질성 검사를 시행하였다. 검사 결과 정서에 대한 우울 변화 전체($\chi^2=.505$, $n.s$), 신체 및 우울 정서($\chi^2=.387$, $n.s$), 정서적 고통($\chi^2=.680$, $n.s$), 대인관계($\chi^2=.3.354$, $n.s$), 긍정적 정서($\chi^2=.1.148$, $n.s$), 등 모든 요인에서 통계적으로 유의한 차이를 보이지 않는 것으로 나타나 세 집단 간 사전 동질성이 검증되었다. 집단 간 정서적 변인(우울)의 사전 동질성 검사 결과는 <표 V-3>과 같다.

<표 V-3> 집단 간 정서적 변인(우울)의 사전 동질성 비교

변인 및 하위 요인			평균(표준편차)			평균순위			X^2	df (p)
			실험 집단 (N=7)	통제 집단 (N=7)	비교 집단 (N=7)	실험 집단 (N=7)	통제 집단 (N=7)	비교 집단 (N=7)		
정 서 적 변 인	우 울	전 체	62.43 (18.95)	67.29 (14.21)	68.29 (17.75)	10.29	10.36	12.36	.50 5	2 (.777)
		신체 및 우울 정서	32.86 (13.56)	35.57 (9.41)	35.57 (11.63)	10.71	10.14	12.14	.38 7	2 (.824)
		정서적 고통	16.29 (4.23)	17.86 (5.01)	18.29 (4.75)	9.43	11.71	11.86	.68 0	2 (.712)
		대인관 계	6.57 (1.90)	8.14 (2.41)	7.71 (2.29)	7.64	13.36	12.00	3.3 54	2 (.187)
		긍정적 정서	10.57 (2.30)	9.86 (1.68)	10.14 (1.57)	13.0 0	9.79	10.2 1	1.1 48	2 (.563)

(3) 집단 간 행동적 변인(고통감내력 및 자해행동) 변화 사전 동질성 비교

① 집단 간 행동적 변인(고통감내력)의 사전 동질성 비교

연구 참여집단 간 행동적 변인의 고통감내력(조절, 감내력과 몰두, 평가)에 대한 사전 동질성 검사를 시행하였다. 검사 결과 고통감내력에 대한 조절($p>.05$), 감내력과 몰두($p>.05$), 평가($p>.05$) 등 모든 요인에서 통계적으로 유의한 차이를 보이지 않는 것으로 나타나 세 집단 간 사전 동질성이 검증되었다.

집단 간 행동적 변인(고통감내력)의 사전 동질성 검사 결과는 <표 V-4>과 같다.

<표 V-4> 집단 간 행동적 변인(고통감내력)의 사전 동질성 비교

변인 및 하위 요인			평균(표준편차)			평균순위			X^2	df (p)
			실험 집단 (N=7)	통제 집단 (N=7)	비교 집단 (N=7)	실험 집단 (N=7)	통제 집단 (N=7)	비교 집단 (N=7)		
행 동 적 변 인	고 통 감 내 력	전 체	48.43 (5.97)	50.43 (9.13)	50.43 (4.58)	9.14	12.29	11.57	1.004	2 (.605)
		조 절	8.57 (1.81)	9.43 (2.37)	8.71 (2.29)	11.14	12.07	9.79	.509	2 (.775)
		감내력과 몰두	16.71 (3.95)	17.86 (3.80)	17.14 (2.34)	10.00	12.14	10.86	.436	2 (.804)
		평 가	23.71 (3.86)	25.71 (5.06)	25.43 (3.10)	8.14	13.36	11.50	2.616	2 (.270)

② 집단 간 행동적 변인(자해행동)의 사전 동질성 비교

연구 참여집단 간 행동적 변인의 고통감내력(자해행동)에 대한 사전 동질성 검사를 시행하였다. 검사 결과 자해행동, $p>.05$), 모든 요인에서 통계적으로 유의한 차이를 보이지 않는 것으로 나타나 세 집단 간 사전 동질성이 검증되었다. 집단 간 행동적 변인(자해행동)의 사전 동질성 검사 결과는 <표 V-5>과 같다.

<표 V-5> 집단 간 행동적 변인(자해행동)의 사전 동질성 비교

변인 및 하위 요인			평균(표준편차)			평균순위			X^2	df (p)
			실험 집단 (N=7)	통제 집단 (N=7)	비교 집단 (N=7)	실험 집단 (N=7)	통제 집단 (N=7)	비교 집단 (N=7)		
행 동 적 변 인	자 해 행 동	전 체	37.43 (1.72)	38.14 (1.35)	37.43 (2.07)	9.79	12.29	10.93	.607	2 (.738)
		자해행동	37.43 (1.72)	38.14 (1.35)	37.43 (2.07)	9.79	12.29	10.93	.607	2 (.738)

2) 실험, 통제, 비교집단 간 사후 차이 검증

(1) 집단 간 인지적 변인(비합리적 신념) 사후 차이 검증

프로그램 시행 후, 실험집단, 통제집단, 비교집단 간 비합리적 신념의 변화를 알아보기 위하여 비모수 검증의 Kruskal-Wallis와 Bonferroni Correction 사후검정을 시행하였다. 구체적인 내용은 다음과 같다.

유의한 차이($X^2=9.692$, $p<.01$)가 있으며 구체적으로, 실험집단의 평균값이($M=45.43$) 통제집단($M=62.14$)과 비교집단($M=57.00$)보다 비합리적 신념이 낮은 것으로 확인되었다. 비합리적 신념의 구성 요인인 자기 비하($X^2=11.375$, $p<.01$)는 통계적으로 유의한 차이가 있는 것으로 나타났고, 실험집단($M=8.71$)이 통제집단($M=14.43$)과 비교집단($M=13.29$)보다 낮게 나타났다. 또한, 성취 및 편안한 욕구($X^2=7.143$, $p<.05$) 역시 통계적으로 유의한 차이가 있으며 실험집단($M=20.86$)이 통제집단($M=25.57$)과 비교집단($M=21.43$)보다 낮게 상대적으로 낮은 평균값을 보였다. 승인 및 공평한 욕구($X^2=6.324$, $p<.05$)도 통계적으로 유의한 차이를 보였으며, 실험집단($M=15.86$)은 통제집단($M=22.14$)과 비교집단($M=22.29$)보다 낮은 것으로 분석되었다. 집단 간 인지적 변인(비합리적 신념) 사후검사 차이 검증 결과는 <표 V-6>와 같다.

<표 V -6> 집단 간 인지적 변인(비합리적 신념) 사후검사 차이 검증

변인		집단영역	평균(M) (SD)	평균 순위	Kruskal-Wallis		Bonferroni Correction
					X^2	df(p)	
비합리적인신념	전체	실험집단	45.43 (9.22)	5.29	9.692**	2(.008)	a
		통제집단	62.14 (8.32)	15.29			b
		비교집단	57.00 (4.62)	12.43			b
	자기비하	실험집단	8.71 (2.81)	4.86	11.375**	2(.003)	a
		통제집단	14.43 (1.62)	15.57			b
		비교집단	13.29 (2.14)	12.57			b
	성취 및 편안한 욕구	실험집단	20.86 (4.60)	8.14	7.143*	2(.028)	a
		통제집단	25.57 (1.99)	16.00			b
		비교집단	21.43 (1.72)	8.86			b
	승인 및 공평한 욕구	실험집단	15.86 (1.95)	6.21	6.324*	2(.042)	a
		통제집단	22.14 (5.87)	13.57			b
		비교집단	22.29 (4.15)	13.21			b

* $p<.05$; ** $p<.01$

(2) 집단 간 정서적 변인 사후 차이 검증(정서조절 및 우울)

① 집단 간 정서적 변인(정서조절) 사후 차이 검증

프로그램 시행 후, 실험집단, 통제집단, 비교집단 간 정서조절 변화를 알아보기 위한 사후검정을 시행하였다. 검정 결과, 집단 간 정서조절 변화($X^2=1.463$, $n.s$)는 통계적으로 유의한 차이가 없는 것으로 나타났다. 정서조절의 하위 요인으로서 정서에 대한 비수용성($X^2=1.827$, $n.s$), 목표 지향 행동 수행의 어려움($X^2=4.336$, $n.s$), 충동 통제 곤란($X^2=5.084$, $n.s$), 정서적 자각 부족($X^2=3.379$, $n.s$), 정서적 명료성의 부족($X^2=1.341$, $n.s$), 정서조절 전략 부족($X^2=1.975$, $n.s$) 또한, 통계적으로 유의한 차이가 없는 것으로 나타났다.

집단 간 정서적 변인(정서조절) 사후 차이 검증 결과는 <표 V-7>과 같다.

<표 V-7> 집단 간 정서적 변인(정서조절) 사후 차이 검증

변인	집단영역	평균(M) (표준편차, SD)	평균 순위	Kruskal-Wallis		Bonferroni Correction
				χ^2	$df(p)$	
정서적 변인	전체	실험집단	75.86(25.27)	1.463	2(.481)	-
		통제집단	66.57(11.82)			
		비교집단	75.29(14.85)			
	정서에 대한 비수용성	실험집단	12.86(7.13)	1.827	2(.401)	-
		통제집단	14.00(3.61)			
		비교집단	13.71(3.45)			
	목표지향 행동 수행의 어려움	실험집단	10.43(2.94)	4.336	2(.114)	-
		통제집단	8.14(1.68)			
		비교집단	10.14(2.41)			
	충동 통제 곤란	실험집단	11.29(3.68)	5.084	2(.079)	-
		통제집단	10.43(1.90)			
		비교집단	13.57(2.37)			
	정서적 자각 부족	실험집단	19.71(6.29)	3.379	2(.185)	-
		통제집단	14.14(6.07)			
		비교집단	16.43(4.47)			
	정서적 명료성의 부족	실험집단	7.86(3.72)	1.341	2(.511)	-
		통제집단	6.29(2.50)			
		비교집단	5.71(2.69)			
	정서조절 전략 부족	실험집단	13.71(5.12)	1.975	2(.372)	-
		통제집단	12.71(2.56)			
		비교집단	15.43(4.12)			

* $p < .05$; ** $p < .01$

② 집단 간 정서적 변인(우울) 사후 차이 검증

프로그램 시행 후, 실험집단, 통제집단, 비교집단 간 정서적 변인의 우울과 구성 하위 요인의 변화를 알아보기 위한 사후검정을 하였다. 검정 결과, 검증 결과, 세 집단 간 우울($X^2=12.983$, $p<.01$)은 통계적으로 유의한 차이가 있는 것으로 나타났으며 실험집단($M=50.00$)이 통제집단($M=69.71$)과 비교집단($M=67.86$)에 비해 상대적으로 낮은 평균값을 보였다.

우울의 하위 요인인 신체 및 우울정서($\chi^2=6.152$, $p<.05$)는 통계적으로 유의한 차이가 있으며, 실험집단($M=25.57$)이 통제집단($M=35.29$)과 비교집단($M=32.71$)보다 낮은 평균값을 나타냈다. 또한, 정서적 고통($X^2=14.325$, $p<.01$) 역시 통계적으로 유의한 차이가 있으며 평균값에 있어서 실험집단($M=11.86$)이 통제집단($M=16.57$)과 비교집단($M=18.57$)보다 낮은 것으로 확인되었다. 우울의 하위 구성 요인은 대인관계($\chi^2=12.696$, $p<.01$)도 통계적으로 유의한 차이를 보였으며, 실험집단($M=4.14$)이 통제집단($M=8.71$)과 비교집단($M=8.57$)보다 낮은 평균값을 보였다.

하위 요인 중 긍정적 정서($X^2=9.309$, $p<.05$)도 통계적으로 유의한 차이를 보였으며, 실험집단($M=10.14$)이 통제집단($M=13.14$)과 비교집단($M=11.57$)보다 낮게 나타났다. 집단 간 정서적 변인(우울) 사후 차이 검증 결과는 <표 V-8>과 같다.

<표 V-8> 집단 간 정서적 변인(우울) 사후 차이 검증

변인		집단영역	평균(M) (표준편차SD)	평균 순위	Kruskal-Wallis		Bonferroni Correction
					X^2	$df(p)$	
우울	전체	실험 집단	50.00 (4.93)	4.14	12.983**	2(.002)	a
		통제 집단	69.71 (9.53)	14.86			b
		비교 집단	67.86 (4.88)	14.00			b
	신체 및 우울 정서	실험 집단	25.57 (5.35)	6.29	6.152*	2(.046)	a
		통제 집단	35.29 (8.99)	13.71			b
		비교 집단	32.71 (3.86)	13.00			b
	정서적 고통	실험 집단	11.86 (1.77)	4.21	14.325**	2(.001)	a
		통제 집단	16.57 (2.15)	12.36			b
		비교 집단	18.57 (1.72)	16.43			a
	대인관계	실험 집단	4.14 (1.57)	4.29	12.696**	2(.002)	a
		통제 집단	8.71 (1.38)	14.64			b
		비교 집단	8.57 (1.40)	14.07			b
	긍정적 정서	실험 집단	10.14 (1.07)	6.00	9.309*	2(.01)	a
		통제 집단	13.14 (1.46)	16.00			b
		비교 집단	11.57 (1.62)	11.00			a

* $p < .05$; ** $p < .01$

a와 b의 기준

- 집단 간에 유의미한 차이가 없음: 동일한 문자
- 집단 간에 유의미한 차이가 있음: 다른 문자

(3) 집단 간 행동적 변인 사후 검증(고통감내력 및 자해행동)

① 집단 간 행동적 변인(고통감내력) 사후 차이 검증

프로그램 시행 후 집단 간 고통감내력의 변화를 알아보기 위해 사후검정을 실시한 결과, 고통감내력은 통계적으로 유의한 차이($X^2=9.883$, $p<.01$)가 있는 것으로 실험집단의 고통감내력($M=35.43$)이 통제집단($M=49.29$)과 비교집단($M=42.14$)보다 낮게 나타났다. 고통감내력의 하위 요인으로 조절은 통계적으로 유의미($X^2=2.382$, $n.s$)하지 않게 나타났다. 반면, 하위 요인 중 감내력과 몰두는 통계적으로 유의한 차이($X^2=6.298$, $p<.05$)가 있는 것으로 나타났고, 실험집단($M=10.71$)이 통제집단($M=15.57$)과 비교집단($M=13.14$)에 비해 평균값이 낮게 나타났다. 하위 요인 평가 역시 통계적으로 유의한 차이($X^2=9.593$, $p<.01$)가 있는 것으로 나타났으며, 실험집단($M=17.43$)이 통제집단($M=24.00$)과 비교집단($M=20.57$)보다 평균값이 낮은 것을 확인하였다. 집단 간 행동적 변인(고통감내력) 사후 차이 검증 결과는 <표 V-9>와 같다.

<표 V-9> 집단 간 행동적 변인(고통감내력) 사후 차이 검증

변인	집단영역	평균(M) (표준편차, SD)	평균 순위	Kruskal-Wallis		Bonferroni Correction
				χ^2	$df(p)$	
고 통 감 내 력	전체	실험집단	35.43 (6.63)	9.883**	2(.007)	a
		통제집단	49.29 (6.45)			b
		비교집단	42.14 (6.26)			a
	조절	실험집단	9.00 (1.63)	2.382	2(.304)	a
		통제집단	10.00 (22.4)			a
		비교집단	8.71 (1.38)			a
	감내력과 몰두	실험집단	10.71 (3.68)	6.298*	2(.043)	a
		통제집단	15.57 (2.88)			b
		비교집단	13.14 (2.04)			b
	평가	실험집단	17.43 (2.99)	9.593**	2(.008)	a
		통제집단	24.00 (2.08)			b
		비교집단	20.57 (3.26)			a

* $p<.05$; ** $p<.01$

a와 b의 기준

- 집단 간에 유의미한 차이가 없음: 동일한 문자
- 집단 간에 유의미한 차이가 있음: 다른 문자

② 집단 간 행동적 변인(자해행동) 사후 차이 검증

프로그램 시행 후, 집단 간 행동적 변인(자해행동)의 사후 변화를 시행하였다. 검증 결과, 집단의 자해행동($\chi^2=13.641$, $p<.01$)은 통계적으로 유의한 차이가 있는 것으로 분석되었으며 실험집단의 평균($M=24.57$)값이, 통제집단($M=38.14$)과 비교집단($M=38.42$) 보다 낮은 것으로 나타났다. 집단 간 행동적 변인(자해행동)의 사후 차이 검증은 <표 V-10>과 같다.

<표 V-10> 집단 간 행동적 변인(자해행동) 사후 차이 검증

변인	집단영역	평균(M) (표준편차, SD)	평균 순위	Kruskal-Wallis		Bonferroni Correction
				X^2	$df(p)$	
자해 행동	실험 집단	24.57 (2.50)	4.00	13.64 1**	2(.001)	a
	통제 집단	38.14 (6.34)	13.71			b
	비교 집단	38.42 (4.72)	15.29			b

** $p < .01$

a와 b의 기준

- 집단 간에 유의미한 차이가 없음: 동일한 문자
- 집단 간에 유의미한 차이가 있음: 다른 문자

3) 집단 내 사전-사후 차이 검증

(1) 집단 내 인지적 변인(비합리적 신념)의 사전-사후 차이 검증

프로그램 시행 후 실험, 통제 및 비교집단 내 비합리적 신념 사전-사후 점수 차이를 알아보기 위해 비모수 검정인 Wilcoxon signed-rank test를 진행하였다. 집단 내 비합리적 신념 사전-사후검사를 실시하였다.

실험집단의 인지적 변인(비합리적 신념) 비합리적 사고($Z = -2.366$, $p < .05$), 자기비하($Z = -2.371$, $p < .05$), 승인 및 공평한 욕구($Z = -2.371$, $p < .05$)에서 통계적으로 유의한 감소를 했다. 다만, 성취 및 평안한 욕구($Z = -1.863$, $p > .05$)에서는 통계적으로 유의한 차이가 없었다.

통제집단의 인지적 변인(비합리적 신념) 비합리적 사고($Z = -1.103$, $p > .05$), 자기비하($Z = -.511$, $p > .05$), 성취 및 평안한 욕구($Z = -1.364$, $p > .05$), 승인 및 공평한 욕구($Z = -1.014$, $p > .05$)에서 통계적으로 유의한 차이가 없었다.

비교집단의 인지적 변인(비합리적 신념) 비합리적 사고($Z = -2.375$, $p < .05$), 성취 및 평안한 욕구($Z = -2.117$, $p < .05$)는 통계적으로 유의한 감소 했다. 하지만 자기비하($Z = -1.903$, $p > .05$), 승인 및 공평한 욕구($Z = -1.476$, $p > .05$)에

서는 통계적으로 유의한 차이가 없었다. 집단 내의 인지적 변인(비합리적 신념)의 사전-사후검사 결과는 <표 V-11>와 같다.

<표 V-11> 집단 내 인지적 변인(비합리적 신념)의 사전-사후 차이 검증

변인		집단영역	n	사전		사후		Wilcoxon
				중위수	범위 (25 th %~75%)	중위수	범위 (25 th %~75%)	
비 합 리 적 신 념	전 체	실험집단	7	66.00	61.00~71.00	44.00	36.00~57.00	-2.366*
		통제집단	7	67.00	60.00~74.00	62.00	54.00~69.00	-1.103
		비교집단	7	66.00	64.00~73.00	59.00	56.00~60.00	-2.375*
	자기 비하	실험집단	7	16.00	15.00~17.00	9.00	6.00~12.00	-2.371*
		통제집단	7	15.00	12.00~17.00	14.00	13.00~16.00	-.511
		비교집단	7	16.00	14.00~18.00	13.00	11.00~16.00	-1.903
	성취 및 편안 한 욕구	실험집단	7	26.00	23.00~27.00	19.00	17.00~27.00	-1.863
		통제집단	7	28.00	23.00~34.00	27.00	24.00~27.00	-1.364
		비교집단	7	26.00	24.00~28.00	22.00	19.00~23.00	-2.117*
	승인 및 공평 한 욕구	실험집단	7	24.00	22.00~25.00	16.00	14.00~18.00	-2.371*
		통제집단	7	24.00	22.00~25.00	25.00	15.00~26.00	-1.014
		비교집단	7	26.00	24.00~26.00	23.00	20.00~25.00	-1.476

* $p<.05$

(2) 집단 내 정서적 변인(정서조절 및 우울) 변화의 사전-사후 차이 검증

① 집단 내 정서적 변인(정서조절) 변화의 사전-사후 차이 검증

프로그램 시행 후 실험, 통제 및 비교집단 내 정서조절 변화 사전-사후 점수 차이를 알아보기 위해 비모수 검정인 Wilcoxon signed-rank test를 진행하였다. 실험집단의 정서조절 변화는 통계적으로 유의하지 않았다 ($Z=-1.014$, $p>.05$). 하위 요인에 해당하는 정서에 대한 비수용성($Z=-1.187$, $p>.05$), 목표지향 행동 수행의 어려움($Z=-.339$, $p>.05$), 충동 통제 곤란($Z=-1.693$, $p>.05$), 정서적 자각 부족($Z=-.677$, $p>.05$), 정서적 명료성의 부족($Z=-.339$, $p>.05$), 정서조절 전략 부족($Z=-1.352$, $p>.05$)에 통계적으로 유의하지 않았다.

통제집단은 정서조절 변화가 통계적으로 유의하게 감소 했다($Z=-2.197$, $p<.05$). 하위요인은 정서에 대한 비수용성($Z=-2.214$, $p<.05$), 충동 통제 곤란 ($Z=-2.375$, $p<.05$), 정서조절 전략 부족($Z=-2.388$, $p<.05$)에서 통계적으로 유의한 감소세를 보였다. 그 외에 목표지향 행동 수행의 어려움($Z=-1.261$, $p>.05$), 정서적 자각 부족($Z=-.938$, $p>.05$), 정서적 명료성의 부족($Z=-1.876$, $p>.05$)은 통계적으로 유의한 차이를 보이지 않았다.

비교집단은 정서에 대한 비수용성($Z=-2.023$, $p<.05$)만 통계적으로 유의미한 감소세를 보였으며, 그 외에 정서조절 변화($Z=-1.781$, $p>.05$), 목표지향 행동 수행의 어려움($Z=-1.194$, $p>.05$), 충동 통제 곤란($Z=-1.084$, $p>.05$), 정서적 자각 부족($Z=-.339$, $p>.05$), 정서적 명료성의 부족($Z=-2.207$, $p>.05$), 정서조절 전략 부족($Z=-1.352$, $p>.05$)이 통계적으로 유의한 차이가 없었다. 집단 내 정서적 변인(정서조절) 변화의 사전-사후검사 결과는 <표 V-12>와 같다.

<표 V-12> 집단 내 정서적 변인(정서조절) 변화의 사전-사후검사 비교

변인	집단영역	n	사전		사후		Wilcoxon	
			중위수	범위 (25 th %~75 th %)	중위수	범위 (25 th %~75 th %)		
정서 조절 변화	전체	실험집단	7	90.00	81.00~104.00	63.00	56.00~89.00	-1.014
		통제집단	7	97.00	87.00~106.00	62.00	58.00~77.00	-2.197*
		비교집단	7	96.00	84.00~114.00	73.00	70.00~92.00	-1.781
	정서에 대한 비수용성	실험집단	7	16.00	15.00~23.00	10.00	8.00~18.00	-1.187
		통제집단	7	18.00	18.00~20.00	14.00	12.00~17.00	-2.214*
		비교집단	7	20.00	15.00~26.00	14.00	11.00~15.00	-2.023*
	목표 지향 동행 수행 의 어려움	실험집단	7	10.00	8.00~12.00	10.00	8.00~12.00	- .339
		통제집단	7	11.00	6.00~13.00	7.00	7.00~10.00	-1.261
		비교집단	7	11.00	9.00~14.00	11.00	8.00~12.00	-1.194
	충동 통제 곤란	실험집단	7	16.00	13.00~16.00	10.00	8.00~12.00	-1.693
		통제집단	7	16.00	15.00~17.00	11.00	8.00~12.00	-2.375*
		비교집단	7	15.00	14.00~19.00	14.00	12.00~15.00	-1.084
	정서 적 자각 부족	실험집단	7	18.00	16.00~22.00	20.00	17.00~24.00	- .677
		통제집단	7	21.00	11.00~23.00	15.00	7.00~18.00	- .938
		비교집단	7	18.00	11.00~24.00	16.00	13.00~21.00	- .339
	정서 적 명료 성의 부족	실험집단	7	9.00	7.00~10.00	6.00	5.00~12.00	- .085
		통제집단	7	9.00	9.00~10.00	6.00	4.00~8.00	-1.876
		비교집단	7	11.00	8.00~12.00	6.00	3.00~8.00	-2.207
	정서 조절 전략 부족	실험집단	7	20.00	16.00~23.00	13.00	12.00~16.00	-1.352
		통제집단	7	20.00	16.00~21.00	13.00	10.00~14.00	-2.388*
		비교집단	7	21.00	18.00~22.00	15.00	13.00~18.00	-1.352

* $p<.05$

② 집단 내 정서적 변인(우울) 변화의 사전-사후 차이 검증

프로그램 시행 후 실험, 통제 및 비교집단 내 우울 사전-사후 점수 차이를 알아보기 위해 비모수 검정인 Wilcoxon signed-rank test를 실시하였다.

실험집단은 우울($Z=-1.577$, $p>.05$), 하위 요인의 신체 및 우울 정서($Z=-1.472$, $p>.05$), 정서적 고통($Z=-1.612$, $p>.05$), 긍정적 정서($Z=-.368$, $p>.05$)에서 통계적 유의미한 차이가 없었다. 대인관계($Z=-2.023$, $p<.05$)만 통계적으로 유의하게 감소하였다.

통제집단은 우울($Z=-.085$, $p>.05$), 신체 및 우울 정서($Z=-.085$, $p>.05$), 정서적 고통($Z=-1.187$, $p>.05$), 대인관계($Z=-.272$, $p>.05$)에서 통계적으로 유의한 차이를 보이지 않았지만, 긍정적 정서($Z=-2.120$, $p<.05$)에서만 통계적으로 유의한 향상을 보였다($Z=-2.023$, $p<.05$). 비교집단은 우울($Z=-.085$, $p>.05$), 신체 및 우울 정서($Z=-.676$, $p>.05$), 정서적 고통($Z=-.106$, $p>.05$) 대인관계($Z=-.816$, $p>.05$), 긍정적 정서($Z=-1.357$, $p>.05$)에서 통계적으로 유의한 차이가 없었다. 집단 내 정서적 변인(우울) 변화의 사전-사후 차이 검증한 결과는 <표 V-13>과 같다.

<표 V-13> 집단 내 정서적 변인(우울) 변화의 사전-사후차이 검증

변인		집단영역	n	사전		사후		Wilcoxon
				중위수	범위 (25 th %~75 th)	중위수	범위 (25 th %~75 th %)	
우울	전체	실험집단	7	71.00	44.00~78.00	50.00	45.00~56.00	-1.577
		통제집단	7	70.00	67.00~78.00	67.00	64.00~78.00	-.085
		비교집단	7	72.00	50.00~81.00	69.00	62.00~72.00	-.085
	신체 및 우울 정서	실험집단	7	39.00	18.00~43.00	24.00	23.00~33.00	-1.472
		통제집단	7	38.00	36.00~42.00	34.00	28.00~44.00	-.085
		비교집단	7	41.00	22.00~45.00	32.00	29.00~35.00	-.676

	정서 적 고통	실험집단	7	18.00	12.00~21.00	12.00	12.00~13.00	-1.612
		통제집단	7	19.00	16.00~22.00	16.00	16.00~18.00	-1.187
		비교집단	7	19.00	15.00~21.00	19.00	17.00~20.00	-.106
	대인 관계	실험집단	7	7.00	6.00~8.00	4.00	3.00~6.00	-2.023 *
		통제집단	7	9.00	8.00~10.00	9.00	8.00~10.00	-.272
		비교집단	7	9.00	5.00~9.00	9.00	8.00~10.00	-.816
	긍정 적 정서	실험집단	7	11.00	10.00~12.00	10.00	9.00~11.00	-.368
		통제집단	7	10.00	9.00~11.00	14.00	12.00~14.00	-2.120 *
		비교집단	7	10.00	9.00~11.00	12.00	10.00~13.00	-1.357

* $p<.05$

(3) 집단 내 행동적 변인(고통감내력 및 자해행동) 사전-사후 차이 검증

① 집단 내 행동적 변인(고통감내력)의 사전-사후 차이 검증

집단 내 행동적 변인(고통감내력)의 사전-사후 차이 검증은 프로그램 시행 후 실험, 통제, 그리고 비교집단 내 고통감내력 사전-사후 점수 차이를 알아보기 위해 비모수 검정인 Wilcoxon signed-rank test를 실시하였다.

분석결과, 실험집단의 고통감내력은 통계적으로 유의하게 감소하였다 ($Z=-2.207$, $p<.05$). 하위 요인 중 감내력과 몰두($Z=-2.201$, $p<.05$), 평가($Z=-2.375$, $p<.05$)까지 사전보다 사후에 유의미하게 감소하였다. 통제집단은 고통감내력($Z=-.338$, $p>.05$), 조절($Z=-.604$, $p>.05$), 감내력과 몰두($Z=-1.620$, $p>.05$), 평가($Z=-.677$, $p>.05$)에서 통계적으로 유의한 차이가 없었다.

비교집단은 고통감내력($Z=-1.997$, $p<.05$), 감내력과 몰두($Z=-2.238$, $p<.05$), 평가($Z=-2.043$, $p<.05$)에서 통계적으로 유의한 차이를 보였고, 조

절($Z=-.272$, $p<.05$)에서 통계적으로 유의미한 차이가 없었다. 집단 내 행동적 변인(고통감내력)의 사전-사후 차이 검증 결과는 <표 V-14>과 같다.

<표 V-14> 집단 내 행동적 변인(고통감내력)의 사전-사후검사 비교

변인		집단영역	n	사전		사후		Wilcoxon
				중위수	범위 (25 th %~75 th %)	중위수	범위 (25 th %~75 th %)	
고 통 감 내 력	전 체	실험집단	7	48.00	46.00~49.00	36.00	28.00~38.00	-2.207*
		통제집단	7	49.00	47.00~56.00	53.00	41.00~55.00	-.338
		비교집단	7	49.00	47.00~54.00	44.00	35.00~48.00	-1.997*
	조 절	실험집단	7	9.00	6.00~10.00	9.00	7.00~11.00	-1.342
		통제집단	7	9.00	9.00~10.00	11.00	8.00~12.00	-.604
		비교집단	7	44.00	35.00~48.00	9.00	7.00~10.00	-.272
	감 내 력 과 물 두	실험집단	7	16.00	14.00~19.00	13.00	8.00~13.00	-2.201*
		통제집단	7	17.00	14.00~20.00	16.00	12.00~19.00	-1.620
		비교집단	7	19.00	15.00~19.00	14.00	11.00~15.00	-2.238*
	평 가	실험집단	7	24.00	22.00~25.00	17.00	16.00~18.00	-2.375*
		통제집단	7	25.00	25.00~31.00	25.00	22.00~25.00	-.677
		비교집단	7	25.00	24.00~27.00	21.00	17.00~23.00	-2.043*

* $p<.05$

② 집단 내 행동적 변인 (자해행동)의 사전-사후 차이 검증

집단 내 행동적 변인(자해행동)의 사전-사후 차이 검증은 프로그램 시행 후 실험, 통제 및 비교집단 내 중학생의 자해행동 사전-사후 점수 차이를 알아보기 위해 비모수 검정인 Wilcoxon signed-rank test를 실시하였다.

실험집단의 자해행동은 통계적으로 유의하게 감소하였다($Z=-2.371$, $p<.05$). 통제집단($Z=-.254$, $p>.05$)과 비교집단($Z=-.314$, $p>.05$)의 자해행동은 통계적으로 유의하지 않았다. 집단 내 행동적 변인(자해행동)의 사전-사후 차이 검증 결과는 <표 V-15>과 같다.

<표 V-15> 집단 내 행동적 변인(자해행동)의 사전-사후차이 검증

변인	집단영역	n	사전		사후		Wilcoxon
			중위수	범위 (25 th %~75 th %)	중위수	범위 (25 th %~75 th %)	
자 해 행 동	실험집단	7	38.00	37.00~39.00	24.00	23.00~26.00	-2.371*
	통제집단	7	38.00	37.00~39.00	35.00	33.00~44.00	-.254
	비교집단	7	38.00	35.00~39.00	37.00	34.00~42.00	-.314

* $p<.05$

4) 실험집단과 비교집단 간(인지적, 정서적, 행동적) 추후 차이 검증

(1) 집단 간 인지적 변인(비합리적 신념) 추후 차이 검증

실험집단과 비교집단 간 인지적 변인(비합리적 신념) 추후 차이 검증 프로그램 종료 1개월 후 실험집단과 비교집단 간 중학생의 비합리적 신념 추후검사 점수 차이를 알아보기 위해 비모수 검정인 Mann-Whitey U 검정을 시행하였다.

실험집단과 비교집단 간 비합리적 사고는 프로그램 종료 후 1개월 후 통계적으로 유의한 차이를 보였다($Z=-3.137$, $p<.01$). 이를 구체적으로 살펴보면, 자기비하($Z=-3.141$, $p<.01$), 성취 및 편안한 욕구($Z=-2.820$, $p<.01$), 승인 및 공평한 욕구($Z=-3.090$, $p<.01$) 모두 통계적으로 유의한 차이가 있는 것으로 나타났다. 실험집단과 비교집단 간 인지적 변인(비합리적 신념) 추후 차이 검증 결과는 <표 V-16>와 같다.

<표V-16> 실험집단과 비교집단 간 인지적 변인(비합리적 신념) 추후 차이 검증

변인		집단 구분	n	평균순위	순위 합	Mann-Whitney U	Z
비합리적 신념	전체	실험집단	7	4.00	28.00	.000	-3.137**
		비교집단	7	11.00	77.00		
	자기비하	실험집단	7	4.00	28.00	.000	-3.141**
		비교집단	7	11.00	77.00		
	성취 및 편안한 욕구	실험집단	7	4.36	30.50	2.500	-2.820**
		비교집단	7	10.64	74.50		
	승인 및 공평한 욕구	실험집단	7	4.07	28.50	.500	-3.090**
		비교집단	7	10.93	76.50		

** $p < .01$

(2) 집단 간 정서적 변인(정서조절 및 우울) 추후 차이 검증

① 실험집단과 비교집단 간 정서적 변인(정서조절) 추후 차이 검증

프로그램 종료 1개월 후 실험집단과 비교집단 간 중학생의 정서조절 변화 추후검사 점수 차이를 알아보기 위해 비모수 검정인 Mann-Whitey U 검정을 시행하였다.

실험집단과 비교집단 간 정서조절 변화는 프로그램 종료 후 1개월 후 통계적으로 유의한 차이가 없었다($Z = -.128$, $n.s$). 하위 요인 정서에 대한 비수용성($Z = -.456$, $n.s$), 목표지향 행동 수행의 어려움($Z = 1.000$, $n.s$), 충동 통제 곤란($Z = .165$, $n.s$), 정서적 자각 부족($Z = .259$, $n.s$), 정서적 명료성의 부족($Z = .259$, $n.s$), 정서조절 전략 부족($Z = .456$, $n.s$)에서도 통계적으로 유의한 차이가 없었다. 실험집단과 비교집단 간 중학생의 정서조절 변화 추후검사 결과는 <표V-17>과 같다.

<표 V-17> 실험집단과 비교집단 간 정서적 변인(정서조절) 변화의 추후검사 비교

변인		집단 구분	n	평균순위	순위 합	Mann- Whitney U	Z
정서조절	전체	실험집단	7	7.36	51.50	23.500	-.128
		비교집단	7	7.64	53.50		
	정서에 대한 비수용 성	실험집단	7	6.64	46.50	18.500	.456
		비교집단	7	8.36	58.50		
	목표지 향 행동 수행의 어려움	실험집단	7	7.57	53.00	24.00	1.000
		비교집단	7	7.43	52.00		
	충동 통제 곤란	실험집단	7	5.93	41.50	13.500	.165
		비교집단	7	9.07	63.50		
	정서적 자각 부족	실험집단	7	8.93	62.50	14.500	.209
		비교집단	7	6.07	42.50		
	정서적 명료성 의 부족	실험집단	7	8.86	62.00	15.00	.259
		비교집단	7	6.14	43.00		
	정서 조절 전략 부족	실험집단	7	6.57	46.00	18.00	.456
		비교집단	7	8.43	59.00		

** $p<.01$

② 실험집단과 비교집단 간 정서적 변인(우울) 추후 차이 검증

실험집단과 비교집단 간 정서적 변인(우울) 추후 차이 검증은 프로그램 종료 1개월 후 실험집단과 비교집단 간 우울 추후검사 점수 차이를 알아보기 위해 비모수 검정인 Mann-Whitey U 검정을 실시하였다.

실험집단과 비교집단 간 우울은 프로그램 종료 후 1개월 후 통계적으로 유의한 차이를 보였다($Z=-3.137$, $p<.01$). 이를 구체적으로 살펴보면, 신체 및 우울정서 ($Z=-2.833$, $p<.01$), 정서적 고통($Z=-3.151$, $p<.01$), 대인관계 ($Z=-3.176$, $p<.01$), 긍정적 정서($Z=-3.036$, $p<.01$) 모두 통계적으로 유의한 차이가 있는 것으로 나타났다.

실험집단과 비교집단 간 정서적 변인(우울) 추후 차이 검증 결과는 <표 V-18>과 같다.

<표 V-18> 실험집단과 비교집단 간 정서적 변인(우울) 추후 차이 검증

변인		집단 구분	n	평균순위	순위 합	Mann-Whitney U	Z
우울	전체	실험집단	7	4.00	28.00	.00	-3.137**
		비교집단	7	11.00	77.00		
	신체 및 우울 정서	실험집단	7	4.36	30.50	2.500	-2.833**
		비교집단	7	10.64	74.50		
	정서적 고통	실험집단	7	4.00	28.00	.000	-3.151**
		비교집단	7	11.00	77.00		
	대인 관계	실험집단	7	4.00	28.00	.000	-3.176**
		비교집단	7	11.00	77.00		
	긍정적 정서	실험집단	7	4.14	29.00	1.000	-3.036**
		비교집단	7	10.86	76.00		

** $p < .01$

(3) 집단 간 행동적 변인(고통감내력 및 자해행동) 추후 차이 검증

① 실험집단과 비교집단 간 행동적 변인(고통감내력) 추후 차이 검증

실험집단과 비교집단 간 행동적 변인(고통감내력) 추후 검증은 프로그램 종료 1개월 후 실험집단과 비교집단 간 자해행동의 추후검사 점수 차이를 알아보기 위해 비모수 검정인 Mann-Whitey U 검정을 시행하였다.

실험집단과 비교집단 간 고통감내력은 프로그램 종료 후 1개월 후 통계적으로 유의한 차이가 없었다($Z = -1.797$ *n.s.*). 고통감내력의 하위 요인인 조절($Z = -.562$, *n.s.*), 감내력과 몰두($Z = -1.821$, *n.s.*), 평가($Z = -1.748$, *n.s.*)에서도 통계적으로 유의한 차이가 없었다. 실험집단과 비교집단 간 행동적 변인(고통감내력) 추후 검증 결과는 <표 V-19>와 같다.

<표 V-19> 실험집단과 비교집단 간 행동적 변인(고통감내력) 추후 차이 검증

변인		집단구분	n	평균순위	순위합	Mann-Whitney U	Z
고통감내력	전체	실험집단	7	5.50	38.50	10.500	-1.797
		비교집단	7	9.50	66.50		
	조절	실험집단	7	8.07	56.50	20.500	-.526
		비교집단	7	6.93	48.50		
	감내력과 물두	실험집단	7	5.50	38.50	10.500	-1.821
		비교집단	7	9.50	66.50		
	평가	실험집단	7	5.57	39.00	11.000	-1.748
		비교집단	7	9.43	66.00		

($Z=-3.144$, $p<.01$)

② 실험집단과 비교집단 간 행동적 변인(자해행동) 추후 차이 검증

실험집단과 비교집단 간 행동적 변인(자해행동) 추후 차이 검증은 프로그램 종료 1개월 후 실험집단과 비교집단 간 자해행동의 추후검사 점수 차이를 알아보기 위해 비모수 검정인 Mann-Whitey U 검정을 시행하였다. 실험집단과 비교집단 간 자해행동은 프로그램 종료 1개월 후 통계적으로 유의한 차이($Z=-3.144$, $p<.01$)를 보였다. 실험집단과 비교집단 간 행동적 변인(자해행동) 추후 차이 검증 결과는 <표 V-20>과 같다.

<표 V-20> 실험집단과 비교집단 간 행동적 변인(자해행동) 추후 차이 검증

변인	집단구분	n	평균순위	순위합	Mann-Whitney U	Z
자해 행동	실험집단	7	4.00	28.00	.000	-3.144**
	비교집단	7	11.00	77.00		

** $p < .01$

5) 집단 내 사전-사후-추후(인지적 변인, 정서적 변인, 행동적 변인) 차이 검증

(1) 실험집단과 비교집단 내 인지적 변인(비합리적 신념) 사전-사후-추후

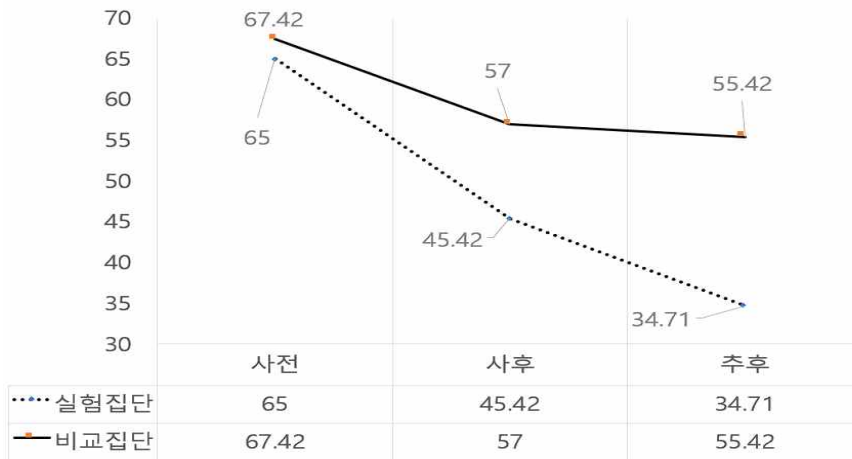
검사 차이 검증은 실험집단과 비교집단을 대상으로 집단 내 비합리적 신념 사전-사후-추후검사 점수의 변화를 알아보기 위해 Friedman test를 실시하였다.

실험집단의 비합리적 사고는 통계적으로 유의한 감소를 했다($Z=13.040$, $p < .01$). 하위 요인 자기비하($Z=13.040$, $p < .01$), 성취 및 편안한 욕구($Z=8.880$, $p < .01$), 승인 및 공평한 욕구($Z=13.040$, $p < .01$)은 통계적으로 유의한 감소세를 보였다. 비교집단의 비합리적 사고는 통계적으로 유의한 감소세를 보였다($Z=11.143$, $p < .01$). 하위 요인 성취 및 편안한 욕구($Z=6.889$, $p < .05$), 승인 및 공평한 욕구($Z=8.538$, $p < .05$)에서도 통계적으로 유의한 감소를 보였다. 그 외에 자기비하($Z=3.739$, $n.s$)에서는 통계적으로 유의한 변화가 없었다. 실험집단과 비교집단 내 인지적 변인(비합리적 신념) 사전-사후-추후 검사 차이 검증 결과는 <표 V-21>와 같다.

<표 V-21> 실험집단과 비교집단 내 인지적 변인(비합리적 신념) 사전-사후
-추후 검사 차이 검증

변인	집단영역	n	검사	평균(M) (표준편차, SD)	평균순 위	X^2	$df(p)$
비 합 리 적 신 념	전 체	실험 집단	사전	65.00(6.68)	3.00	13.040* *	2(.001)
			사후	45.42(9.21)	1.79		
			추후	34.71(6.29)	1.21		
		비교 집단	사전	67.42(6.10)	3.00	11.143* *	2(.004)
			사후	57.00(4.61)	1.71		
			추후	55.42(2.57)	1.23		
	자기 비하	실험 집단	사전	16.00(1.82)	3.00	13.040* *	2(.001)
			사후	8.71(2.81)	1.79		
			추후	6.57(1.51)	1.21		
		비교 집단	사전	15.57(2.76)	2.50	3.739	2(.154)
			사후	13.28(2.13)	1.57		
			추후	13.71(2.13)	1.93		
	성취 및 편안 한 욕구	실험 집단	사전	26.00(4.08)	2.71	8.880*	2(.012)
			사후	20.85(4.59)	2.07		
			추후	15.00(3.69)	1.21		
		비교 집단	사전	26.42(4.15)	2.79	6.889*	2(.032)
			사후	21.42(1.71)	1.71		
			추후	20.85(2.41)	1.50		
	승인 및 공평 한 욕구	실험 집단	사전	23.00(3.16)	3.00	13.040* *	2(.001)
			사후	15.85(1.95)	1.79		
			추후	13.14(1.95)	1.21		
		비교 집단	사전	25.42(1.90)	2.71	8.538*	2(.014)
			사후	22.28(4.15)	2.07		
			추후	20.85(3.80)	1.21		

* $p<.05$; ** $p<.01$



[그림 V-1] 실험집단과 비교집단 내 인지적 변인(비합리적 신념) 사전-사후-추후 검사 차이 검증

(2) 실험집단과 비교집단 내 정서적 변인(정서조절 및 우울) 사전-사후-추후

① 실험집단과 비교집단 내 정서적 변인(정서조절) 변화 사전-사후-추후 차이 검증

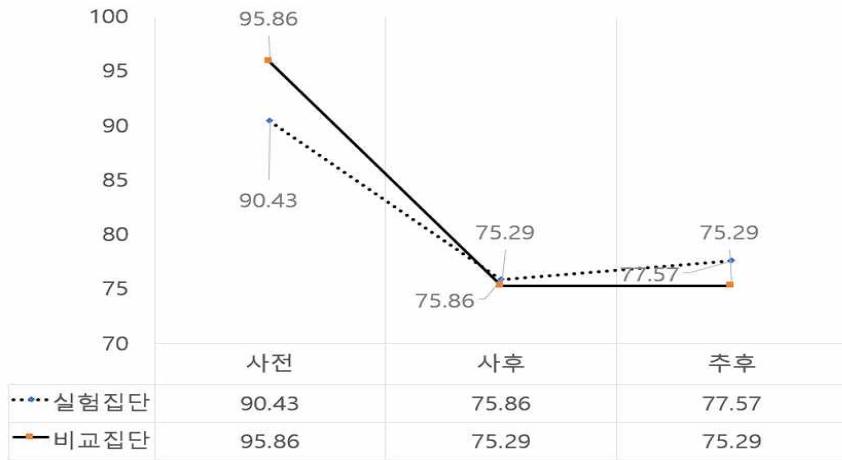
실험집단과 비교집단 내 정서적 변인(정서조절) 변화의 사전-사후-추후검사는 실험집단과 비교집단을 대상으로 집단 내 정서조절 변화 사전-사후-추후검사 점수의 변화를 알아보기 위해 Friedman test를 실시하였다.

실험집단의 정서조절 변화는 프로그램 종료 1개월 후 통계적으로 유의하지 않았다($Z=2.348$, $n.s$). 하위요인은 정서에 대한 비수용성($Z=6.909$, $p<.05$), 충동 통제 곤란($Z=6.333$, $p<.05$), 정서조절 전략 부족($Z=6.522$, $p<.01$)에서 통계적으로 유의한 변화가 있었다. 그 외 목표 지향 행동 수행의 어려움($Z=.609$, $n.s$), 정서적 자각 부족($Z=1.583$, $n.s$), 정서적 명료성의 부족($Z=.364$, $n.s$)은 통계적으로 유의한 변화가 없었다. 실험집단과 비교집단 내 정서적 변인(정서조절) 변화의 사전-사후-추후검사를 비교한 결과는 <표 V-22>와 같다.

<표V-22> 실험집단과 비교집단 내 정서적 변인(정서조절) 변화 사전-사후-추후 차이 검증

변인	집단영역	n	검사	평균(M) (표준편차, SD)	평균 순위	X^2	$df(p)$
정서조절변화	전체	실험집단	사전	90.43(14.06)	2.43	2.348	2(.309)
			사후	75.86(25.27)	1.79		
			추후	77.57(24.38)	1.79		
		비교집단	사전	95.86(19.16)	2.43	2.571	2(.276)
			사후	75.29(14.85)	1.79		
			추후	75.29(14.85)	1.79		
	정서에 대한 비수용성	실험집단	사전	18.00(4.76)	2.71	6.909*	2(.032)
			사후	12.86(7.13)	1.57		
			추후	13.43(7.02)	1.71		
		비교집단	사전	19.71(5.71)	2.71	10.000* *	2(.007)
			사후	13.71(4.45)	1.64		
			추후	13.71(4.45)	1.64		
	목표 지향 동행 수행 의 어려움	실험집단	사전	10.29(2.87)	2.14	.609	2(.738)
			사후	10.43(2.94)	1.79		
			추후	10.86(2.61)	2.07		
		비교집단	사전	10.86(3.02)	2.71	7.143*	2(.028)
			사후	10.14(2.41)	1.64		
			추후	10.14(2.41)	1.64		
	충동 통제 곤란	실험집단	사전	14.86(1.86)	2.71	6.333*	2(.042)
			사후	11.28(3.68)	1.57		
			추후	11.71(3.68)	1.71		
		비교집단	사전	16.14(3.24)	2.21	.783	2(.676)
			사후	13.57(2.37)	1.79		
			추후	13.86(2.67)	2.00		
	정서 적 자각 부족	실험집단	사전	17.57(5.15)	1.64	1.583	2(.453)
			사후	19.71(6.29)	2.21		
			추후	20.14(4.98)	2.14		
		비교집단	사전	17.28(6.07)	2.00	.000	2(1.000)
			사후	16.42(4.46)	2.00		
			추후	16.42(4.15)	2.00		
	정서 적 명료 성의 부족	실험집단	사전	8.14(3.02)	1.86	.364	2(.834)
			사후	7.85(3.71)	2.00		
			추후	8.14(3.33)	2.14		
		비교집단	사전	10.14(1.77)	2.86	12.000* *	2(.002)
			사후	5.71(2.69)	1.57		
			추후	5.71(2.69)	1.57		
	정서 조절 전략 부족	실험집단	사전	19.00(5.16)	2.71	6.522**	2(.038)
			사후	13.71(5.12)	1.64		
			추후	13.42(5.59)	1.64		
		비교집단	사전	19.14(4.74)	2.43	2.571	2(.276)
			사후	15.42(4.11)	1.79		
			추후	15.42(4.11)	1.79		

* $p<.05$; ** $p<.01$



[그림 V-2] 실험집단과 비교집단 내 정서적 변인(정서조절) 변화
사전-사후-추후 차이 검증

② 실험집단과 비교집단 내 정서적 변인(우울) 변화 사전-사후-추후 차이 검증

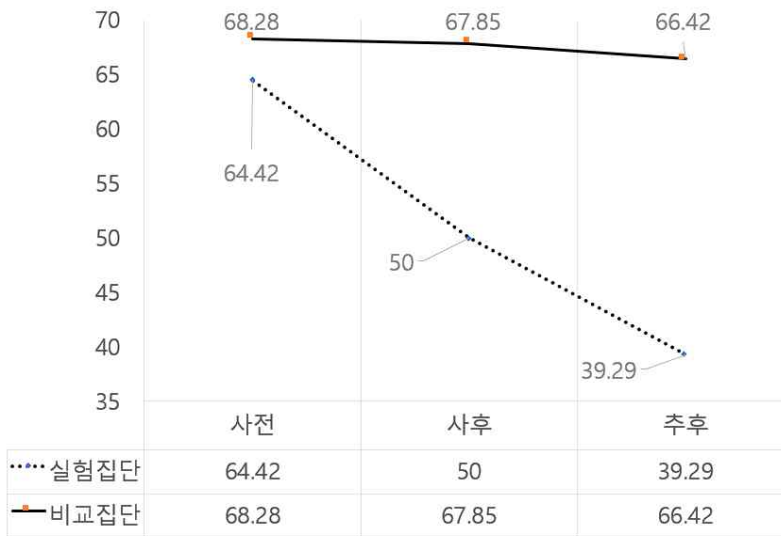
실험집단과 비교집단 내 정서적 변인(정서조절) 변화 사전-사후-추후 차이 검증은 실험집단과 비교집단을 대상으로 집단 내 중학생의 우울 변화 사전-사후-추후검사 점수의 변화를 알아보기 위해 Friedman test를 실시하였다.

실험집단의 우울은 통계적으로 유의한 감소를 했다($Z=7.000$, $p<.05$). 하위 요인에서 정서적 고통($Z=9.538$, $p<.01$), 대인관계($Z=9.238$, $p<.05$), 긍정적 정서($Z=7.750$, $p<.05$)에서는 통계적으로 유의한 변화를 보였다. 그 외에 신체 및 우울정서($Z=1.040$, $n.s$)는 통계적으로 유의한 변화가 없었다. 한편, 비교집단의 우울은 통계적으로 유의하지 않았다($Z=1.652$, $n.s$). 하위 요인에서 신체 및 우울정서($Z=.857$, $n.s$), 정서적 고통($Z=1.368$, $n.s$), 대인관계($Z=1.684$, $n.s$)에서는 통계적으로 유의하지 않았다. 그 외 긍정적 정서($Z=6.909$, $p<.05$)는 통계적으로 유의한 상승을 보였다. 실험집단과 비교집단 내 정서적 변인(정서조절) 변화 사전-사후-추후 차이 검증 결과는 <표 V-23>과 같다.

<표V-23> 실험집단과 비교집단 내 정서적 변인(정서조절) 변화 사전-사후-추후 차이 검증

변인	집단영역	n	검사	평균(M) 표준편차, SD)	평균 순위	X^2	$df(p)$
우울	전체	실험집단	사전	64.42(18.95)	2.43	7.000*	2(.030)
			사후	50.00(4.93)	2.36		
			추후	39.28(7.91)	1.21		
		비교집단	사전	68.28(17.75)	2.21	1.652	2(.438)
			사후	67.85(4.87)	2.14		
			추후	66.42(3.30)	1.64		
	신체 및 우울정서	실험집단	사전	32.85(13.55)	2.21	1.040	2(.595)
			사후	25.57(5.34)	2.07		
			추후	21.28(6.47)	1.71		
		비교집단	사전	35.57(11.63)	2.21	.857	2(.651)
			사후	32.71(3.86)	2.00		
			추후	32.00(2.51)	1.79		
	정서적 고통	실험집단	사전	16.28(4.23)	2.71	9.538**	2(.008)
			사후	11.85(1.77)	2.14		
			추후	8.28(2.49)	1.14		
		비교집단	사전	18.28(4.75)	2.29	1.368	2(.504)
			사후	18.57(1.71)	1.93		
			추후	18.42(1.51)	1.79		
	대인관 계	실험집단	사전	6.57(1.90)	2.79	9.238*	2(.010)
			사후	4.14(1.57)	1.79		
			추후	3.28(1.11)	1.43		
		비교집단	사전	7.71(2.28)	2.00	1.684	2(.431)
			사후	8.57(1.39)	2.29		
			추후	8.14(1.21)	1.71		
	긍정적 정서	실험집단	사전	10.57(2.30)	2.50	7.750*	2(.021)
			사후	10.14(1.06)	2.29		
			추후	7.71(1.38)	1.21		
		비교집단	사전	10.14(1.57)	1.29	6.909*	2(.032)
			사후	11.57(1.61)	2.43		
			추후	11.42(1.511)	2.29		

* $p < .05$; ** $p < .01$



[그림 V-3] 실험집단과 비교집단 내 정서적 변인(정서조절) 변화
사전-사후-추후 차이 검증

(3) 실험집단과 비교집단 내 행동적 변인 (고통감내력 및 자해행동) 사전-사후-추후 차이 검증

① 실험집단과 비교집단 내 행동적 변인(고통감내력) 사전-사후-추후 차이 검증

실험집단과 비교집단 내 행동적 변인(고통감내력) 사전-사후-추후 차이 검증은 실험집단과 비교집단을 대상으로 집단 내 고통감내력 사전-사후-추후 검사 점수의 변화를 알아보기 위해 Friedman test를 실시하였다.

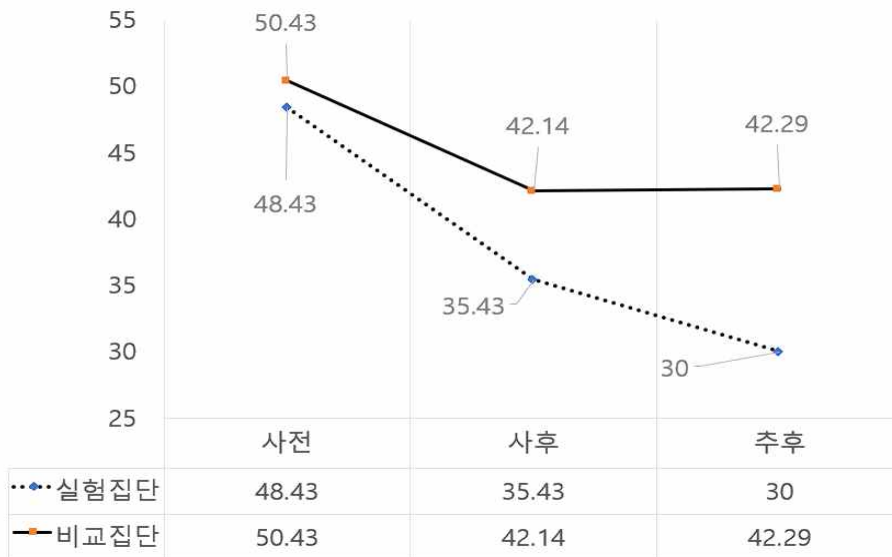
실험집단의 고통감내력은 프로그램 종료 1개월 후 통계적으로 유의한 수준으로 감소한 것으로 나타났다($Z=10.800$, $p<.01$). 구체적으로 살펴보면, 감내력과 몰두($Z=6.522$, $p<.05$), 평가($Z=13.455$, $p<.01$)에서 통계적으로 유의한 수준을 보이며 감소하였다. 다만, 조절($Z=2.00$, $n.s$)은 통계적으로 유의한 차이가 없었다. 비교집단은 감내력($Z=6.909$, $p<.05$), 평가($Z=6.909$, $p<.05$)에서 통계적으로 유의한 수준을 보이며 감소하였다. 다만, 고통감내력($Z=4.800$, $n.s$), 조절($Z=.400$, $n.s$)에서는 통계적으로 유의한 차이가 없었다.

실험집단과 비교집단 내 행동적 변인(고통감내력) 사전-사후-추후 차이 검증을 비교한 결과는 <표 V-24>과 같다.

<표 V-24> 실험집단과 비교집단 내 행동적 변인(고통감내력) 사전-사후-추후 차이 검증

변인	집단영역	n	검사	평균(M) (표준편차, SD)	평균순위	X^2	df(p)
고통감내력	전체	실험집단	사전	48.43(5.97)	2.86	10.800**	2(.005)
			사후	35.43(6.63)	1.57		
			추후	30.00(6.03)	1.57		
		비교집단	사전	50.43(4.58)	2.57	4.800	2(.091)
			사후	42.14(6.26)	1.71		
			추후	42.29(5.88)	1.71		
	조절	실험집단	사전	8.57(1.81)	1.64	2.00	2(.368)
			사후	9.00(1.63)	2.21		
			추후	9.14(1.68)	2.14		
		비교집단	사전	8.71(2.29)	1.86	.400	2(.819)
			사후	8.71(1.38)	2.07		
			추후	8.71(1.38)	2.07		
	감내력과 몰두	실험집단	사전	16.71(3.95)	2.71	6.522*	2(.038)
			사후	10.71(3.68)	1.64		
			추후	10.29(3.50)	1.64		
		비교집단	사전	17.14(2.34)	2.71	6.909*	2(.032)
			사후	13.14(2.03)	1.57		
			추후	13.43(1.81)	1.71		
	평가	실험집단	사전	23.71(3.86)	3.00	13.455**	2(.001)
			사후	17.43(2.99)	1.57		
			추후	17.14(3.13)	1.43		
		비교집단	사전	25.43(3.10)	2.71	6.909*	2(.032)
			사후	20.57(3.26)	1.71		
			추후	20.43(3.05)	1.57		

* $p < .05$; ** $p < .01$



[그림 V-4] 실험집단과 비교집단 내 행동적 변인(교통감내력)
사전-사후-추후검사 비교

② 실험집단과 비교집단 내 행동적 변인(자해행동) 사전-사후-추후 차이 검증

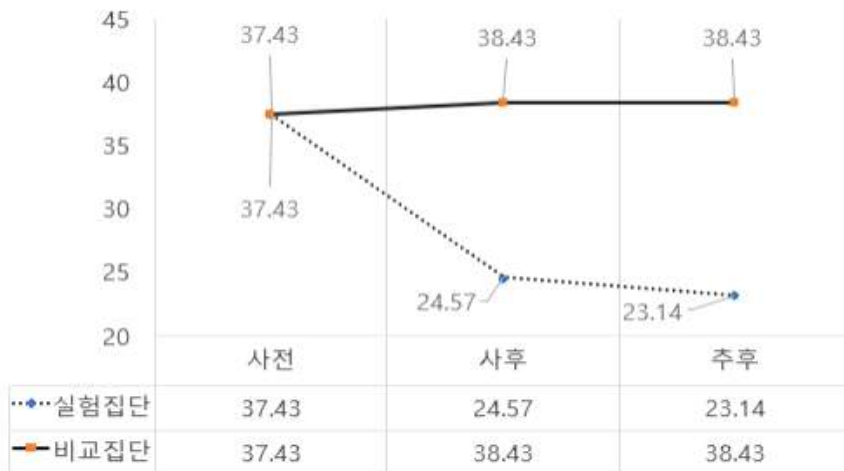
실험집단과 비교집단 내 자해행동의 사전-사후-추후검사는 실험집단과 비교집단을 대상으로 집단 내 자해행동 사전-사후-추후검사 점수의 변화를 알아보기 위해 Friedman test를 실시하였다.

실험집단의 자해행동은 프로그램 종료 1개월 후 통계적으로 유의한 수준으로 감소한 것으로 나타났다($Z=12.00$, $p<.01$). 비교집단의 자해행동은 프로그램 종료 1개월 후 통계적으로 유의미한 감소가 없었다($Z=.091$, $n.s$). 실험집단과 비교집단 내 자해행동의 사전-사후-추후검사를 비교한 결과는 <표 V-25>과 같다.

<표V-25> 실험집단과 비교집단 내 행동적 변인 (자해행동) 사전-사후-추후 차이 검증

변인	집단영역	n	검사	평균(M) (표준편차, SD)	평균순위	X ²	df(p)
자해행동	실험 집단	7	사전	37.43(1.72)	3.00	12.00**	2(.002)
			사후	24.57(2.51)	1.71		
			추후	23.14(2.34)	1.23		
	비교 집단	7	사전	37.43(2.07)	1.93	.091	2(.956)
			사후	38.43(4.72)	2.00		
			추후	38.43(5.19)	2.07		

** $p < .01$



[그림 V-5] 실험집단과 비교집단 내 행동적 변인(자해행동) 사전-사후-추후 차이 검증

2. 프로그램 참여자 성찰 경험 및 연구자 관찰

본 연구에서 제안하는 중학생 비자살적 자해행동 감소를 위한 변증법적 행동치료(DBT) 집단기술훈련은 연구자 본인이 직접 운영하였다. 이 과정에서 연구자는 프로그램 참여자의 경험을 보다 입체적으로 이해하고자 참여자 성찰 내용을 기술하도록 하였으며 해당 내용에 대한 연구자의 관찰 일지를 작성하여 절차에 따라 정제하였으며 회기별로 정리하였다. 구체적인 내용은 다음과 같다.

1) 1회기: 변증법적 행동치료(DBT) 이해와 마음 친구와 함께 해봐요.

본 프로그램의 1회기는 프로그램의 본격적인 시작에 앞서 서로 간의 친밀감을 형성하고 이해하는 것을 주요 목표로 하였고, 구체적인 3가지 목표를 제시하였다.

이를 살펴보면, ‘첫째 프로그램 목적을 이해하고, 프로그램에 대한 기대를 할 수 있다’. ‘둘째 호흡 관찰에서 마음챙김을 경험할 수 있다’. ‘셋째 자기소개를 통해 참여자들과 친밀감 및 신뢰감을 형성할 수 있다’로 오리엔테이션의 성격으로 진행되었다. 이는 참여자들의 프로그램에 대한 개념과 이해를 높이고 연구자와 참여자 간의 상호 신뢰성을 기반으로 참여 안정성을 높이는 동시에 개인의 참여 동기를 증진함으로써 보다 실효적인 프로그램 운영을 담보하기 위한 것이다.

프로그램들은 프로그램 1 회기에서 신뢰 관계(rapport) 형성을 위하여 자기소개와 참여 동기를 서로 나누었으며, 프로그램의 운영 목적을 포함하는 진행 규칙을 정하고 서약서 및 개인정보 동의서를 작성하였다. 또한, 비밀보장의 범위와 녹음에 대한 동의 등의 절차를 거치는 등 원활한 프로그램 운영을 위한 오리엔테이션을 진행하였다.

1회기를 정리하면 프로그램 참여자들의 긴장감을 낮추고, 친밀감을 형성하였으며, 1 회기에서 10회기까지 프로그램의 전반적인 과정의 진행 및 내용을 안내하고 하였던 목표를 달성한 것으로 평가할 수 있다.

1회기에 연구자는 변증법적 행동치료(DBT)의 개념 4가지 안내하였고 (마음챙김, 고통감내력, 정서조절, 대인관계 효율성) 변증법에 대한 설명과 변증법적 행동치료가 프로그램 참여자들에게 어떠한 의미가 있는지를 구체적으로 설명하였다. 1회기 진행을 마치고 의 소감을 나누도록 하였으며 참여자들에게 다음 회기의 소개와 과제를 안내하고 마무리하였다. 1회기 프로그램 참여자 성찰 경험과 연구자 관찰 내용은 <표 V-26>와 같다.

<표 V-26> 1회기 프로그램 참여자 성찰 경험 및 연구자 관찰

단계	회기	DBT 이해와 마음 친구와 함께 해박요	
도입	1)		
		참여자 성찰 경험	연구자 관찰
		• ①번: 나 자신을 좀 더 잘 알 수 있었다. 내가 진짜로 좋아하는 것들을 떠올릴 수 있었다. • ②번: 호흡명상을 하며, 언제든지 편안해질 수 있다는 것을 경험하였다. 마음의 색깔을 떠올리며 편안함을 경험하였다. • ③번: 집단에서 자기소개를 통해 친구들에 대해 알게 되었고 좀 더 편안해졌다. • ④번: 프로그램 참여자 활동에 참여하면서 마음이 편안해졌다. 처음보다 심란한 게 풀렸다. • ⑥번: 마음이 차분하게 가라앉았다. 나 자신을 돌아보고 나를 느낄 수 있었다. • ⑦번: 나를 돌아보는 것을 느꼈고, 내가 잘하는 것이 아주 많다는 것을 알게 되었다. 차분히 상상하는 것을 경험하였다.	• 프로그램 시작에 주의 사항은 참여하는 동안 충분한 수면과 규칙적인 생활, 하도록 합의적인 약속은 했으나 2~3명의 참가자는 약속을 지키려는 의지가 약해 보였다. • 호흡명상을 통하여 자기 이해하는 마음챙김 기술 훈련을 다소 어려워하였다. • 변증법에 대한 설명이 충분히 이해시킬 수 있는 시간 확보가 요구되었다.

2) 마음챙김(mindfulness training): ‘What’ 기술(2회기)

본 프로그램의 2회기 활동 목표는 ‘What’ 기술(관찰하기, 기술하기, 참여하기) 익히기이다. 구체적으로는 내 마음이 나를 통제하게 두지 않고, 내가 내 마음을 통제할 상태에서 한 번에 한 가지 ‘what’만 사용하는 기술을 습득하는 것이다.

2회기 활동은 DBT 기술훈련 중에서 마음챙김에 해당하는 것으로는 현재 순간을 인식하고, 단 한 가지에만 마음을 두도록 반복된 훈련을 하고, 이를 통해 자신의 마음을 관찰할 수 있다. 집중할 대상을 정하지 못하거나, 집중하기 어려운 참여자에게는 연구자가 나뭇잎을 제시하여 관찰하도록 하는 훈련을 하였다. 이를 통해 참여자는 사물을 더욱 잘 관찰하고 집중하게 된다.

프로그램 참여자는 ‘프로그램 시작 전보다 회기가 끝난 후에 더 편안함을 경험했다’, ‘편안하고 안락함을 느꼈다’, ‘마음이 안정되고 편안해지는 것을 느꼈다.’ 등의 참여 성찰 내용을 밝혀 2회기 프로그램을 통해 들은 편안함을 경험한 것을 확인할 수 있었다. 종합하면, 2회기 프로그램을 통해 들은 자신의 불편한 마음을 이해하고 수용하는 마음가짐에 도움이 되었다고 소감을 밝혔다.

연구자는 2회기 프로그램에서 참여자들이 눈을 감고 호흡하는 모습과 들숨, 날숨의 호흡명상을 통해 명상하는 모습을 관찰하였다. 관찰과 참여 성찰 내용을 통하여 연구자는 비합리적 신념이 긍정적 신념으로 변화되었음을 알 수 있었다.

2회기 프로그램 참여자 성찰 경험 및 연구자 관찰 내용은 <표 V-27>과 같다.

<표 V-27> 2회기 프로그램 참여자 성찰 경험 및 연구자 관찰

단계	회기	'What' 기술	
도입	2)		
참여자 성찰 경험		연구자 관찰	
• ①번: 마음의 안정을 느꼈다. • ②번: 마음이 복잡했는데 고민이 해결되었다. • ③번: 처음 프로그램하기 전에는 마음이 불편했는데 감정 변화를 느꼈다. • ④번: 재미있었고 마음이 편안해졌다. 내 마음을 털어놓는 느낌, 힘들 때 명상하는 법을 알게 되었다. • ⑥번: 차분하고 조용한 분위기 덕분에 편안해지면서, 처음 프로그램하기 전에는 마음이 불편했는데 감정 변화를 느꼈다. • ⑦번: 힘들 때 명상하는 법을 알게 되었다.		• 마음챙김의 인지적 변인 중 비합리적 신념을 긍정적인 신념으로 수용하고 변화하는 모습을 보였다. • 참여자들은 눈을 감고 호흡 관찰하기와 마음챙김 기술훈련에 진지하게 참여하였다. • 활동이 어려운 것을 위해 나뭇잎에 집중하도록 하였고, 들은 쉽게 이해하고 수용하였다.	

3) 마음챙김(mindfulness training): 'HOW' 기술(3회기)

3회기 프로그램은 마음챙김 'HOW' 기술훈련으로 활동 목표는 일어나는 감정의 파도를 조심하기이다. 구체적으로는 '무비판적 마음을 갖고, 있는 그대로를 보기', '좋은 것과 나쁜 것을 평가하려고 하지 않기'. '한가지 마음 갖기' 등을 훈련하는 것으로 구성되어 있다. 프로그램을 시작하기 전에 마음챙김을 위해 호흡 관찰을 연습하였다.

연구자는 비자살적 자해 감소를 위해 자해를 이해하고, 자해의 이유와 당시 감정을 이해하고 느껴보도록 하였다. 이 과정에서 자신을 평가하지 않도록 주의하였고, 참여자들은 자책하지 않고 있는 그대로의 자신을 바라볼 수 있었다.

3회기 프로그램에 대한 참여자의 성찰 내용을 살펴보면, 프로그램에 참여하는 동안 잠시 마음의 온도가 따뜻해짐을 느꼈다고 하였고, 한가지 마음에

집중하니 안 좋은 과거를 풀어내는 방법을 알게 되었다고 하였다.

연구자는 3회기 프로그램에서 참여자들이 일어나는 감정의 파도를 조심하면서 고통과 문제를 행동으로 옮겼던 과거의 자신을 담담히 표현하고 이해하는 모습을 보았고, 이 과정에서 문제를 하나씩 생각하고 해결하는 기술 훈련을 통해 자신을 수용하는 모습을 관찰할 수 있었다. 3회기 프로그램 참여자 성찰 경험 및 연구자 관찰 내용은 <표 V-28>과 같다.

<표 V-28> 3회기 프로그램 참여자 성찰 경험 및 연구자 관찰

단계 회기		‘HOW’ 기술
전개	(3)	
참여자 성찰 경험		연구자 관찰
- 참여자 ①번: 이 활동을 하며 잠시나마 마음의 온도가 따뜻해짐을 느꼈다. - 참여자 ②번: 이제 지난 기억도 지난 것이니까 마음에 담지 말지를 생각했고, 마음이 따뜻해짐을 경험하였다. - 참여자 ③번: 안 좋은 과거를 어떻게 풀어야 할지 방법을 알았다. 편안하고 기분 좋은 감정을 경험했다. - 참여자 ④번: 막상 크다고 생각했던 고민이 적어졌다. - 참여자 ⑥번: 내 마음은 언제든지 따뜻해질 수 있다고 느꼈다. 14살까지의 나의 감정들과 사건들을 알게 되었다. - 참여자 ⑦번: 편안함과 내 이야기를 꺼내면서 후련함을 느꼈다.		- 마음챙김 기술훈련을 연습하면서 자신의 고통과 문제점이 자해행동으로 표출하는 자신을 알아차리는 과정이었다. - 마음챙김을 통하여 학생 자신의 마음이 편안함으로 주의를 집중하고 하나씩 생각하는 기술훈련이 참여자의 자신을 수용하는 데 도움이 되었다.

4) 고통 감내(distress tolerance) 기술훈련(4회기)

본 프로그램의 4회기 활동 목표는 고통감내력 기술훈련으로 자해충동 상

황에서 STOP 기술 연습하기이다. 이 활동은 참여자가 자해 충동이 발생할 때, 자해행동을 즉시 멈추고 이를 감소하기 위한 위기 생존 기술을 훈련하는 것이다. 또한, ‘달라진 활기비밀’ 활동을 통해 주의를 환기하는데, 자해 충동 촉발 사건을 4요소(누가, 무엇을, 언제, 어디서) 고 구분하여 이해하고, 불편한 감정을 긍정적 감정으로 전환하도록 한다.

4회기 프로그램에 대한 참여자들의 성찰 경험 알아보며 냉동 복식을 한 뒤 자해충동이 감소했다. 자해 도구를 보아도 자해충동을 참을 수 있었다. 세수하고 움직이니 충동이 사라졌다. 등의 긍정적인 성찰 내용을 밝혔다.

연구자 관찰은 자해행동 정지 연습하기와 위기 대처 기술 배우기 활동을 하면서 자해행동을 하고 싶은 감정을 접촉할 때 주의를 분산시키기 위해 기술훈련을 연습이 도움이 되었다.

연구자는 4회기 프로그램에서 참여자들이 냉동 복식에 진지하게 임하는 모습을 관찰할 수 있었고, 진심으로 자해행위를 멈추고 싶다는 태도를 관찰할 수 있어 자해 충동 시 참여자들의 주의를 적절히 분산하는 기술훈련이 매우 도움이 된다고 생각하였다. 4회기 프로그램 참여자 성찰 경험 및 연구자 관찰 내용은 <표 V-29>와 같다.

<표 V-29> 4회기 프로그램 참여자 성찰 경험 및 연구자 관찰

단계	회기	고통 감내 기술훈련(1)	
전개	(4)	참여자 성찰 경험	연구자 관찰
		• 참여자 ①번: 아빠가 잔소리하셔서 자해하고 싶었는데 고통감내력 기술훈련을 배웠던 (냉동 복식)을 실천해 보았다. 처음엔 별생각이 없이 찬물에 세수하고 복식호흡을 5번 했는데 자해하고 싶은 마음이 생각나지 않았다. • 참여자 ②번: 친구가 복도에서 어깨를 치고 가서 화가 나서 그 친구의 등짝을 세게 때렸는데 담임선생님 화를 내면서 또 너야 하는 말에 매우 슬퍼서 자해하고 싶었는데 복식호흡하면서 내 생각을 다른 곳으로 분산했다. • 참여자 ③번: 집에서는 자해 도구가 보이면 자해충동이 억제되지 않았는데, 냉동 복식을 하고 난 후에는 억제가 되었다. • 참여자 ④번: 남자 친구가 카톡을 읽고 답장을 안 해주니 나 또 차였다는 생각에 화가 나고 우울했는데, 냉동 복식을 하니 아무 일도 아닌 것처럼 느껴졌다. • 참여자 ⑥번: 학원 숙제가 많아 짜증 나서 DBT 기술훈련에 집중할 수가 없었다. • 참여자 ⑦번: 집에 들어가기 싫어서 방과후에 DBT 기술훈련을 계속하고 싶었다.	• 자해충동을 인식하는 참여자들은 본인들의 자해행위를 멈추기 위한 간절함이 있었음을 인식하였다. • 참여자들은 자신의 자해충동을 줄이기 위해 냉동 복식이라는 구체적인 전략을 절실하게 필요하다고 인식하였다. • 자해충동이 한번 발생하면, 스스로 멈추기 매우 어려우나 참여자들은 STOP 기술 연습을 통해 자해행동을 멈추는 모습을 보였다. • STOP 기술 연습을 반복한 뒤, 집으로 돌아가서도 자해충동을 낮추는 결과를 얻어 이러한 훈련이 일상에서 반복 훈련이 될 수 있도록 지원하는 것이 필요하다.

5) 고통 감내(distress tolerance) 기술훈련(5회기)

본 프로그램의 5회기 활동 목표는 고통 감내 기술훈련을 통해 나를 긍정적으로 돌보기이다. 구체적으로 자기 위안 기술을 익히고, 혐의 상자 만들기를 통해 고통을 일으키는 촉발 사건(정지하기, 한 걸음 물러서기)에 대한 자동적

사고와 비합리적 신념을 긍정적인 신념으로 바꾸도록 하는 것이다. 이를 통해 참여자들은 자해충동이 발생할 때, 자해행동을 멈추기 위한 ‘나의 구급상자’를 직접 만들고 활용하여 고통감내력 기술을 훈련하였다. 참여자들은 쉼의 상자를 활용하여, 자해충동을 잠시 미루고 주위를 환기할 수 있었다.

참여자의 성찰 경험을 살펴보면, 쉼의 상자에서 불편한 감정과 충동에 대처하고 갈등을 피하는 데 도움이 되었다고 하였으며, 자해행동을 하고 싶을 때 잘 견딜 수 있었다고 성찰 경험을 밝혔다. 이러한 성찰 경험을 통해 참여자들은 5회 프로그램 활동에서 자해충동을 좋아하는 다른 것으로 관심을 이동하고, 자신을 자해충동에서 통제하는 기술을 습득한 것으로 볼 수 있다.

연구자는 참여자들이 자신들이 좋아하는 것을 하나씩 밝히면서 행복해하는 모습을 관찰할 수 있었고, 자기만의 쉼의 상자를 만들어 나가는 모습을 볼 수 있었다. 특히, 사진첩, 캐러멜 등 자신이 일상에 좋아하는 것에 대해 남에게 말하거나, 남이 들어주는 것에 기쁨을 느끼는 모습을 보였다. 이에 일상에서 자신들에게 관심을 가지고, 자신들이 좋아하는 것에 대한 공감대를 형성하는 것을 기쁘게 생각함에 따라 잠시나마 자해 문제로부터 해방되는 모습을 확인할 수 있었다. 5회기 프로그램 참여자 성찰 경험과 연구자 관찰 내용은 <표 V-30>과 같다.

<표 V-30> 5회기 프로그램 참여자 성찰 경험 및 연구자 관찰

단계	회기	고통 감내 기술훈련(2)	
전개	(5)	참여자 성찰 경험	연구자 관찰
		①번: 고통스러운 생각이 들면 먹는 것으로 스트레스를 푸는데 고통감내력 기술을 배워서 다행이다. ②번: 평소에는 항상 애착 인형을 가방에 넣고 다니면서 위안을 삼았는데, 고통감내력 기술을 배워서 이번 기회에 애착 인형 없이 학교에 가보고 싶다. ③번: 자해행동을 하고 싶을 때, 이 순간을 잘 견디고 있었다. ④번: 쉽의 상자에서 이번 주에 기분 안 좋은 생각이 많이 났는데 고통감내력 기술훈련 적용하였다. 기분이 좋고 마음이 편했다. ⑥번: 쉽의 상자에서 불편한 감정과 충동에 대처하고 갈등을 피하는 데 도움이 되었다. ⑦번: 쉽의 상자를 만들기에서 신체 이완하는 방법이 어려웠다.	- 참여자들은 고통스러운 상황에서 기존의 대처 방식(예: 과식, 애착 인형 의존 등) 대신 고통감내력 기술을 활용하여 감정을 조절하는 모습을 보였다. 이는 DBT 기술이 자해 충동을 감소시키는 곳인데 효과적임을 시사한다. - 쉽의 상자'를 통한 활동은 들에 정서적 안정감을 제공하였다. 일부는 이 활동을 통해 불편한 감정과 충동을 효과적으로 대처하였으며, 이는 정서조절 능력 향상에 이바지한 것으로 판단된다.

6) 정서조절(emotion regulation 기술훈련 (6회기))

본 프로그램의 6회기 활동 목표는 감정에 머무르기 정서조절 기술훈련이다. 이는 참여자로 하여금 감정에 지각하고 인식하도록 하여 자신의 감정을 알도록 한다. 구체적으로는 먼저 참여자들이 자신이 자해행동을 할 때의 감정을 정리할 수 있도록, 자해 원인과 당시의 감정에 머무르도록 한다. 또한, 이후 서로 역할극을 통해 자해의 원인을 제공한 상대방이 상황을 이해하도록 하였다. 이는 자해행동의 핵심 감정을 알도록 하여 스스로 감정을 다스리는 정서조절 기술을 훈련하도록 하는 것을 목표로 한다.

참여자들은 부모님 잔소리로 자해충동이 생겼는데, 속으로는 내가 부모님께 인정받고 싶은 마음이 있었다는 것을 알게 되었다. 또한, 자해행동에 대해서 죄책감을 느꼈는데 정서조절 기술을 훈련하면서 나 스스로가 자해행동을 하지 않고 싶다는 마음이 있음을 알게 되었다고 성찰 내용에서 기술하였다.

연구자는 6회기 프로그램 참여자들이 감정에 머무르기, 상대 이해하기, 감정 표현하기 등에서 많은 어려움을 겪는 모습을 관찰할 수 있었으며, 감정표현이 정확하지 않고 서툰 모습을 관찰할 수 있었다. 따라서, 이들의 감정표현을 훈련하여 자신의 마음과 타인의 마음을 모두 이해할 수 있는 능력을 갖추는 그것이 필요하다고 생각하였다. 이를 통해 들이 핵심 신념을 찾아가는 모습을 확인할 수 있었고, 자해행동의 지속 여부와 자동적 사고, 그리고 비합리적 신념을 확인할 수 있었다.

6회기 프로그램 참여자 성찰 경험과 연구자 관찰 내용은 <표V-31>와 같다.

<표 V-31> 6회기 프로그램 참여자 성찰 경험 및 연구자 관찰

회기 단계 전개 (6)	정서조절 기술훈련(1)
참여자 성찰 경험	연구자 관찰
①번: 나의 감정이 우울하다는 감정은 정서조절의 사실확인을 하면서 나는 행복하고 싶다는 나의 감정을 알았다. ②번: 자해행동하고 나면 죄책감을 느꼈는데 정서조절 기술훈련 연습하면서 나는 자해행동 안 하고 싶은 마음도 있다는 그것을 알게 되었다. 참 의미 있는 시간이었다. ③번: 부모님 잔소리에 자해행동의 촉발 사건이었다는 것을 알았는데 촉발 사건 속의 팩트는 부모님께 인정받고 싶은 마음이 있다는 것을 느꼈다. ④번: 나는 우리 반에서 따돌림당한다고 느꼈는데 감정 조절 기술훈련에서 단계별 감정을 검사해 보니 친구들과 잘 지내고 싶은 마음이 있다는 것을 알았다. ⑥번: 매일 지각하고 결석으로 생활선도위원회를 한다고 하셔서 우리 담임 선생님이 나만 미워한다고 생각했는데 감정 조절 기술훈련에 단계별 감정 다루기 훈련하면서 담임선생님께서 나에 대한 관심이 많다는 것을 느꼈다. ⑦번: 나의 감정 팩트를 알기가 어려웠다.	- 우울한 감정을 인식하고, 이를 통해 자신이 행복을 추구하고 있음을 깨달았다. 이는 정서조절 기술이 자기 인식에 도움을 줄 수 있음을 시사한다. - 자해행동 후 느끼는 죄책감을 인식하고, 자해하지 않으려는 내면의 욕구를 발견하였다. 이는 자해행동의 충동을 조절하는 데 정서조절 기술이 효과적임을 보여준다. - 부모님의 잔소리가 자해행동의 촉발 요인임을 인식하고, 그 이면에 부모님의 인정을 받고자 하는 욕구가 있음을 깨달았다. 이는 촉발 사건에 대한 인지적 재해석이 자해행동 감소에 기여할 수 있음을 시사한다. - 따돌림을 당한다고 느꼈으나, 감정 조절 기술을 통해 친구들과 잘 지내고 싶은 마음을 인식하였다. 이는 사회적 관계에서의 감정 인식이 자해행동 감소에 영향을 미칠 수 있음을 보여준다. 그러나 일부들은 감정의 팩트를 인식하는 데 어려움을 겪었다. 이는 감정 인식 능력의 개인차를 고려하여 프로그램을 설계할 필요가 있음을 시사한다.

7) 정서조절(emotion regulation 기술훈련(7회기))

본 프로그램 참여자의 7회기 활동에 대한 목표는 일어나는 감정을 조절하기이다. 이는 참여자로 하여금 현재 삶에서 본인이 중요하다고 생각하는 일의 목록을 작성하게 하여 그 중요도를 척도 점수를 부여하게 하였다. 이

를 통해 자신이 정작 중요한 일에 집중하고, 많은 시간을 보내고 있었는지를 직접 눈으로 확인하게 한 후 중요하지 않음에도 많은 시간을 들여서 하고 있었던 일들을 확인하도록 목표로 한다.

참여자들은 7회기 활동에서 자신이 중요하지 않은 일을 찾아내는 작업을 하도록 함과 동시에 자신의 일상에서 집중해야 하는 포인트를 발견하고, 감정 조절 훈련에 참여 하였고, 감정경로를 탐색하고 자신의 자해행동 유발한 진실 검증을 확인하여 부정적인 정서를 긍정적인 정서로 정반대 행동하기를 연습하였다. 이에 참여자들은 DBT 집단기술훈련 프로그램에 참여하면서 처음으로 나의 감정을 알아보려 시도하였음을 진술 하였고, 외롭고 우울할 때 자해충동이 생겼는데 반대로 행동하기 해보니, 자해행동이 멈추어졌다는 성찰 내용을 밝혔다.

연구자는 6회기 프로그램에서 정서조절 기술훈련이 우울할 때 자해충동이 생기는 데 이를 반대로 행동하기의 기술훈련 하면서 참여자들이 자해행동 감소하는 데 큰 영향이 미친다는 것을 관찰하였다.

감정을 이해하고 알아차리는 데 어려웠던 부분이, 자해를 촉발하는 요인이라는 것이 알았고 이를 지혜롭게 대처하고 반대로 행동하기 기술훈련이들의 자해행동 감소한 것이 확인되었다.

7회기 프로그램 참여자 성찰 경험과 연구자 관찰 내용은 <표V-32>와 같다.

<표 V-32> 7회기 프로그램 참여자 성찰 경험 및 연구자 관찰

단계 회기		정서조절 기술훈련(2)
전개 (7)		
참여자 성찰 경험		연구자 관찰
• ①번: 감정조절 신체 변화는 밖으로 나가 기 싫어졌다. 살도 찌고 눈물만 난다. 울고 싶은 감정이 슬플 때도 있지만 게임을 못해서 화나서도 슬프다는 감정을 알아차렸다. • ②번: 감정이 얼굴 표현은 손이 떨리고 머리가 아프다. 잠을 자려고 게임을 안 했더니. 잠이 잘 왔다. 우울한 감정이 좀 나아졌다. • ③번: 외롭다는 생각에 모든 그것이 귀찮아졌다. 외로움 감정은 놀고 싶은 생각이기 때문이라는 것을 느꼈다. • ④번: 외로움 감정은 공부하기 싫은 감정이 외로움으로 느껴졌다. • ⑥번: DBT 기술훈련 프로그램에 참여하면서 처음으로 나의 감정을 알아보려고 했다. • ⑦번: 부모님께 열심하고 있는 모습을 보여드리고 싶은데 감정이 속상해서 울었다. 감정을 이해하는 기술훈련을 배워서 적용해보고 싶다.		• 참여자들은 프로그램을 통해 자신의 감정을 더 명확하게 인식하고 명명하는 능력을 향상하게 시켰다. 예를 들어, 한 참여자는 우울한 감정을 느끼는 상황에서 "나는 행복하고 싶다"라는 내면의 욕구를 인식하게 되었으며, 또 다른 참여자는 자해행동 후 느끼는 죄책감 속에서 "자해하지 않고 싶은 마음도 있다"라는 이중적인 감정을 발견하였다. 이러한 감정 인식의 증가는 정서조절 기술훈련의 효과를 반영하는 것으로 판단된다.

8) 대인관계 효율성(interpersonal effectiveness)기술훈련1(8회기)

본 프로그램의 8회기 활동 목표는 다른 사람을 수인하기이다.

대인관계 효율성 집단기술훈련 중 진심을 보여주는 기술로 친절하게, 관심을 보이기, 원만하게, 이해해 주기의 활동으로 친구가 자해행동에 관해서 이야기할 때 친절하게 관심을 보이고, 비난하지 않는 활동을 하였다. 다른 사람이 말한 내용 잘 듣고 다시 말해주기 등의 연습으로 활동 목표를 달성

하였다.

참여자들은 8회기 활동에서 나의 감정의 이름 자해 후 아프다. 신체적 감각은 아무 감각이 없었는데 집단에서 친구랑 이야기하니까 조금 ‘후련했다’. 라는 대인관계 효율성의 수인하기에 도움이 되었다.

연구자는 8회기 에서 참여자들에게 각자 상대방의 자해행동 정지에 관한 이야기를 적어보게 하였는데 이 과정에서 친구에게 관심 기울이기 위해 용기를 내는 참여자들의 모습을 볼 수 있었다. 또한, 다른 사람이 말한 내용을 주의 깊게 경청하고 이를 재진술하는 연습과정에서 감정표현이 세련되지는 않았지만 타인을 이해해 주기 위해서 노력하였으며 이 과정에서 상호 존중과 배려의 경험이 관찰되었다. 8회기 프로그램 참여자 성찰 경험과 연구자 관찰 내용은 <표 V-33>과 같다.

<표 V-33> 8회기 프로그램 참여자 성찰 경험 및 연구자 관찰

단계	회기	대인관계 효율성 기술훈련(1)	
전개	(8)		
참여자 성찰 경험		연구자 관찰	
①번: 나의 감정의 이름 자해 후 아프다. 신체적 감각은 아무 감각이 없었는데 집단에서 친구랑 이야기하니까 조금 후련했다. ②번: 금가진자 기술훈련 자존심을 지켜다. ③번: 00 친구가 나랑 헤어지자고 일주일도 안 돼서 폐소를 받았다. 대인관계 효율성 기술훈련 연습했는데 친구랑 잘 지내고 싶은 마음이 있어서 친구가 원하는 것이 무엇인지 궁금했다. ④번: 자기 감정을 친구에게 정확히 표현하고 주장하는 대인관계 효율성 기술훈련을 알았다. ⑥번: 문제가 될 때 대인관계에서 우선순위를 결정하기를 배워서 나의 권리를 주장해서 좋았다. ⑦번: 친구랑 관계를 더 좋게 만들고 싶은 상황에서 나의 욕구와 원하는 것을 서로 대화하는 기술훈련을 배워서 적용해 보니 친구를 이해하는 데 도움이 되었다.		- 친구와 함께 자해행동 정지에 관한 이야기 적어보게 하였는데 관찰된 부분은 친구에게 관심 기울이기 위해 용기를 내는 들의 모습을 볼 수 있었다. - 다른 사람이 말한 내용 잘 듣고 다시 말해주기 연습의 재진술 기술훈련은 서로 어색하고 감정표현은 어색해하였으나, 자해행동 정지에 관한 이야기 적어 보는 과정에서는 타인을 원만하게 해주려는 참여자들의 모습이, 자해행동 감소에 영향이 있다고 사료된다.	

9) 대인관계 효율성(interpersonal effectiveness)기술훈련2(9회기)

본 프로그램의 9회기 활동 목표는 대인관계 효율성 활동 목표는 “금 가진 자” 기술로 ‘금지하라 사과, 가치 지키기, 진솔하게, 자타공평’이다.

친구와 갈등을 피하고자 무조건 사과하는 것은 금지하도록 하였다. 친구에게 관심을 기울이기 훈련으로 친구랑 자해행동 정지했던 경험을 나누고 칭찬해 주면서 스스로 자신을 격려 주기의 기술훈련으로 대인관계 효율성

목표를 달성하였다.

참여자들은 9회기 활동에서 친구한테 원하는 그것을 원지 못했을 때 친구가 밉고 속상했는데 상대를 이해할 수 있었다.

연구자는 9회기 프로그램 참여자에서 참여자들의 자기 존중감이 낮은 심리적 특성을 고려하여 자기 존중감을 유지하도록 타인에게 무조건 사과를 금지하도록 하였고, 자해행동 재발 방지 교육과 함께 타인에게 요청하거나 거절할 때 고려할 것과 나의 가치와 의견을 지키고 자신과 타인에게 공평하게 행동하는 점이 대인관계 맺는 데 도움이 되고 큰 영향을 주었다. 9회기 프로그램 참여자 성찰 경험과 연구자 관찰 내용은 <표 V-34>과 같다.

<표 V-34> 9회기 프로그램 참여자 성찰 경험 및 연구자 관찰

단계 회기		대인관계 효율성 기술훈련(2)
전개	(9)	
참여자 성찰 경험		연구자 관찰
①번: 자존감이 낮아서 친구와 대화가 어려웠는데 대인관계 기술훈련 배워서 친구랑 이야기할 수 있는 용기가 생겼다. ②번: 친구랑 대화할 때 나의 욕구와 바람이 무엇인지 알 수 있었다. ③번: 대인관계에서 우선순위 정하는 방법을 알아 내가 손해 보지는 않을 것 같다. ④번: 친구랑 싸워서 손절했는데 대인관계 효율성 기술훈련을 배워서 친구랑 이야기해 보고 싶다. 친구의 뒷말에서 미안했다. ⑥번: 친구한테 원하는 것을 원지 못했을 때 친구가 밉고 속상했는데 상대를 이해할 수 있었다. ⑦번: 나에 대해서 어떻게 느끼고 바라고 있는지를 알았다.		- 참여자들의 자기 존중감이 낮은 심리적 특성을 고려하여 자기 존중감을 유지하도록 타인에게 무조건 사과를 금지하도록 하었는데 도움이 되었다. - 자해행동 재발 방지 교육과 함께 타인에게 요청하거나 거절할 때 고려할 것과 나의 가치와 의견을 지키고 자신과 타인에게 공평하게 행동하는 점이 대인관계 맺는 데 도움이 되고 큰 영향을 주었다.

10) 종결 단계 (10회기)

전체 프로그램 참여 여정을 마치는 10회기 활동 목표는 참여자의 자해행동 재발 방지에 비중을 두었다. 종결 단계로 10회기로 동안 익힌 집단 기술훈련에 대해 참여자들이 돌아가면서 그동안 배운 기술의 명칭을 하나씩 이야기하도록 하였고, 퀴즈를 통해 배운 기술에 대해 정리하도록 하여 10회기 총정리의 목표를 달성하였다.

연구자는 10회기 프로그램에서 앞으로 발생할 수 있는 자해 충동 상황에서 어떤 기술을 사용해 볼 수 있을지 미리 연습하기 기술을 통해 생각해 보도록 하였다. 비자살적 자해행동을 멈출 수 있는 대처 방법을 찾아보는 시간을 갖도록 하는 과정에서, 참여자들은 DBT의 4가지(마음챙김, 고통감 내력, 정서조절, 대인관계 효율성) 기술훈련 지혜로운 활동 하겠다는 모습이 관찰되었다. 또한, 마음으로 주의 환기를 통해 비자살적 자해행동의 위기 상황에서 대처하는 재교육과 비자살적 자해행동을 재발 방지 서약서를 작성하면서 자해행동을 멈추겠다는 의지를 볼 수 있었다. 10회기 프로그램 참여자 성찰 경험 및 연구자 관찰 내용은 <표 V-35>과 같다.

<표 V-35> 10회기 프로그램 참여자 성찰 경험 및 연구자 관찰

단계	회기	종결	
전개	(10)		
성찰 경험		연구자 관찰	
①번: 자해행동에서 충동적인 생각을 1분 견딜 수 있게 되었다. ②번: 나는 고통감내력 부족이 약해서 자해하고 후회했는데, 잠시 이 상황을 이겨낼 수 있게 기능이 도움이 되었다. ③번: 고통감내력 이겨 낼 수 있는 문제충동에서 자해행동 멈출 방법을 확실히 배웠다. ④번: 자해행동이 귀찮아졌다. 피 나면 뒤처리하기도 귀찮아서 자해를 안 하고 싶다. ⑥번: 집 밖에 안 나가고 싶은 마음이 정서를 관찰하고 기술하기 훈련을 통하여 편안해졌다. ⑦번: 자해행동의 반대로 행동하기에서 자해행동을 멈출 수 있었다.		- 앞으로 발생할 수 있는 상황에서 어떤 기술을 사용해 볼 수 있을지 참여자들과 미리 연습하기 활동이 자해행동 재발 방지에 큰 효과가 있을 것으로 사료 되었다. - 참여자들은 프로그램을 통해 자해행동을 감소시키는 데 도움이 되었음을 보고하였다. 특히, 자해행동의 충동 시 반대로 행동하기 등의 정서조절 기술훈련이 자해행동을 멈추고 반복된 자해행동을 감소시키는 데 효과적이었다고 평가하였다.	

VI. 논의 및 결론

1. 논의

본 연구는 중학생의 비자살적 자해행동 감소를 위해 변증법적 행동치료 집단기술훈련 프로그램을 제안하고, 프로그램 참여가 중학생 비자살적 자해행동 경험자에게 미치는 효과를 검증하는 것을 목적으로 수행되었다. 비자살적 자해행동 감소를 위해 변증법적 행동치료 프로그램 개발을 위해서 관련 선행연구를 검토하였으며, 중학생과 상담사를 대상으로 요구조사를 실시하였고 도출된 시사점을 기반으로 프로그램의 초안을 제시하였다. 전문가의 타당성 검토 과정을 거쳐 내용과 운영 지침을 수정하였으며, 최종적으로 10회기의 변증법적 행동치료 집단기술훈련 프로그램을 개발하였다.

본 프로그램의 적용 효과 검증을 위해서 비자살적 자해행동이 높은 중학생을 7명을 선정하여 총 10회기의 프로그램을 진행하였다. 프로그램 효과 검증은 실험집단과 비교집단 및 통제집단으로 구성하였으며 집단 간 사전 동질성 검증을 거쳐 주요 변인에 대한 사전, 사후, 추후 검사를 실시하고 통계적 의미를 분석하였다.

정성적 관점에서 프로그램 참여자의 경험을 확인하기 위하여 프로그램 참여 경험에 대한 성찰 기록과 연구자의 관찰 기록을 제시함으로써 프로그램의 효과를 보다 입체적으로 조망하고자 하였다. 본 연구를 통해 현상된 쟁점의 논의는 다음과 같다.

1) 프로그램 개발에 대한 논의

본 연구에서 제안하는 중학생의 비자살적 자해행동 감소를 위한 변증법적 행동치료 집단기술훈련 프로그램 개발에 대한 논의는 다음과 같다.

첫째, 본 연구에서 제시하는 DBT 프로그램이 중학생의 비합리적 신념에 미치는 효과는 어떠한가에 대한 다각도의 검증 결과 프로그램 참여집단의 비합리적 신념 지수가 긍정적으로 개선되는 효과를 확인할 수 있었다.

프로그램에 참여한 실험집단과 비교 및 통제집단 간의 사후 검증 결과, 프로그램에 참여한 실험집단이 통제, 비교집단에 비해 비합리적 신념 수준이 통계적으로 유의한 수준에서 낮게 나타났다. 또한, 실험집단과 비교집단 간의 추후 비교에서도 실험집단이 통계적으로 유의미한 수준에서 개선된 지수를 보이고 있으며 집단 내 비교에서의 자기 비하, 성취 및 편안한 욕구, 승인 및 공평한 욕구 중 ‘평안한 욕구’를 제외한 모든 요인에서 유의한 차이를 확인하였다. 또한, 실험집단 내 비합리적 신념 사전-사후-추후 검사 비교에서도 모든 하위 요인의 유의미한 감소가 확인되었다.

이러한 결과는 본 연구에서 제안하는 DBT 프로그램이 중학생의 자해행동 중 인지적 변인에 긍정적인 영향을 미칠 가능성을 시사하는 것이다. 이와 관련하여 강은숙(2024), 이종국 외(2023)의 DBT 프로그램이 청소년 대상자의 자해 예방과 관련된 인지적 영역에 유의미한 영향이 있다는 결과는 본 연구의 결과를 지지하는 것이다. 또한, DBT 프로그램을 적용함으로써의 인지적 변화를 기술한 관련 연구(김민주, 2021; 유숙경, 김영은, 2023; 배은희, 2021) 등에서 일관적으로 보고하고 있는 바와 맥락적으로 유사한 결과를 확인할 수 있다.

일반적으로 비합리적 신념은 논리적 근거가 부족하거나 현실과 맞지 않는 믿음으로 정의되며, 이러한 신념은 개인의 감정 및 행동에 부정적인 영향을 미칠 수 있다(김수연, 2019; 김수진, 2016, 2017; 나현주, 2022;

Hamann, & Reese, 2020; Pagiaslis, & Krontalis, 2014). 이러한 맥락에서 개인이 "나는 결코 행복할 수 없다"거나 "고통을 통해서만 내 감정을 통제할 수 있다"라는 비합리적 신념을 가질 경우, 비자살적 자해행위로 이어질 수 있다(김수진, 2016, 2017; Tuomela, 2020). 비합리적 신념은 개인의 심리적 상태와 행동에 영향을 미친다는 점에서, 개인의 불안과 불확실성 회피와 관련이 있으며, 이는 부정적인 경험을 강화하는 악순환을 초래할 수 있다(Liekefett et al., 2021). 이러한 믿음이 지속되면, 개인은 자신의 심리적 고통을 해결하는 데 가장 간편하고 즉각적인 방법의 하나로 비자살적 자해행위와 같은 비합리적인 선택을 할 가능성이 높아진다.

본 연구에서 제시하는 DBT 프로그램 참여자의 비합리적 신념 개선에 유의미한 영향을 미치는 것은 몇 가지 요인으로 압축할 수 있다. 먼저, 본 연구의 DBT 운영 체계가 집단참여체제로 구성되어 있다는 것이다. 실제로, 집단 내에서 암묵적으로 공유되고 표출되는 행위의 경향은 개인의 신념과 행동에 강력한 영향을 미친다(김수진, 2016, 2017; Tuomela, 2020). 이는 집단 내에서 공유되는 정서와 신념이 개인의 신념과 행위가 부정적인 방향으로 전환 되거나 반대로 집단의 정서와 신념이 긍정적일 때 개인에게도 긍정적 영향을 미칠 수 있음을 시사한다.

본 연구에서 제시한 DBT는 공동의 문제와 공통의 목표를 가지고 모인 또래 집단에 대한 훈련 프로그램으로서 자해행위의 비합리성을 강조할 뿐만 아니라 또래 집단에서 자신의 행위를 객관적으로 인식하는 기회를 제공하였으며 사회적 맥락에서 자신의 자해행위가 비합리적 선택임을 인식하게 하는 기회가 되었다는 것이다.

한편, 본 연구에서 제시하는 DBT 프로그램의 ‘마음챙김 기술’은 수용 기술에 기반하고 있으며(조안남, 2023; Linehan, 1993a, 1993b) 자신에 대한 수용은 변증법적 사고(Dialectical Thinking) 경험에 기초한 논리적이고

체계적인 자기 객관화를 가능하게 한 것으로 판단된다. 다시 말해, 본 연구에서 제시하는 DBT 프로그램은 자해 동기 탐색, 비합리적 신념 파악 원인 알아차리기, 자해행동 이해, 자해행동에 대한 내 생각과 감정, 행동 기술 등의 경험을 통해 자신의 비자살적 자해행동의 모순을 더욱 객관적으로 바라보는 기회(김수진 2016)가 되었다는 것이다. DBT의 핵심은 모순적인 감정이나 상황을 인정하고, 이를 통합하여 보다 효과적인 행동을 유도하는 것에 있다(Rudge et al., 2020; Mehlum, et al., 2019)는 전제는 바로 이러한 실천을 함의하는 것에 불과하다. 실제로 프로그램 참여 경험에 대한 정량적 분석에서 들은 ‘막상 크다고 생각했던 고민이 적어졌다.’, ‘14살까지의 감정들과 사건들을 알게 되었다’, ‘지나간 것이니깐 마음에 담지 말지를 생각했다’ 등의 반응을 보인다. 프로그램 참여 중학생의 이러한 사고 경험은 자신의 행동과 행동을 유발하는 동기, 환경과 사건에 대한 해석이 불완전한 감정이었으며, 자신의 감정적 행위로 인한 결과가 매우 비합리적이었음을 인식하는 기회가 있음을 시사하는 것이다.

둘째, DBT 프로그램이 중학생의 정서조절에 미치는 효과는 어떠한가에 대한 다각도의 검증 결과 각 집단 간 비교, 집단 내 사후 비교, 추후 비교, 실험집과 비교집단의 추후 비교, 실험집단과 비교집단의 사전, 사후, 추후 검사 결과 비교 분석에서 정서조절의 하위 요인인 비수용성, 충동 통제 곤란, 정서조절 전략 부족 등에서 통계적으로 유의미한 차이를 확인하지 못하였다. 또한, 실험집단과 비교집단 간 정서조절 변화의 추후검사에서도 유의미한 변화를 관측할 수 없었다.

반면, 통제집단 내에서 정서조절과 비수용성, 충동통제 곤란, 정서조절 전략 부족 등의 하위 요인에서 유의미한 변화를 확인할 수 있었으며 실험집단과 비교집단 내 정서조절 사전, 사후, 추후 비교에서 실험집단의 정서조절 하위 요인 비수용성, 충동 통제 곤란, 정서조절 전략 부족에서 통계적으

로 유의미한 변화를 확인하였다.

본 연구의 결과와 같이 특정 행동과 심리적 변화를 유도하는 프로그램이 효과를 발휘하지 못하는 이유에 대해 몇 가지 해석을 해 볼 수 있다. 우선, 행동과 인식의 변화 의도와 실제 행동 변화 간의 관계는 매우 복잡하며 (Webb, & Sheeran, 2006), 구체적인 행동과 인식변화 단계에 맞춘 개입이 요구(Sheeran, & Rothman, 2017; Prochaska, & Velicer, 1997) 되지만 이를 정교하게 관리하지 못하는 경우, 의도했던 효과를 산출하지 못할 수 있다는 것이다. 또한, 프로그램의 성공은 프로그램이 목표로 하는 특정 세부 행동 또는 목표에 대한 명확한 이해를 바탕으로, 효과적으로 수용자에게 전달하는 그것이 매우 중요하다. 따라서 프로그램의 목표와 이를 달성하기 위한 운영 지침을 잘못 이해하고 전달에 실패하는 경우 프로그램의 효과가 제한될 수 있다(Ersche, et al., 2016). 다른 한편 프로그램의 운영 과정에서 회기나 차시에서 얻은 피드백이나 평가가 부족할 경우 프로그램 내에서 수정과 개선이 어렵기 때문에(Caronet al., 2018) 프로그램 적용 효과가 반감될 수 있다. 이러한 관점에서 본 연구에서 제안하는 중학생 비자살적 자해행동 감소를 위한 DBT 프로그램을 보다 체계적이고 정교하게 운영하는 방안에 대한 고민이 필요할 것으로 판단된다.

셋째, 집단 간 우울 수준에 대한 사후검사 및 추후검사에서 모두 실험집단이 통계적으로 유의한 수준에서 감소 추세를 보였다. 또한, 실험집단 내 우울 사전, 사후검사의 경우 우울의 하위 요인인 대인관계에서 유의미한 변화를 확인하였으며 실험집단과 비교집단 내 우울 수준의 사전, 사후, 추후 검사 값 비교에서는 실험집단에서 신체 및 우울 정서를 제외한 모든 요인에서 유의한 감소를 확인하였다.

이러한 결과는 맥락적으로 비슷한 국·내외 관련 논의에서 일부 확인할 수 있다(김소율, 권해수, 2023; 이종국 외, 2023; 조안남, 권해수, 2021;

Linehan, et al., 2015; Goldstein, et al., 2015). 각각의 논의들은 프로그램 참여 대상자를 달리하고는 있지만 프로그램 참여자가 우울 및 우울과 관련된 다양한 변인을 억제하거나 개선하는 참여 프로그램이 의미 있는 작용을 한다는 점을 일관적으로 밝히고 있다. 또한, DBT는 다양한 정신건강 문제와 관련된 증상에 효과적이라는 것이 다수의 해외 연구를 통해 입증되고 있다(Linehan, et al., 2015; Rudegeir et al., 2020) 이러한 치료 효과는 DBT의 여러 구성요소 가운데 특히, 정서조절 중재의 결과로 보는 관점이 있다.

다시 말해 정서조절 능력의 향상은 자해행동의 감소와도 밀접하게 연관되어 있으며, 이는 우울증의 심각성을 완화하는 데 도움을 주며 문제해결, 감정 조절 및 대인관계 경험을 통해서 심리적, 정서적 스트레스 상황보다 적극적으로 대처함에 따라서 우울을 억제한다는 것이다(Linehan et al., 2015; Goldstein, et al., 2015; Panos, et al., 2014).

본 연구에서 제시한 DBT 프로그램의 경우, 정서조절 경험으로서 ‘일어나는 감정에 머무르기’, ‘일어나는 감정 조절하기’를 활동 목표로 설정하고 ‘마음챙김’ 경험으로서 ‘감정 지각하고 인식하기’, ‘감정에 머무르기 행동치료(DBT)’, ‘정서 반응 변화 기술’, ‘정서변화와 반대로 행동하기’, ‘자신의 감정 이해하고 우울감 감소하기’ 등의 구성요소를 제공하였다. 이 과정에 대한들의 경험을 정성적 관점에서 분석한 결과 ‘나의 감정이 우울하다는 감정은 정서조절의 사실 확인을 하면서 나는 행복하고 싶다는 나의 감정을 알았다.’, ‘나는 우리 반에서 따돌림당한다고 느꼈는데 정서조절 기술훈련에서 단계별 감정을 검사해 보니 친구들과 잘 지내고 싶은 마음이 있다는 것을 알았다.’, ‘감정이 얼굴 표현은 손이 떨리고 머리가 아프다. 잠을 자려고 게임을 안 했더니. 잠이 잘 왔다. 우울한 감정이 좀 나아졌다.’와 같은 반응을 확인하였다. 프로그램 참여자들의 이러한 반응은 자신의 감정을 확인하

고 그 감정의 원인을 직시하고 조절함으로써 우울과 같은 부정적 정서를 억제하는 경험으로 해석할 수 있다. 이러한 해석은 앞서 기술한 DBT 프로그램의 정서조절 중재 효과라는 맥락에서 이해될 수 있다는 것이다.

넷째, 본 연구에서 확인한 DBT 프로그램의 적용은 들의 고통감내력 부족에 유의미한 영향을 미치는 것으로 분석되었다. 조절을 제외한 감내력과 몰두, 평가 등 구성 하위 요인에서 통계적으로 유의미한 수준에서 낮다는 것이 확인되었다. 실험집단과 비교집단 간 추후 검사 결과 두 집단 간 차이는 발견되지 않았지만, 집단 내 고통감내력 사전, 사후 비교에서는 조절, 감내력과 몰두, 평가 등 모든 구성 하위 요인에서 유의미한 수준에서 사전보다 낮은 값을 확인할 수 있었다. 또한, 실험집단과 비교집단 내 고통감내력 사전-사후-추후검사 비교에서 프로그램 종료 후 1개월까지 하위 요인 중 조절을 제외하고 감내력과 몰두, 평가 등 하위 요인에서 통계적으로 유의미하게 낮은 수준을 유지하고 있음을 확인하였다.

이상의 연구 결과는 진다슬, 손정락(2013)의 DBT 기술훈련이 청소년의 공격성, 자아존중감 및 분노 표현 양식에 미치는 효과에 대한 논의에서 제시한 연구 결과와 맥락적으로 일치하는 것이다. 이 연구는 본 연구에서 설정한 행동 변인으로서 고통감내력을 직접 변인으로 설정하지는 않았지만, 공격성, 분노 표현, 공격성과 같은 관련 변인의 감소를 보고하고 있다. 이러한 요소는 본질적으로 개인이 느끼는 정서적 고통의 감내와 몰두, 감정에 대한 평가를 통해 조절 가능하다는 점에서 본 연구의 결과에 더해 시사하는 바가 있다. 이와 비슷한 관점에서 유숙경, 양영길(2022)은 교정시설 성범죄 수형자의 재범 예방을 위한 DBT 프로그램의 효과를 보고하였다. 이 연구에서도 DBT 프로그램 참여자의 충동성, 공격성, 자기 통제력의 재배열이 관측되었음을 보고하였고 특히, 자기 통제력과 같은 고통감내력 구성 요인의 긍정적 변화를 확인하였다는 점에서 본 연구의 결과를 부분적으로 지

지하고 있다.

이와 관련하여 DBT 프로그램이 개인이 느끼는 고통을 피하지 않고 직면하게 하여 고통을 견뎌내는 능력을 강화함으로써 정서적 고통을 피하려는 충동을 줄이고, 불편한 감정과 상황을 더욱 효과적으로 다룰 수 있는 경험을 제공한다는 연구(Niedtfeld, et al., 2017; Hempel et al., 2018)가 비교적 최근에 논의된 바 있다. 개인이 직면한 고통을 감내하는 능력은 자신의 감정을 조절하고, 마음챙김과 객관적 사실에 대한 수용 능력(Niedtfeld, et al., 2017)을 키우며 자기효능감을 향상(Pistorello, et al., 2012) 하는 등 다면적인 정서조절 능력이 동반되어야 가능하다(이종국, 2023; Panos, et al., 2014). 본 연구에서 제시하는 DBT 프로그램은 ‘위기 상황 STOP 스킬 연습하기’, ‘나를 긍정적으로 돌보기’ 등의 목표를 제시하고 ‘고통을 일으키는 촉발 사건(정지하기, 한걸음 물러서기)’, ‘나의 위기 생존 구급상자 만들기’와 같은 구체적인 경험을 통해 고통을 감내한다는 추상적인 개념을 실천할 수 있었다. 이와 관련하여 DBT 프로그램들은 “아빠가 잔소리하셔서 자해하고 싶었는데 고통감내력 기술훈련을 배웠던 (냉동 복식) 을 실천해 보았다. 처음엔 별생각이 없이 찬물에 세수하고 복식호흡을 5번 했는데 자해하고 싶은 마음이 생각나지 않았다.”, ‘쉽의 상자’에서 자해충동이 생기면 ‘쉽의 상자’를 열어 “내가 좋아하는 마이쥬 와 내가 좋아하는 친구랑 찍은 사진을 보니”, “불편한 감정과 자해충동에 대처하고 갈등을 피하는 데 도움이 되었다”. 와 같은 반응을 보였다. 이는 앞서 기술한 참여자의 정서조절 능력에 대한 실천 경험의 구체적인 반응으로 해석할 수 있다.

본 연구는 DBT 프로그램 참여자의 자해행동에 미치는 영향을 확인하고자 집단 간 참여자의 자해행동 사후검사를 실시하였다. 앞서 분석한 프로그램 참여자의 반응은 비자살적 자해행동을 강화하거나 억제하는 잠재적 요소로서 간접적으로 비자살적 자해행위의 증감을 관측하기 위한 것이다. 반

면, 여기서 제시하는 자해행동 분석력과는 자해행동에 대한의 실제 행위를 분석하였다는 점에 주목할 필요가 있다.

먼저, 집단에 따른 자해행동 사후검사 결과, 프로그램에 참여한 실험집단의 자해행동이 다른 두 집단에 비해 통계적으로 유의미한 수준에서 낮은 것으로 확인되었다. 또한, 실험집단과 비교집단 간 추후 비교에서도 실험집단이 유의미한 수준에서 자해행동이 낮은 것으로 분석되었다. 실험집단과 비교집단 내 자해행동 사전-사후-추후검사 비교 역시 실험집단의 자해행동이 실험종료 1개월까지 지속되어 비교집단에 비해 유의미한 수준에서 영향을 미치고 있었다. 이러한 결과는 DBT 프로그램이 중학생의 자해행동 개선에 직접적인 영향을 미친다는 것을 보여주는 것이다.

이와 관련하여 국내 연구로는 드물게 여자대학생의 DBT 프로그램 경험과 자해행동 사례를 질적 수준에서 기술한 김명숙 외(2024)의 논의는 본 연구의 결과에 비추어 시사하는 바가 크다. 이 연구는 업무에 부모와의 갈등 대한 압박감과 압박된 상황에서 촉발된 부정적 자동적 사고가 자기혐오로 이어져 부정적 정서에 압도되는 상태에서의 자해 충동이 자해행동으로 발전하는 사례 1과 대인관계 스트레스 상황에서 자기 비난을 하며 처벌의 의미로 자해행동 하게 되는 사례 2를 대상으로 DBT 프로그램을 시행하고 그 과정과 결과를 심층 기술하였다. 두 가지 비슷한 맥락의 사례에 대해서 각 개인의 자해 충동과 자해행동이 나타나기까지의 과정에서 감정 상태에 대한 마음챙김과 비판적 사고를 통한 자해행동의 지연 및 중단에 집중하여 프로그램을 적용하였다. 프로그램 처치 결과, 두 사례 모두 비자살적 자해행동의 체인 분석을 통하여 자신의 표적 행동의 연결고리를 깨닫고 이러한 연결고리를 끊기 위한 시도로서 정서조절 기법을 적용하여 표적 행동을 지연 혹은 중단하는 데 성공하였음을 보고하였다. 또한, 이종국(2023)의 논의는 직접적인 자해행위에 대한 측정은 아니지만 자해행위 촉발 요인으로서

정서적, 심리적 상태를 효과적으로 제어하는 데 DBT 프로그램이 효과적임을 밝히고 있다.

DBT 프로그램 참여 학생의 경험을 정성적 관점에서 분석한 본 연구에서도 비슷한 반응을 관찰할 수 있다. 예컨대, ‘자해행동 감소변화 알기’를 목표로 수행된 대인관계 효율성 훈련에서 프로그램 참여자들은 친구와 자해행동 정지 경험을 나누고 서로 칭찬해 주는 경험을 통해 자존감을 회복하고 구체적인 자해행동 재발 방지 교육을 수행하였다. 이에 대해서 프로그램들은 ‘자해행동에서 충동적인 생각을 1분 견딜 수 있게 되었다’, ‘고통감내력 부족이 약해서 자해하고 후회했는데, 잠시 이 상황을 이겨 낼 수 있게 스킬이 도움이 되었다’, ‘고통감내력 이겨 낼 수 있는 문제 충동에서 자해행동 멈춤 방법을 확실히 배웠다’, ‘자해행동이 귀찮아졌다. 피 나면 뒤처리 하기도 귀찮아서 자해를 안 하고 싶다’ 와 같이 자해행동 중단에 대한 구체적인 경험과 의지를 밝혔다.

DBT 프로그램이 중학생의 자해행위를 예방하거나 감소시키는 데 효과적인 주요한 이유는 DBT가 마음챙김, 정서조절, 대인관계 효율성, 고통감내력 등 감정 조절 기술을 발달시키고 실천을 통해 경험하는 곳인데 있다 (Lynch, et al., 2006; Mehlum, et al., 2006). 특히, 감정조절 훈련이 중학생과 같은 청소년에게 중요한 이유는 이 시기가 감정적 변화와 사회적 스트레스에 매우 민감할 뿐만 아니라 주변 환경으로부터 받는 감정적 영향이 극적인 형태로 표출될 수 있는 시기이다.

따라서 비자살적 자해행위와 같은 정서적 문제를 겪고 있는 청소년들의 경우 더욱 적극적인 중재가 필요하다고 할 수 있다. 이러한 관점에서 본 연구에서 제안하는 DBT 프로그램은 중학생의 비자살적 자해행동의 감소, 예방, 개선 기여할 수 있다는 가능성을 확인하였다는 점에 의미가 있으며 후속 논의 등을 통해서 보완 및 발전시킬 가치가 있다고 판단된다.

2) 프로그램 효과에 대한 논의

다음으로 프로그램 효과에 대해 논의하고자 한다. 본 연구에서는 중학생의 비자살적 자해행동 감소를 위한 변증법적 행동치료(DBT) 과정의 효과를 검증하기 위하여 정량적, 정성적 관점의 관측을 시도하였으며, 연구결과에 토대하여 논의하면 다음과 같다.

첫째, 본 연구에서 제시하는 DBT 프로그램이 중학생의 비합리적 신념에 미치는 효과는 어떠한가에 대한 다각도의 검증 결과 프로그램 참여집단의 비합리적 신념 지수가 긍정적으로 개선되는 효과를 확인할 수 있었다.

프로그램에 참여한 실험집단과 비교 및 통제집단 간의 사후 검증 결과, 프로그램에 참여한 실험집단이 통제, 비교집단보다 비합리적 신념 수준이 통계적으로 유의한 수준에서 낮게 나타났다. 또한, 실험집단과 비교집단 간의 추후 비교에서도 실험집단이 통계적으로 유의미한 수준에서 개선된 지수를 보이고 있으며 집단 내 비교에서도 ‘평안한 요구’를 제외한 모든 요인에서 유의한 차이를 확인하였다. 또한, 실험집단 내 비합리적 신념 사전-사후-추후 검사비교에서도 모든 하위 요인의 유의미한 감소가 확인되었다.

이러한 결과는 본 연구에서 제안하는 DBT 프로그램이 중학생의 자해행동 중 인지적 변인에 긍정적인 영향을 미칠 가능성을 시사하는 것이다. 이와 관련하여 강은숙(2024), 이종국 외(2023)의 DBT 프로그램이 청소년 대상자의 자해 예방과 관련된 인지적 영역에 유의미한 영향이 있다는 결과는 본 연구의 결과를 지지하는 것이다. 또한, DBT 프로그램을 적용함으로써의 인지적 변화를 기술한 관련 연구(김민주, 2021; 배은희, 2021; 유숙경, 김영은, 2023) 등에서 일관적으로 보고하고 있는 바와 맥락적으로 유사한 결과를 보이는 것이다.

일반적으로 비합리적 신념은 논리적 근거가 부족하거나 현실과 맞지 않

는 믿음으로 정의되며, 이러한 신념은 개인의 감정 및 행동에 부정적인 영향을 미칠 수 있다(김수연, 2019; 김수진, 2016, 2017; 나현주, 2022; Hamann, & Reese, 2020; Pagiaslis, & Krontalis, 2014). 이러한 맥락에서 개인이 "나는 결코 행복할 수 없다"거나 "고통을 통해서만 내 감정을 통제할 수 있다"라는 비합리적 신념을 가질 경우, 비자살적 자해행위로 이어질 수 있다(김수진, 2016, 2017; Tuomela, 2020). 비합리적 신념은 개인의 심리적 상태와 행동에 영향을 미친다는 점에서, 개인의 불안과 불확실성 회피와 관련이 있으며, 이는 부정적인 경험을 강화하는 악순환을 초래할 수 있다(Liekefett, Christ, & Becker, 2021). 이러한 믿음이 지속되면, 개인은 자신의 심리적 고통을 해결하는 데 가장 간편하고 즉각적인 방법의 하나로 비자살적 자해행위와 같은 행동을 선택할 가능성이 높아진다.

본 연구에서 제시하는 DBT 프로그램 참여자의 비합리적 신념 개선에 유의미한 영향을 미치는 것은 몇 가지 요인으로 압축할 수 있다. 먼저, 본 연구의 DBT 운영 체계가 집단참여 체계로 구성되어 있다는 것이다. 실제로, 집단 내에서 암묵적으로 공유되고 표출되는 행위의 경향은 개인의 신념과 행동에 강력한 영향을 미친다(김수진, 2016, 2017; Tuomela, 2020).

이는 집단 내에서 공유되는 정서와 신념이 개인의 신념과 행위가 부정적인 방향으로 전환 되거나 반대로 집단의 정서와 신념이 긍정적일 때 개인에게도 긍정적 영향을 미칠 수 있음을 시사한다. 본 연구에서 제시한 DBT는 공동의 문제와 공통의 목표를 가지고 모인 또래 집단에 대한 훈련 프로그램으로서 자해행위의 비합리성을 강조할 그럴 뿐만 아니라 또래 집단에서 자신의 행위를 객관적으로 인식하는 기회를 제공하였으며 사회적 맥락에서 자신의 자해행위가 비합리적 선택임을 인식하게 하는 기회가 되었다는 것이다.

한편, 본 연구에서 제시하는 DBT 프로그램의 ‘마음챙김 기술’은 수용 기

술에 기반하고 있으며(조안남, 2023; Linehan, 1993a, 1993b) 자신에 대한 수용은 변증법적 사고(Dialectical Thinking) 경험에 기초한 논리적이고 체계적인 자기 객관화를 가능하게 한 것으로 판단된다. 다시 말해, 본 연구에서 제시하는 DBT 프로그램은 자해 동기 탐색, 비합리적 신념 파악 원인 알아차리기, 자해행동 이해, 자해행동에 대한 내 생각과 감정, 행동 기술 등의 경험을 통해 자살의 비자살적 자해행동의 모순을 더욱 객관적으로 바라보는 기회(김수진, 2016, 2017; Lindner et al., 1999)가 되었다는 것이다.

DBT의 핵심은 모순적인 감정이나 상황을 인정하고, 이를 통합하여 보다 효과적인 행동을 유도하는 것에 있다(Rudge et al., 2020; Mehlum, et al., 2019)는 전제는 바로 이러한 실천을 함의하는 것에 불과하다. 실제로 프로그램 참여 경험에 대한 정량적 분석에서 들은 ‘막상 크다고 생각했던 고민이 적어졌다.’, ‘14살까지의 감정들과 사건들을 알게 되었다’, ‘지나간 것이니깐 마음에 담지 말지를 생각했다’ 등의 반응을 보인다. 프로그램 참여 중학생의 이러한 사고 경험은 자신의 행동과 행동을 유발하는 동기, 환경과 사건에 대한 해석이 불완전한 감정이었으며, 자신의 감정적 행위로 인한 결과가 매우 비합리적이었음을 인식하는 기회가 있음을 시사하는 것이다.

둘째, DBT 프로그램이 중학생의 정서조절에 미치는 효과는 어떠한가에 대한 다각도의 검증 결과 각 집단 간 비교, 집단 내 사후 비교, 추후 비교, 실험집과 비교집단의 추후 비교, 실험집단과 비교집단의 사전, 사후, 추후 검사 결과 비교 분석에서 정서조절의 하위 요인인 비수용성, 충동 통제 곤란, 정서조절 전략 부족 등에서 통계적으로 유의미한 차이를 확인하지 못하였다. 또한, 실험집단과 비교집단 간 정서조절 변화의 추후 검사에서도 유의미한 변화를 관측할 수 없었다.

반면, 통제집단 내에서 정서조절과 비수용성, 충동 통제 곤란, 정서조절

전략 부족 등의 하위 요인에서 유의미한 변화를 확인할 수 있었으며 실험 집단과 비교집단 내 정서조절 사전, 사후, 추후 비교에서 실험집단의 정서 조절 하위 요인 비수용성, 충동 통제 곤란, 정서조절 전략 부족에서 통계적으로 유의미한 변화를 확인하였다. 이상의 결과를 객관적으로 평가한다면 본 연구에서 제시하는 프로그램이 정서조절 변화에 과학적으로 검증할 수 있는 수준의 영향을 미치고 있다고 평가하기 어렵다.

본 연구의 결과와 같이 특정 행동과 심리적 변화를 유도하는 프로그램이 효과를 발휘하지 못하는 이유는 몇 가지 요인에서 찾을 수 있다. 우선, 행동과 인식의 변화 의도와 실제 행동 변화 간의 관계는 매우 복잡하며 (Webb, & Sheeran, 2006), 구체적인 행동과 인식변화 단계에 맞춘 개입이 요구(Sheeran, & Rothman, 2017; Prochaska, & Velicer, 1997)되지만 이를 정교하게 관리하지 못하는 경우, 의도했던 효과를 산출하지 못할 수 있다는 것이다.

또한, 프로그램의 성공은 프로그램이 목표로 하는 특정 세부 행동 또는 목표에 대한 명확한 이해를 바탕으로, 효과적으로 수용자에게 전달하는 것이 매우 중요하다. 따라서 프로그램의 목표와 이를 달성하기 위한 운영 지침을 잘못 이해고 전달에 실패하는 경우 프로그램의 효과가 제한될 수 있다(Ersche, et al., 2016). 다른 한편 프로그램의 운영 과정에서 회기나 차시에서 얻은 피드백이나 평가가 부족할 경우 프로그램 내에서 수정과 개선이 어렵기 때문(Caronet al., 2018) 프로그램 적용 효과가 반감될 수 있다. 이러한 점을 생각한다면 본 연구에서 제안하는 중학생 비자살적 자해행동 감소를 위한 DBT 프로그램을 보다 체계적이고 정교하게 운영하는 방안 에 대한 고민이 필요할 것으로 판단된다.

셋째, 집단 간 우울 수준에 대한 사후검사 및 추후 검사에서 모두 실험집단이 통계적으로 유의한 수준에서 감소 추세를 보였다. 또한, 실험집단 내

우울 사전, 사후검사의 경우 우울의 하위 요인인 대인관계에서 유의미한 변화를 확인하였으며 실험집단과 비교집단 내 우울 수준의 사전, 사후, 추후 검사 값 비교에서는 실험집단에서 신체 및 우울 정서를 제외한 모든 요인에서 유의한 감소를 확인하였다.

이러한 결과는 맥락적으로 비슷한 국·내외 관련 논의에서 일부 제한적으로 확인할 수 있다(김소율, 권해수, 2023; 이종국 외, 2023; 조안남, 권해수, 2021; Goldstein, et al., 2015). 각각의 논의들은 프로그램 참여 대상자를 달리하고는 있지만 DBT 프로그램이 우울 및 우울과 관련된 다양한 변인을 억제하거나 개선하는 데 매개로서 의미 있는 작용을 한다는 점을 일관적으로 밝히고 있다. 또한 DBT는 다양한 정신건강 문제와 관련된 증상에 효과적이라는 것이 다수의 해외 연구를 통해 입증되고 있다(Linehan, et al., 2015; Rudgeet al., 2020).

이러한 치료 효과는 DBT의 여러 구성요소 가운데 특히, 정서조절 중재 효과로 보는 관점이 있다. 다시 말해 정서조절 능력의 향상은 자해행동의 감소와도 밀접하게 연관되어 있으며, 이는 우울증의 심각성을 완화하는 데 도움을 주며 문제해결, 감정조절 및 대인관계 경험을 통해서 심리적, 정서적 스트레스 상황보다 적극적으로 대처함에 따라서 우울을 억제한다는 것이다(Linehan, et., al, 2015; Goldstein, et al., 2015; Panos, et al., 2014).

본 연구에서 제시한 DBT 프로그램의 경우, 정서조절 경험으로서 ‘일어나는 감정에 머무르기’, ‘일어나는 감정 조절하기’를 활동 목표로 설정하고 ‘마음챙김’ 경험으로서 ‘감정 지각하고 인식하기’, ‘감정에 머무르기 행동치료’, ‘정서반응 변화 기술’, ‘정서변화와 반대로 행동하기’, ‘자신의 감정 이해하고 우울감 감소하기’ 등의 구성요소를 제공하였다. 이 과정에 대한들의 경험을 정성적 관점에서 분석한 결과 ‘나의 감정이 우울하다는 감정은 정서

조절의 사실확인을 하면서 나는 행복하고 싶다는 나의 감정 알았다’, ‘나는 우리 반에서 따돌림당한다고 느꼈는데 정서조절 기술훈련에서 단계별 감정을 조사해 보니 친구들과 잘 지내고 싶은 마음이 있다는 그것을 알았다.’, ‘감정이 얼굴 표현은 손이 떨리고 머리가 아프다. 잠을 자려고 게임을 안 했더니. 잠이 잘 왔다. 우울한 감정이 좀 나아졌다.’와 같은 반응을 확인하였다.

프로그램 참여자들의 이러한 반응은 자신의 감정을 확인하고 그 감정의 원인을 직시하고 조절함으로써 우울과 같은 부정적 정서를 억제하는 경험으로 해석할 수 있다. 이러한 해석은 앞서 기술한 DBT 프로그램의 정서조절 중재 효과라는 맥락에서 이해될 수 있다.

넷째, 본 연구에서 확인한 DBT 프로그램의 적용은 참여자들의 고통감내력 부족에 유의미한 영향을 미치는 것으로 분석되었다. 조절을 제외한 감내력과 몰두, 평가 등 구성 하위 요인에서 통계적으로 유의미한 수준에서 낮다는 것이 확인되었다. 실험집단과 비교집단 간 추후 검사 결과 두 집단 간 차이는 발견되지! 않았지만, 집단 내 고통감내력 사전, 사후 비교에서는 조절, 감내력과 몰두, 평가 등 모든 구성 하위 요인에서 유의미한 수준에서 사전 더 낮은 값을 확인할 수 있었다. 또한, 실험집단과 비교집단 내 고통감내력 사전-사후-추후검사 비교에서 프로그램 종료 후 1개월까지 하위 요인 중 조절을 제외하고 감내력과 몰두, 평가 등 하위 요인에서 통계적으로 유의미하게 낮은 수준을 유지하고 있음을 확인하였다.

이상의 연구 결과는 진다슬, 손정락(2013)의 DBT 기술훈련이 청소년의 공격성, 자아존중감 및 분노 표현 양식에 미치는 효과에 대한 논의에서 제시한 연구 결과와 맥락적으로 일치하는 것이다. 이 연구는 본 연구에서 설정한 행동 변인으로서 고통감내력을 직접 변인으로 설정하지는 않았지만, 공격성, 분노 표현과 같은 관련 변인의 감소를 보고하고 있다. 이러한 요소

는 본질적으로 개인이 느끼는 정서적 고통의 감내와 몰두, 감정에 대한 평가를 통해 조절 가능하다는 점에서 본 연구의 결과에 더해 시사하는 바가 있다. 이와 비슷한 관점에서 유숙경, 양영길(2022)는 교정시설 성범죄 수형자의 재범 예방을 위한 DBT 프로그램의 효과를 보고하였다.

본 연구에서도 DBT 프로그램 참여자의 충동성, 공격성, 자기 통제력의 재배열이 관측되었음을 보고하였고 특히, 자기 통제력과 같은 고통감내 구성 요인의 긍정적 변화를 확인하였다는 점에서 본 연구의 결과를 부분적으로 지지하고 있다.

이와 관련하여 DBT 프로그램이 개인이 느끼는 고통을 피하지 않고 직면하게 하여 고통을 견뎌내는 능력을 강화함으로써 정서적 고통을 피하려는 충동을 줄이고, 불편한 감정과 상황을 더욱 효과적으로 다룰 수 있는 경험을 제공한다는 연구(Hempel et al., 2018; Niedtfeld, et al., 2017)가 비교적 최근에 논의된 바 있다. 개인이 직면한 고통을 감내하는 능력은 자신의 감정을 조절하고, 마음챙김과 객관적 사실에 대한 수용 능력(Niedtfeld, et al., 2017)을 키우며 자기 효능감을 향상(Pistorello, et al., 2012)하는 등 다면적인 정서조절 능력이 동반되어야 가능(이종국, 2023; Panos, et al., 2014)하다.

본 연구에서 제시하는 DBT 프로그램은 ‘위기 상황 STOP 스킬 연습하기’, ‘나를 긍정적으로 돌보기’ 등의 목표를 제시하고 ‘고통을 일으키는 촉발 사건(정지하기, 한걸음 물러서기)’, ‘나의 위기 생존 구급상자 만들기’기와 같은 구체적인 경험을 통해 고통을 감내한다는 추상적인 개념을 실천할 수 있었다. 이와 관련하여 DBT 프로그램들은 “아빠가 잔소리하셔서 자해하고 싶었는데 고통감내력 기술훈련을 배웠던 (냉동복식)을 실천해 보았다. 처음엔 별생각이 없이 찬물에 세수하고 복식호흡을 5번 했는데 자해하고 싶은 마음이 생각나지 않았다.”, ‘쉽의 상자’에서 자해충동이 생기면 ‘쉽의

상자’를 열어 “내가 좋아하는 마이썬과 내가 좋아하는 친구랑 찍은 사진을 보니”, “불편한 감정과 자해충동에 대처하고 갈등을 피하는 데 도움이 되었다”. 와 같은 반응을 보였다. 이는 앞서 기술함의 정서조절 능력에 대한 실천 경험의 구체적인 반응으로 해석할 수 있다.

본 연구는 DBT 프로그램 참여자의 자해행동에 미치는 영향을 확인하고자 집단 간 참여자의 자해행동 사후검사를 실시하였다. 앞서 분석한 프로그램 참여자의 반응은 비자살적 자해행동을 강화하거나 억제하는 잠재적 요소로서 간접적으로 비자살적 자해행위의 증감을 관측하기 위한 것이다. 반면, 여기서 제시하는 자해행동 분석 결과는 자해행동에 대한 참여자의 실제 행위를 분석하였다는 점에 주목할 필요가 있다.

먼저, 집단에 따른 자해행동 사후검사 결과, 프로그램에 참여한 실험집단의 자해행동이 다른 두 집단에 비해 통계적으로 유의미한 수준에서 낮은 것으로 확인되었다. 또한, 실험집단과 비교집단 간 추후 비교에서도 실험집단이 유의미한 수준에서 자해행동이 낮은 것으로 분석되었다. 실험집단과 비교집단 내 자해행동 사전-사후-추후 검사비교 역시 실험집단의 자해행동이 실험종료 1개월까지 지속되어 비교집단에 비해 유의미한 수준에서 영향을 미치고 있었다. 이러한 결과는 DBT 프로그램이 중학생의 자해행동 개선에 직접적인 영향을 미친다는 것을 보여주는 것이다.

이와 관련하여 국내 연구로는 드물게 여자대학생의 DBT 프로그램 경험과 자해행동 사례를 질적 수준에서 기술한 김명숙 외(2024)의 논의는 본 연구의 결과에 비추어 시사하는 바가 크다. 이 연구는 업무에 대한 압박감과 부모와의 갈등 상황에서 촉발된 부정적 자동적 사고가 자기혐오로 이어져 부정적 정서에 압도되는 상태에서의 자해 충동이 자해행동으로 발전하는 사례 1과 대인관계 스트레스 상황에서 자기 비난을 하며 처벌의 의미로 자해행동을 하게 되는 사례 2를 대상으로 DBT 프로그램을 시행하고 그 과

정과 결과를 심층 기술하였다.

두 가지 비슷한 맥락의 사례에 대해서 각 개인의 자해 충동과 자해행동이 나타나기까지의 과정에서 감정 상태에 대한 마음챙김과 비판 단적 사고를 통한 자해행동의 지연 및 중단에 집중하여 프로그램을 적용하였다. 프로그램 처치 결과, 두 사례 모두 비자살적 자해행동의 체인 분석을 통하여 자신의 표적 행동의 연결고리를 깨닫고 이러한 연결고리를 끊기 위한 시도로서 정서조절 기법을 적용하여 표적 행동을 지연 혹은 중단하는 데 성공하였음을 보고하였다. 또한, 이종국(2023)의 논의는 직접적인 자해행위에 대한 측정은 아니지만 이를 촉발하는 요인으로서 정서적, 심리적 상태를 효과적으로 제어하는 데 DBT 프로그램이 효과적임을 밝히고 있다.

DBT 프로그램 참여 학생의 경험을 정성적 관점에서 분석한 본 연구에서도 비슷한 반응을 관찰할 수 있다. 예컨대, ‘자해행동 감소변화 알기’를 목표로 수행된 대인관계 효율성 훈련에서 프로그램 참여자들은 친구와 자해행동 정지 경험을 나누고 서로 칭찬해 주는 경험을 통해 자존감을 회복하고 구체적인 자해행동 재발 방지 교육을 수행하였다.

이에 대해서 프로그램 참여자들은 ‘자해행동에서 충동적인 생각을 1분 견딜 수 있게 되었다’, ‘고통감내력 부족으로 자해하고 후회했는데, 잠시 이 상황을 이겨 낼 수 있게 스킬이 도움이 되었다’, ‘고통감내력 훈련으로 문제 충동에서 자해행동을 멈출 방법을 확실히 배웠다’, ‘자해행동이 귀찮아졌다. 피 나면 뒤처리하기도 귀찮아서 자해를 안 하고 싶다’와 같이 자해행동 중단에 대한 구체적인 경험과 의지를 밝혔다.

DBT 프로그램이 중학생의 자해행위를 예방하거나 감소시키는 데 효과적인 주요한 이유는 DBT가 마음챙김, 정서조절, 대인관계 효율성, 고통 감내 등 감정 조절 기술을 발달시키고 실천을 통해 경험하도록 한다는 데 있다 (Lynch, et al., 2006; Mehlum, et al., 2006; Zaki, & Williams, 2013).

특히, 감정 조절 훈련이 중학생과 같은 청소년에게 중요한 이유는 이 시기가 감정적 변화와 사회적 스트레스에 매우 민감할 뿐만 아니라 주변 환경으로부터 받는 감정적 영향이 극적인 형태로 표출될 수 있는 시기이기 따라서 비자살적 자해행위와 같은 정서적 문제를 겪고 있는 청소년들의 경우 더욱 적극적인 중재가 필요하다고 할 수 있다.

이러한 관점에서 본 연구에서 제안하는 DBT 프로그램은 중학생의 비자살적 자해행동의 감소, 예방, 개선 기여할 수 있다는 가능성을 확인하였다는 점에 의미가 있으며, 후속 논의 등을 통해서 보완 및 발전시킬 가치가 있다고 판단된다.

2. 결론 및 제언

1) 결론

본 연구는 중학생의 비자살적 자해행동 감소를 위해 변증법적 행동치료(DBT) 집단기술훈련 프로그램을 개발하고 그 효과를 검증하는 것을 목적으로 수행 되었다. 프로그램 개발을 위해 문헌 고찰과 전문 상담사와 중학생 대상 요구 조사를 시행하여 적합한 내용을 선정하였다. 예비 프로그램은 전문가와의 논의를 통해 수정 및 보완하였으며, 최종 프로그램은 DBT의 네 가지 기술(마음챙김, 고통감내력, 정서조절, 대인관계 효율성)을 기반을 구성하였다.

프로그램 효과를 검증하기 위하여 비자살적 자해행동 경험이 있는 중학교 1학년 학생을 각 7명 씩 실험집단, 비교집단, 대기자 통제집단으로 임의 배당하였으며 10주 간의 프로그램 참여 후 관련 척도를 사용하여 자료를

수집하고 분석하였다. 프로그램 효과 검증 결과, 비합리적 신념의 긍정적 변화와 정서조절의 개선이 확인되었으며, 자해행동이 감소하는 효과를 나타냈다. 이러한 결과는 DBT 집단기술훈련 프로그램이 중학생의 비자살적 자해행동 감소에 효과적임을 시사하는 것이다.

본 연구를 통해 도출된 결론은 다음과 같다.

첫째, 본 연구에서 제안하는 프로그램은 관련 이론의 검토, 사전 요구도 조사, 프로그램의 목적, 목표, 내용, 운영 등 구조 전반에 대한 타당성 검토 등의 과정을 거쳐 체계적으로 개발되었다.

둘째, 본 연구에서 제안하는 프로그램 참여자는 인지적 변인 중 비합리적 신념의 긍정적 변화에 개인의 부정적 감정을 온전히 수용하여 긍정 정서와 부정 정서를 통합하는 데 전반적으로 의미 있는 영향을 미친다.

셋째, 본 연구에서 제안하는 프로그램 참여자는 정서적 변인 중 정서조절 및 우울, 슬픔의 감정, 외로움의 정서적 증상을 정, 반합의 변증법적 토대로 있는 그대로 수용하여 자해 청소년의 정신건강에 변화하는 전반적인 영향을 미친다.

넷째, 본 연구에서 제안하는 프로그램 참여자는 행동적 변인 중 고통감내력 부족 및 자해행동이 긍정적으로 변화하는 데 전반적으로 의미 있는 영향을 미친다.

다섯째, 본 연구에서 제안하는 프로그램은 청소년의 과도한 스트레스 관리에 도움이 되는 마음챙김 기술훈련과 정서조절에 어려움으로 자해하는 중학생뿐만 아니라, 자신의 감정표현이 서툴러 타인과 갈등 생긴 경우 이를 개선하는 데 유효할 것으로 판단된다. 다시말해, 본 연구의 프로그램을 적용할 수 있는 범위는 비교적 넓으며, 청소년의 자해행동 예방 교육에 활용한다면 자해행동 감소 및 재발 방지에 교육적으로 기여할 것으로 기대된다.

결론적으로 본 연구에서 제안한 중학생 비자살적 자해행동 감소를 위한

변증법적 행동치료(DBT) 프로그램은 국내·외 관련 논의에서 참여자에게 의미 있는 경험을 제공할 충분한 가능성이 있음을 검증받고 있으며 본 연구에서도 같은 맥락의 결과를 제시하였다. 최근까지 다양한 요인으로 인한 비자살적 자해행동 청소년이 증가하고 있는 상황에서 DBT 프로그램의 기반 이론과 적용이 청소년의 부적절한 행동 감소 및 완화에 효과가 있다면 이를 제도적 차원에서 공유하고 확산하려는 노력이 필요하다. 이를 위한 실천으로써 중등 예비 교사 교육 단계에서 이론적 수준의 소개, 교사 재교육 과정에서의 프로그램 구성 및 실행 여건에 대한 논의, 현장 청소년 심리상담사 교육 및 재교육에서의 관련 쟁점에 대한 논의와 적용 사례 공유 등, 다각도의 관심이 필요하다. 또한, 이를 지원하고 발전시키기 위한 학술적 수준에서의 심도있는 논의가 다양한 각도에서 활발하게 진행될 필요가 있다.

2) 제언

본 연구의 제한점 및 후속 연구를 위한 제언은 다음과 같다.

첫째, 본 연구는 연구에 참여한 대상자 수가 실험집단, 비교집단, 통제 집단별로 각 7명씩 총 21명으로 제한되어 있기 때문에 프로그램 효과를 모든 비자살적 자해행동 청소년에게 일반화하는데 한계가 있다.

둘째, 청소년의 비자살적 자해행동을 유발하는 심리적, 정서적, 환경적 요인은 매우 다양하게 거론되고 있다. 본 연구에서는 변증법적 행동치료(DBT) 이론에서 추출한 상담 치료 요인과 이에 대한 검증 요인을 중심으로 논의가 진행되었기 때문에 개인의 특성과 상황, 환경 측면으로 다양할 수 있는 관련 요인을 모두 고려하는데 한계가 있다.

셋째, 본 연구의 프로그램 개입 효과가 어느 정도 지속적으로 유지되었

는지 평가할 필요가 있다. 본 연구에서 추후 검사를 시행하였지만, 청소년 발달단계의 특수성을 고려하고 프로그램 참여자의 안정성을 평가하기 위해서는 보다 장기적 관점의 접근이 필요할 것으로 판단된다.

넷째, 본 연구는 DBT 프로그램 참여자의 성찰 경험을 정성적 관점에서 접근함으로써 프로그램 효과를 보다 입체적으로 서술하고자 노력하였다. 그럼에도 불구하고 이는 단순히 프로그램 참여자의 의견과 표면적으로 드러난 현상을 지엽적으로 묘사한 시도로서 당사자의 경험과 인식 세계를 심층적으로 이해하는데 명백한 제한이 있다. 이러한 제한은 본 연구가 프로그램 개발과 적용에 따른 효과를 객관적으로 평가하는 것을 연구의 중심 과제로 설정한 지점에서부터 노정(露呈)된 것이다.

이상과 같은 본 연구의 제한점을 바탕으로 제기되는 후속 연구 제언은 다음과 같다.

첫째, 청소년의 비자살적 자해행위는 개인 내·외적인 요인에 의해 발생한다는 것이 일반적인 시각이다. 특히, 청소년 발달단계의 특수성을 고려한다면 개인의 심리적, 정서적 상태에 영향을 줄 수 있는 생활환경, 학교, 가정, 주거지역 등 다양한 외생변수를 고려하는 논의로 확장 및 병행될 필요가 있다.

둘째, 적용된 프로그램의 효과성 검증을 위한 다각도 접근이 필요하다. 후속 연구에서는 프로그램 적용 전과 후, 추후 검사 추적을 확장하여 대상에 대한 장기적인 종단연구(longitudinal study), 패널 연구 등이 병행될 필요가 있으며, 관련 프로그램의 효과 크기 등을 종합적으로 판단할 수 있는 메타 연구(Meta-analysis)가 반드시 병행될 필요가 있다.

셋째, 후속 연구에서는 프로그램 적용 과정에서 참여자의 경험과 인식을 전적으로 현상학적 관점에서 심층적으로 탐구하고 이해하려는 시도가 필요하다. 일반적으로 현상학적 해석 연구에서 중요한 질적 자료 수집은 면담뿐

만 아니라 참여 관찰, 연구 참여자들이 생성하는 다양한 기록물 등을 포괄함으로써 질적 자료 분석의 정확성과 타당성을 확보하게 된다. 따라서 특정한 프로그램을 운영하고 참여자의 경험을 심층적으로 이해하기 위해서는 연구 기획 단계에서부터 치밀한 준비가 필요하며 특히, 질적연구에 대한 지식과 실천 역량을 갖춘 연구자의 개입을 고려한 연구설계가 필요하다.

넷째, 본 연구에서 제시한 프로그램 참여자의 성찰과 연구자 관찰 내용은 프로그램 효과에 대한 간접적 이해를 돕는데 일정 부분 도움을 주었지만, 구체적인 정황과 맥락, 정량적 효과 검증 결과와의 연계적 이해를 도모하기에는 부족하다는 점을 전술하였다. 따라서 후속 연구에서는 프로그램 운영에 따른 다양한 현상을 정교하고 확장된 관점에서 논의하기 위한 통합설계(김영천, 2017; Tashakkori & Teddlie, 1998)를 시도할 필요가 있다.

참 고 문 헌

- 강순전 (2002). 선형적 변증법과 사변적 변증법: 칸트와 헤겔의 Antinomie
론을 중심으로: 칸트와 헤겔의 Antinomie론을 중심으로. **철학연
구**, 58, 227-257.
- 강은숙 (2024). 변증법적 행동치료(DBT) 집단프로그램이 여자 중학생의 정
서조절 곤란, 마음챙김, 고통감내력에 미치는 영향. 국내 석사학위
논문, 한남대학교 일반대학원.
- 강화정, 이지연 (2016). 여고생의 부정적 정서와 대인불안과의 관계: 자기위
로능력과 정서적 고통 감내력의 매개효과. **청소년시설환경**, 14(2),
69-81.
- 공성숙, 이정현, 신미연 (2009). 섭식장애 환자의 아동기 외상 경험이 자해
행동에 미치는 영향과 부모 간 갈등의 매개 효과 분석. **정신 간호
학회지**, 18(1), 31-40.
- 곽현주, 김영희 (2012). DBT 음악치료가 대학생의 심리적 안녕감과 자아탄
력성 향상에 미치는 영향. **예술심리치료연구**, 8(2), 173-195.
- 곽희정, 김해숙, 임남열, 국혜윤 (2021). 20대 여성 강력범죄 피해자를 대상
으로한 단기 변증법적 행동치료 스킬훈련의 효과에 대한 질적 연
구. **피해자학연구**, 29(2), 165-196.
- 권경인, 김지영 (2019). 청소년 비자살적 자해 위기 상담 경험에 관한 현상
학적 연구: 상담자 경험을 중심으로. **상담학 연구**, 20(3), 369-393.
- 권석만 (2017). **인간관계의 심리학**. 서울: 학지사.
- 권혁진 (2014). 비자살적 자해에 영향을 미치는 정서적·인지적 요인의 탐색.
국내 석사학위논문, 서울대학교 대학원.

- 권혁진, 권석만 (2017). 한국판 자해 기능 평가지의 타당한 연구. **한국심리학회지**, 3(1), 187-205.
- 권혜미 (2013). DBT(Dialectical Behavior Therapy)가 우울성향의 청소년들의 우울감, 자기조절, 대인관계에 미치는 효과. 국내석사학위논문, 건국대학교 교육대학원.
- 김경미 (2024). 비자살적 자해 청소년을 위한 개인 정서조절 프로그램의 효과. 국내 석사학위논문. 충북대학교 대학원.
- 김경희 (2017). 중학생 분노조절의 향상을 위한 프로그램. 국내박사학위논문, 영남대학교 대학원.
- 김남성 (1995). **교육심리학**. 서울: 교육과학사.
- 김동일, 이예슬, 손수빈 (2024). 국내 DBT 프로그램에 대한 체계적 문헌 고찰 및 메타분석. **상담학연구**, 25(5), 1-21.
- 김명숙, 강예령, 최유주, 구훈정 (2024). 비자살적 자해를 위한 단기 변증법적 행동치료의 적용 사례 예비 연구: 여자 대학생 사례를 중심으로. **한국심리학회지: 여성**, 29(2), 165-197.
- 김민주 (2021). 경계선 성격 특성 여대생의 심리적 수용과 정서조절 곤란에 대한 변증법적 행동치료(DBT) 기술훈련 집단프로그램의 효과. 국내 석사학위논문, 조선대학교 대학원.
- 김보영, 이정숙 (2009). 청소년 자살 생각 관련 변인에 관한 메타분석. **대한간호학회지**, 39(5), 651-661.
- 김선영 (2008). 지각된 부모의 문제 해결 방식과 청소년의 문제해결 방식 및 자살 생각과의 관계. 국내 석사학위논문, 이화여자대학교 교육대학원.
- 김소율, 권해수 (2023). 변증법적 행동치료 집단기술훈련이 대학 운동선수의 정서조절과 대인관계 유능성에 미치는 효과. **교육치료연구**,

15(3), 347-362.

김소정, 우성범, 구훈정, 이종선 (2019). 한국판 자해 척도(K-SHI) 타당화 연구. **인지행동치료**, 19(2), 205-228.

김수연 (2019). 우울과 분노와의 관계에서 비합리적 신념의 인지 내용 중 자기비난과 의존성의 매개효과: 대학생들을 대상으로. **미래청소년학회지**, 16(4), 83-101.

김수진 (2015). 비자살적 자해와 애착 연구 개관: 국회 연구를 중심으로. **인간 발달연구**, 22(3), 1-24.

김수진 (2016). **비자살적 자해의 시작과 중단에 대한 내러티브 탐구**. 국내 박사학위논문, 숙명여자대학교 대학원.

김수진 (2017). 비자살적 자해의 위험요인과 보호요인 개관. **청소년학연구**, 24(9), 31-53.

김수진 (2019). 대학생의 부모애착과 사회적지지가 자해에 미치는 영향: 스트레스 대처방식의 조절된 매개효과. **청소년학연구**, 26(11), 105-132.

김수진, 김봉환 (2015). 청소년 내담자의 반복적 자해 행동의 의미탐색: 고통으로 고통을 견디기. **한국심리학회지: 상담 및 심리치료**, 27(2), 231-250.

김수진, 김수미, 박하은, 윤향미 (2020). 부정적 부모 양육 태도, SNS 중독 경향성이 초등학생의 비자살적 자해에 미치는 영향. **한국 웰니스학회**, 15(2), 89-101.

김영근, 김창대 (2015). 상담 과정에서 정서의 활성화 및 반복적 수용의 역할에 관한 이론적 고찰. **상담학 연구**, 16(6), 1-23.

김영채 (2015). 창의적 행동에 대한 상호작용 주의적 접근: 체계적이고 변증법적인 창의를 과정. **사고개발**, 11(3), 1-30.

김영천 (2017). **질적 연구방법론: 오디세이**. 서울: 아카데미 프레스.

- 김은이 (1998). **중·고등학생의 우울에 미치는 역기능적 태도와 스트레스의 영향**. 국내 석사학위논문, 가톨릭대학교 일반대학원.
- 김정민, 박준희 (2011). 자살 행동 예방을 위한 핵심 명상 인지행동치료 프로그램 개발 및 효과 자살 고위험 여대생집단을 대상으로. **상담학 연구**, 12(5), 1451-1471.
- 김정범 (2000). 인지-행동치료의 발전과정. **생물 치료 정신의학**, 6(1), 140-149.
- 김정희 (2017). **중학생 분노조절 향상을 위한 인지·정서·행동 통합프로그램 개발 및 효과**. 국내 박사학위논문, 영남대학교 대학원.
- 김준수 (2012). 헤겔 철학에서 모순과 변증법. **코기토**, (71), 305-342.
- 김진화 (2008). **평생교육 프로그램 개발론**. 파주: 교육 과학사.
- 김창대 (2002). 몰입 (Flow) 이론을 적용한 진로상담모형. **[KYCI] 청소년상담연구**, 10(1), 0-0.
- 김창대, 김형수, 신을진, 이상희, 최한나 (2011). **상담 및 심리교육 프로그램 개발과 평가**. 서울: 학지사.
- 김태선 (2005). 청소년의 자살 문제 현황. **청소년 상담 문제 연구보고서** 53.
- 김화정, 송현주 (2019). 청소년의 비자살적 자해와 수치심 경향성, 죄책감 경향성의 관계. **한국 심리치료학회지**, 11(1), 1-20.
- 김형수, 이주영 (2021). 청소년의 비자살적 자해 잠재계층유형 분석: 영향요인과 유형별 정서·행동문제 차이. **청소년학연구**, 28(12), 271-297.
- 나현주 (2022). 성취 목표 지향성이 학업 소진에 미치는 영향: 비합리적 신념의 매개효과. **한국 상담학회 학술대회 논문집(8)**, 21-21.
- 남동현, 이해국, 이경옥, 이정태, 권용실 (2012). 청소년 자살시도자의 Dialectical Behavior Therapy 기반 단기치료 적용에 대한 예비조

- 사. 대한소아청소년정신의학회 학술대회논문집, 151-151.
- 남정우 (2009). 칸트의 선형론적 변증론의 의미와 기능-아리스토텔레스의 '변증술'과의 비교를 중심으로. *칸트연구*, (23), 107-142.
- 문현미 (2005). 인지행동치료의 제3 동향. *한국심리학회지: 상담 및 심리치료*, 17(1), 15-33, 207.
- 박광배, 신민섭 (1991). 고등학생의 지각된 스트레스와 자살 생각. *한국심리학회지*, 10(1), 298-314.
- 박문숙 (2020). 부모의 부정적 양육 행동이 청소년의 비자살적 자해에 미치는 영향: 부모 애착과 부적응적 인지적 정서조절 전략의 순차적 매개효과. 국내 석사학위논문, 연세대학교 대학원.
- 박문숙, 안하얀, 서영석 (2020). 부모양육행동과 남자 청소년들의 비자살적 자해행동. *학습자중심교과교육연구*, 20(22), 833-859.
- 박석원, 서청희, 이성규, 전준희 (2020). 청소년 자살예방 게이트키퍼 교육 프로그램의 개발 및 효과. *청소년복지연구*, 22(2), 115-137.
- 박선영 (2014). 중학생의 우울과 SNS 중독 경향성의 관계: 자기 조절을 매개변인으로. 국내 석사학위논문, 한양대학교 교육대학원.
- 박성아 (2010). 정서에 대한 두려움; 감정에 대한 두려움. 국내 석사학위논문, 서울대학교 대학원.
- 박소연 (2021). 비자살적 자해 청소년 상담에서 상담자 체험에 관한 내러티브 탐구. 국내 박사학위논문, 숙명여자대학교 대학원, 서울.
- 박숙경 (2019). 자해 청소년을 위한 DBT 의 미술치료적 접근. *계간 미술치료*, (13), 48-53.
- 박순득 (2009). 단기 학교 개인 상담 모형개발과 적용. *상담학 연구*, 10(1), 501-516.
- 박준희 (2011). 자살 예방을 위한 핵심 명상 인지행동치료 프로그램 개발

- 및 효과 자살 고위험 여대생집단을 대상으로. 국내 박사학위논문, 명지대학교 대학원.
- 박지선 (2013). 경험논문: 청소년의 정서조절곤란 측정-DERS 의 심리측정적 속성. **한국심리학회지: 건강**, 18(4), 727-746.
- 반신환 (2007). 우리나라 청년 자살의 특징과 변증법적 행동치료 위기개입. **대학과 선교**, 13, 78-90.
- 반신환 (2010). 경계선 성격장애에 대한 변증법적 행동치료와 기독교 상담. **신학과 실천**, (23), 317-340.
- 방선경 (2024). 비자살적 자해 대학생의 자해행동 구조 경로 및 개인 심상재구성하기 처치효과 검증. 국내박사학위논문, 경남대학교 대학원, 경상남도.
- 배수현 (2019). 중학생의 비자살적 자해에 영향을 미치는 요인에 관한 연구. 국내 석사학위논문, 경북대학 대학원.
- 배수현, 성희자 (2020). 중학생의 비자살적 자해에 영향을 미치는 요인: 자해의 심각성을 중심으로. **정신건강과 사회복지**, 48(2), 122-148.
- 배은희 (2021). 비자살적 자해 학생의 상담사례 연구. 국내 박사학위논문, 가톨릭관동대학교 대학원.
- 백보겸 (2017). 자의적 부정 정서가 비자살적 자해에 미치는 영향: 부정적 반추의 매개효과를 중심으로. 국내 석사학위논문, 전주대학교 대학원.
- 백보겸, 김지인, 권호인 (2019). 자의식적 부정 정서가 비자살적 자해에 미치는 영향. 정서조절 전략의 매개효과를 중심으로. **한국콘텐츠학회 논문지**, 19(3), 385-395.
- 백훈승 (2015). **철학입문**. 전북대학교 출판문화원.
- 변영주 (1994). 부모의 양육 태도와 청소년의 비합리적 신념 및 스트레스의

- 상호 관계 연구.** 국내 석사학위논문, 연세대학교 대학원.
- 서 미 (2016). 청소년 자해 행동: 여중생의 자살적 자해와 비(非)자살적 자해행동 여중생의 자살적 자해와 비자살적 자해, **한국심리학회지**, 28(4), 1171-119.
- 서 미, 김은하, 이태영, 김지혜 (2018). 고위기 청소년 정신건강 상담개입 매뉴얼: 자살·자해편. **[KYCI] 청소년상담연구**.
- 서 미, 김지혜, 이태영, 김은하 (2019). 비자살적 자해와 극복과정 경험에 대한 질적 연구: 상담경험이 있는 청소년을 대상으로. **상담학연구**, 20(4), 179-207.
- 서 미, 소수연, 강유임, 손지아, 김지혜 (2020). EBP 기반 자살·자해 청소년 상담클리닉 운영 모형 개발. **청소년상담연구**, 28(1), 99-121.
- 서아현 (2019). **비자살적 자해에 대한 경계선 성격 성향, 통증감내력, 대인 관계에서의 정서적 고통의 효과**. 국내 석사학위논문, 동덕여자대학교 대학원.
- 성나경, 강이영. (2016). 청소년의 일상적 스트레스와 자해행동: 인지적 정서조절전략의 조절효과. **한국심리학회지: 상담 및 심리치료**, 28(3), 855-873.
- 송영희, 이운주 (2010). 대학생의 비합리적 신념과 우울: 목표 안정성과 자존감의 매개 역할. **한국심리학회지: 상담 및 심리치료**, 22(3), 553-573.
- 송지숙, 구본용 (2023). 청소년의 유년기 무효화 환경이 비자살적 자해에 미치는 영향 간에 고통 감내력 부족과 비자살적 자해 결과기대의 이중매개 효과. **학습자중심교과교육연구**, 23(3), 327-342.
- 송지원, 조한익 (2018). 청소년의 일상적 스트레스가 심리적 안녕감에 미치는 영향: 인지적 정서조절 전략의 매개효과. **청소년학 연구**, 25(8),

103-129.

신민섭, 박광배, 오경자, 김중술 (1990). 고등학생의 자살 성향에 관한 연구: 우울-절망-자살간의 구조적 관계에 대한 분석. **한국심리학회지: 임상**, 9(1), 1-19.

신수정 (2020). **비자살적 자해 청소년의 자해 중단 경험연구**. 국내 박사학위논문, 백석대학교 기독교전문대학원.

신주영, 김정민 (2018). 성인 ADHD 대학생을 위한 인지행동치료 (CBT)와 마음챙김기반 스트레스 감소 개입(MBSR)의 효과 비교: 인지, 정서 및 실행기능을 중심으로. **정서·행동장애연구**, 34(4), 213-236.

안영신, 송현주 (2017). 청소년 비자살적 자해 행동에 관한 연구. **정서장애 행동 연구**. 33(4), 257-281.

안재순 (2016). **ADHD 성향 대학생을 위한 인지행동치료 프로그램의 개발 및 효과**. 국내 박사학위논문, 명지대학교 대학원.

유선미 (2018). **사회불안 장애 청소년을 위한 인지과정 강화 인지행동 치료 프로그램 개발 및 효과**. 국내 박사학위논문, 명지대학교 대학원.

유숙경, 양영길 (2022). 교정시설 성범죄 수형자의 재범 예방을 위한 변증법적 행동치료(DBT) 프로그램 효과: 혼합연구 방법으로. **교정 연구**, 32(3), 61-98.

유숙경, 김영은 (2023). 교정시설 남성 성범죄자의 대인관계 증진과 가족관계 회복을 위한 변증법적 행동치료(DBT) 프로그램 개발 및 효과. **부부가족 상담 연구**, 4(1), 45-66.

유현주 (2021). **중학생의 비자살적 자해의 특성과 요인 탐색**. 국내 박사학위논문, 평택대학교 일반대학원.

윤다운, 엄연용, 송원영 (2025). 중학생과 고등학생의 성별에 따른 위기청소년의 비자살적 자해 예측요인 탐색: 머신러닝 및 네트워크 분석을 활용하여. **청소년학연구**, 32(1), 251-277.

- 윤지영 (2019). **중학생의 우울이 학교생활적응에 미치는 영향 : 자아존중감의 매개효과**. 국내석사학위논문, 제주대학교 교육대학원.
- 이귀숙, 장은희, 김은영 (2016). 청소년 자살예방 프로그램의 개발 및 적용효과. **청소년상담연구**, 24(2), 99-124.
- 이금희 (2007). **청소년의 외모만족도, 지각된 어머니양육태도와 우울 및 자아존중감과의 관계 연구**. 국내 석사학위논문, 한양대학교 대학원.
- 이다슬, 오성은, 신성만 (2021). 청소년의 복합외상이 비자살적 자해에 미치는 영향: 부적응적 인지 정서조절 전략과 생리적 스트레스의 이중매개효과. **청소년학연구**, 28(11), 235-257.
- 이동귀, 함경애, 배병훈 (2016). 청소년 자해행동: 여중생의 자살적 자해와 비 (非) 자살적 자해. **한국심리학회지: 상담 및 심리치료**, 28(4), 1171-1192.
- 이동훈, 양미진, 김수리 (2010). 청소년 자해의 이해 및 특성에 대한 고찰. **청소년 상담 연구**, 18(1), 1-24.
- 이문영 (2021). **청소년 자해 행동, 자살 생각 및 자살 시도와 관련 요인: 개인 특성, 가정환경, 학교 환경을 중심으로**. 국내 박사학위논문, 인하대학교 대학원.
- 이수정 (2019). **청소년의 정서적 학대 경험이 비자살적 자해에 미치는 영향: 초기부적응도식과 정서조절곤란의 이중매개효과**. 국내 석사학위논문, 서울여자대학교 대학원.
- 이영희 (2020). **청소년 자해 행동의 보호요인과 위험 요인: 중학생의 일상적 스트레스, 자기 통제, 사회적 지지를 중심으로**. 국내 석사학위논문, 강원대학교 대학원.
- 이종국, 김경민, 장옥란, 박병욱, 김현정, 현경미, 신철규, 이제정 (2023). 단기간의 변증법적 행동치료 기술훈련(Dialectical Behavioral

- Therapy-Skills Training, DBT-ST)을 적용한 청소년 비자살성 자해 예방 프로그램의 개발 및 효과성 연구. **신경정신의학**, 62(3), 102-110.
- 이지영, 권석만 (2006). 정서조절과 정신병리의 관계: 연구 현황과 과제. **한국심리학회지: 상담 및 심리치료**, 18(3), 461-493.
- 이혜림 (2013). **청소년의 처벌 민감성과 강화 민감성이 불안, 우울, 자해 행동에 미치는 영향: 스트레스와 통제 가능성 귀인의 역할**. 국내 석사학위논문, 가톨릭대학교 대학원.
- 임경문, 김혜경, 백운진, 이윤주 (2020). 청소년 자해에 관한 연구동향. **인문사회** 21, 11(1), 717-731.
- 장은선(2007). **청소년의 스트레스와 비합리적 신념이 자살 생각에 미치는 영향**. 국내 석사학위논문, 숙명여자대학교 대학원.
- 장은선, 김광웅, 조유진 (2007). 청소년의 스트레스와 비합리적 신념 및 자살생각의 관계-고등학교 재학중인 여학생을 대상으로. **청소년학연구**, 14(5), 27-47.
- 장현갑 (2007). **마음챙김**. 서울: 미다스북스.
- 장현갑 (2008). **마음챙김을 기반으로 하는 스트레스 감소훈련프로그램**. 심리 플러스 고통감내력 연구소.
- 전미량 (2019). **대학생용 자살 예방 교육프로그램 개발 및 효과**. 국내 박사학위논문, 한남대학교 대학원.
- 정종진 외 (2014). **연구 방법 질적·양적 및 혼합연구의 실제**. 서울: 시그마프레스.
- 정지현 (2015). **고통감내력과 정신건강의 관계: 주관적·행동적 고통감내력이 우울 및 불안에 미치는 영향**. 국내 박사학위논문, 서울대학교 대학원.
- 정지현, 권석만 (2013). 고통 감내력과 심리적 건강의 관계: 탈중심화와 회

- 피적 대처의 매개효과. **한국심리학회지: 임상**, 32(3), 627-647.
- 정혜경, 노승혜, 조현주 (2017). 마음챙김 자비 프로그램 (MLCP) 이 우울 경향 대학생의 우울, 반추, 마음챙김, 자기자비 및 사회적 유대감에 미치는 효과. **한국심리학회지: 건강**, 22(2), 271-287.
- 조순아 (2021). **자해 청소년의 들을 위한 행동 상담의 기독교적 적용**. 국내 박사학위논문, 성경신학대학교 대학원.
- 조안남 (2023). **성인 ADHD 성향 대학생을 위한 변증법적 행동치료(DBT) 프로그램 개발 및 효과분석: 주의집중 곤란과 정서조절 곤란을 중심으로**. 국내 박사학위논문, 조선대학교 대학원.
- 조안남, 권해수 (2021). 비대면 변증법적 행동치료 기술훈련 집단프로그램 이 대학생의 사회불안 감소에 미치는 효과. **청소년시설 환경**, 19(3) 41-50.
- 조용범 (2018). **전문가를 위한 DBT 다이아몬드 정체 티끌 행동치료(2판)**. 서울: 더 트리그룹.
- 조윤화, 김기환, 권승희, 최현정 (2022). **DBT, 학교에 가다: 청소년 정서 문제해결을 위한 DBT 기술훈련**. 서울: 학지사.
- 조은지 (2018). **외로움과 비자살적 자해의 관계: 정서조절능력과 문제해결 능력의 조절효과**. 국내 석사학위논문, 부산대학교 대학원.
- 주은정, 이영호 (2013). 자해척도(ISAS)의 한국판 타당화 연구. **상담학 연구**, 3(1), 187-205.
- 진다슬, 손정락 (2013). 변증법적 행동치료(DBT) 기술훈련이 청소년의 공격성, 자아존중감 및 분노 표현 양식에 미치는 효과. **Korean Journal of Clinical Psychology**, 32(4), 917-933.
- 최주연 (2005). **만병의 근원 스트레스를 즐기자**. 서울: 태웅 출판사.
- 최지선, 이민지 (2023). 무용동작치료와 변증법적 행동치료의 절충적 통합

- 프로그램의 필요성에 대한 연구. *무용동작심리치료연구*, 7(1), 5-23.
- 최초롱, 손정락 (2014). 변증법적 행동치료(DBT) 기술훈련이 정서지능이 낮은 대학생의 정서지능, 대인관계 문제 및 정신건강에 미치는 효과. *한국심리학회지*, 19(2), 469-483.
- 최현정 (2018). 변증법행동치료 (DBT) 의 근거와 한국 보급: 체계적 문헌 고찰. *Korean Journal of Clinical Psychology*, 37(3), 443-463.
- 추은정 (2019). 부정 정서가 비자살적 자해에 미치는 영향: 자해 갈망의 매개효과와 인지적 정서조절 전략, 감정표현 불능증, 의도적 통제의 조절 효과를 중심으로. 국내 박사학위논문, 가톨릭대학교 대학원.
- 하영민 (2024). 여자 청소년 대상 자살예방 프로그램 효과성에 관한 체계적 문헌고찰과 메타분석. 국내석사학위논문, 숭실대학교 대학원, 서울.
- 하정희, 조한익 (2006). 비합리적 신념에 따른 완벽주의의 순기능과 역기능. *한국심리학회지: 상담 및 심리치료*, 18(4), 873-896.
- 한국 청소년 상담복지개발원 (2021). *청소년 상담프로그램 개발*.
- 한국 청소년 정책연구원 (2016). *대학생 자살 예방을 위한 정책연구*.
- 한동화 (2009). *청소년의 분노 표현 방식에 대한 불안, 우울, 자존감의 영향*. 석사학위 논문, 서울여자대학교 대학원.
- 한상철 (2014). 청소년 위험행동의 기능과 지도. *청소년행동연구*, 19, 5-33.
- 한상철 (2014). *청소년학: 청소년의 이해와 지도*. 서울: 학지사.
- 황소희 (2018). 중학생의 우울증상과 스마트폰 과의존의 관계에서 학교생활 적응의 매개효과. 국내 석사학위논문, 숙명여자대학교 심리치료대학원.
- 황임란 (2001). 단기 학생 상담 모형 개발- Osborn-Parnes의 창의적 문제해결(CPS) 이론을 중심으로. 국내 박사학위 논문. 한국교원대학교 대학원
- Abrams, M., & Ellis, A. (1994). Rational-emotive behavior therapy

- in the treatment of stress. *British Journal of Guidance and Counseling*, 22, 39-50.
- American Psychiatric Association (2013). 권준수 역 (2018). DSM-5. **간편 정신질환 진단 통계 편람**, 서울: 학지사.
- Andrei, L. E., Efrim-Budisteanu, M., Mihailescu, I., Buică, A., Moise, M., & Rad, F. (2024). *Non-Suicidal Self-Injury (NSSI) Patterns in Adolescents from a Romanian Child Psychiatry Inpatient Clinic*. *Children*, 11.
- Anestis, M. D., & Joiner, T. E. (2012). Behaviorally-indexed distress tolerance and suicidality. *Journal of psychiatric research*, 46(6), 703-707.
- APA (2017). **DSM-5 우울장애**. 서울: 학지사.
- Aldwin, C. M., & Revenson, T. A. (1987). Does coping help? A reexamination of the relation between coping and mental health. *Journal of personality and social psychology*, 53(2), 337.
- Baer, R. A., Smith, G. T., Hopkins, J., Krietemeyer, J., & Toney, L. (2006). Using self-report assessment methods to explore facets of mindfulness. *Assessment*, 13(1), 27-45.
- Bandura, A. (1977). Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change. *Psychological review*, 84(2), 191.
- Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action. *Englewood Cliffs, NJ, 1986*(23-28), 2.
- Bandura, A. (1997). *Self-efficacy: The exercise of control*. W. H. Freeman.

- Beck, A. T. (1979). *Cognitive Therapy and the Emotion Disorders*. New York: International Universities Press.
- Beck, A. T. (1963). Thinking and depression: I. Idiosyncratic content and cognitive distortions. *Archives of general psychiatry*, 9(4), 324-333.
- Beck, A. T., Emery, G., & Grenberg, R. L. (1985). *Anxiety disorders and phobias: A cognitive perspective*. New York: Plenum Press.
- Beck, A. T., Kovacs, M., & Weissman, A. (1979). Assessment of suicidal intention: the Scale for Suicide Ideation. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 37, 343-352.
- Beck, A. T., Rush, A. J., Shaw, B. F., & Emery, G. (1979). *Cognitive therapy of depression*. New York: Guilford Press.
- Beck, A. T., Steer, R. A., Kovacs, M., & Garrison, B. (1985). Hopelessness and eventual suicide: A 10-year prospective study of patients hospitalized with suicidal ideation. *The American Journal of Psychiatry*, 142(5), 559-563.
- Beck, A. T., Kovacs, M., Weissman, A. (1979). Assessment of suicidal intention: the Scale for Suicide Ideation. *Journal of Consulting and Clinic Psychology*, 47(2), 343-352.
- Bernstein, A., Vujanovic, A. A., Leyro, T. M., & Zvolensky, M. J. (2011). Research synthesis and the future. *Distress tolerance*, 263-280.
- Bjureberg, J., Sahlin, H., Hedman-Lagerlöf, E., Gratz, K. L., Tull, M. T., Jokinen, J., & Ljótsson, B. (2018). Extending research

- on Emotion Regulation Individual Therapy for Adolescents (ERITA) with nonsuicidal self-injury disorder: open pilot trial and mediation analysis of a novel online version. *BMC psychiatry*, 18, 1-13.
- Bohus, M., Kleindienst, N., Hahn, C., Müller-Engelmann, M., Ludäscher, P., Steil, R., Fydrich, T., Kuehner, C., Resick, P., Stiglmayr, C., Schmahl, C., & Priebe, K. (2020). Dialectical Behavior Therapy for Posttraumatic Stress Disorder (DBT-PTSD) Compared With Cognitive Processing Therapy (CPT) in Complex Presentations of PTSD in Women Survivors of Childhood Abuse: A Randomized Clinical Trial. *JAMA Psychiatry*, 77(12), 1235-1245.
- Bradley, R. G., & Follingstad, D. R. (2003). Group therapy for incarcerated women who experienced interpersonal violence: A pilot study. *Journal of Traumatic Stress*, 16, 337-340.
- Braga, C., & Gonçalves, S. (2014). Non-Suicidal Self Injury, Psychopathology and Attachment: A Study with University Students. *The Spanish Journal of Psychology*, 17.
- Bresin, K., & Gordon, K. H. (2013). Changes in negative affect following pain (vs. nonpainful) stimulation in individuals with and without a history of nonsuicidal self-injury. *Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment*, 4(1), 62-66.
- Bresin, K., & Gordon, K. H. (2013). Endogenous opioids and

- nonsuicidal self-injury: a mechanism of affect regulation. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 37(3), 374-383.
- Briere. J., & Gil, E. (1998). Self-mutilation in clinical and general population samples: Prevalence, Correlates, and Functions. *American Journal of Psychiatry*, 68(4), 609-620.
- Brown, R. A., Lejuez, C. W., Kahler, C. W., Strong, D. R., & Zvolensky, M. J. (2005). Distress tolerance and early smoking lapse. *Clinical psychology review*, 25(6), 713-733.
- Buerger, A., Fischer-Waldschmidt, G., Hammerle, F., Auer, K. V., Parzer, P., & Kaess, M. (2019). Differential Change of Borderline Personality Disorder Traits During Dialectical Behavior Therapy for Adolescents. *Journal of Personality Disorders*, 33(1), 119-134.
- Bunclark, J., & Crowe, M. (2000). Repeated self-injury and its management. *International Review of Psychiatry*, 12(1), 48-53.
- Caron, E., Bernard, K., & Dozier, M. (2018). In Vivo Feedback Predicts Parent Behavior Change in the Attachment and Biobehavioral Catch-up Intervention. *Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology*, 47, 35-46.
- Cavanaugh, M. M., Solomon, P. L., & Gelles, R. J. (2011). The dialectical psychoeducational workshop (DPEW) for males at risk for intimate partner violence: A pilot randomized controlled trial. *Journal of Experimental Criminology*, 7, 275-291.

- Cavicchioli, M., Movalli, M., Ramella, P., Vassena, G., Prudenziati, F., & Maffei, C. (2020). Feasibility of dialectical behavior therapy skills training as an outpatient program in treating alcohol use disorder: The role of difficulties with emotion regulation and experiential avoidance. *Addiction Research & Theory, 28*, 103-115.
- Cavicchioli, M., Ramella, P., Vassena, G., Simone, G., Prudenziati, F., Sirtori, F., Movalli, M., & Maffei, C. (2020). Dialectical behaviour therapy skills training for the treatment of addictive behaviours among individuals with alcohol use disorder: the effect of emotion regulation and experiential avoidance. *American Journal of Drug and Alcohol Abuse, 46*, 368-384.
- Chapman, A. L., Gratz, K. L., & Brown, M. Z. (2006). Solving the puzzle of deliberate self-harm: The experiential avoidance model. *Behavior Research and Therapy, 44*, 371-394.
- Conterio, K., Lader, W., & Bloom, J. K. (1998). *Bodily harm: The breakthrough healing program for self-injurers*. New York: Hyperion.
- Cooper, A. M., & Michels, R. (1988). Diagnostic and statistical manual of mental disorders, revised (DSM-III-R). *American journal of Psychiatry, 145*(10), 1300-1301.
- Corbisiero, S., Stieglitz, R. D., Retz, W., & Rösler, M. (2013). Is emotional dysregulation part of the psychopathology of ADHD in adults?. *ADHD Attention deficit and hyperactivity*

disorders, 5, 83-92.

- Corstorphine, E., Mountford, V., Tomlinson, S., Waller, G., & Meyer, C. (2007). Distress tolerance in the eating disorders. *Eating behaviors*, 8(1), 91-97.
- Darche, M. A. (1990). Psychological factors differentiating self-mutilating and non-self-mutilating adolescent inpatient females. *Psychiatric Hospital*, 21(1), 31-35.
- Daughters, S. B., Lejuez, C. W., Bornovalova, M. A., Kahler, C. W., Strong, D. R., & Brown, R. A. (2005). Distress tolerance as a predictor of early treatment dropout in a residential substance abuse treatment facility. *Journal of abnormal psychology*, 114(4), 729.
- Daughters, S. B., Sargeant, M. N., Bornovalova, M. A., Gratz, K. L., & Lejuez, C. W. (2008). The relationship between distress tolerance and antisocial personality disorder among male inner-city treatment seeking substance users. *Journal of personality disorders*, 22(5), 509-524.
- Dawkins, J. C., Hasking, P. A., Boyes, M. E., Greene, D., & Passchier, C. (2019). Applying a cognitive-emotional model to nonsuicidal self-injury. *Stress and Health*, 35(1), 39-48.
- Delaquis, C. P., Joyce, K., Zalewski, M., Katz, L., Sulymka, J., Agostinho, T., & Roos, L. (2020). *Dialectical Behaviour Therapy Skills Training Groups for Common Mental Health Disorders: A Systematic Review and Meta-Analysis*. Canada: University of Manitoba.

- Dobson, K. S. (2009). *Handbook of cognitive-behavioral therapies*. New York: Guilford Press.
- Donaldson, D., Spirito, A., & Esposito-Smythers, C. (2005). Treatment for adolescents following a suicide attempt: results of a pilot trial. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 44(2), 113-120.
- Dopson, K. S., & Block, L. (1988). *Historical and philosophical bases of cognitive-behavioral therapies*. New York: Guilford Press.
- Ehring, T., & Watkins, E. R. (2008). Repetitive negative thinking as a transdiagnostic process. *International journal of cognitive therapy*, 1(3), 192-205.
- Ellis, A. (1962). *Reason and emotion in psychotherapy*. Oxford: England.
- Ersche, K., Gillan, C., Jones, P., Williams, G. B., Ward, L. H. E., Luijten, M., wit, S. d., Sahakian, B., Bullmore, E., & Robbins, T. (2016). Carrots and sticks fail to change behavior in cocaine addiction. *Science*, 352, 1468-1471.
- Favazza, A. R. (1996). *Bodies under siege: Self-mutilation and body modification in culture and psychiatry*. Jhu Press.
- Ferrara, M., Terrinoni, A., & Williams, R. (2012). Non-suicidal self-injury (Nssi) in adolescent inpatients: assessing personality features and attitude toward death. *Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health*, 6(1), 12.
- Fortune, S. A., & Hawton, K. (2005). Deliberate self-harm in

- children and adolescents: a research update. *Current opinion in Psychiatry*, 18(4), 401-406.
- Fox, C., & Hawton, K. (2004). *Deliberate self-harm in adolescence*. Jessica Kingsley Publishers.
- Fox, K. R., Ribeiro, J. D., Kleimana, E. M., Hooley, J. M., Nock, M. K., & Franklin, J. C. (2018). Affect toward the self and self-injury stimuli as potential risk factors for nonsuicidal self-injury. *Psychiatry Research*, 260(7), 279-285.
- Freeman, A., & Dattilio, F. M. (Eds.). (1992). *Comprehensive casebook of cognitive therapy*. New York: Plenum Press.
- Gandhi, A., Luyckx, K., Goossens, L., Maitra, S., & Claes, L. (2018). Association between Non-Suicidal Self-Injury, Parents and Peers Related Loneliness, and Attitude Towards Aloneness in Flemish Adolescents: An Empirical Note. *Psychologica Belgica*, 58(1), 3-12.
- Gibbins, C., & Weiss, M. (2007). Clinical recommendations in current practice guidelines for diagnosis and treatment of ADHD in adults. *Current psychiatry reports*, 9(5), 420-426.
- Giletta, M., Scholte, R. H., Prinstein, M. J., Engels, R. C., Rabaglietti, E., & Burk, W. J. (2012). Friendship context matters: Examining the domain specificity of alcohol and depression socialization among adolescents. *Journal of abnormal child psychology*, 40, 1027-1043.
- Glenn, C. R., & Klonsky, E. D. (2009). Social context during non-suicidal self-injury indicates suicide risk. *Personality*

and Individual Differences, 46(1), 25-29.

- Gohm, C. L., & Clore, G. L. (2002). Four latent traits of emotional experience and their involvement in well-being, coping, and attributional style. *Cognition and Emotion*, 16(4), 495-518.
- Goldstein, T., Fersch-Podrat, R. K., Rivera, M., Axelson, D., Merranko, J., Yu, H., Brent, D., & Birmaher, B. (2015). Dialectical behavior therapy for adolescents with bipolar disorder: results from a pilot randomized trial. *Journal of child and adolescent psychopharmacology*, 25(2), 14-21.
- Goleman, D. J. (1978). Meditation as an intervention in stress reactivity. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 44, 456-466.
- Gratz, K. L., & Roemer, L. (2004). Multidimensional assessment of emotion regulation and dysregulation: Development, factor structure, and initial validation of the difficulties in emotion regulation scale. *Journal of psychopathology and behavioral assessment*, 26, 41-54.
- Gratz, K. L., Conrad, S. D., & Roemer, L. (2002). Risk factors for deliberate self-harm among college students. *American Journal of Orthopsychiatry*, 72(1), 128-140.
- Gratz, K. L., & Roemer, L. (2008). The Relationship Between EmotionDysregulation and Deliberate Self-Harm Among Female Undergraduate Students at an Urban Commuter University. *Cognitive Behaviour Therapy*, 37(1), 14-25
- Gratz, K. L., Bardeen, J. R., Levy, R., Dixon-Gordon, K. L., & Tull,

- M. T. (2015). Mechanisms of change in an emotion regulation group therapy for deliberate self-harm among women with borderline personality disorder. *Behavior Research and Therapy*, 65, 29-35.
- Gross, J. J. (1998). The emerging field of emotion regulation: An integrative review. *Review of general psychology*, 2(3), 271-299.
- Guan, K., Fox, K. R., & Prinstein, M. J. (2012). Nonsuicidal self-injury as a time-invariant predictor of adolescent suicide ideation and attempts in a diverse community sample. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 80, 842-849.
- Hal, R. C. W., Plat, D. E., & Hal, R. C. W. (1999). Suicide risk assessment: a review of risk factors for suicide in 100 patients who made severe suicide attempts: evaluation of suicide risk in a time of managed care. *Psychosomatics*, 40(1), 18-29.
- Hamann, K. R. S., & Reese, G. (2020). My Influence on the World (of Others): Goal Efficacy Beliefs and Efficacy Affect Predict Private, Public, and Activist Pro-environmental Behavior. *Journal of Social Issues*, 76(1), 35-53.
- Harned, M., Korslund, K., Schmidt, S. C., & Gallop, R. (2021). The Dialectical Behavior Therapy Adherence Coding Scale (DBT ACS): Psychometric properties. *Psychological Assessment*, 33(6), 552-561.

- Hasking, P., Whitlock, J., Voon, D., & Rose, A. (2017). A cognitive-emotional model of NSSI: Using emotion regulation and cognitive processes to explain why people self-injure. *Cognition and Emotion*, 31(8), 1543-1556.
- Hawton, K., Rodham, K., Evans, E., & Weatherall, R. (2002). Deliberate self harm in adolescents: self report survey in schools in England. *British Medical Journal*, 325(7374), 1207-1211.
- Hawton, K., Zahl, D. & Weatherall, R. (2003). Suicide following deliberate self-harm: long-term follow-up of patients who presented to a general hospital. *The British Journal of Psychiatry*, 182, 537-542.
- Hayes, S. C., & Strosahl, K. D. (2004). *A Practical Guide to Acceptance and Commitment Therapy*. New York: Springer.
- Hayes, S. C., Wilson, K. G., Gifford, E. V., Follette, V. M., & Strosahl, K. (1996). Experiential avoidance and behavioral disorders: A functional dimensional approach to diagnosis and treatment. *Journal of consulting and clinical psychology*, 64(6), 1152.
- Heath, N. L., Toste, J. R., Nedechewa, T., & Charlebois, A. (2008). An examination of nonsuicidal self-injury among college students. *Journal of mental health counseling*, 30(2), 137-156.
- Hempel, R. J., Vanderbleek, E. N., & Lynch, T. (2018). Radically open DBT: Targeting emotional loneliness in Anorexia

- Nervosa. *Eating Disorders*, 26, 104-192.
- Hesslinger, B., Tebartz van Elst, L., Nyberg, E., Dykieriek, P., Richter, H., Berner, M., & Ebert, D. (2002). Psychotherapy of attention deficit hyperactivity disorder in adults: A pilot study using a structured skills training program. *European archives of psychiatry and clinical neuroscience*, 252, 177-184.
- Jacobson, C. M, & Gould, M. (2007). The epidemiology and phenomenology of non-suicidal self-injurious behavior among adolescents: A critical review of the literature. *Archives of Suicide Research*, 11(2), 129-147.
- Jacobson, C. M., & Batejan, K. (2014). *Comprehensive theoretical models of nonsuicidal self-injury*. The Oxford handbook of suicide and self-injury, 308-320.
- Jacobson, C. M., & Gould, M. (2007). The epidemiology and phenomenology of non-suicidal self-injurious behavior among adolescents: A critical review of the literature. *Archives of Suicide Research*, 11(2), 129-147.
- Joiner, T. E. (2005). *Why people die by suicide*. Cambridge, MA, US: Harvard University Press.
- Kabat-Zinn, J. (1994). *Wherever you go, there you are: Mindfulness meditation in everyday life*. New York: Hyperion
- Kahan, J., & Pattison, E. M. (1984). Proposal for a distinctive diagnosis: The Deliberate Self-Harm syndrome (DSH). *Suicide and Life-Threatening Behavior*, 14(1), 17-35.

- Kanter, N. J., & Goldfried, M. R. (1979). Relative effectiveness of rational restructuring and self-control desensitization in the reduction of interpersonal anxiety. *Behavior Therapy*, 10(4), 472-490.
- Kenny, T. E., Carter, J., & Safer, D. (2020). Dialectical behavior therapy guided self-help for binge-eating disorder. *Eating Disorders*, 28, 202-211.
- Keough, M. E., Riccardi, C. J., Timpano, K. R., Mitchell, M. A., & Schmidt, N. B. (2010). Anxiety symptomatology: The association with distress tolerance and anxiety sensitivity. *Behavior therapy*, 41(4), 567-574.
- Kims, C. L., Lee, S. H., & Chang, H. (2018). Influence of non-suicidal self-injury on suicide attempt among depressed patients. *Korean Journal of Clinical Psychology*, 37(4), 465-478.
- Klonsky, E. D. (2007). Non-suicidal self-injury: an introduction. *Journal of Clinical psychology*, 63(11), 1039-43.
- Klonsky, E. D., & Muehlenkamp, J. J. (2007). Self-injury: A research review for the practitioner. *Journal of clinical psychology*, 63(11), 1045-1056.
- Klonsky, E. D., Muehlenkamp, J. J., Lewis, S. P., & Walsh, B. (2011). *Nonsuicidal self-injury*. Boston: Hogrefe Publishing.
- Klonsky, E. D., Oltmanns, T. F., & Turkheimer, E. (2003). Deliberate self-harm in a nonclinical population: Prevalence and psychological correlates. *American Journal of*

- Psychiatry*, 160(8), 1501-1508.
- Laye-Gindhu, A., & Schonert-Reichl, K. A. (2005). Nonsuicidal self-harm among community adolescents: Understanding the “whats” and “whys” of self-harm. *Journal of youth and Adolescence*, 34, 447-457.
- Lazarus (1971). *Behavior Therapy and Beyond*. New York: Mc Grow Hill.
- Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). *Stress, Appraisal, and Coping*. New York: Springer.
- Lee, R. K., Harms, C., & Jeffery, S. E. (2022). The contribution of skills to the effectiveness of dialectical behavioral therapy. *Journal of clinical psychology*.
- Leith, K. P., & Baumeister, R. F. (1996). Why do bad moods increase self-defeating behavior? Emotion, risk taking, and self-regulation. *Journal of Personality and Social Psychology*, 71(6), 1250-1267.
- Linehan, M., Korslund, K., Harned, M., Gallop, R., Lungu, A., Neacsiu, A. D., McDavid, J., Comtois, K., & Murray-Gregory, A. M. (2015). Dialectical behavior therapy for high suicide risk in individuals with borderline personality disorder: a randomized clinical trial and component analysis. *JAMA psychiatry*, 72(5), 475-82.
- Lerner, M. S., & Clum, G. A. (1990). Treatment of suicide ideators: A problem-solving approach. *Behavior Therapy*, 21(4), 403-411.

- Lewis, S. P., Rosenrot, S. A., & Messner, M. A. (2012). Seeking validation in unlikely places: the nature of online questions about non-suicidal self-injury. *Archives of Suicide Research, 16*(3), 263-272.
- Leyro, T. M., Zvolensky, M. J., & Bernstein, A. (2010). Distress tolerance and psychopathological symptoms and disorders: a review of the empirical literature among adults. *Psychological bulletin, 136*(4), 576.
- Liekefett, L., Christ, O., & Becker, J. (2021). Can Conspiracy Beliefs Be Beneficial? Longitudinal Linkages Between Conspiracy Beliefs, Anxiety, Uncertainty Aversion, and Existential Threat. *Personality & Social Psychology Bulletin, 49*, 167-179.
- Lindner, H., Kirkby, R., Wertheim, E., & Birth, P. (1999). A Brief Assessment of Irrational Thinking: The Shortened General Attitude and Belief Scale. *Cognitive Therapy and Research, 23*, 651-663.
- Linehan M. M. (1987). Dialectical Behavior Therapy for borderline personality disorder: Theory and method. Bulletin of the Method. *Bulletin of the Menninger Clinic 51*(3), 261-276.
- Linehan, M. M. (1993a). *Cognitive-Behavioural Treatment of Borderline Personality Disorder*. Guilford Press. *Personality Disorder*. NewYork: Guilford Press.
- Linehan, M. M. (1993b). *Skills training manual for treating borderline personality disorder*. New York: Guilford press.

- Linehan, M. M. (2020). *Dialectical behavior therapy in clinical practice*. Guilford Publications.
- Linehan, M. M., & Heard, H. L. (1993). Impact of treatment accessibility on clinical course of parasuicidal patients. In reply to R. E., Hofman (Letter to the editor). *Archives of General Psychiatry*, 50, 157-159.
- Linehan, M. M., & Schmidt, H. III. (1995). The dialectics of effective treatment of borderline personality disorder. *Theories of behavior therapy: Exploring behavior change*, 553-584.
- Linehan, M., Korslund, K., Harned, M., Gallop, R., Lungu, A., Neacsiu, A. D., McDavid, J., Comtois, K., & Murray-Gregory, A. M. (2015). Dialectical behavior therapy for high suicide risk in individuals with borderline personality disorder: a randomized clinical trial and component analysis. *JAMA psychiatry*, 72(5), 475-82.
- Lloyd-Richardson, E. E., Perrine, N., Dierker, L., & Kelley, M. L. (2007). Characteristics and functions of non-suicidal self-injury in a community sample of adolescents. *Psychological Medicine*, 37(8), 1183-1192.
- Lynch, T., Chapman, A., Rosenthal, Z., Kuo, J. R., & Linehan, M. (2006). Mechanisms of change in dialectical behavior therapy: theoretical and empirical observations. *Journal of clinical psychology*, 62(4), 459-480.
- Marra, T. (2005). *Dialectical behavior therapy in private practice*:

- A practical and comprehensive guide.* Oakland: New Harbinger Publications.
- Marsha M. Linehan (1993). *Dialectical Behavior Therapy*. 조용범 역 (2007). *경계선 성격장애 치료를 위한 다이어렉티컬 행동치료*. 서울: 학지사.
- Mattick, R. P., & Peters, L. (1988). Treatment of severe social phobia: Effects of guided exposure with and without cognitive restructuring. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 56(2), 251-260.
- McMulin, R. E. (1986). *Handbook of cognitive therapy techniques*. New York: W. W. Norton.
- McMullen, R. J. (1987). Youth prostitution: a balance of power. *Journal of Adolescence*, 10(1), 35.
- McNair, L., Woodrow, C., & Hare, D. (2017). Dialectical behaviour therapy [DBT] with people with intellectual disabilities: A systematic review and narrative analysis. *Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities*, 30(5), 787-804.
- Mehlum, L., & Jensen, A. I. (2006). Suicidal atferd ved ustabil personlighetsforstyrrelse. *Suicidologi*, 11(3), 17-21.
- Mehlum, L., Ramleth, R., Tørmoen, A. J., Haga, E., Diep, L., Stanley, B., Miller, A. L., Larsson, B., Sund, A., & Grøholt, B. (2019). Long term effectiveness of dialectical behavior therapy versus enhanced usual care for adolescents with self-harming and suicidal behavior. *Journal of child psychology and psychiatry, and allied disciplines*. 60(10),

1112-1122.

- Meichenbaum, D. (1977). *Cognitive-Behavior Modification: An Integrative Approach*. New York: Plenum Press.
- Menninger, K. A. (1938). *Man against himself*. New York: Harcourt Brace.
- Mereish, E. H., Peters, J. R., Brick, L., Killam, M. A., & Yen, S. (2023). A daily diary study of minority stressors, suicidal ideation, nonsuicidal self-injury ideation, and affective mechanisms among sexual and gender minority youth. *Journal of psychopathology and clinical science*.
- Michael Hollander (2017). *Helping Teens Who Cut: Using DBT Skills to End Self-Injury*. 안병은, 서청희, 백민정, 문현호 역 (2017). **자해 청소년을 돕는 방법**. 홍성: 그물코.
- Miller, A. L., Rathus, J. H., Linehan, M. M., Wetzler, S., & Leigh, E. (1997). Dialectical behavior therapy adapted for suicidal adolescents. *Journal of Psychiatric Practice*®, 3(2), 78.
- Muehlenkamp, J. J., & Kerr, P. L. (2010). Untangling a Complex Web: How Non-Suicidal Self-Injury and Suicide Attempts Differ. *Prevention researcher*, 17(1), 8-10.
- Nagy, L. M., Shanahan, M. L., & Seaford, S. P. (2022). Nonsuicidal self-injury and rumination: A meta-analysis. *Journal of Clinical Psychology*, 79, 7-27.
- Nelson-Gray, R. O., Keane, S. P., Hurst, R. M., Mitchell, J. T., Warburton, J. B., Chok, J. T., & Cobb, A. R. (2006). A modified DBT skills training program for oppositional

- defiant adolescents: Promising preliminary findings. *Behaviour research and therapy*, 44(12), 1811-1820.
- Niedtfeld, I., Schmitt, R., Winter, D., Bohus, M., Schmahl, C., & Herpertz, S. (2017). Pain-mediated affect regulation is reduced after dialectical behavior therapy in borderline personality disorder: a longitudinal fMRI study. *Social Cognitive and Affective Neuroscience*, 12, 739-747.
- Nock, M. K. (2009). Why do People Hurt Themselves? New Insights Into the Nature and Functions of Self-Injury. *Current Directions in Psychological Science*, 18(2), 78-83.
- Nock, M. K. (Ed.), Understanding nosuicdal self-injury p. Nock, M. K. (2009). Why do people hurt themselves? New insights into the nature and functions of self-injury. *Current Directions in Psychological Science*, 18, 78-83.
- Nock, M. K. (2010). Self-injury. *Annual Review of Clinical psychology*, 6(1), 339-363.
- Nock, M. K., & Favza, A. R. (2009). *Nonsuicidal self-injury: Definition and classification*. American Psychological Association.
- Nock, M. K., & Kessler, R. C. (2006). Prevalence of and risk factors for suicide attempts versus suicide gestures: analysis of the National Comorbidity Survey. *Journal of Abnormal Psychology*, 115(3), 616-623.
- Nock, M. K., & Prinstein, M. J. (2004). A functional approach to the assessment of self-mutilative behavior. *Journal of*

- Consulting and Clinical Psychology*, 72(5), 885-890.
- Nock, M. K., Borges, G., Bromet, E. J., Cha, C. B., Kessler, R. C., & Lee, S. (2008). Suicide and suicidal behavior. *Epidemiologic reviews*, 30(1), 133.
- Nyanaponika, Ther., T. (1972). *The Power of Mindfulness*. San Francisco: Unity Press. *Personality Disorder*. New York: Guilford Press.
- Pagiaslis, A., & Krontalis, A. K. (2014). Green Consumption Behavior Antecedents: Environmental Concern, Knowledge, and Beliefs. *Psychology & Marketing*, 31, 335-348.
- Panos, P., Jackson, J., Hasan, O. K., & Panos, A. (2014). Meta-Analysis and Systematic Review Assessing the Efficacy of Dialectical Behavior Therapy (DBT). *Research on Social Work Practice*, 24, 213-223.
- Perepletchikova, F., Axelrod, S. R., Kaufman, J., Rounsaville, B. J., Douglas-Palumberi, H., & Miller, A. L. (2011). Adapting Dialectical Behaviour Therapy for children: Towards a new research agenda for paediatric suicidal and non-suicidal self-injurious behaviours. *Child and adolescent mental health*, 16(2), 116-121.
- Pistorello, J., Fruzzetti, A., Maclane, C., Gallop, R., & Iverson, K. M. (2012). Dialectical behavior therapy (DBT) applied to college students: a randomized clinical trial. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 80(6), 982-94.
- Plener, P. L., Kaess, M., Schmahl, C., Pollak, S., Fegert, J. M., &

- Brown, R. C. (2018). Nonsuicidal self-injury in adolescents. *Deutsches Ärzteblatt International*, 115(3), 23.
- Prochaska, J., & Velicer, W. (1997). The Transtheoretical Model of Health Behavior Change. *American Journal of Health Promotion*, 12, 38-48.
- Radloff, L. S. (1977). The CES-D scale: A self-report depression scale for research in the general population. *Applied psychological measurement*, 1(3), 385-401.
- Ribeiro, J. D., Franklin, J. C., Fox, K. R., Bentley, K. H., Kleiman, E. M., Chang, B. P., & Nock, M. K. (2016). Self-injurious thoughts and behaviors as risk factors for future suicide ideation, attempts, and death: a meta-analysis of longitudinal studies. *Psychological medicine*, 46(2), 225-236.
- Roemer L. & Orsillo S. M. (2020). *Acceptance-based behavioral therapy: treating anxiety and related challenges*. New York: Guilford Press.
- Ross, S. & Heath, N. A. (2002). Study of the Frequency of Self-Mutilation in a Community Sample of Adolescents. *Journal of Youth and Adolescence* 31, 67-77.
- Rubin, K. H. (1990). Peer relationships and social skills in childhood: An international perspective. *Human development*, 51(3) 261-276.
- Rubin, K. H., LeMare, L. J., & Lollis, S. (1990). Social withdrawal in childhood: Developmental pathways to peer rejection. *Peer rejection in childhood*, 217-249.

- Rudd, M. D. (1990). An Integrative Model of Suicidal Ideation. *Suicide and Life Threatning Behavior*, 20, 16-30.
- Rudge, S., Feigenbaum, J., & Fonagy, P. (2020). Mechanisms of change in dialectical behaviour therapy and cognitive behaviour therapy for borderline personality disorder: a critical review of the literature. *Journal of Mental Health*, 29, 102-92.
- Sakdalan, J. A., & Gupta, R. (2014). Wise mind—risky mind: A reconceptualisation of dialectical behaviour therapy concepts and its application to sexual offender treatment. *Journal of sexual aggression*, 20(1), 110-120.
- Sansone, R. A., Wiederman, M. W., & Sansone, L. A. (1998). The self-harm inventory (SHI): Development of a scale for identifying self-destructive behaviors and borderline personality disorder. *Journal of clinical psychology*, 54(7), 973-983.
- Scott E. S. (2003). *Dont's Let your Emotions Run Your Life*, 김송호 역 (2012). *정서조절설명서*. 서울: 학지사, 27.
- Selby, E. A., & Joiner Jr, T. E. (2009). Cascades of emotion: The emergence of borderline personality disorder from emotional and behavioral dysregulation. *Review of general psychology*, 13(3), 219-229.
- Selby, E. A., Bender, T. W., Gordon, K. H., Nock, M. K., & Joiner Jr, T. E. (2012). Non-suicidal self-injury (NSSI) disorder: a preliminary study. *Personality Disorders: Theory, Research,*

- and Treatment*, 3(2), 167-175.
- Shattuck, D. K. (1994). Mindfulness and metaphor in relapse prevention: an interview with G. Alan Marlatt. *Journal of the American Dietetic Association*, 94(8), 846-849.
- Sheeran, P., Klein, W., & Rothman, A. J. (2017). Health Behavior Change: Moving from Observation to Intervention. *Annual Review of Psychology*, 68, 573-600.
- Shingler, J. (2004). A process of cross-fertilization: What sex offender treatment can learn from dialectical behaviour therapy. *Journal of Sexual Aggression*, 10(2), 171-180.
- Simons, J. S., & Gaher, R. M. (2005). The Distress Tolerance Scale: Development and validation of a self-report measure. *Motivation and emotion*, 29(2), 83-102.
- Soler, J., Pascual, J. C., Tiana, T., Cebrià, A., Barrachina, J., Campins, M. J., ... & Pérez, V. (2009). Dialectical behaviour therapy skills training compared to standard group therapy in borderline personality disorder: a 3-month randomised controlled clinical trial. *Behaviour research and therapy*, 47(5), 353-358.
- Southward, M. W., Eberle, J. W., & Neacsiu, A. D. (2021). Multilevel associations of daily skill use and effectiveness with anxiety, depression, and stress in a transdiagnostic sample undergoing dialectical behavior therapy skills training. *Cognitive Behaviour Therapy*, 51, 114-129.
- Spandler, H (1996). *Who's Hurting Who? Young People, self-harm*

- and suicide*. Manchester: 42nd Street.
- Stanley, B., Fineran, V., & Brodsky, B. (2014). *Psychological Treatments for Nonsuicidal Self-Injury*. In M. K. Nock (Ed.), *The Oxford Handbook of Suicide and Self-Injury*, 426-435.
- Stanley, B., Gameroff, M. J., Michalsen, V., & Mann, J. J. (2001). Are suicide attempters who self-mutilate a unique population?. *American Journal of Psychiatry*, 158(3), 427-432.
- Sutton, J. (2007). *Healing the Hurt Within: 3rd edition*. Oxford: How To Books.
- Swannell, S. V., Martin, G. E., Page, A., Hasking, P., & St John, N. J. (2014). Prevalence of nonsuicidal self-injury in nonclinical samples: Systematic review, meta-analysis and meta-regression. *Suicide and Life-Threatening Behavior*, 44(3), 273-303.
- Tashakkori, A., & Teddlie, C. (1998). *Mixed methodology: Combining qualitative and quantitative approaches*. Sage.
- Taylor, L. S., Fiore, A. T., Mendelsohn, G. A., & Cheshire, C. (2011). Out of my league: A real-world test of the matching hypothesis. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 37(7), 942-954.
- Tsai, M. H., Chen, Y. H., Chen, C. D., Hsiao, C. Y., & Chien, C. H. (2011). Deliberate self-harm by Taiwanese adolescents. *Acta Paediatrica*, 100(11), 223-226.
- Tuomela, R. (2020). Group beliefs. *Synthese*, 91, 285-318.
- Van Dijk, S., Jeffrey, J., & Katz, M. R. (2013). A randomized,

- controlled, pilot study of dialectical behavior therapy skills in a psychoeducational group for individuals with bipolar disorder. *Journal of affective disorders*, 145(3), 386-393.
- Victoria M. Follette, (2007). *Finding Life Beyond Trauma*. 유성진 역 (2014). **외상의 치유 인생의 치유 트라우마의 수용전념치료**. 서울: 학지사.
- Vieira, A. I., Ramalho, S., Brandão, I., Saraiva, J., & Gonçalves, S. (2016). Adversity, emotion regulation, and non-suicidal self-injury in eating disorders. *Eating Disorders*, 24, 440-452.
- Vujanovic, A. A., Marshall, E. C., Gibson, L. E., & Zvolensky, M. J. (2010). Cognitive-affective characteristics of smokers with and without posttraumatic stress disorder and panic psychopathology. *Addictive Behaviors*, 35(5), 419-425.
- Walsh, B. W. (2012). *Treating Self-Injury*, 이동훈 역, (2019). **자해 치료 실무지침서**. 서울: 박영스토리.
- Webb, T. L., & Sheeran, P. (2006). Does changing behavioral intentions engender behavior change? A meta-analysis of the experimental evidence. *Psychological bulletin*, 132(2), 249-68.
- Weiss, M., Hechtman, L., & Adult ADHD Research Group. (2006). A randomized double-blind trial of paroxetine and/or dextroamphetamine and problem-focused therapy for attention-deficit/hyperactivity disorder in adults. *Journal of Clinical Psychiatry*, 67(4), 611-619.
- Whitlock, J., Eckenrode, J., & Silverman, D. (2006). Self-injurious

- behaviors in a college population. *Pediatrics*, 117(6), 1939-1948.
- Whitlock, J., Purington, A., & Gershkovich, M. (2009). *Media, the internet, and nonsuicidal self-injury*. Cornell University.
- Wilens, T. E., Biederman, J., Spencer, T. J., Bostic, J., Prince, J., Monuteaux, M. C., & Polisner, D. (1999). A pilot controlled clinical trial of ABT-418, a cholinergic agonist, in the treatment of adults with attention deficit hyperactivity disorder. *American Journal of Psychiatry*, 156(12), 1931-1937.
- Wilkinson, P., Kelvin, R., Roberts, C., Dubicka, B., & Goodyer, I. (2011). Clinical and psychosocial predictors of suicide attempts and nonsuicidal self-injury in the Adolescent Depression Antidepressants and Psychotherapy Trial (ADAPT). *American journal of psychiatry*, 168(5), 495-501.
- Wolpe, J. (1969). Basic principles and practices of behavior therapy of neuroses. *The American Journal of Psychiatry*, 125(9), 1242-1247.
- Ye, D., Song, J., Hong, H. J., Lee, J., & Yook, K. (2012). Psychosocial and clinical characteristics of depressed adolescents with a history of non-suicidal self-injury. *Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence*, 60(5), S167.
- Yin, R. K. (2016). *Case study research and applications: Design and methods*. Sage Publications.

- Yip, K. S. (2005). A multi-dimensional perspective of adolescents' self-cutting. *Child and Adolescent Mental Health, 10*(2), 80-86.
- You, J., Leung, F., & Fu, K. (2012). Exploring the reciprocal relations between nonsuicidal self-injury, negative emotions and relationship problems in Chinese adolescents: A longitudinal cross-lag study. *Journal of abnormal child psychology, 40*, 829-836.
- Zaki, J., & Williams, W. C. (2013). Interpersonal emotion regulation. *Emotion, 13*(5), 803-810.
- Zila, L. M., & Kiselica, M. S. (2001). Understanding and counseling self-mutilation in female adolescents and young adults. *Journal of Counseling & Development, 79*(1), 46-52.

Abstract

Development and Effectiveness Analysis of a Dialectical Behavior Therapy (DBT) Group Skills Training Program for Reducing Nonsuicidal Self-Injury in Middle School Students

Sun, Me Ran
Department of Education
Suncheon National University
Graduate School
(Supervisor by prof, Lim, Kyung Hee)

The purpose of this study was to develop a dialectical behavior therapy (DBT) skills training group program to reduce non-suicidal self-injury behavior in middle school students and to verify its effectiveness by comparing it with an emotional anger management program. Non-suicidal self-injury (NSSI) refers to an act of directly damaging the body without suicidal intent. It can take various forms, such as cutting, scratching, and hitting, and is committed as a coping mechanism to temporarily relieve emotional pain. Since it mainly occurs during adolescence, appropriate intervention is required. In this regard, DBT can be a method that can help improve emotional regulation and interpersonal skills. This study aimed to develop a DBT program and verify its effectiveness in evaluating whether the application of DBT is actually effective in suppressing and alleviating

non-suicidal self-injury behavior in adolescents.

The subjects of this study were middle school students in C Middle School in G Metropolitan City, and the selection criteria for the subjects were set at two levels. First, students who reported self-harming behaviors in the Emotional and Behavioral Characteristics Screening Questionnaire (AMPQ- II) conducted at C Middle School, and second, adolescents who committed NSSI according to the diagnostic criteria of DSM-5, and who intentionally damaged their own body for more than 5 days over a year without intent, were included. Among these, students who committed self-harming behaviors more than 5 times within a year on the Self-Injury Functional Assessment Inventory (SHI) were finally selected through a pre-interview. The selected students were randomly assigned to the experimental group, comparison group, and control group (7 each).

The program development process of this study is as follows. First, a literature review on the psychological mechanisms and risk factors of non-suicidal self-harm behavior was conducted, and through this, the various functions of NSSI and the emotional distress caused by it were analyzed. Second, a preliminary program draft was created based on the four core modules of DBT: mindfulness, distress tolerance, emotional regulation, and interpersonal efficacy. Third, theoretical validity and clinical appropriateness were reviewed through expert advice. Fourth, the preliminary program was conducted for four sessions with three middle school students in the experimental group, and the program was optimized by modifying the discovered problems. Fifth, the final program consisted of a total of 10 sessions, and

specific activities were set for each session. Finally, the effectiveness of the program for each group was compared to provide basic data to confirm the effectiveness of the DBT program.

In this study, data were analyzed using SPSS 21.0. The sociodemographic characteristics of the research subjects were identified through frequency analysis, and the reliability of the assessment list was verified using the Pearson correlation coefficient. The difference in pre-test scores between groups was analyzed through the Kruskal-Wallis test, and the post-test scores were compared using the Bonferroni correction. The difference in pre- and post-test scores of each group was confirmed through the Wilcoxon signed-rank test, and the difference in the post-test was analyzed through the Mann-Whitney U test. Finally, the Friedman test was conducted to evaluate the change in pre-, post-, and post-test scores.

As a result of the effectiveness verification, the DBT group skills training program presented in this study showed significant improvement in indicators such as irrational beliefs, self-deprecation, emotional regulation difficulties, depression level, and lack of distress tolerance at the post-test and follow-up tests, and it was confirmed that the effect was continuously maintained compared to the comparison group.

The significance of this study is as follows. First, in the domestic reality where there is a lack of treatment programs specialized for middle school students' NSSI, a DBT-based program was proposed to fill the clinical gap and provide an effective intervention model. Second, the core principles of DBT

were successfully applied according to the developmental level of adolescents, thereby establishing an evidence base for NSSI treatment. Third, the systematic program development process provided practical guidelines to clinical practitioners and educational sites, providing implications for the application of alternative interventions that counselors and teachers can use to effectively treat middle school students.

.....

Key words: Nonsuicidal self-injury, Dialectical Behavior Therapy (DBT), group skills training, middle school students, irrational beliefs, emotional regulation, depression, distress tolera

부 록

[부록1] 프로그램 개발 요구 조사 설문지	242
[부록 2] 비자살적 자해행동 프로그램 개발 요구도 조사(중학생 대상) ...	244
[부록 3] 비자살적 자해행동 프로그램 개발 요구도 조사(전문 상담사 대상)	245
[부록 4] 자해행동 척도(SHI)	250
[부록 5] 고통감내력 척도	251
[부록 6] 정서조절 척도	252
[부록 7] 우울 척도	254
[부록 8] 비합리적 척도	255
[부록 9] 중학생의 비자살적 자해행동 감소를 위한 변증법적 행동치료(DBT) 집단기술훈련 프로그램 활동 내용	257

[부록 1] 프로그램 개발 요구 조사 설문

안녕하십니까?

본 요구 조사 설문지는 비자살적 자해해동 중학생을 대상으로 하는 집단프로그램의 개발을 위한 요구 조사입니다. 본 설문의 결과는 무기명으로 통계 처리되며, 연구 의외로 다른 목적으로 사용되지 않을 것임을 약속드립니다. 또한, 반복된 자해행동으로 일상생활에 어려움을 겪는 중학생의 문제를 개선하기 위한 프로그램을 개발하는데, 기초자료로 활용될 예정입니다.

바쁘시겠지만, 설문에 제시된 문항을 읽은 다음 한 문항도 빠짐없이 솔직하게 응답해 주시면 연구에 많은 도움이 될 것입니다. 감사합니다.

2023년 6월

순천대학교 대학원 교육학과

지도교수: 임경희

박사 과정 수료 : 선미란

비자살적 자해행동 이란?

“ 자신이 죽고 싶은 욕구 없이 의도적으로 신체적 해를 입히는 행동”이며 신체를 칼로 베거나 긁기, 상처 난 곳을 방치하기, 할퀴기, 신체 부위 때리기, 머리카락 뽑기 등이 있습니다.

폭음, 문신, 등 실수로 자신을 다치게 하는 행동은 자해가 아닙니다.

응답 정보

번호	내용	문항 체크
1	귀하의 성별은?	①남성 ②여성
2	귀하가 현재 재학 중인 학년은?	①1학년 ②2학년 ③3학년
3	귀하의 학생 정서·행동 특성 검사에서 선별되어 상담을 받은 경험이 있습니까?	①있다 ②없다.
4	최근 3개월 이내에 비자살적 자해행동 경험이 있습니까?	①있다 ②없다.
5	4번 ‘① 있다’ 답변에 최근 3개월 이내에 비자살적 자해행동 횟수는?	①1회 ②2회 ③3회 ④3회 이상

[부록2] 비자살적 자해행동 프로그램 요구도 조사(중학생 대상)

번호	비자살적 자해행동 감소를 위한 집단상담 프로그램 개발 요구 조사 내용
1	학교생활 중 가장 큰 어려움을 겪고 있는 영역은 무엇인가요? 1. 학업 활동(지각이나 결석하지 않고 수업에 충실하게 참여하기 어려움) 2. 개인 심리(나에 대해 잘 모르겠음, 우울, 불안, 낮은 자존감) 3. 대인관계(또래 관계를 맺는 것이 어려움, 모둠 수업이 참여가 두렵다.) 4. 사회 체험(교내외에서 진행하는 행사 및 단체활동에 참여하는 것이 어려움)
2	비자살적 자해행동 감소를 위한 교육 및 프로그램 또는 유사 프로그램에 참여해 본 경험이 있나요? 1. 여러 차례 참여해 봤다. 2. 한두 번 참여해 봤다. 3. 전혀 참여해 본 적이 없다.
3	비자살적 자해행동 개선할 수 있는 집단프로그램이 개설된다면 참여할 마음이 있으신가요? 1. 매우 참여하고 싶다. 2. 참여하고 싶다. 3. 참여하고 싶지 않다. 4. 전혀 참여하고 싶지 않다.
4	비자살적 자해행동 개선할 수 있는 집단프로그램이 참여하게 되면 어느 정도의 도움이 될 거라고 기대하시나요? 1. 매우 도움이 될 것이다. 2. 도움이 될 것이다. 3. 도움이 되지 않을 것이다. 4. 전혀 도움이 되지 않을 것이다.
5	중학생은 프로그램에 참여한다면 일주일에 몇 번이 적당하다고 생각하나요? 1. 주 1회 2. 주 2회 3. 주 3회 4. 기타()
6	프로그램에 대한 다른 의견이 있으면 자유롭게 작성해 주세요. ()

[부록 3] 비자살적 자해행동 프로그램 요구도 조사. (전문 상담사 대상)
비자살적 자해행동 감소를 위한 변증법적 행동치료(DBT) 집단기술훈련 프로그램 개발 필요성과 운영 요구도 조사

안녕하십니까?

본 질문지는 중학생의 비자살적 자해행동 감소를 위한 변증법적 행동치료(DBT) 집단기술훈련 프로그램 개발에 대한 학교 상담사들의 요구도 조사를 위한 것입니다. 반복된 자해행동으로 일상생활에 어려움을 겪는 중학생의 문제를 개선하기 위한 프로그램을 개발하는 데 기초자료로 활용될 예정입니다. 본 설문지 결과는 무기명으로 통계 처리되며, 연구 의외로 다른 목적으로 사용되지 않을 것을 약속드립니다. 바쁘시겠지만, 설문지 제시된 문항을 읽은 다음 한 문항도 빠짐없이 솔직하게 응답해 주시면 연구에 많은 도움이 될 것입니다. 감사합니다.

2024년 2월

순천대학교 대학원 교육학과

지도교수: 임경희

박사 과정 수료: 선미란

번호	내용	문항 체크
1	귀하의 성별은?	① 남성 ② 여성
2	귀하가 현재 근무하는 곳은?	① 교육청 ② Wee센터 ③ Wee 클래스 ④ 기타()
3	귀하의 상담 기관 근무지 경력은?	① 1년 이상 ② 3년 이상 ③ 5년 이상 ④ 10년 이상
4	최근 1년 이내에 비자살적 자해 상담 경험이 있습니까?	① 있다 ② 없다.
5	4번 '① 있다' 답변에 최근 1년 이내에 비자살적 자해 상담 건수는?	① 1회 ② 2회 ③ 3회 ④ 3회 이상

*** 비자살적 자해행동**

“죽고 싶은 욕구 없이 의도적으로 신체적 해를 입히는 행동”을 말합니다. 신체를 칼로 베거나 긁기, 상처 난 곳을 방치하기, 할퀴기, 신체 부위 때리기, 머리 카락 뽑기 등이 있습니다. 폭음, 문신, 등 실수로 자신을 다치게 하는 행동은 자해가 아닙니다.

*** 변증법적 행동치료(DBT) 집단기술훈련 프로그램 이란?**

1인 이상이 모여서 자신의 부정적인 행동 및 감정을 긍정적으로 변화할 수 있도록 훈련하고, 자신의 행동수정을 교정하는 기술을 익히는 과정을 말한다.

1. 최근 1년 이내 비자살적 자해 감소를 위한 변증법적 행동치료(DBT) 집단 기술 훈련 프로그램을 진행해 본 경험이 있나요?

①있다. ②없다.

2. 비자살적 자해 감소를 위한 변증법적 행동치료 프로그램이 학교나 지역사회에서 제공되는 메뉴얼이 있나요?

① 많이 제공되고 있다. ② 적당히 제공되고 있다. ③ 조금 제공된다.

④ 전혀 제공되지 않고 있다.

3. 다음 비자살적 자해 감소를 위한 집단 행동치료(DBT) 프로그램 개발에 대해 어떻게 생각하시나요?

① 매우 필요하다. ②필요하다. ③ 필요하지 않다. ④ 전혀 필요하지 않다.

4. 다음 비자살적 자해 감소를 위한 집단 행동치료 프로그램이 제공된다면 진행할 마음이 있으신가요?

①진행할 것이다. ② 진행하지 않을 것이다.

5. (4번) 문항에서 ②번 진행하지 않는 경우 어떻게 처리할 것인가요?

① 병원 의뢰한다. ② 외부 상담 기관에 의뢰한다. ③ 기타 ()

6. (5번) 문항에 그렇게 답한 이유는 무엇인지 기술해 주세요.

()

7. 비자살적 자해 감소를 위한 변증법적 행동치료 프로그램 구성 시 적절하다고 생각되는 의견에 √ 표시해 주세요.

번호	문항	①	②	③	④	⑤
1	주당 몇 회가 적절한가요?	1회	2회	3회	4회 이상	기타 ()
2	회기 시간은 어느 정도가 적절한가요?	45분	50분	60분	90분	기타 ()
3	몇 회기 구성이 적당한가요?	8회기	10회기	12회기	14회기	기타 ()

8. 다음은 비자살적 자해행동 감소를 위한 변증법적 행동치료 프로그램에 포함되어야 할 내용을 인지, 정서, 행동 영역으로 구분하여 제시한 것입니다. 필요한 내용의 예를 기술하고, 필요한 정도를 √ 표시해 주세요.

번호	영역	①	②	③	④	⑤	필요한 내용을(예시)와 그 외 기타 의견을 기술해 주세요
		전혀 필요하지 않음	필요하지 않음	보통	필요함	매우 필요함	
1	인지적						
2	정서적						
3	행동적						

(예시: 비합리적 신념, 우울감, 정서, 스트레스 대처, 자해 충동, 자존감, 자기 통제, 공감, 자기주장, 정서적 무책임, 신념, 자동적 사고, 등)

***변증법 행동치료(Dialectical Behavior Therapy: DBT)**

미국의 심리학자 리네한(M. Linehan)이 경계선 성격장애의 치료를 위해 개발한 치료입니다. 인지행동치료(DBT) 원리와 선불교 철학, 변증법 철학을 기반으로 하며, 인지행동치료(DBT) 범주에 포함됩니다. DBT는 정서, 인지, 행동, 대인관계, 자기조절 등 전반적 정서조절 문제를 완화하는 것에 초점을 맞추고 있습니다.

10. 다음은 비자살적 자해 감소를 위한 변증법적 행동치료(DBT) 집단기술훈련 프로그램의 구성 내용입니다. 각 내용에 대하여 필요하다고 생각되는 정도를 √ 표시해 주세요.

번호	구성 내용	①	②	③	④	⑤
		전혀 필요 하지 않음	필요 하지 않음	보통	필요 함	매우 필요 함
1	마음챙김 스킬 (자유로운 감각 발전시키기)					
2	정서조절 훈련 (정서조절 하는 것 도와주기)					
3	고통 감내 훈련 (위기 상황을 감내하여 생존하는 것을 배울 수 있게 돕는 것)					
4	대인관계 효율성 훈련 (대인관계 갈등을 효과적으로 해결)					

11. 비자살적 자해 내담자와의 만남 및 상담 경험에 비추어 비자살적 자해 감소를 위한(DBT) 집단기술훈련 프로그램 개발에 대한 의견을 자유롭게 작성해 주세요.

13. 비자살적 자해 내담자와의 만남 및 상담 경험에 비추어 비자살적 자해 감소를 위한 집단프로그램 구성 내용에 관한 의견을 자유롭게 작성해 주세요.

[부록 4] 자해행동 척도(SHI)

다음 설문지를 읽고 최근 6개월간 또는 현재 자신의 모습과 어느 정도 일치하는 지에 대해 표시해 주시기를 바랍니다.

번호	문항 체크	거 의 그 렇 지 않 다	가 끔 그 렇 다	자 주 그 렇 다	항 상 그 렇 다
1	약물을 과다 복용한다.	1	2	3	4
2	날카로운 물건으로 내 몸에 상처를 낸다.	1	2	3	4
3	일부러 내 몸에 화상을 입힌다.	1	2	3	4
4	나 자신을 때린다.	1	2	3	4
5	벽이나 책상 등에 머리를 부딪힌다.	1	2	3	4
6	과음한다.	1	2	3	4
7	위험하게 운전한다.	1	2	3	4
8	내 몸을 할컾다.	1	2	3	4
9	몸에 난 상처를 치료하지 않고 내버려둔다.	1	2	3	4
10	일부러 병을 악화시킨다. (예를 들어, 처방받은 약 먹지 않기)	1	2	3	4
11	불건전한 성관계를 한다. (예를 들어, 여러 명의 파트너와 관계 맺기)	1	2	3	4
12	대인관계에서, 일부러 남들로부터 거절당하게끔 행동한다.	1	2	3	4
13	처방받은 약물을 과다복용한다.	1	2	3	4
14	스트레스를 심하게 받는 인간관계에 매달린다.	1	2	3	4
15	나에게 피해를 주는 성적인 관계를 맺는다.	1	2	3	4
16	자살 시도를 한다.	1	2	3	4
17	몸이 상할 정도로 무리하게 운동한다.	1	2	3	4
18	자기 비하적인 생각을 해서 나 자신을 괴롭힌다.	1	2	3	4
19	몸이 상할 정도로 굶는다.	1	2	3	4
20	몸이 상할 정도로 변비약, 이뇨제 등을 먹는다	1	2	3	4

[부록 5] 고통감내력 척도

각 문항을 주의 깊게 읽고 당신이 경험한 정도를 가장 잘 나타내는 숫자에
○표해 주시기를 바랍니다.

		전혀 그렇지 않다	때 때로 그렇 다	보 통이 다	거 의 그 렇 다	매 우 그 렇 다
1	고통스러운 감정은 참기 힘들다.	1	2	3	4	5
2	고통스러운 감정을 느낄 때면 그 감정이 얼마나 끔찍한 지에 대해서만 생각하게 된다.	1	2	3	4	5
3	고통스러운 감정을 다루기 어렵다.	1	2	3	4	5
4	고통스러운 감정이 너무 강렬한 나머지 거기에 완전히 압도된다.	1	2	3	4	5
5	고통스러운 감정보다 더 나쁜 것은 없다.	1	2	3	4	5
6	대부분의 사람처럼 나도 고통스러운 감정을 견뎌낼 수 있다.	1	2	3	4	5
7	고통스러운 감정은 수용할 만한 것이 아니다.	1	2	3	4	5
8	고통스러운 감정을 피하고자 무엇이든 할 것이다.	1	2	3	4	5
9	다른 사람들은 고통스러운 감정을 나보다 잘 견뎌내는 것 같다.	1	2	3	4	5
10	고통스러운 감정은 항상 나에게 가장 큰 시련이다.	1	2	3	4	5
11	고통스러운 감정이 느껴질 때면 내 자신이 부끄럽다.	1	2	3	4	5
12	고통스러운 감정이 두렵다.	1	2	3	4	5
13	고통스러운 감정을 멈추기 위해 무슨 일이든 할 것이	1	2	3	4	5
14	고통스러운 감정이 느껴지면 즉시 뭔가를 해야 한다.	1	2	3	4	5
15	고통스러운 감정을 느낄 때면, 그 고통이 실제로 얼마 나 끔찍한지에 대해서만 집중하게 된다.	1	2	3	4	5

[부록 6] 정서조절 척도

각 문장을 읽고 문항의 내용 여러분의 자신을 얼마나 잘 나타내고 있는지에 따라 가장 가깝다고 생각되는 번호를 골라 한군데에 ○표하세요.

번호	문항	전혀 아니다	가끔 그렇다	보통 이다	대부분 그렇다	거의 항상 그렇다
1	내가 무엇을 느끼고 있는지 분명하게 안다.	0	1	2	3	4
2	내가 어떻게 느끼고 있는지 주의를 기울인다.	0	1	2	3	4
3	내 감정은 너무도 강렬하여 통제할 수 없는 것처럼 느낀다.	0	1	2	3	4
4	내가 어떻게 느끼고 있는지 잘 모르겠다.	0	1	2	3	4
5	내가 어떻게 느끼는지 이해하기 어렵다.	0	1	2	3	4
6	내 기분에 주의를 기울인다.	0	1	2	3	4
7	내가 어떤 식으로 느끼는지 정확하게 알고 있다.	0	1	2	3	4
8	내가 무엇을 느끼고 있는지 신경을 쓴다.	0	1	2	3	4
9	내가 어떻게 느끼는지 혼란스럽다.	0	1	2	3	4
10	기분이 나쁠 때, 그 감정을 알아차릴 수 있다.	0	1	2	3	4
11	기분이 나쁠 때, 그렇게 느낀 나 자신에게 화가 난다.	0	1	2	3	4
12	기분이 나쁠 때, 그렇게 느낀 나 자신이 당황스럽다.	0	1	2	3	4
13	기분이 나쁠 때, 일을 마무리하기가 힘들다.	0	1	2	3	4
14	기분이 나쁠 때, 그 기분을 통제할 수 없다.	0	1	2	3	4
15	기분이 나쁠 때, 나는 그 기분이 오랫동안 지속될 거로 생각한다.	0	1	2	3	4
16	기분이 나쁠 때, 결국 나는 매우 우울해질 것이다.	0	1	2	3	4
17	기분이 나쁠 때는 다른 일에 집중하기가 어렵다.	0	1	2	3	4
18	기분이 나쁠 때, 통제할 수 없을 것 같은 기분이 든다.	0	1	2	3	4
19	기분이 나빠도 여전히 해야 할 일을 마무리할 수 있다.	0	1	2	3	4
20	기분이 나쁠 때, 그렇게 느끼고 있는 나 자신이 창피하다.	0	1	2	3	4

21	기분이 나쁠 때, 내 기분이 좀 더 나아지는 방법을 찾아낼 수 있다.	0	1	2	3	4
22	기분이 나쁠 때는 내가 나약한 사람처럼 느껴진다.	0	1	2	3	4
23	기분이 나쁠 때도 여전히 내 행동을 통제할 수 있을 것처럼 느껴진다.	0	1	2	3	4
24	기분이 나쁠 때, 그렇게 느낀 것에 대해 죄책감이 든다	0	1	2	3	4
25	기분이 나쁠 때는 집중하기가 힘들다.	0	1	2	3	4
26	기분이 나쁠 때, 내 행동을 통제하기가 힘들다.	0	1	2	3	4
27	기분이 나쁠 때, 내 기분을 좀 나아지게 할 수 있는 방법은 아무것도 없다고 생각한다.	0	1	2	3	4
28	기분이 나쁠 때, 그렇게 느낀 나 자신에게 짜증이 난다.	0	1	2	3	4
29	기분이 나쁠 때, 나 자신을 부정적으로 평가하기 시작한다.	0	1	2	3	4
30	기분이 나쁠 때, 내가 할 수 있는 일은 내가 느낀 그 기분에 빠져있는 것뿐이다.	0	1	2	3	4
31	기분이 나쁠 때, 행동 통제가 안 된다.	0	1	2	3	4
32	기분이 나쁠 때, 나는 그 밖의 다른 어떤 일에 대해 생각하는 것이 어렵다.	0	1	2	3	4
33	기분이 나쁠 때, 기분이 풀리는 데 시간이 오래 걸린다.	0	1	2	3	4
34	기분이 나쁠 때, 내 기분에 압도된다.	0	1	2	3	4

[부록 7] 우울 척도

아래의 항목들은 지난 일주일 동안은 당신의 상태에 관한 질문입니다.

그와 같은 일들이 얼마나 자주 일어났는지 해당하는 곳에 표시(√)해 주세요

번호	문항 내용	극히 드물다	가끔 그렇다	보통이다	종종 그렇다	대부분 그렇다
1	평소에는 아무렇지도 않던 일들이 괴롭고 귀찮게 느껴졌다.	1	2	3	4	5
2	먹고 싶지 않고, 식욕이 없었다.	1	2	3	4	5
3	어느 누가 도와준다고 하더라도, 나의 울적한 기분을 떨쳐버릴 수 없을 것 같았다.	1	2	3	4	5
4	무슨 일을 하든 정신을 집중하기 힘들었다.	1	2	3	4	5
5	비교적 잘 지냈다.*	1	2	3	4	5
6	상당히 우울했다.	1	2	3	4	5
7	모든 일들이 힘들게 느껴졌다.	1	2	3	4	5
8	앞 일이 암담하게 느껴졌다.	1	2	3	4	5
9	지금까지의 내 인생은 실패작이라는 생각이 들었다.	1	2	3	4	5
10	적어도 보통 사람들만큼의 능력은 있었다고 생각한다.*	1	2	3	4	5
11	잠을 설쳤다(잠을 잘 이루지 못했다).	1	2	3	4	5
12	두려움을 느꼈다.	1	2	3	4	5
13	평소에 비해 말수가 적었다.	1	2	3	4	5
14	세상에 홀로 있는 듯한 외로움을 느꼈다.	1	2	3	4	5
15	큰 불만이 없이 생활했다.*	1	2	3	4	5
16	갑자기 나에게 차갑게 대하는 것 같았다.	1	2	3	4	5
17	갑자기 울음이 나왔다.	1	2	3	4	5
18	마음이 슬펐다.	1	2	3	4	5
19	사람들이 나를 싫어하는 것 같았다.	1	2	3	4	5
20	도무지 뭘 해 나갈 엄두가 나지 않았다.	1	2	3	4	5

[부록 8] 비합리적인 신념 척도

다음은 사람들이 가지고 있는 여러 가지 신념과 태도를 열거한 것입니다. 각 문항을 주의 깊게 읽고 여러분들이 평소에 생각하는 바에 비추어 그 내용에 어느 정도로 동의 또는 반대하는지에 따라서 1에서 5까지의 숫자에 V표를 하여 주십시오. 어떤 문장에 대해 동의하는지 아닌지를 도저히 결정할 수 없을 때를 제외하고는 가급적 중립적 반응을 나타내는 3번에는 표시하지 않도록 해 주십시오.

사람들은 각자 생각이 달라서 여기에는 옳고 그른 답이 없습니다.

전혀 그렇지 않다(1점), 그렇지 않다(2점) 중간이다(3점), 그렇다(4점), 항상 그렇다(5점)

번호	문항 내용	점수				
		1	2	3	4	5
1	중요한 일들에 실패하는 것을 참을 수 없고, 그 일들에 성공하지 못하는 그것을 견딜 수 없다.	1	2	3	4	5
2	다른 사람들이 나를 배려하지 않는 그것을 참을 수 없고, 그들의 조금만 부당함에 대해서도 참을 수 없다.	1	2	3	4	5
3	불편하거나, 긴장되거나 신경과민이 되는 것을 견딜 수 없고, 자신이 그러한 상태가 되는 것을 참을 수 없다.	1	2	3	4	5
4	나는 긴장되거나 신경과민 상태를 참을 수 없고, 긴장은 견딜 수 없는 것으로 생각한다.	1	2	3	4	5
5	나에게 중요한 사람이 나를 싫어한다면, 그것은 내가 호감이 가지 않는 형편없는 사람이기 때문이다.	1	2	3	4	5
6	만약 중요한 사람이 나를 싫어한다면, 그것은 내가 호감이 가지 않는 형편없는 사람이기 때문이다.	1	2	3	4	5
7	만약 내가 나에게 중요한 일들을 잘 처리하지 못한다면 그것은 내가 쓸모없고 형편없는 사람이기 때문이다.	1	2	3	4	5
8	중요한 일들을 형편없이 한다는 것은 끔찍한 일이고, 만약 내가 형편없이 했다면 그것은 파멸이라고 생각한다.	1	2	3	4	5
9	나는 사람들이 나에게 무례한 태도를 보이며 대할 때, 매우 불쾌하게 생각한다.	1	2	3	4	5

10	나는 부당한 대우를 받는 것을 참을 수 없고, 부당함은 참을 수 없는 일이라고 생각한다.	1	2	3	4	5
11	만약 중요한 사람들이 나를 싫어한다면, 그것은 내가 얼마나 가치 없는 사람인가를 보여주는 것이다.	1	2	3	4	5
12	내가 좋아하는 사람들이 나를 거부하거나 싫어한다면 그것은 내가 형편없거나 가치 없는 사람이기 때문이다.	1	2	3	4	5
13	삶에 있어서 일상생활의 사소한 문젯거리들이 있다는 것은 끔찍한 일이고, 일상생활의 사소한 문제 거리들로 들볶이게 되는 것은 파멸이다.	1	2	3	4	5
14	내가 중요한 일들을 잘 해내지 못한 것을 참을 수가 없고, 실패하는 그것을 견딜 수 없다.	1	2	3	4	5
15	만약 내가 중요한 일들을 잘 해내지 못한다면, 그것은 파멸이 될 것이다.	1	2	3	4	5
16	나를 좋아해 주기를 바라는 사람들은 나를 좋아해야 하고 인정해야만 하며, 그들이 나를 좋아하지 않는다는 그것을 나는 받아들일 수 없다.	1	2	3	4	5
17	다른 사람으로부터 존경을 받지 못하는 그것은 견딜 수 없고, 나는 그들의 무례함을 참을 수 없다.	1	2	3	4	5
18	나는 내 삶에 있어서 일상생활의 사소한 문젯거리들을 참을 수 없다.	1	2	3	4	5
19	나를 좋아해 주기를 바라는 사람들이 나를 인정하지 않거나 거부할 때, 나는 그들이 나를 좋아하지 않는 것을 참을 수가 없다.	1	2	3	4	5

[부록 9]

중학생의 비자살적 자해행동 감소를 위한
변증법적 행동치료(DBT) 집단기술훈련 프로그램 활동 내용

회기 주제	- 집단 행동치료(DBT) 이해와 마음 친구와 함께 해봐요.	회 기	1
회기 목표	- 프로그램에 대한 이해를 높이고 참여 동기를 증진하기. - DBT에 대한 개념을 이해하고 행동치료(DBT) - 오리엔테이션을 통해 참여 목표를 설정하기. - 상담자와 집단구성원 간의 신뢰감으로 안정성을 확보하기.		
진행 절차 및 내용			소요 시간
회기 들어가기	1. 자기소개 및 참여 동기 나누기. 2. 규칙을 정하고 서약서 개인정보 동의서 작성하기. 3. 비밀보장의 범위 녹음에 대한 동의 4. 프로그램 목적 및 집단 활동 참여하기. 5. 긴장감을 낮추고, 친밀감 형성하기		10분
교육 및 활동하기	6. 프로그램 시작 전 생활 습관 점검표를 점검하도록 안내하기. (수면 및 규칙적인 휴식) 7. 변증법적 집단 행동치료(DBT) 개념 4가지 안내하기. (마음챙김, 고통 감내, 정서조절, 대인관계 효율성) -변증법: 이게 뭐지? 왜 중요한지에 대한 소개 8. 자해행동 이해하기 9. 사전검사 실시. 10. 개인적인 목표 세우기 (감소해야 할 행동과 긍정적인 행동 기술을 작성하기. 11. 지혜로운 마음의 배를 타고 친구랑 함께 여행을 떠나봅시다.		25분
피드백 나누기	12. 소감 나누기. 마음챙김(호흡 관찰 연습하기)		10분
준비물	- 필기도구, 측정 도구 (사전), 프로그램 시작하기 활동지. 4절지		
과제 제시하기	13. 다음 회기(마음챙김) 소개 및 과제 제시 마무리		

회기 주제	-마음챙김 : ‘What’ 기술	회기	2
회기 목표	- ‘What’ 기술 (관찰하기, 기술하기, 참여하기) 익히기 - 한 번에 단 한 가지의 ‘what’ 기술만 사용하는 기술 습득하기. - 마음챙김을 통하여 우울감 알아차리기		
진행 절차 및 내용			소요 시간
생활 습관	1. 생활 습관 점검표 점검하기. 1. 과제 실시 여부를 파악하기.	10분	
DBT 기술 (마음챙김)	3. 마음챙김 :’ What’ 기술 -마음챙김이란? 현재 순간을 인식하고 우리의 마음을 우리가 원하는 곳에 두는 것. 4. 마음챙김: ‘관찰하기’ 연습 - 호흡 관찰하기 - 눈으로 관찰하기 연습: 우리의 마음을 몸과 마음의 감각으로 다시 돌아오도록 하기(나뭇잎 관찰하기) - 소리를 관찰하기(주변의 소리, 음악) - 냄새를 관찰하기: 주변에 있는 냄새 관찰하기 - 음식을 먹을 때의 행동과 맛 관찰하기 - 피부에 느껴지는 촉감 관찰하기 - 마음속에 떠오르는 생각이 오고 가는 것을 관찰하기 5. 마음챙김: 관찰된 부분 기술하기. 6. 마음챙김 : ‘What’ 기술 참여하기.	25분	
심리교육 (자해 감소)	7. 마음챙김을 통하여 우울감 알아차리기. -마음챙김 관찰하기를 통하여 자해행동 동기를 탐색하기.		
피드백 나누기	8. 소감 나누기. 9. 다음 회기 소개 및 과제 마무리	10분	
준비물	- 필기도구, 마음챙김 : ‘What’ 기술 활동지		
과제 제시하기	10. 마음챙김: 호흡 관찰 연습하기		

회기주제	- 마음챙김 ‘HOW’ 기술	회 기	3
회기목표	- 일어나는 감정의 파도를 조심해! - 무비판적 마음 갖기 - 한가지 마음 갖기 - 효과적인 것에 집중하기		
진행 절차 및 내용			소요시간
생활습관	1. 생활 습관 점검표 점검하기. 2. 마음챙김 기술 과제 실시 여부를 파악하기.	10분	
DBT 기술 (마음챙김)	3. 마음챙김(호흡 관찰 연습하기 4. 마음챙김 ‘HOW’ 기술 - 무비판적 마음 갖기 - 있는 그대로를 보십시오. 좋은 것과 나쁜 것을 평가하려고 하지 않기. 4. 한가지 마음 갖기 -지금 이 순간에 완전히 자신을 몰입시키기. 5. 효과적인 것에 집중하기.	25분	
심리 교육 (자해 감소)	6. 마음챙김을 통하여 우울감을 이해하기. 우울감이 있을 때 자해를 왜 할까요? 7. 자해했던 경험 이야기 나누기 (자해 행동 숨기지 않기).		
피드백 나누기	8. 소감 나누기. 9. 다음 회기 소개 및 과제 마무리	10분	
준비물	- 필기도구, 보드마카, 생활 습관 점검표 점검		
과제 제시하기	10. 마음챙김 기술 연습하기		

회기 주제	- 고통 감내 훈련	회 기	4
회기 목표	- 나를 긍정적으로 돌보기		
진행 절차 및 내용			소요 시간
생활 습관	1. 생활 습관 점검표 점검하기. 2. 정서조절 기술(정·반대 행동하기의 효과적일 때 (PPT) 스킬 과제 할 때 시 여부를 파악하기.	10분	
DBT 기술 (고통감내력 훈련)	3. 마음챙김(호흡 관찰하기) - 배의 움직임 - 숨을 들이마시고 내쉬면서 코에서 느껴지는 감각에 집중해 보기 4. 고통 감내 훈련 - 고통스러운 감정과 충동을 감내해야 하는 이유는? - 지혜로운 마음으로 수용하기 스킬로 주의 분산하는 (ACCEPTS) 연습하기. - 활동하기(Activites) - 기여하기(Contributing) - 비교하기(Comparisons) - 정반대 감정 만들기(Emotions) - 밀어내기(Pushing Away) - 생각(Thugts) - 감각(Sensations)	25분	
심리교육 (자해 감소)	5. 고통 감내 훈련을 통하여 자해행동 충동 시 비합리 적 신념을 지혜로운 마음으로 수용하기 스킬로 주의 분산하기 (ACCEPTS) 연습하기.		
피드백 나누기	6. 소감 나누기 7. 다음 회기 소개 및 과제 마무리	10분	
준비물	- 필기도구, 생활 습관 점검표		
과제 제시하기	8. 고통 감내 훈련(ACCEPTS) 스킬 연습하기		

회기 주제	- 고통 감내 훈련	회기	5
회기 목표	- 위기 생존(TIPP) 스킬 연습하기.		
진행 절차 및 내용			소요 시간
생활 습관	1. 생활 습관 점검표 점검하기. 2. 고통 감내 훈련 (ACCEPTS) 스킬 과제 할 땐 시 여부를 파악하기	10분	
DBT 기술 (고통 감내)	3. 마음챙김(호흡 관찰하기) - 배의 움직임 - 숨을 들이마시고 - 내쉬면서 코에서 느껴지는 감각에 집중해 보기 4. 고통 감내 훈련 (자기 위안 하기) -여섯 가지 감각기관을 사용하여 자기 위안하기 (sef-soothe) 5. 위기 생존 스킬 - 위기 상황에서(TIPP) 연습하기 T-Temperature(차가운 물로 얼굴 온도 낮추기) I-Intense exercise(격한 운동) P-Paced breathing(천천히 호흡하기) P-Progressive muscle relaxation (점진적 근육 이완훈련)	25분	
심리교육 (자해 감소)	7. 자해행동 충동 시 고통감내력 행동치료(DBT) 적용하도록 교육. 8. 자해행동 정지 연습하기		
피드백 나누기	9. 소감 나누기 10. 다음 회기 소개 및 과제 마무리	10분	
준비물	- 필기도구, 생활 습관 점검표		
과제 제시하기	11. 고통 감내 (TIPP 스킬) 연습하기.		

회기 주제	- 정서조절 하기.	회 기	6
회기 목표	- 일어나는 감정을 조절하기. - 감정을 이해하고 감정에 이름 붙이기. - 원치 않는 감정 빈도 줄이기		
진행 절차 및 내용			소요 시간
생활 습관	1. 생활 습관 점검표 점검하기. 2. 마음챙김 기술 과제 할 땐 시 여부를 파악하기.	10분	
DBT 기술 (정서조절)	3. 마음챙김(호흡 관찰하기) - 배의 움직임 - 숨을 들이마시고 내쉬면서 코에서 느껴지는 감각에 집중해 보기. 4. 정서조절 (감정을 균형 잡기) -감정을 이해하고 감정 알기. -마음속에 일어나는 감정 이해하기 -정서조절을 어렵게 만드는 요인이 무엇인지 알기. -감정 기술 모델 이해하기. -감정을 기술하는 방법 익히기. 5. 감정을 관찰하고 기술하는 연습하기.	25분	
심리교육 (자해감소)	6. 자해행동을 하도록 하는 감정의 비합리적인 신념 무엇인지 알아보기. 7. 정서조절을 통하여 자해를 촉발하는 요인을 지혜롭 게 대처하기.		
피드백 나누기	8. 소감 나누기. 9. 다음 회기 소개 및 과제 마무리	10분	
준비물	- 필기도구, 칠판 펜, 생활 습관 점검표 워크시트 2-4a, 16		
과제 제시하기	10. 일상에 일어나는 위기 상황에서 감정을 관찰하고 기술하는 연습하기.		

회기 주제	- 정서조절	회기	7
회기 목표	- 일어나는 감정에 머무르기. - 정·반대 행동하기의 효과적일 때(PPT 교육) 익히기.		
진행 절차 및 내용			소요 시간
생활 습관	1. 생활 습관 점검표 점검하기. 2. 정서조절 기술 과제 실시 여부를 파악하기.	10분	
DBT 기술 (정서조절)	3. 마음챙김(호흡 관찰하기) - 배의 움직임 - 숨을 들이마시고 내쉬면서 코에서 느껴지는 감각에 집중해 보기 4. 정서조절 - 현실의 고통을 자연스럽게 받아들이기 5. 기꺼이 하는 마음이 주는 장점을 알고 수용하기 6. 현재 순간에 몰입하기 7. 정·반대 행동하기 - 정·반대 행동하기의 효과적일 때(PPT 교육) 익히기.	25분	
심리교육 (자해 감소)	8. 정서조절 기술의 정반대 행동(PPT 교육)으로 자동적 사고 및 비합리적 신념 찾기. 9. 자해 이해 감정 다루기		
피드백 나누기	10 소감 나누기. 11 다음 회기 소개 및 과제 마무리	10분	
준비물	- 필기도구, 생활 습관 점검표		
과제 제시하기	12. 정서조절 하기 위한 정·반대 행동하기의 효과적일 때 (PPT 스킬) 연습하기.		

회기 주제	- 대인관계 효율성 훈련	회기	8
회기 목표	- 긍정적 관계 만들기		
진행 절차 및 내용			소요 시간
생활 습관	1. 생활 습관 점검표 점검하기. 2. 고통 감내 (TIPP 스킬) 과제 할 땐 시 여부를 파악하기.	10분	
DBT 기술 (대인관계 효율성)	3. 마음챙김(호흡 관찰하기) - 배의 움직임 - 숨을 들이마시고 내쉬면서 코에서 느껴지는 감각에 집중해 보기 4. 대인관계 효율성을 감소시키는 요인 알기. 5. 대인관계 효율성 훈련 (긍정적인 관계를 만들고 유지하는 방법 익히기: GIVE 스킬) -친절하게(Gentle) -호의적으로 행동하면서(Interested) - 수인 적 태도로((Validate) - 가벼운 마음으로(Easy Manner) 6. 좋은 관계 맺고 파괴적인 관계 끝내기.	25분	
심리교육 (자해 감소)	7. 대인관계 효율성 스킬을 통하여 친구와 좋은 관계 맺는 방법 토의하기 8. 자해행동 정지에 관한 이야기 적어보기. -고통감내력 방법에 관하여 이야기해 보기.		
피드백 나누기	9. 소감 나누기 10. 다음 회기 소개 및 과제 마무리	10분	
준비물	- 필기도구, 생활 습관 점검표		
과제 제시하기	11. 대인관계 효율성 훈련 - 긍정적인 관계를 만들고 유지하는 방법 익히기: GIVE 스킬.		

회기 주제	- 대인관계 효율성 훈련	회 기	9
회기 목표	- 자기 존중감 유지하기 위한 (FAST 스킬) 익히기		
진행 절차 및 내용			소요 시간
생활 습관	1. 생활 습관 점검표 점검하기. 2. 대인관계 효율성 (GIVE) 스킬 훈련 과제 실시 여부를 파악하기.	10분	
DBT 기술 (대인관계 효율성)	3. 마음챙김(호흡 관찰하기) - 배의 움직임 - 숨을 들이마시고 내쉬면서 코에서 느껴지는 감각에 집중해 보기 4. 대인관계 효율성 훈련 - 원하는 것을 요청할 때 고려 할 것 - 요청하거나 거절할 때 고려 할 것.	25분	
심리교육 (자해감소)	5. 친구랑 자해행동 정지했던 경험 나누고 칭찬해 주기. -대인관계 스킬을 적용하기. 6 자해행동 재발 교육 -자해행동 재발 방지 교육 7. 예행연습 (탄력성 활용)		
피드백 나누기	8. 소감 나누기 9. 다음 회기 소개 및 과제 마무리	10분	
준비물	- 필기도구, 생활 습관 점검표		
과제 제시하기	10. 자해행동 재발 방지 교육 실천하기.		

회기주제	- 변증법적 행동치료(DBT) 총정리 및 종결	회 기	10
회기목표	- 변화에 대해 점검하고, 평가하기. - 지속적인 DBT 기술 사용을 위한 전략을 수립하기.		
진행 절차 및 내용			소요시간
생활 습관	1. 생활 습관 점검표 점검하기. 2. 대인관계 효율성 기술 과제 실시 여부를 파악하기.		10분
교육 및 활동하기	3. 마음챙김 - 사운드 볼 : 집단상담을 통해 자신에게 가장 유익했던 점을 하나의 단어로 표현해 보게 한다. 한 사람이 선택한 단어를 오른쪽 사람에게 말하여 던져 준다. 그 단어를 받은 사람은 처음 단어를 따라서 반복하고, 새로운 단어를 만들어 다른 사람에게 던져 준다. 4. 미리 연습하기 - 문제행동으로 이어질 수 있는 상황을 상상한다. - 미리 연습하기 워크시트를 완성한다. 5. DBT 행동치료(DBT) 총정리 6. 학습한 기술에 대한 총정리 퀴즈 - 지금까지 배운 기술에 대한 퀴즈를 내고, 맞춘다. - 시나리오를 주고 이때 주인공이 사용할 수 있는 기술이 무엇인지 말하도록 한다. 7. 목표 돌아보기와 평가 - 의미있는 변화에 대해 함께 이야기 나눈다. - 가장 도움받았던 기술과 전략이 무엇이었던지 이야기 나눈다. 8. 앞으로 자해행동 하지 않기 서약서 쓰기 9. 종결 감정 다루기		25분
피드백 나누기	10. 소감 나누기 11. 다음 회기 소개 및 과제 마무리		10분
준비물	-필기도구, 생활 습관 점검표		
과제 제시하기	12. 지속적으로 실천하고 싶은 과제 정하기.		